DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



CHAPITRE 3

Éléments de psychologie sociale

Mots-clés : Psychologie, Sociologie, Anthropologie de l'alimentation

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 3 · Éléments de psychologie sociale · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 96 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 99

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 7 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 100 à 106

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 114 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 107 à 220

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 32 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 221 à 252

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

3.1 Compétences mobilisées 7
3.2 Croisement référentiel × précisions × indications 7
3.3 Cours 9
3.4 Approfondissements 74
3.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 82
3.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 83
3.7 L'essentiel à retenir 86
3.8 Entraînement 87
3.9 Glossaire 97
3.10 Renvois bibliographiques par notion 98
3.12 Bibliographie numérotée 98

2 · Fiche de révision et fiches-outils **100**

Fiche de révision du chapitre 3 102
1. Les définitions à savoir 102
2. Les modèles à connaître 103
3. Les 9 CPS générales (Santé publique France, 2022) 103
4. Les pièges 103
5. Auto-test 103
6. Flashcards 104
Compléments du chapitre enrichi 104
Fiches-outils du chapitre 3 104
O3.1 – Recueil et analyse des représentations 105
O3.2 – Profil du public et adaptations 105
O3.3 – Grille « étapes du changement » 105
O3.4 – Planifier le développement des CPS 105
O3.5 – Règles du groupe et charte de bienveillance 106
O3.6 – Auto-observation de ma posture interculturelle 106

3 · Cahier d'exercices **107**

Cahier d'exercices – Chapitre 3 110
Partie 1 – Regards sur le mangeur, socialisation et identité 111
Partie 2 – Représentations, normes, valeurs et culture 125
Partie 3 – Influence sociale, attitudes et stigmatisation 138
Partie 4 – Compétences psychosociales, émotions, image du corps et estime de soi 153
Partie 5 – Les modèles du changement de comportement 166
Partie 6 – Communiquer, écouter, accompagner la motivation 180
Partie 7 – Animer un groupe, motiver, tenir compte des biais de décision 194
Partie 8 – Mesurer les attitudes et les représentations ; cas complet 206
Bilan : grille d'auto-évaluation 220

4 · Annales E5 ..... **221**

Cahier d'annales E5 – chapitre 3 223
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 224
Partie II – Les corrigés détaillés 234
Grille d'auto-évaluation 252

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS



CHAPITRE

03

Éléments de psychologie sociale

Psychologie | Sociologie | Anthropologie de l'alimentation

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

3.1 Compétences mobilisées 7

3.2 Croisement référentiel × précisions × indications 7

3.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 8

3.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 8

3.3 Cours 9

3.3.1 Psychologie, sociologie, anthropologie : trois regards sur le mangeur 10

3.3.2 Identité individuelle et sociale ; socialisation 13

3.3.3 Représentations, normes, valeurs ; culture et interculturalité 17

3.3.4 La relation sociale et ses dynamiques 23

3.3.5 Les compétences psychosociales 31

3.3.6 Image corporelle, émotions, estime de soi 34

3.3.7 Connaître les publics et comprendre le changement de comportement 37

3.3.8 Communiquer et écouter : les bases de la relation éducative 45

3.3.9 L'esprit de l'entretien motivationnel appliqué au collectif 48

3.3.10 Animer un groupe : étapes, rôles et styles d'animation 52

3.3.11 La motivation et les biais de décision 57

3.3.12 Mesurer attitudes et représentations 60

3.3.13 Un modèle intégrateur : COM-B et la roue du changement de comportement 64

3.3.14 Adapter l'approche psychosociale aux publics 68

3.3.15 Concevoir une séance qui développe les compétences psychosociales en nutrition 70

3.3.16 Fil rouge : les représentations et les dynamiques du groupe des Tilleuls 71

3.3.17 Trois cas guidés pour s'entraîner à l'analyse psychosociale 71

3.4 Approfondissements 74

3.4.1 Néophobie alimentaire et exposition répétée 74

3.4.2 Les normes sociales comme levier 75

3.4.3 L'influence des réseaux sociaux 76

3.4.4 La pair-éducation et les personnes relais 77

3.4.5 La motivation des enfants et des adolescents 78

3.4.6 Les émotions dans l'apprentissage 79

3.4.7 Précarité alimentaire : honte, dignité et pouvoir d'agir 80

3.4.8 Le numérique dans l'accompagnement du changement 80

3.4.9 Les personnes âgées : vieillissement, isolement et plaisir de manger 81

3.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 82

3.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 83

Méthode 1 – Justifier un choix d'animation par un modèle, à l'oral 84

Méthode 2 – Analyser une situation de groupe en quatre questions 84

Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve 84

3.7 L'essentiel à retenir 86

3.8 Entraînement 87

3.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 87

3.8.2 Exercices 88

3.8.3 Questions de réflexion 92

3.8.4 Étude de cas 92

3.8.5 Mises en situation express 93

3.8.6 Exercices complémentaires 95

3.9 Glossaire 97

3.10 Renvois bibliographiques par notion 98

3.12 Bibliographie numérotée..... 98

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir la psychologie, la sociologie et l'anthropologie et montrer ce que chacune apporte à la compréhension des comportements alimentaires ;
- définir l'identité individuelle et sociale, la socialisation primaire et secondaire, et les appliquer à l'alimentation ;
- définir les représentations sociales, les normes, les valeurs et les attitudes ;
- définir la culture, identifier des différences culturelles et expliquer l'interculturalité et l'acculturation (spontanée et planifiée) ;
- décrire les dynamiques d'une relation sociale et d'un groupe (influence, conformisme, engagement) ;
- définir les compétences psychosociales et proposer des activités pour les développer ;
- définir l'image corporelle, l'insatisfaction corporelle, les émotions, l'estime de soi et la confiance en soi, et en tenir compte dans une action ;
- connaître les spécificités des publics et les principaux modèles du changement de comportement ;
- relier ces savoirs à vos propres observations et interroger votre propre système de valeurs (objectif du guide 2025).

3.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.1	Comprendre les publics et les ressorts du changement pour concevoir des actions adaptées et non stigmatisantes	Priorités et objectifs adaptés au contexte ; règles éthiques respectées
C3.2	Adapter un atelier culinaire aux cultures, aux âges et aux émotions liées à l'alimentation	Besoins, objectifs et spécificités du public identifiés ; méthodes d'animation appropriées
C3.5	Animer un groupe, mobiliser l'écoute active, gérer les dynamiques et les émotions	Techniques d'animation et posture adaptées ; capacités d'écoute active mobilisées

3.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Psychologie, sociologie, anthropologie	Définir et distinguer ; citer des apports à l'alimentation	Connaître quelques auteurs repères (Fischler, Poulain, Lewin)
Identité individuelle et sociale	Définir ; exemples alimentaires	Pas de théorie de la personnalité
Compétences psychosociales	Définir, classer (cognitives, émotionnelles, sociales), proposer des activités	Référentiel Santé publique France 2022
Représentations, normes, valeurs	Définir, recueillir et utiliser les représentations d'un public	Méthodes de recueil (photolangage, associations libres)
Culture, interculturalité, acculturation	Identifier les différences culturelles ; adopter une posture interculturelle	Modèle de Berry ; acculturation spontanée et planifiée
Relation sociale, socialisation	Décrire les dynamiques ; rôle de la famille, de l'école, des pairs	Expérience de Lewin, conformisme, engagement
Image corporelle, émotions, estime de soi	Définir ; repérer les risques (stigmatisation, restriction)	Orientation si troubles du comportement alimentaire (BC1)

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Connaissance des publics	Adapter l'action à l'âge, la culture, la précarité, le handicap	Modèles du changement : HBM, Prochaska, Ajzen, Bandura

3.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, savoirs « Éléments de psychologie sociale ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 60 et 61). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les corrections sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 3.2.2.

Texte	Critère ou indication	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 60-61	Définitions : psychologie, sociologie, anthropologie	3.3.1 (trois regards, fondateurs à connaître)
Guide 2025, p. 61	Identité individuelle et sociale ; socialisation primaire et secondaire	3.3.2 (dont identité collective, déviance)
Guide 2025, p. 61	Représentations, normes, valeurs ; culture, interculturalité, acculturation spontanée et planifiée	3.3.3
Guide 2025, p. 61	Relation sociale et ses dynamiques	3.3.4 (influence, attitudes, stéréotypes, communication, rumeurs) ; 3.3.10
Guide 2025, p. 61	Compétences psychosociales et leur développement	3.3.5 et 3.3.15 (référentiel de Santé publique France, 2022)
Guide 2025, p. 61	Image corporelle, émotions, estime de soi	3.3.6
Guide 2025, p. 61	Connaissance des publics et de leurs spécificités	3.3.7 (dont pauvreté et exclusion) ; 3.3.14 (dont développement et maladie)
Référentiel, C3.1, C3.2, C3.5	Publics, objectifs adaptés, animation, écoute active	3.3.7 à 3.3.16 ; 3.6

3.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié par rapport au fascicule *Environnement professionnel – Synthèse du cours en bref*, 1re année (CNED 3-6123-AN-WT-00-21), module 5 « Éléments de psychologie et de sociologie » (p. 32 à 46). Les pratiques et comportements alimentaires (module 2) sont traités au chapitre 4.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M5 S1 §1 et §2 (p. 32 et 33)	Sociologie et psychologie ; fondateurs : Marx, Durkheim, Weber, Freud, Winnicott, Piaget, Bowlby	3.3.1 (fondateurs à connaître)
M5 S1 §3 et §4 (p. 33)	Socialisation ; identités individuelle, collective et sociale	3.3.2
M5 S1 §5 et §6 (p. 34)	Déviance (Merton, Becker) et délinquance	3.3.2 (déviance et délinquance)
M5 S2 §1 (p. 35 et 36)	Représentations sociales (Moscovici, Jodelet, Abric) ; stéréotypes, TIP, préjugés, discriminations	3.3.3 ; 3.3.4 (stéréotypes, juger autrui)
M5 S2 §2 (p. 36 à 38)	Communication (modèle de Shannon, moi intime et moi public, non-verbal) ; attitudes, distances, analyse transactionnelle ; rumeurs	3.3.4 (communiquer) ; 3.3.8
M5 S2 §3 (p. 38 et 39)	Intégration, lien social, socialisation, pauvreté, exclusion ; disqualification (Paugam), désaffiliation (Castel) ; classes, stratification, Bourdieu	3.3.7 (vocabulaire de la sociologie)

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M5 S3 (p. 40 à 43)	Courants de la psychologie du développement ; stade du miroir ; stades de Piaget ; adolescence, adulte, personne âgée	3.3.14 (développement de la personne)
M5 S4 (p. 44 à 46)	Maladie, psychosomatique, stress, mort ; rôle du diététicien	3.3.14 (maladie, stress et fin de vie)

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou était inexact

- **Durkheim** (p. 32) : le fascicule écrit qu'« il a mis en place la laïcité ». C'est faux : la laïcité de l'État vient de la **loi du 9 décembre 1905** (séparation des Églises et de l'État), votée par le Parlement. Durkheim est l'un des **fondateurs de la sociologie** (*Les Règles de la méthode sociologique*, 1895 ; *Le Suicide*, 1897) ; il a seulement défendu une morale laïque à l'école.
- **Définition de la psychologie** (p. 32) : la phrase « … agit sur son environnement social » définit la **psychologie sociale**. La psychologie étudie plus largement les processus mentaux et les comportements de la personne.
- **Pauvreté** (p. 39) : la pauvreté monétaire de l'Insee n'est pas « le seuil en deçà duquel il est impossible de survivre ». C'est une pauvreté **relative** (60 % du niveau de vie médian). Le seuil de **1 041 €** date de 2017 ; le dernier publié est de **1 337 € par mois en 2024** (Insee, 9 juillet 2026), avec un taux de pauvreté de **15,4 %** (9,8 millions de personnes).
- **« Définitions selon Durkheim »** (p. 38) : toutes ces notions ne sont pas de Durkheim. L'**exclusion sociale** a été popularisée par René Lenoir (1974), la **disqualification** par Serge Paugam (1991), la **désaffiliation** par Robert Castel (1995), et le seuil de pauvreté est une convention statistique.
- **Auteurs non nommés** : le fascicule ne cite pas les auteurs de la **proxémie** (Edward T. Hall, 1966), de l'**analyse transactionnelle** (Eric Berne), des mécanismes de la **rumeur** (Allport et Postman, 1947) ni des **trois phases du stress** (Hans Selye, 1936). Le cours les donne, car le jury attend des références.
- **Modèle de Shannon** (p. 37) : il s'agit du modèle de Shannon et Weaver (1949), conçu pour les télécommunications ; il oublie la rétroaction et le contexte, que complète le schéma de la section 3.3.8.

3.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Compétences psychosociales** : le référentiel de Santé publique France (2022) et la stratégie interministérielle de développement des compétences psychosociales des enfants et des jeunes (2022-2037) sont les textes de référence ; consultez les outils et retours d'expérience publiés depuis sur *santepubliquefrance.fr*.
- **Stigmatisation du poids** : le consensus international de 2020 (*Nature Medicine*) reste la référence ; vérifiez les recommandations françaises récentes sur la communication non stigmatisante (HAS, Santé publique France).
- **Pauvreté** : dernier seuil publié par l'Insee (9 juillet 2026) : 1 337 € par mois en 2024 ; taux de pauvreté 15,4 % (section 3.3.7).
- **PNNS 5 (2026-2030)** : lancé le 8 avril 2026, il compte 3 axes et 20 mesures ; son troisième axe vise à « faire des milieux de vie des espaces promoteurs de santé » (voir le chapitre 1).

3.3.1 Psychologie, sociologie, anthropologie : trois regards sur le mangeur

Module · Guide 2025 : p. 60-61 · CNED : Synthèse M5 S1 §1 et §2 (p. 32 et 33)

Discipline	Objet	Apport pour comprendre l'alimentation
Psychologie	Étude des processus mentaux et des comportements de l'individu (perceptions, émotions, motivations, apprentissages) ; la psychologie sociale étudie l'influence des autres sur l'individu	Préférences et aversions, néophobie, alimentation émotionnelle, motivation au changement, influence du groupe
Sociologie	Étude des groupes et des faits sociaux (classes sociales, institutions, normes)	Différences de pratiques selon le milieu social, le genre, l'âge ; repas comme fait social ; inégalités
Anthropologie	Étude de l'être humain dans ses dimensions culturelles (ethnologie) et biologiques, souvent par comparaison entre sociétés	Interdits, rites, symboliques des aliments, manières de table, cuisines du monde

Définition – Psychologie sociale

Discipline qui étudie la façon dont les pensées, les sentiments et les comportements des individus sont influencés par la présence réelle, imaginée ou implicite des autres (Gordon Allport, 1954). Elle se situe à l'interface de la psychologie (l'individu) et de la sociologie (le groupe).

Quelques repères en sociologie et anthropologie de l'alimentation

- **Claude Lévi-Strauss** (*Le cru et le cuit*, 1964) : la cuisine transforme la nature en culture ; le « triangle culinaire » (cru, cuit, pourri) montre que chaque société organise symboliquement ses aliments.
- **Claude Fischler** (*L'Homnivore*, 1990) : le **paradoxe de l'omnivore** : l'être humain a besoin de variété (**néophilie**), mais se méfie de l'inconnu (**néophobie**) ; le **principe d'incorporation** : « je deviens ce que je mange », d'où l'importance symbolique et l'anxiété autour des aliments. Il décrit aussi la **gastro-anomie** : l'affaiblissement des règles collectives du repas laisse le mangeur moderne seul face à des injonctions contradictoires.
- **Jean-Pierre Poulain** (*Sociologies de l'alimentation*, 2002) : l'**espace social alimentaire**, zone de liberté laissée au mangeur par les contraintes biologiques et environnementales, structurée en six dimensions.
- **Pierre Bourdieu** (*La Distinction*, 1979) : les goûts alimentaires sont socialement construits ; les milieux populaires valorisent le « nourrissant », les milieux favorisés la « légèreté » et la forme.

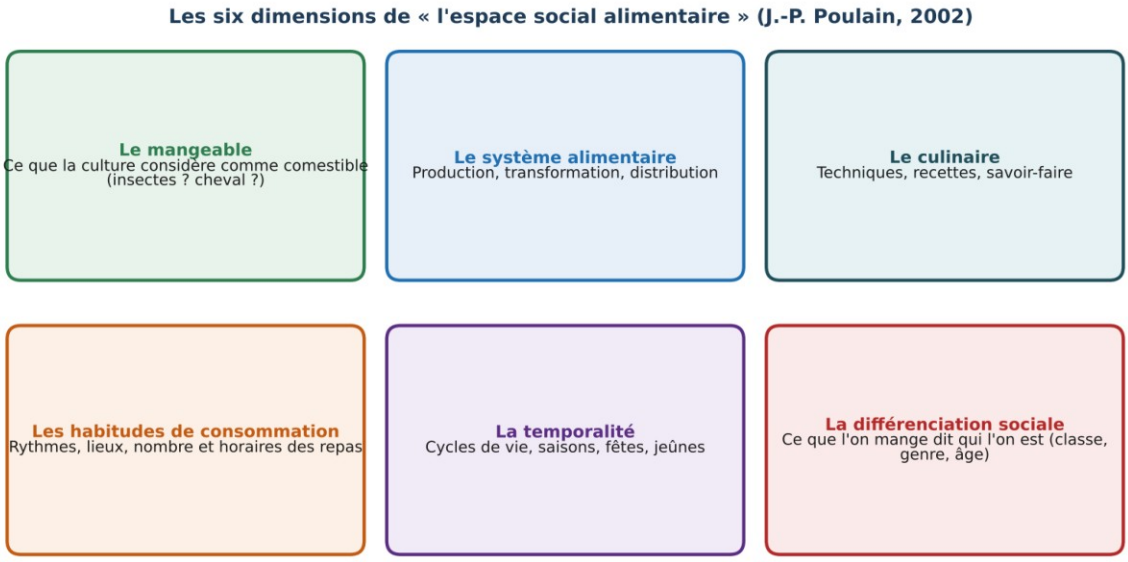


Figure 3.1 – Les six dimensions de l'espace social alimentaire (Poulain, 2002)

Comprendre le schéma – Figure 3.1

1. Le mangeable : chaque culture définit ce qui est comestible (le cheval, les insectes, le porc ne sont pas « mangeables » partout).

2. Le système alimentaire : chaîne de la production à la distribution, qui conditionne ce qui est disponible.

3. Le culinaire : techniques, recettes et savoir-faire qui transforment l'aliment.

4. Les habitudes de consommation : nombre de repas, horaires, lieux, prises hors repas.

5. La temporalité : âges de la vie, saisons, calendrier des fêtes et des jeûnes (Ramadan, Carême).

6. La différenciation sociale : l'alimentation marque l'appartenance à un groupe (classe, génération, genre, religion).

7. Lecture pour le diététicien : un conseil nutritionnel touche à **toutes** ces dimensions ; il est efficace s'il les respecte.

Les fondateurs à connaître (programme du CNED)

La **sociologie** donne des outils, un vocabulaire et des théories pour expliquer la vie sociale ; elle pose des questions et y répond par des hypothèses vérifiées sur le terrain. La **psychologie** étudie scientifiquement les processus mentaux et les comportements de la personne (perception, mémoire, émotions, jugement, action). Quand elle étudie l'influence des autres sur la personne, c'est la **psychologie sociale**.

Auteur	Discipline	Idée à retenir	Lien avec l'alimentation
Karl Marx (1818-1883)	Sociologie, économie	Classes sociales définies par la place dans la production ; domination et aliénation	Inégalités d'accès à une alimentation de qualité
Émile Durkheim (1858-1917)	Sociologie	Le fait social s'impose à l'individu ; intégration, lien social, solidarité mécanique (ressemblance) et organique (complémentarité)	Le repas partagé comme lien social ; l'isolement comme risque
Max Weber (1864-1920)	Sociologie	Comprendre le sens que les personnes donnent à leurs actions ; « type idéal » pour comparer ; stratification	Comprendre pourquoi une personne fait un choix alimentaire
Sigmund Freud (1856-1939)	Psychanalyse	Développement psycho-affectif ; place de l'inconscient et de l'enfance	Stade oral, valeur affective de la nourriture

Auteur	Discipline	Idée à retenir	Lien avec l'alimentation
Donald W. Winnicott (1896-1971)	Pédiatrie, psychanalyse	Lien entre le nourrisson et les soins maternels ; mère « suffisamment bonne »	Le nourrissage comme relation, pas seulement comme apport
Jean Piaget (1896-1980)	Psychologie du développement	L'intelligence se construit par adaptation, en quatre stades	Adapter les messages à l'âge des enfants
John Bowlby (1907-1990)	Pédopsychiatrie	Théorie de l'attachement : le lien au parent est un besoin premier	Climat affectif des repas de l'enfant

À vous de jouer – Exercice d'application 3.1

Associez chaque phrase à un auteur du tableau : a) « Le repas de famille entretient le sentiment d'appartenir au groupe. » b) « Un enfant de 5 ans ne comprend pas encore la notion abstraite de "nutriment". » c) « Pour comprendre ce choix, je cherche le sens que la personne lui donne. » d) « Un bébé a besoin de la présence stable d'une figure d'attachement pendant les repas. »

Corrigé

a) **Durkheim** (intégration, lien social). b) **Piaget** (stade préopératoire : pensée concrète, pas encore de raisonnement abstrait). c) **Weber** (sociologie compréhensive). d) **Bowlby** (attachement), et aussi Winnicott (soins maternels).

Les fonctions de l'alimentation : pourquoi mange-t-on ?

Manger ne sert pas seulement à couvrir des besoins en énergie et en nutriments. Les sciences humaines distinguent plusieurs **fonctions** de l'alimentation, toujours présentes en même temps. Un conseil qui n'en considère qu'une (la fonction nutritionnelle) a peu de chances d'être suivi.

Fonction	Ce qu'elle recouvre	Exemple	Conséquence pour l'action
Biologique (nutritionnelle)	Couvrir les besoins, apaiser la faim, se maintenir en santé	Manger des féculents avant un effort	Nécessaire mais rarement suffisante pour motiver
Hédonique (plaisir)	Goût, odeurs, textures, plaisir des sens	Le chocolat, le plat préféré	Garder le plaisir dans toute proposition
Psychologique et affective	Réconfort, régulation des émotions, souvenirs	Le gâteau de la grand-mère, manger quand on est triste	Comprendre l'alimentation émotionnelle sans juger
Sociale et relationnelle	Partager, recevoir, créer du lien, marquer les rythmes collectifs	Repas de famille, apéritif entre collègues	Proposer des repas partagés, agir avec le groupe
Identitaire	Dire qui l'on est et à quel groupe on appartient	Cuisine du pays d'origine, végétarisme, plats régionaux	Valoriser les cuisines d'origine, ne pas les dévaloriser
Symbolique et religieuse	Interdits, rites, fêtes, jeûnes	Ramadan, Carême, repas de Noël	Adapter le calendrier et le contenu des actions

Le modèle alimentaire français et la gastro-anomie

Le **modèle alimentaire français** (trois repas par jour à heures fixes, pris à table et à plusieurs) et son évolution sont présentés au chapitre 4. On retient ici une notion de sociologie utile pour comprendre le mangeur d'aujourd'hui.

Définition – Gastro-anomie (Fischler, 1979)

Situation du mangeur moderne qui, face à l'abondance de l'offre et à l'affaiblissement des règles collectives

(horaires, structure du repas, transmission familiale), doit faire seul ses choix au milieu de messages contradictoires (publicité, médecine, médias, réseaux sociaux). La gastro-anomie favorise l'anxiété alimentaire et la recherche de repères, parfois dans des régimes ou des modes peu fondés.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.2

Lors d'un atelier avec des retraités, une participante dit : « Depuis que je suis veuve, je ne fais plus de vrais repas : un yaourt et une tranche de jambon devant la télévision. Cuisiner pour une personne, ça ne vaut pas la peine. » a) Identifiez les fonctions de l'alimentation qui ont disparu pour elle. b) Expliquez pourquoi un conseil purement nutritionnel (« il faut manger des protéines et des légumes ») a peu de chances de réussir. c) Proposez deux actions qui redonnent leurs fonctions aux repas.

Corrigé

a) Les fonctions **sociale et relationnelle** (elle mange seule, sans personne pour qui cuisiner), **hédonique** (repas sans plaisir) et **identitaire** (son rôle de « celle qui cuisine pour la famille » a disparu). La fonction biologique elle-même est menacée (risque de dénutrition). **b)** Le conseil ne répond pas à la cause du problème, qui est la perte du sens social du repas ; il risque même de culpabiliser. **c)** Un repas partagé hebdomadaire au club ou au foyer-restaurant, où elle peut aussi transmettre une recette (valorisation, lien social) ; des recettes « pour un » rapides et des idées de portions à congeler, présentées lors d'un atelier convivial ; la participation à une action de « repas solidaires » entre voisins.

3.3.2 Identité individuelle et sociale ; socialisation

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M5 S1 §3 et §4 (p. 33) ; Synthèse M5 S1 §5 et §6 (p. 34)

Définition – Identité individuelle et identité sociale

- L'**identité individuelle** (ou personnelle) est l'ensemble des caractéristiques par lesquelles une personne se reconnaît comme unique (histoire, goûts, valeurs, image de soi).
- L'**identité sociale** est la partie de l'image de soi qui provient de l'**appartenance à des groupes** (famille, génération, origine, religion, profession, quartier) et de la valeur qu'on leur attribue (Tajfel et Turner, théorie de l'identité sociale, 1979).

L'alimentation est un puissant **marqueur d'identité** : « dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es » (Brillat-Savarin, 1825). Les plats familiaux, régionaux ou du pays d'origine, les interdits religieux (halal, casher, végétarisme hindou), les choix éthiques (végétarisme, véganisme) ou les styles de vie (« healthy ») expriment l'appartenance à un groupe. Toucher à l'alimentation, c'est toucher à l'identité : un conseil qui dévalorise un plat familial peut être vécu comme une attaque.

Définition – Socialisation

Processus par lequel une personne **intériorise** les normes, les valeurs et les pratiques de la société et des groupes auxquels elle appartient.

- **Socialisation primaire** : pendant l'enfance, principalement par la **famille** (goûts, horaires des repas, manières de table, aliments « de fête » et « de tous les jours »), puis l'école.
- **Socialisation secondaire** : à l'adolescence et à l'âge adulte, par l'école, les **pairs**, le travail, le couple, les médias et les réseaux sociaux ; elle peut renforcer ou transformer la socialisation primaire.

Exemple – La socialisation alimentaire en action

- Un enfant apprend à aimer les légumes s'il les goûte **à plusieurs reprises** (8 à 15 expositions sont souvent

nécessaires) dans un climat positif, en voyant ses parents en manger (modèle).
- À l'adolescence, les **pairs** et les réseaux sociaux prennent le relais : restauration rapide entre amis, boissons énergisantes, régimes vus sur les réseaux.
- À l'entrée dans la vie étudiante ou professionnelle, la cantine, les horaires et la vie en couple transforment les habitudes (socialisation secondaire).

Lien diététique – Ce que cela change pour l'animation

Pour un atelier avec des enfants, impliquer les **parents** (socialisation primaire) ; pour des adolescents, s'appuyer sur des **pairs** ou des ambassadeurs (socialisation secondaire) ; pour des adultes, partir des **plats familiaux** valorisés et proposer des adaptations plutôt que des ruptures.

Identité collective, déviance et délinquance

Le CNED distingue trois niveaux d'identité :

- l'**identité individuelle** : ce que la personne s'attribue (traits, rôles, valeurs) ;
- l'**identité collective** : la façon dont une personne se définit et est définie par les autres à partir de ses appartenances (profession, âge, genre, religion, territoire, famille) ;
- l'**identité sociale** : la combinaison des deux ; c'est ce qui permet aux autres de situer la personne, par la **catégorisation sociale**.

Définition – Déviance et délinquance

- La **déviance** est le fait de ne pas suivre une **norme sociale**, souvent implicite. Elle est relative : ce qui est déviant ici ou aujourd'hui peut être accepté ailleurs ou demain. Robert K. Merton (1938) l'explique par l'écart entre les buts valorisés et les moyens disponibles ; Howard Becker (*Outsiders*, 1963) montre qu'est déviant celui à qui le groupe **colle l'étiquette** de déviant.
- La **délinquance** est le non-respect d'une norme **écrite dans la loi** ; elle expose à une sanction pénale.

Lien diététique – Ne pas étiqueter les mangeurs

Manger seul, sauter un repas, refuser la viande ou suivre un jeûne religieux peuvent être vus comme « déviants » dans un groupe et normaux dans un autre. Le diététicien évite les étiquettes (« le mauvais élève », « l'obèse ») : selon Becker, l'étiquette elle-même peut enfermer la personne dans le comportement qu'on lui reproche.

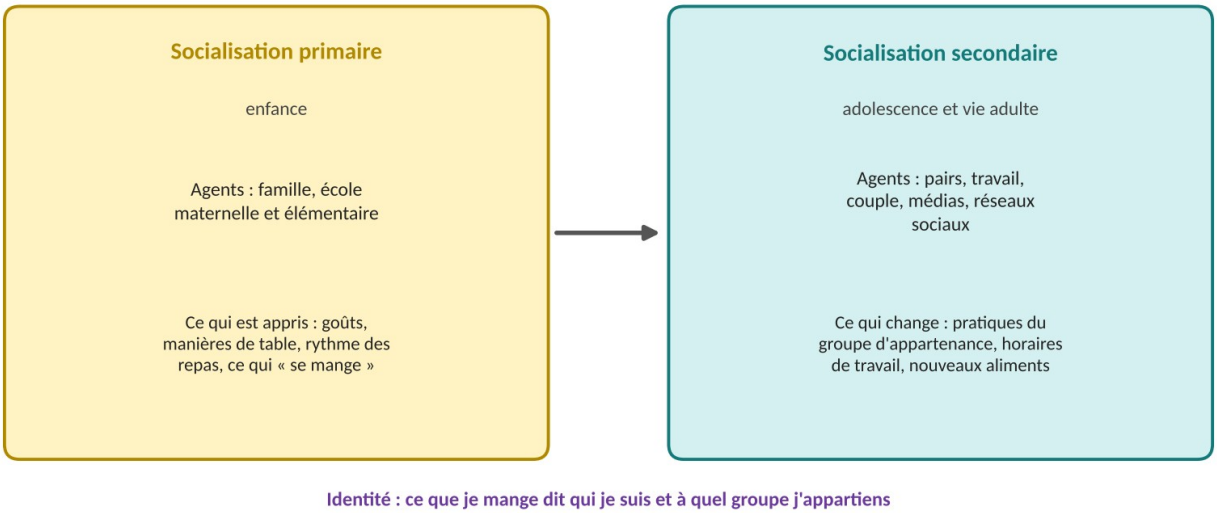


Figure 3.1 bis – Socialisation primaire et secondaire

Comprendre le schéma – Figure 3.1 bis

1. La **socialisation primaire** se fait dans l'enfance, surtout dans la famille et à l'école : l'enfant y apprend ses goûts, les manières de table, le rythme des repas et ce qui « se mange ».
2. La **socialisation secondaire** se poursuit toute la vie : pairs, travail, couple, médias et réseaux sociaux transforment ou renforcent les apprentissages de l'enfance.
3. La flèche montre une continuité : la socialisation secondaire ne remplace pas la primaire, elle s'y ajoute. Beaucoup d'adultes reviennent aux plats de leur enfance quand ils deviennent parents.
4. En bas, l'**identité** : ce que l'on mange dit qui l'on est et à quel groupe on appartient.

Identité sociale, groupes d'appartenance et de référence

Selon la théorie de l'identité sociale (Tajfel et Turner, 1979), chacun **catégorise** le monde en groupes, s'**identifie** à certains d'entre eux et se **compare** aux autres. On cherche une identité sociale positive : on valorise son groupe (**endogroupe**) par rapport aux autres (**exogroupes**). Le **groupe d'appartenance** est celui dont on fait partie ; le **groupe de référence** est celui auquel on se compare ou auquel on aimerait appartenir (un adolescent peut prendre pour référence un groupe de sportifs ou d'influenceurs).

Notion	Définition	Exemple alimentaire	Conséquence pour le diététicien
Catégorisation	Classer les personnes en groupes	« Les jeunes », « les bobos », « les gens du quartier »	Ne pas se présenter comme membre d'un groupe perçu comme « contre » le public
Favoritisme pour son groupe	Juger plus favorablement son propre groupe	« Chez nous, on mange bien, pas comme eux »	Valoriser les pratiques du groupe plutôt que celles d'un autre
Menace identitaire	Sentiment que l'identité de son groupe est dévalorisée	Un conseil qui critique un plat traditionnel	Partir des plats du groupe et proposer des adaptations
Groupe de référence	Groupe auquel on veut ressembler	Sportifs, influenceurs, collègues expérimentés	Faire porter le message par des modèles issus de ce groupe

Genre, normes et alimentation

Les pratiques alimentaires sont aussi marquées par les **normes de genre** apprises pendant la socialisation. Dans beaucoup de milieux, la viande rouge, les portions copieuses et la force sont associées au masculin, tandis que les légumes, les produits « légers » et le souci de la ligne sont associés au féminin. Ces normes expliquent en partie pourquoi, en moyenne, les hommes mangent plus de viande et moins de fruits et légumes que les femmes, et pourquoi les femmes sont davantage exposées aux régimes amaigrissants et à l'insatisfaction corporelle. Elles varient selon les milieux sociaux, les générations et les cultures, et elles évoluent.

Lien diététique – Utiliser l'identité plutôt que la combattre

- Avec un public masculin attaché à la « force », parler d'énergie, de récupération et de performance plutôt que de « régime ».
- Avec des personnes migrantes, partir des plats d'origine, souvent riches en légumineuses et en légumes, et les valoriser devant le groupe.
- Avec des adolescents, faire porter les messages par des pairs ou des modèles du groupe de référence.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.3

Dans un foyer de jeunes travailleurs, un résident de 19 ans dit : « Les légumes, c'est pour les filles. Moi je fais de la muscu, il me faut de la viande et des pâtes. » a) Identifiez la norme sociale et le groupe de référence en jeu. b) Expliquez pourquoi un message sur les « 5 fruits et légumes » risque d'être rejeté. c) Reformulez un message qui respecte son identité.

Corrigé

a) Une norme de genre qui associe les légumes au féminin et la viande à la force masculine ; le groupe de référence est celui des pratiquants de musculation. **b)** Le message entre en conflit avec son identité (menace identitaire) et avec les normes de son groupe de référence ; il sera perçu comme venant d'un exogroupe (« les diététiciens »). **c)** Exemple : « Les sportifs de haut niveau mettent des légumes dans chaque repas : ils apportent les vitamines et les minéraux qui aident les muscles à récupérer. Tu veux qu'on regarde ce que mange un athlète en préparation ? »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.1 et 3.3.2 – Regards sur le mangeur, identité et socialisation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Distinguez l'objet de la psychologie, de la sociologie et de l'anthropologie.
2. Énoncez le paradoxe de l'omnivore et donnez son auteur et son année.
3. Citez trois fonctions de l'alimentation, en plus de la fonction biologique.
4. Distinguez socialisation primaire et socialisation secondaire, avec un agent de chacune.
5. Qu'est-ce qu'un groupe de référence ? Donnez un exemple chez un adolescent.
6. Vrai ou faux : « La gastro-anomie désigne un trouble du comportement alimentaire. » Justifiez.

Corrigé – Point d'étape 3.3.1 et 3.3.2

1. La psychologie étudie l'individu (perceptions, émotions, motivations) ; la sociologie, les groupes et les faits sociaux (classes, genre, âge) ; l'anthropologie, les cultures (symboles, rites, interdits).
2. L'être humain a besoin de variété (néophilie) mais se méfie de l'inconnu (néophobie) ; Claude Fischler, *L'Homnivore*, 1990.
3. Par exemple : fonction sociale (partager, créer du lien), identitaire (dire qui l'on est), hédonique (plaisir), symbolique ou religieuse, éducative.
4. Primaire : pendant l'enfance, par la famille puis l'école. Secondaire : tout au long de la vie, par les pairs, le

travail, le couple, les médias.

5. Le groupe auquel on se compare ou auquel on aimerait appartenir, sans en faire forcément partie : des sportifs, des influenceurs.

6. Faux : c'est la perte de repères sur ce qu'il faut manger, quand les normes se multiplient et se contredisent (Fischler, 1979) ; ce n'est pas une maladie.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.3 Représentations, normes, valeurs ; culture et interculturalité

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M5 S2 §1 (p. 35 et 36)

Représentations sociales

Définition – Représentation sociale (Serge Moscovici, 1961)

Forme de connaissance **socialement élaborée et partagée**, qui permet aux membres d'un groupe d'interpréter la réalité et d'orienter leurs comportements (« sens commun »). Selon Jean-Claude Abric (1994), une représentation est organisée autour d'un **noyau central** stable (les éléments essentiels, difficiles à changer) et d'**éléments périphériques** plus flexibles.

Exemple – Représentations alimentaires fréquentes

« Un repas sans viande n'est pas un vrai repas » ; « manger équilibré coûte cher » ; « le pain fait grossir » ; « un enfant gros est un enfant en bonne santé » ; « bio = sans calories » ; « les féculents le soir font grossir ». Ces représentations ne sont pas des « erreurs » à corriger brutalement : elles ont une **cohérence** pour ceux qui les portent (expérience, culture, publicité). L'éducateur les **recueille** d'abord, puis les fait évoluer en s'appuyant sur les éléments périphériques (« un repas sans viande peut être complet s'il associe légumineuses et céréales »).

Méthode pas à pas – Recueillir les représentations d'un groupe

1. Associations libres : « Quand je dis "manger équilibré", à quoi pensez-vous ? » ; noter tous les mots au tableau, puis les regrouper.

2. Photolangage : choisir parmi 30 à 40 photos celle qui représente « bien manger pour moi » et expliquer son choix.

3. Abaque de Régnier : réagir à des affirmations avec des cartes de couleur (d'accord / pas d'accord) puis en débattre.

4. Classement de cartes : classer des aliments selon le prix, le plaisir, la santé, puis comparer.

5. Synthèse : repérer ce qui est partagé (noyau), ce qui varie, ce qui peut évoluer ; adapter les messages.

Comment se forme et à quoi sert une représentation sociale

Serge Moscovici (*La psychanalyse, son image et son public*, 1961) décrit deux processus qui transforment une notion nouvelle ou abstraite en savoir de sens commun.

- L'**objectivation** rend concret ce qui est abstrait : on sélectionne quelques éléments, on les simplifie et on en fait une image. « Manger équilibré » devient « manger de la salade et du poisson » ; « le cholestérol » devient « le gras qui bouche les artères ».
- L'**ancrage** rattache la nouveauté à des catégories déjà connues, ce qui la rend familière : « les produits ultra-transformés, c'est comme les plats tout prêts de la télé » ; « le bio, c'est comme les légumes du jardin de mon grand-père ».

Jean-Claude Abric (*Pratiques sociales et représentations*, 1994) attribue aux représentations **quatre fonctions**.

Fonction	Rôle	Exemple
De savoir	Comprendre et expliquer la réalité avec des mots communs	« Le sucre donne le diabète »
Identitaire	Situer la personne et son groupe, protéger leur image	« Nous, les ouvriers, on mange solide »
D'orientation	Guider les comportements, définir ce qui est attendu	« Un vrai repas, c'est un plat chaud » : on refuse la salade du soir
Justificatrice	Justifier après coup les choix et les comportements	« Je ne mange pas de légumes parce que c'est trop cher »

Noyau central et périphérie

	Noyau central	Éléments périphériques
Rôle	Donne le sens de la représentation, l'organise	Adaptent la représentation aux situations concrètes
Caractère	Stable, consensuel, lié à l'histoire et aux valeurs du groupe	Souples, variables selon les personnes
Face au changement	Résiste ; s'il change, la représentation change entièrement	Évoluent facilement ; ils protègent le noyau
Comment l'identifier	Fréquent et cité tôt dans l'évocation ; massivement refusé quand on le met en cause	Moins fréquent ou cité tard ; on accepte de s'en passer

Méthode pas à pas – Vérifier qu'un élément est central : le questionnaire de mise en cause (Moliner, 1988)

1. Partir des éléments situés dans la zone du noyau après une évocation hiérarchisée.

2. Pour chacun, poser la question : « Peut-on encore parler de [objet] si [élément] est absent ? » (par exemple : « Un repas peut-il être un vrai repas s'il n'y a pas de plat chaud ? »).

3. Calculer la part de réponses « non » : un élément refusé par une très large majorité (souvent au moins 75 %) est central ; un élément que beaucoup acceptent de retirer est périphérique.

4. En déduire les leviers : on agit d'abord sur la périphérie, en s'appuyant sur le noyau, sans le heurter.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.4

Dans un quartier, 100 parents répondent à un questionnaire de mise en cause sur « le petit-déjeuner ». « Peut-on parler de petit-déjeuner sans boisson chaude ? » : 82 répondent non. « … sans pain ni céréales ? » : 64 répondent non. « … s'il est pris debout ? » : 21 répondent non. a) Calculez les pourcentages et appliquez la règle des 75 %. b) Que proposez-vous aux familles qui manquent de temps le matin ?

Corrigé

a) Boisson chaude : 82 / 100 = **82 %** de « non » : élément central. Pain ou céréales : **64 %** : sous le seuil, élément plutôt périphérique mais important. Pris assis : **21 %** de « non » seulement : élément périphérique

(on accepte un petit-déjeuner pris debout). **b)** Ne pas toucher au noyau (garder une boisson chaude, par exemple un lait chaud ou un chocolat) et agir sur la périphérie : un petit-déjeuner rapide, éventuellement pris debout ou emporté, avec un produit céréalier simple (tartine préparée, pain) et un fruit facile à manger.

Normes, valeurs, attitudes

- Une **valeur** est un idéal collectif qui oriente les jugements (santé, plaisir, convivialité, partage, respect de l'animal, économie).
- Une **norme sociale** est une règle de conduite, explicite ou implicite, attendue dans un groupe : manger à heures fixes, finir son assiette, ne pas manger seul devant la télévision… On distingue les normes **descriptives** (« ce que les gens font ») et **injonctives** (« ce qu'il faut faire »). Montrer que « la majorité des familles de l'école donnent de l'eau au goûter » (norme descriptive) est souvent plus efficace qu'une injonction.
- Une **attitude** est une disposition favorable ou défavorable envers un objet (« j'aime / je n'aime pas les légumes secs »), composée d'éléments cognitifs (croyances), affectifs (émotions) et conatifs (intentions d'agir).

Culture, différences culturelles, interculturalité, acculturation

Définition – Culture

Ensemble des manières de penser, de sentir et d'agir, **apprises et partagées** par les membres d'un groupe, et transmises de génération en génération (langue, croyances, valeurs, techniques, cuisine, rites). La culture alimentaire comprend ce qui est mangé, comment, quand, avec qui, et ce que cela signifie.

Les **différences culturelles** portent par exemple sur : la structure du repas (plat unique ou succession d'entrée-plat-dessert), les horaires, l'usage des mains ou des couverts, les aliments interdits ou valorisés, la place des enfants à table, la valeur de la corpulence (signe de santé et de prospérité dans certaines cultures), le rapport au temps du repas, les fêtes et jeûnes.

Définition – Interculturalité

Ensemble des **relations et échanges** entre personnes de cultures différentes, fondés sur la reconnaissance mutuelle et la réciprocité. La **posture interculturelle** du professionnel consiste à prendre conscience de son propre cadre culturel (décentration), à découvrir celui de l'autre sans jugement, et à négocier des solutions acceptables pour les deux (Margalit Cohen-Emerique, 2011).

Définition – Acculturation

Ensemble des changements qui se produisent lorsque des groupes de cultures différentes sont en **contact continu et direct** (Redfield, Linton et Herskovits, 1936). Roger Bastide distingue l'acculturation **spontanée** (non dirigée, par le simple contact : adoption progressive de produits du pays d'accueil) et l'acculturation **planifiée** (organisée volontairement par une institution, par exemple un programme d'éducation alimentaire ou la cantine scolaire). Le **syncrétisme culinaire** désigne la combinaison d'éléments de cultures différentes dans une même pratique (couscous aux légumes de saison français, « burger » maison avec épices du pays d'origine).

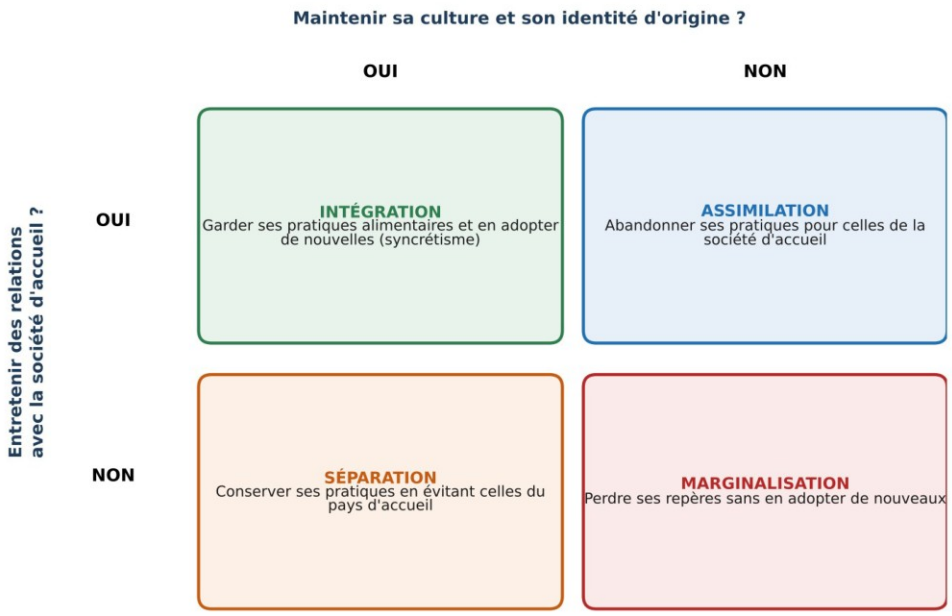


Figure 3.2 – Les stratégies d'acculturation selon John Berry (1997), appliquées à l'alimentation

Comprendre le schéma – Figure 3.2

1. Le modèle croise deux questions : la personne **maintient-elle** sa culture d'origine ? **Entretient-elle** des relations avec la société d'accueil ?

2. Intégration (oui / oui) : on garde ses plats et on en adopte de nouveaux ; c'est la stratégie généralement la plus favorable au bien-être et à la santé.

3. Assimilation (non / oui) : abandon des pratiques d'origine ; en alimentation, elle s'accompagne souvent de l'adoption de produits transformés, de sodas et de restauration rapide, avec un risque de dégradation de la qualité nutritionnelle (« transition nutritionnelle »).

4. Séparation (oui / non) : maintien des pratiques d'origine sans contact avec celles du pays d'accueil ; difficultés possibles d'accès aux produits.

5. Marginalisation (non / non) : perte des repères sans en adopter de nouveaux ; situation de grande vulnérabilité, y compris alimentaire.

6. Pour le diététicien : favoriser l'**intégration** en valorisant les pratiques d'origine favorables (légumineuses, légumes, cuisine maison) et en aidant à utiliser les produits disponibles.

Attention – Respecter sans enfermer

Ne pas réduire une personne à sa culture supposée (« les Africains mangent… ») : il existe une grande diversité à l'intérieur de chaque groupe. On **demande** à la personne ce qu'elle mange et ce qui compte pour elle, plutôt que de le présumer.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.5

Lors d'un atelier, Mme A., arrivée du Mali il y a deux ans, explique qu'elle cuisine le tiep (riz au poisson et aux légumes) le week-end, mais que ses enfants réclament des nuggets et des sodas « comme à la cantine et chez les copains ». a) Identifiez les mécanismes de socialisation en jeu. b) Situez la famille dans le modèle de Berry. c) Proposez une attitude et une action.

Corrigé

a) Socialisation **primaire** (transmission du tiep par la mère) et socialisation **secondaire** des enfants par l'école, la cantine et les **pairs**, qui introduit de nouvelles normes et de nouveaux produits (acculturation **spontanée**). **b)** La famille est en situation d'**intégration** (la mère maintient ses plats et s'ouvre aux produits français), avec un risque d'**assimilation** des enfants vers des produits transformés peu favorables. **c)** Attitude : valoriser le tiep (plat complet riche en légumes et en poisson), sans dévaloriser les demandes des enfants. Action : atelier « recettes du monde » où la mère présente le tiep au groupe (valorisation identitaire) et atelier « nuggets maison au four » pour répondre aux envies des enfants avec une version plus favorable (syncrétisme).

Ethnocentrisme, relativisme et démarche interculturelle

- L'**ethnocentrisme** est la tendance à juger les autres cultures à partir des normes de la sienne, considérées comme les seules « normales » (« en France, on mange de tout, les enfants doivent s'adapter »).
- Le **relativisme culturel** considère que chaque pratique a un sens dans sa culture et doit être comprise avant d'être jugée. Poussé à l'extrême, il pourrait conduire à tout accepter, y compris ce qui nuit à la santé : le professionnel garde ses repères (sécurité sanitaire, droits des personnes) tout en cherchant à comprendre.
- Le **choc culturel** est la réaction (incompréhension, malaise, irritation) que provoque la rencontre d'une pratique très différente. Margalit Cohen-Emerique a montré qu'il touche des **zones sensibles** : le corps et sa présentation, le rapport au temps, la place de la famille et des femmes, la religion, la façon de soigner et de nourrir les enfants.

Méthode pas à pas – La démarche interculturelle en trois étapes (Cohen-Emerique, 2011)

1. Décentration : prendre conscience de son propre cadre de référence (valeurs, normes, préjugés) et de ses réactions face à la situation. « Pourquoi cette pratique me choque-t-elle ? »

2. Découverte du cadre de référence de l'autre : chercher à comprendre le sens de la pratique pour la personne, en l'interrogeant sans supposer. « Que représente pour vous ce repas, ce jeûne, cet aliment ? »

3. Négociation et médiation : chercher ensemble une solution acceptable pour les deux parties, qui respecte l'identité de la personne et les impératifs professionnels (santé, sécurité, règlement).

Exemple – Le jeûne du ramadan chez une personne diabétique

M. K., diabétique de type 2 traité par comprimés, annonce à la diététicienne qu'il fera le ramadan. **Décentration** : la diététicienne repère sa première réaction (« c'est dangereux, il ne doit pas jeûner »), liée à son cadre médical. **Découverte** : elle apprend que le jeûne a pour lui une grande valeur spirituelle et familiale, et qu'il l'a toujours fait. **Négociation** : elle l'oriente vers son médecin pour adapter le traitement et la surveillance de la glycémie, et travaille avec lui la composition des repas de rupture du jeûne et du repas avant l'aube (féculents complets, légumineuses, eau en quantité suffisante, dattes en quantité raisonnable). Le jeûne n'est ni interdit ni ignoré : il est accompagné.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.6

Dans une crèche, une mère d'origine sénégalaise donne à son fils de 18 mois un biberon de bouillie très sucrée le soir. L'auxiliaire de puériculture dit : « Ce n'est pas comme ça qu'on fait ici. » a) Identifiez l'attitude de l'auxiliaire. b) Appliquez les trois étapes de la démarche interculturelle. c) Proposez une solution négociée.

Corrigé

a) Une attitude **ethnocentrique** : la pratique est jugée à partir des normes de l'auxiliaire et de l'institution, sans chercher à la comprendre. **b)** Décentration : l'auxiliaire repère que, pour elle, la « bonne » alimentation d'un enfant de 18 mois passe par des repas à la cuillère et peu de sucre. Découverte : elle interroge la mère, qui explique que la bouillie du soir aide l'enfant à dormir et qu'elle a été élevée ainsi ; elle craint qu'il ait faim

la nuit. Négociation : on part de l'objectif commun (un enfant qui dort bien et qui n'a pas faim). **c)** Garder le repas du soir rassasiant, mais remplacer peu à peu la bouillie sucrée par une bouillie de céréales non sucrée ou peu sucrée, avec du lait ou un fruit écrasé, donnée à la cuillère quand c'est possible, et parler du brossage des dents. La mère choisit le rythme du changement.

Pratiques alimentaires religieuses : connaître pour adapter

Dans un atelier, le respect des pratiques religieuses et culturelles conditionne la participation. Le diététicien ne suppose rien à partir de l'origine ou du nom d'une personne : il **demande**, car les pratiques varient beaucoup d'une personne à l'autre au sein d'une même religion.

Les règles des grandes traditions religieuses (islam, judaïsme, christianisme, hindouisme, bouddhisme, sikhisme, jaïnisme) et la question de la laïcité en restauration collective sont présentées au chapitre 4 (section 4.3.15). On retient ici la posture : ces règles sont aussi des **marqueurs d'identité** (section 3.3.2) ; les respecter évite la **menace identitaire** et favorise la stratégie d'**intégration** de Berry. En restauration scolaire, les menus de substitution ne sont ni obligatoires ni interdits ; le Conseil d'État (11 décembre 2020) a jugé qu'une commune qui décide de les supprimer doit tenir compte de l'intérêt des enfants.

Méthode pas à pas – Préparer un atelier interculturel respectueux

1. À l'inscription, demander simplement : « Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas, pour des raisons de santé, de religion ou de goût ? »
2. Construire la recette de base avec des ingrédients acceptables par tous (légumes, légumineuses, céréales, épices).
3. Prévoir les éventuelles variantes à part (viande halal, fromage) plutôt que de les mélanger.
4. Vérifier les ingrédients cachés : gélatine, bouillon, vin, saindoux, présure.
5. Tenir compte du calendrier (ramadan, carême, fêtes) pour fixer les dates et les horaires.
6. Valoriser les plats et les savoir-faire des participants (stratégie d'**intégration** de Berry).

À vous de jouer – Exercice d'application 3.7

Un centre social prévoit un atelier « gratin de fin d'été » (pommes de terre, lardons, crème, emmental) un vendredi soir de mars. Parmi les 10 inscrits, 4 personnes ne mangent pas de porc, une famille est orthodoxe et une personne ne consomme aucun produit d'origine animale. a) Repérez les difficultés. b) Proposez une recette et une organisation adaptées. c) Quelle phrase utilisez-vous à l'inscription pour éviter ces difficultés ?

Corrigé

a) Les **lardons** excluent les personnes qui ne mangent pas de porc ; un vendredi de mars peut tomber en période de **carême** (jeûne orthodoxe sans produits animaux, abstinence de viande pour certains catholiques) ; la crème et l'emmental excluent la personne végétalienne ; le « gratin de fin d'été » est hors saison en mars. **b)** Un **gratin de légumes de saison et de pois chiches** à base de lait végétal et de chapelure, avec une petite portion gratinée au fromage préparée à part pour ceux qui le souhaitent ; aucun produit carné. **c)** « Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas, pour des raisons de santé, de religion ou de goût ? », posée à tous, sans demander de justification.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.3 – Représentations, normes, culture

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Définissez une représentation sociale et citez son auteur fondateur.
2. Nommez les deux processus de formation d'une représentation.

3. Distinguez noyau central et éléments périphériques.
4. Distinguez norme descriptive et norme injonctive, avec un exemple alimentaire.
5. Citez les quatre stratégies d'acculturation de Berry.
6. Qu'est-ce que l'ethnocentrisme ? Pourquoi est-il un risque pour le diététicien ?

Corrigé – Point d'étape 3.3.3

1. Une connaissance de sens commun, partagée par un groupe, socialement construite, qui guide les conduites (Serge Moscovici, 1961).
2. L'objectivation (rendre concret un concept abstrait) et l'ancrage (l'intégrer dans des catégories déjà connues).
3. Le noyau central est stable, consensuel, résistant et donne son sens à la représentation ; les éléments périphériques sont plus souples, liés au contexte, et changent en premier.
4. Descriptive : ce que font la plupart des gens (« 7 familles sur 10 servent des légumes le soir »). Injonctive : ce qu'il faut faire, ce qui est approuvé (« il faut manger des légumes »).
5. Intégration, assimilation, séparation, marginalisation.
6. Juger les pratiques des autres cultures à partir des normes de sa propre culture ; il conduit à des conseils inadaptés et à la perte de confiance du public.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.4 La relation sociale et ses dynamiques

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M5 S2 §1 (p. 35 et 36) ; Synthèse M5 S2 §2 (p. 36 à 38)

Le groupe et l'influence sociale

Définition – Groupe

Ensemble de personnes en **interaction**, qui partagent des objectifs, des normes et un sentiment d'appartenance, et dont les membres s'influencent mutuellement. Kurt Lewin (années 1940) a fondé l'étude de la **dynamique des groupes** : le groupe est un tout dont les propriétés dépassent la somme des individus.

Exemple – L'expérience fondatrice de Kurt Lewin (1943)

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les autorités américaines voulaient que les ménagères cuisinent des **abats** (moins chers, disponibles) à la place des morceaux nobles de viande. Lewin a comparé deux méthodes : des **conférences** persuasives données par un expert, et des **discussions de groupe** où les participantes échangeaient puis décidaient collectivement. Résultat : environ **3 %** des femmes ayant assisté aux conférences ont ensuite cuisiné des abats, contre environ **32 %** de celles qui avaient participé aux discussions de groupe et pris une décision publique. **Leçons pour le diététicien** : la **participation** et la **décision prise en groupe** (engagement) changent davantage les comportements que l'information descendante ; c'est le fondement de l'approche participative en éducation pour la santé (chapitre 1).

Phénomène	Définition	Application en atelier
Conformisme (Asch, 1951)	Tendance à aligner son jugement ou son comportement sur celui du groupe, même s'il paraît erroné	Un participant n'ose pas goûter si les autres refusent : faire goûter l'animateur et un « leader » positif en premier
Soumission à l'autorité (Milgram, 1963)	Tendance à obéir à une figure d'autorité	La blouse ou le statut de professionnel donnent du poids aux paroles : éviter l'injonction, privilégier l'échange
Influence minoritaire (Moscovici, 1969)	Une minorité cohérente et constante peut faire évoluer la majorité	Quelques parents convaincus peuvent faire évoluer les goûters de toute une classe
Facilitation sociale	On mange en moyenne davantage à plusieurs que seul	Repas partagés pour stimuler l'appétit des personnes âgées dénutries
Normes du groupe	Règles implicites partagées	Définir avec le groupe ses règles (bienveillance, droit de ne pas aimer, confidentialité)

Comment naît une norme de groupe : quatre expériences classiques

Le tableau précédent résume les grands phénomènes d'influence. Il est utile de connaître les expériences qui les ont mis en évidence, car le jury attend des références précises et datées.

Expérience	Ce qui a été fait	Résultat principal	Leçon pour l'atelier
Effet autocinétique (Muzafer Sherif, 1935)	Dans une pièce noire, un point lumineux fixe paraît bouger. Chacun estime d'abord seul le déplacement, puis en groupe.	Les estimations individuelles, très différentes au départ, convergent vers une **norme commune** qui persiste ensuite quand la personne est de nouveau seule.	Face à une situation nouvelle (un aliment inconnu), le groupe fabrique sa propre norme : les premiers avis exprimés comptent beaucoup.
Lignes de Solomon Asch (1951)	Un participant naïf doit dire quelle ligne a la même longueur qu'une ligne modèle, après plusieurs complices qui donnent une réponse fausse.	Environ un tiers des réponses suivent la majorité erronée, et environ trois participants sur quatre se conforment au moins une fois. Il suffit d'**un seul allié** qui donne la bonne réponse pour que le conformisme chute fortement.	Un seul participant qui ose dire « j'aime bien » ou « je goûte » libère les autres.
Facilitation sociale (Norman Triplett, 1898 ; Robert Zajonc, 1965)	Comparaison de performances réalisées seul ou en présence d'autres personnes.	La présence d'autrui améliore les tâches **simples et maîtrisées** et gêne les tâches **complexes ou nouvelles**.	Un geste culinaire nouveau s'apprend mieux en petit binôme que devant tout le groupe.
Apprentissage par observation (Albert Bandura, 1961 ; théorie de l'apprentissage social, 1977)	Des enfants observent un adulte qui frappe ou non une poupée, puis sont laissés seuls avec elle.	Les enfants reproduisent le comportement observé, surtout si le modèle leur ressemble ou est valorisé.	Le **modèle** (animateur, pair, parent) qui goûte et cuisine est un puissant levier.

Exemple – Manger à plusieurs : la facilitation sociale de la prise alimentaire

Le psychologue John de Castro a fait tenir des carnets alimentaires détaillés à des adultes pendant sept jours. Les repas pris avec d'autres personnes étaient en moyenne **44 % plus importants** que les repas pris seul (de Castro et Brewer, 1992), et la quantité augmentait avec le nombre de convives. Ce résultat a deux usages opposés :

- en **gériatrie** ou en EHPAD, le repas partagé est un outil contre la **dénutrition** (chapitre 4) : mieux vaut une table conviviale qu'un plateau en chambre quand c'est possible ;
- dans un atelier destiné à des adultes qui veulent mieux réguler leurs apports, on parle des repas de fête et des buffets sans culpabiliser, en travaillant les signaux de faim et de rassasiement.

Définition – Influence informationnelle et influence normative (Deutsch et Gerard, 1955)

- L'**influence informationnelle** : on suit le groupe parce qu'on pense qu'il a raison (« s'ils trouvent cela bon, c'est sûrement bon »). Elle est forte quand la situation est **ambiguë** ou nouvelle (expérience de Sherif). Elle produit un changement durable, même en privé.
- L'**influence normative** : on suit le groupe pour être accepté et éviter le rejet (expérience d'Asch). Elle produit surtout un changement **public**, qui peut disparaître quand la personne est seule.

Conséquence : une dégustation « parce que tout le monde goûte » (normative) change peu les habitudes à la maison ; une dégustation suivie d'un échange sur le goût et la recette (informationnelle) a plus de chances de durer.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.8

Lors d'un atelier en foyer de jeunes travailleurs, l'animatrice propose un houmous de pois chiches. Le premier jeune à qui elle tend la cuillère dit « Beurk, ça a l'air bizarre ». Les cinq suivants refusent aussi. a) Quel phénomène observe-t-on ? Citez l'expérience correspondante. b) Quel type d'influence domine ici ? c) Proposez deux façons d'organiser la dégustation pour limiter cet effet.

Corrigé

a) C'est un **conformisme** : les jeunes alignent leur comportement sur le premier avis exprimé (Asch, 1951 ; la première réponse fixe aussi une norme, comme chez Sherif, 1935). **b)** Surtout une **influence normative** : on refuse pour ne pas se démarquer devant les autres, plus que parce qu'on est convaincu que le houmous est mauvais. **c)** Faire goûter d'abord l'animatrice et un jeune volontaire connu pour être curieux (un **allié** suffit à réduire le conformisme) ; faire goûter **en même temps** et en silence, puis noter son avis sur une fiche avant d'en parler ; présenter le plat avec des repères familiers (pain pita, crudités à tremper).

Attitudes, dissonance cognitive et engagement

Définition – Dissonance cognitive (Leon Festinger, 1957)

État d'inconfort ressenti lorsqu'une personne a des cognitions (pensées, croyances, comportements) **contradictoires** (« je fume / fumer tue »). Pour réduire cet inconfort, elle modifie l'une des cognitions : changer son comportement… ou, plus souvent, **rationaliser** (« mon grand-père a fumé et a vécu vieux »). Les messages culpabilisants augmentent la dissonance et provoquent souvent le rejet du message.

Définition – Engagement (Kiesler, 1971 ; Joule et Beauvois, 1987)

Lien qui unit une personne à ses actes. Un acte réalisé **librement**, **publiquement**, de façon **répétée** et **coûteuse** engage davantage la personne et favorise le maintien du comportement. La technique du **pied-dans-la-porte** consiste à obtenir d'abord un petit acte (goûter une cuillère de lentilles) avant une demande plus importante (cuisiner une recette à la maison).

Lien diététique – Appliquer l'engagement en atelier

- Faire **choisir librement** une recette à refaire à la maison (« vous êtes libre de… » augmente l'engagement).
- Faire énoncer un petit **objectif personnel** devant le groupe (« je vais essayer les lentilles une fois cette semaine »).
- Revenir sur cet engagement à la séance suivante, en valorisant chaque essai.
- Rester **éthique** : ces techniques servent l'intérêt de la personne et ne doivent jamais manipuler ni

contraindre (chapitre 6).

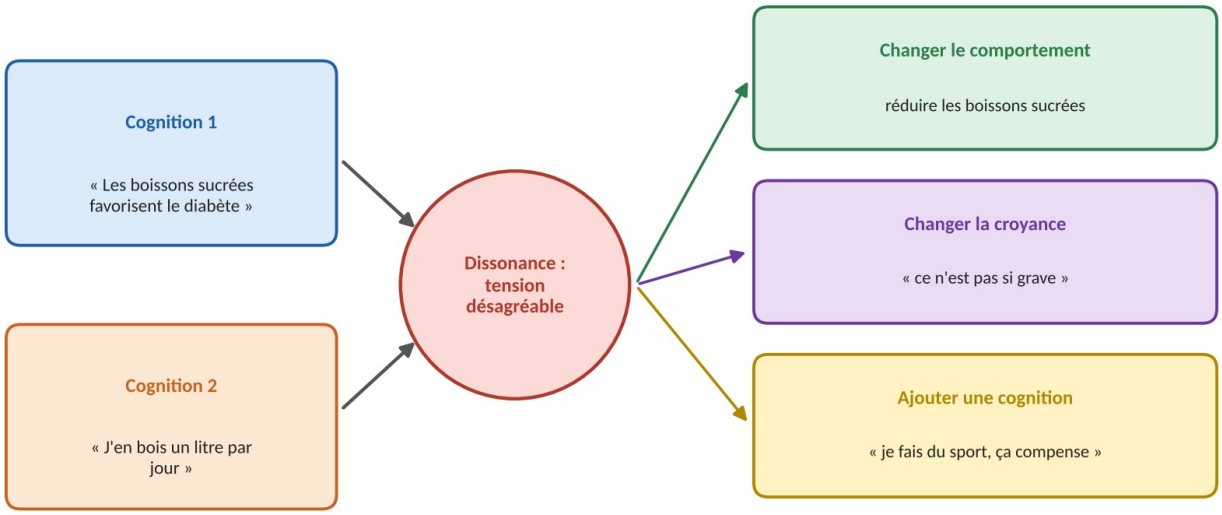


Figure 3.2 bis – La dissonance cognitive et ses trois issues

Comprendre le schéma – Figure 3.2 bis

1. À gauche, deux **cognitions** qui se contredisent : une connaissance (« les boissons sucrées favorisent le diabète ») et un comportement (« j'en bois un litre par jour »).
2. Au centre, la **dissonance** : un état d'inconfort désagréable que la personne cherche à réduire.
3. À droite, trois issues possibles : **changer le comportement** (réduire les boissons sucrées : la seule issue qui intéresse la santé publique), **changer la croyance** (« ce n'est pas si grave ») ou **ajouter une cognition** qui justifie (« je fais du sport, ça compense »).
4. Les deux dernières issues sont les plus faciles, donc les plus fréquentes : un message qui augmente fortement la dissonance sans donner de moyen d'agir pousse vers le déni plutôt que vers le changement.

Deux expériences fondatrices sur la dissonance et l'engagement

Exemple – L'expérience de Festinger et Carlsmith (1959)

Des étudiants réalisent pendant une heure une tâche très ennuyeuse (tourner des chevilles sur une planche). On leur demande ensuite de dire à l'étudiant suivant que la tâche était intéressante. Certains reçoivent **1 dollar** pour ce mensonge, d'autres **20 dollars**. Interrogés ensuite, ceux qui ont reçu 1 dollar jugent la tâche **plus agréable** que ceux qui ont reçu 20 dollars et que les étudiants d'un groupe témoin.

Explication : avec 20 dollars, le mensonge est justifié par l'argent ; avec 1 dollar, il ne l'est pas, et la seule façon de réduire la dissonance est de changer d'avis sur la tâche. **Leçon** : une petite incitation, ou aucune, engage davantage qu'une grosse récompense ; c'est un argument de plus contre les récompenses en éducation nutritionnelle (section 3.3.11).

Exemple – Le pied-dans-la-porte (Freedman et Fraser, 1966)

Des chercheurs demandent à des propriétaires californiens d'installer dans leur jardin un grand panneau peu esthétique « Conduisez prudemment ». Sans préparation, **16,7 %** acceptent (groupe témoin). Dans un autre groupe, on avait demandé deux semaines plus tôt de coller un petit autocollant sur le même thème, ce que presque tous avaient accepté. Dans ce groupe, **76 %** acceptent ensuite le grand panneau.

Leçon : obtenir d'abord un petit acte, librement consenti, rend plus probable un acte plus important. En

atelier, on demande d'abord de goûter une cuillère, puis de choisir une recette à refaire.

Technique d'engagement	Principe	Exemple éthique en nutrition
Pied-dans-la-porte	Un petit acte préalable facilite une demande plus coûteuse.	Goûter une cuillère de soupe de légumes, puis noter la recette pour la refaire.
Porte-au-nez (Cialdini et collaborateurs, 1975)	Après le refus d'une demande excessive, une demande modérée est plus souvent acceptée (dans l'expérience originale, 50 % contre 16,7 % sans demande préalable).	« Vous pourriez cuisiner tous les soirs ? Non ? Alors une fois cette semaine ? » À utiliser avec prudence : la première demande ne doit pas être culpabilisante.
Déclaration de liberté (« vous êtes libre de… »)	Rappeler la liberté de refuser augmente l'acceptation et l'engagement.	« Vous êtes libre de goûter ou non. »
Engagement public	Un engagement annoncé devant d'autres est mieux tenu qu'un engagement privé.	Chacun dit au groupe le petit changement qu'il essaiera.
Communication engageante (Joule, Girandola et Bernard, 2007)	Associer un message de prévention à un **acte** préparatoire (signer, choisir, essayer) plutôt qu'au message seul.	Après l'exposé sur l'eau, chaque élève remplit sa gourde et la décore.

Définition – Amorçage

L'**amorçage** est l'effet d'un premier stimulus, souvent non remarqué, sur une réaction qui suit. Une affiche colorée de légumes à l'entrée du self, l'odeur du pain chaud ou la place d'un produit au début de la ligne de service peuvent orienter les choix sans que la personne s'en rende compte. C'est la base de nombreux **nudges** (section 3.3.11 et chapitre 6). Les effets d'amorçage sont souvent plus faibles et moins reproductibles qu'on ne l'a cru : on les évalue toujours sur le terrain.

Attention – Engager sans manipuler

Les techniques d'engagement sont puissantes. Elles sont éthiques si elles servent l'**intérêt de la personne**, si l'objectif est **transparent** (la personne pourrait l'accepter si on le lui expliquait) et si la personne garde sa **liberté** de refuser. Elles deviennent de la manipulation quand elles servent un intérêt commercial ou institutionnel caché, ou quand on exploite la honte et la peur (chapitre 6).

À vous de jouer – Exercice d'application 3.9

Un collège veut que les élèves boivent davantage d'eau. Le principal propose de distribuer un bon d'achat de 10 € aux élèves qui viennent avec une gourde pendant un mois. a) Que prévoit la théorie de la dissonance sur l'effet à long terme de cette récompense ? b) Proposez une action fondée sur l'engagement à la place. c) À quelles conditions cette action reste-t-elle éthique ?

Corrigé

a) La récompense importante fournit une **justification externe** (« je prends ma gourde pour le bon d'achat ») : comme dans l'expérience de Festinger et Carlsmith, l'attitude envers l'eau change peu, et le comportement risque de s'arrêter avec la récompense. **b)** Un **pied-dans-la-porte** : chaque élève choisit et décore librement sa gourde en classe (petit acte, libre, public), puis le groupe décide d'un défi « une gourde pleine par jour » avec un suivi collectif ; on rappelle la liberté de participer. **c)** L'objectif est connu des élèves

> et de leurs familles, la participation est libre, aucun élève n'est montré du doigt, et l'action sert leur santé (pas une marque d'eau).

Stéréotypes, préjugés, discrimination, stigmatisation

- **Stéréotype** : croyance généralisée sur les caractéristiques d'un groupe (« les personnes obèses manquent de volonté »).
- **Préjugé** : attitude (souvent négative) envers les membres d'un groupe.
- **Discrimination** : comportement défavorable envers une personne en raison de son appartenance réelle ou supposée à un groupe (interdite par la loi pour plus de 25 critères, dont l'apparence physique).
- **Stigmatisation** (Erving Goffman, 1963) : processus par lequel une caractéristique (le poids, la pauvreté, l'origine) disqualifie la personne et la réduit à cet attribut. La **stigmatisation du poids** augmente le stress, l'évitement des soins, les comportements alimentaires désordonnés et la prise de poids.

Juger autrui : théories implicites, fonctions des stéréotypes et des préjugés

- Les **théories implicites de la personnalité** (TIP), décrites par Jerome Bruner et Renato Tagiuri (1954), sont les croyances « naïves » qui nous font déduire la personnalité d'une personne à partir de quelques indices (« il est gros, donc il manque de volonté »). Elles ne sont pas vérifiées scientifiquement.
- Les **stéréotypes** ont trois fonctions : **expliquer** un événement (en désignant un groupe responsable), **justifier** un comportement envers ce groupe, **anticiper** ce que l'autre va faire.
- Les **préjugés** ont trois fonctions : **différencier** son groupe des autres, **économiser** l'effort de réflexion, **rationaliser** en servant de norme au groupe.
- La **discrimination** est le comportement qui en découle (Myers et Lamarche) : traiter différemment une personne à cause de son groupe. En droit français, elle est interdite pour plus de vingt critères, dont l'apparence physique et l'état de santé (article 225-1 du Code pénal).

Communiquer : modèle, distances, états du moi et rumeurs

- **Modèle de Shannon et Weaver (1949)** : un émetteur code un message, qui passe par un canal jusqu'à un récepteur qui le décode ; des **bruits** peuvent le déformer. Le schéma de la communication de la section 3.3.8 le complète par la rétroaction.
- **Trois images** guident notre façon d'entrer en relation : le **moi intime** (ce que je pense être), le **moi public** (ce que je veux montrer) et la **représentation d'autrui** (l'image que j'ai de l'autre).
- **Proxémie** (Edward T. Hall, 1966) : chacun règle la distance selon la relation. Repères : distance **intime** (moins de 45 cm), **personnelle** (45 cm à 1,2 m), **sociale** (1,2 à 3,6 m), **publique** (au-delà de 3,6 m). La **place** occupée compte aussi : face à face (confrontation), côte à côte (coopération).
- **Analyse transactionnelle** (Eric Berne, années 1960) : chaque personne passe par trois **états du moi**, **Parent** (règles, protection), **Adulte** (faits, raisonnement), **Enfant** (émotions, spontanéité). Un conseil donné sur le ton du Parent (« vous devez ») appelle souvent une réponse de l'Enfant (révolte ou soumission) ; l'entretien éducatif vise un échange Adulte-Adulte.
- **Rumeurs** : Gordon Allport et Leo Postman (1947) ont montré qu'un récit transmis de bouche à oreille perd la plupart de ses détails après cinq ou six personnes. Trois mécanismes le déforment : la **réduction** (on oublie), l'**accentuation** (on grossit certains détails) et l'**assimilation** (on adapte le récit à ses attentes et à ses stéréotypes). Une rumeur réussit quand l'information est frappante, la source jugée crédible et le démenti difficile.

> **À vous de jouer – Exercice d'application 3.10**
>
> Dans un collège, une rumeur circule : « La viande de la cantine est périmée ; un élève a été malade. » La fréquentation baisse de 412 à 338 repas par jour. a) Calculez la baisse en nombre et en pourcentage. b) Nommez deux mécanismes de déformation probables. c) Proposez une réponse de la diététicienne.

Corrigé

a) 412 − 338 = **74 repas** ; 74 / 412 × 100 = **18,0 %** de baisse. b) **Accentuation** (un malaise isolé devient « la viande périmée ») et **assimilation** (le récit confirme le stéréotype « la cantine, c'est mauvais »). c) Ne pas nier en bloc, ce qui renforcerait la rumeur ; donner des **faits vérifiables** (traçabilité, dates limites, résultats du dernier contrôle), inviter des parents et des délégués à visiter la cuisine, faire goûter, et s'appuyer sur des **élèves relais** crédibles pour leurs pairs.

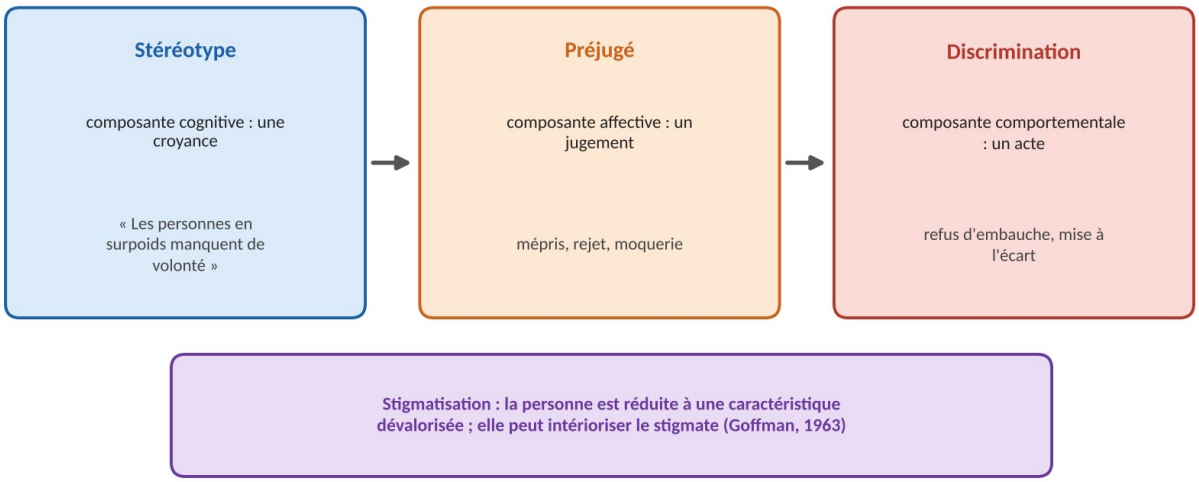


Figure 3.2 ter – Du stéréotype à la discrimination

Comprendre le schéma – Figure 3.2 ter

1. Le **stéréotype** est une **croyance** : il relève de la pensée (« les personnes en surpoids ne font pas d'efforts »).
2. Le **préjugé** est une **attitude**, chargée d'émotion : il relève du jugement (« elles m'agacent », mépris, gêne).
3. La **discrimination** est un **comportement** : traiter moins bien une personne à cause de son appartenance réelle ou supposée à un groupe (ne pas l'embaucher, lui parler avec condescendance, ne pas l'examiner).
4. En bas, la **stigmatisation** englobe tout le processus : la personne est réduite à une caractéristique dévalorisée, et elle peut finir par **intérioriser le stigmate** (Goffman, 1963), c'est-à-dire se dévaloriser elle-même. Le stigmate s'installe aussi dans les institutions (mobilier inadapté, messages de campagne humiliants).
5. Les flèches ne sont pas automatiques : on peut connaître un stéréotype sans y adhérer, et le cadre professionnel (déontologie, formation) peut empêcher le passage au comportement.

La menace du stéréotype

Exemple – Steele et Aronson (1995)

Des étudiants afro-américains et blancs de l'université Stanford passent un test difficile de compréhension verbale. Quand le test est présenté comme une mesure des **capacités intellectuelles**, les étudiants afro-américains réussissent moins bien que les étudiants blancs de même niveau. Quand le **même test** est présenté comme un simple exercice de laboratoire, l'écart disparaît.

Explication : la peur de confirmer un stéréotype négatif sur son groupe crée une anxiété qui diminue la performance. Le même effet a été observé chez des femmes dans des tests de mathématiques (Spencer, Steele et Quinn, 1999).

En nutrition : une personne en surpoids, à qui l'on rappelle sans cesse qu'elle « manque de volonté », peut se sentir incapable dans un atelier culinaire ou une activité physique, et éviter d'y revenir. Un cadre qui ne

renvoie pas au poids protège la participation.

À retenir – Les effets de la stigmatisation du poids

Les revues de la littérature (Puhl et Heuer, 2009 et 2010) montrent que la stigmatisation du poids est répandue, y compris chez les professionnels de santé. Elle ne motive pas à perdre du poids : elle est associée à plus de stress, à une alimentation émotionnelle et à des épisodes d'hyperphagie, à moins d'activité physique, à un **évitement des soins** (rendez-vous annulés, dépistages repoussés) et à une moins bonne estime de soi. Une déclaration internationale de consensus, publiée en 2020 dans *Nature Medicine* (Rubino et collaborateurs), appelle les professionnels et les médias à y mettre fin.

Les biais implicites : les professionnels aussi

Définition – Attitude implicite et test d'association implicite

Une **attitude implicite** est une évaluation automatique, souvent inconsciente, qui peut différer de ce que la personne déclare penser. Le **test d'association implicite** (Greenwald, McGhee et Schwartz, 1998) la mesure à partir des temps de réaction : on associe plus vite deux notions qui sont déjà liées dans la mémoire (par exemple « mince » et « bon »). Une étude menée auprès de près de 400 professionnels spécialistes de l'obésité (Schwartz et collaborateurs, 2003) a montré qu'eux aussi associaient plus facilement les personnes obèses à des adjectifs comme « paresseux » ou « sans valeur ».

Lien diététique – Que faire de ses propres biais ?

Avoir des biais ne fait pas de quelqu'un un mauvais professionnel : ils viennent de la socialisation et des images diffusées par la société. Ce qui compte, c'est de les **connaître** et d'empêcher qu'ils guident les pratiques : utiliser une grille d'entretien identique pour tous, vérifier son langage et ses supports (méthode ci-dessous), s'interroger après une séance difficile (« aurais-je réagi de la même façon avec une autre personne ? »), en parler en analyse de pratiques.

Méthode pas à pas – Vérifier qu'une action ne stigmatise pas

1. **Langage** : dire « une personne vivant avec une obésité » plutôt qu'« un obèse » ; éviter « combat », « lutte contre les kilos », « mauvais aliments ».
2. **Images** : refuser les photos de corps sans tête, de ventres ou de personnes en train de manger seules de la malbouffe ; préférer des personnes de toutes corpulences en activité.
3. **Cible du message** : parler de comportements favorables (cuisiner, bouger, partager un repas) et de leurs bénéfices immédiats, pas du poids.
4. **Environnement** : prévoir des chaises sans accoudoirs et solides, un tablier de grande taille, ne pas peser en public.
5. **Recrutement** : proposer l'action à tous plutôt qu'aux seules « personnes en surpoids » (universalisme proportionné, chapitre 2).
6. **Relecture** : faire relire le support par des personnes concernées avant de le diffuser.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.11

Une mairie prépare une affiche pour un cycle d'ateliers : la photo montre le ventre d'un homme en surpoids qui tient un hamburger, avec le titre « Stop à la malbouffe : reprenez le contrôle de votre poids ! ». a) Relevez trois éléments stigmatisants. b) Expliquez, avec la notion de menace du stéréotype, pourquoi cette affiche risque d'éloigner le public visé. c) Proposez un nouveau titre et une nouvelle image.

Corrigé

a) Un corps **sans tête** réduit la personne à son ventre ; l'association surpoids et « malbouffe » renforce le **stéréotype** de la personne qui mange mal par manque de volonté ; le titre culpabilise (« reprenez le contrôle ») et centre sur le **poids**. **b)** Les personnes concernées se sentent visées et jugées ; la peur de confirmer le stéréotype devant le groupe crée une anxiété qui les dissuade de s'inscrire, ou de revenir après une première séance. **c)** Par exemple « Cuisiner simple, bon et pas cher : venez essayer ! » avec une photo d'un groupe varié (âges, corpulences, origines) en train de cuisiner ensemble.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.4 – Influence sociale, engagement, stigmatisation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel a été le résultat principal de l'expérience de Lewin (1943) ?
2. Qu'a montré Asch (1951) ? Quel facteur fait chuter le conformisme ?
3. Distinguez influence informationnelle et influence normative.
4. Expliquez le résultat de Festinger et Carlsmith (1959).
5. Décrivez la technique du pied-dans-la-porte avec les chiffres de Freedman et Fraser (1966).
6. Distinguez stéréotype, préjugé et discrimination.

Corrigé – Point d'étape 3.3.4

1. Environ 3 % des femmes ayant assisté aux conférences ont cuisiné des abats, contre environ 32 % après une discussion et une décision de groupe.
2. Environ un tiers des réponses suivent une majorité qui se trompe ; la présence d'un seul allié qui donne la bonne réponse fait fortement chuter le conformisme.
3. Informationnelle : on suit le groupe parce qu'on pense qu'il a raison ; changement durable. Normative : on le suit pour être accepté ; changement surtout public.
4. Les étudiants payés 1 dollar pour mentir ont jugé la tâche plus agréable que ceux payés 20 dollars : sans justification externe, ils ont réduit la dissonance en changeant d'avis.
5. Obtenir d'abord un petit acte (un autocollant) rend plus probable un acte plus coûteux : 76 % ont accepté le grand panneau, contre 16,7 % sans demande préalable.
6. Stéréotype : une croyance sur un groupe ; préjugé : une attitude, un jugement affectif ; discrimination : un comportement défavorable.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.5 Les compétences psychosociales

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Définition – Compétences psychosociales (CPS)

Selon Santé publique France (2022), les CPS sont « un ensemble cohérent et interrelié de capacités psychologiques (cognitives, émotionnelles et sociales), impliquant des connaissances, des processus intrapsychiques et des comportements spécifiques, qui permettent d'augmenter l'autonomisation et le

pouvoir d'agir, de maintenir un état de bien-être psychique, de favoriser un fonctionnement individuel optimal et de développer des interactions constructives ». L'OMS les avait définies en 1993 comme la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne, et en avait proposé une liste de 10 (en 5 couples).

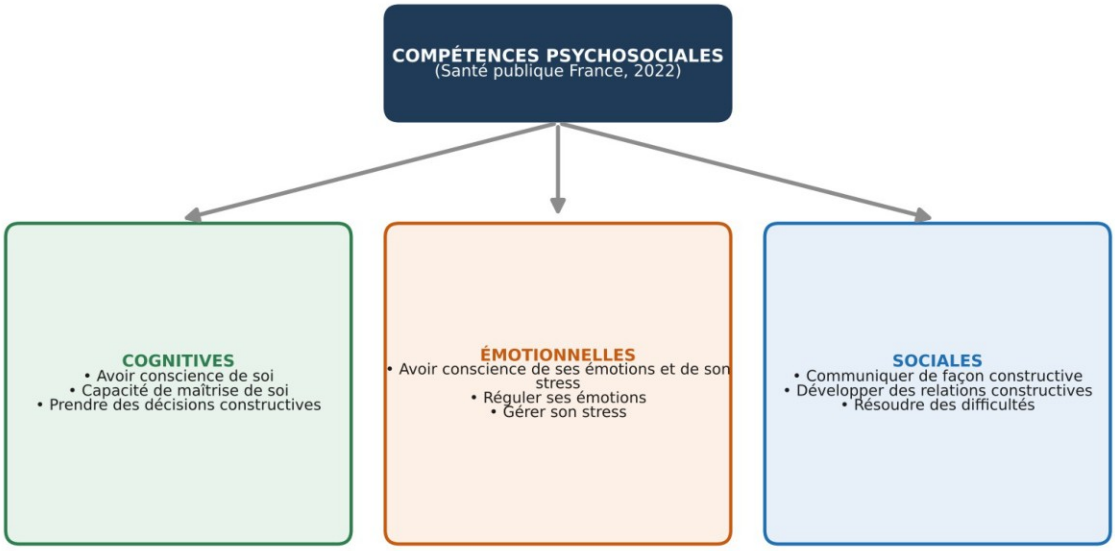


Figure 3.3 – Les 9 compétences psychosociales générales (Santé publique France, 2022)

Comprendre le schéma – Figure 3.3

1. Le référentiel de Santé publique France organise les CPS en **trois catégories**, chacune comportant **trois CPS générales**, elles-mêmes déclinées en CPS spécifiques (une vingtaine au total).

2. **Cognitives** : avoir conscience de soi (connaissance de soi, pensée critique), capacité de maîtrise de soi, prendre des décisions constructives.

3. **Émotionnelles** : avoir conscience de ses émotions et de son stress, réguler ses émotions, gérer son stress.

4. **Sociales** : communiquer de façon constructive (écoute empathique, communication efficace), développer des relations constructives, résoudre des difficultés (demander de l'aide, résoudre des conflits).

5. Les CPS sont un **déterminant majeur** de la santé et du bien-être ; leur développement chez les enfants et les jeunes est une priorité nationale (stratégie interministérielle 2022-2037). Les programmes efficaces sont **structurés**, **interactifs**, **répétés** et animés par des professionnels formés.

CPS	Exemple d'activité en lien avec l'alimentation
Pensée critique	Analyser une publicité pour un produit sucré destiné aux enfants : que cherche-t-elle à me faire croire ?
Prise de décision	Composer un menu à 10 € pour 4 personnes en arbitrant goût, prix et équilibre
Conscience et régulation des émotions	Repérer la différence entre faim physique et envie de manger liée à l'ennui ou au stress ; échelle de la faim
Gestion du stress	Proposer d'autres réponses que la nourriture au stress (respiration, marche, parler à quelqu'un)
Communication constructive	Jeu de rôle : dire non poliment à une seconde portion ou à un soda proposé par un ami
Relations constructives	Cuisiner en binôme, répartir les tâches, s'entraider

CPS	Exemple d'activité en lien avec l'alimentation
Estime de soi (conscience de soi)	Valoriser chaque réussite culinaire ; photographier et exposer les plats réalisés (avec accord)

De la liste de l'OMS (1993) au référentiel de Santé publique France (2022)

La première liste de compétences psychosociales a été publiée par l'OMS en 1993, dans un document destiné aux écoles (*Life skills education in schools*). Elle comptait **10 compétences regroupées en 5 couples**. Elle est encore très citée dans les projets et dans les sujets d'examen : il faut savoir la relier au référentiel actuel.

Couple de CPS (OMS, 1993)	Correspondance dans le référentiel de Santé publique France (2022)
Savoir résoudre des problèmes / savoir prendre des décisions	Compétences cognitives : prendre des décisions constructives ; compétences sociales : résoudre des difficultés
Avoir une pensée créative / avoir une pensée critique	Compétences cognitives : avoir conscience de soi (pensée critique)
Savoir communiquer efficacement / être habile dans les relations interpersonnelles	Compétences sociales : communiquer de façon constructive, développer des relations constructives
Avoir conscience de soi / avoir de l'empathie pour les autres	Compétences cognitives : avoir conscience de soi ; compétences sociales : écoute empathique
Savoir gérer son stress / savoir gérer ses émotions	Compétences émotionnelles : avoir conscience de ses émotions et de son stress, réguler ses émotions, gérer son stress

À retenir – Pourquoi un nouveau référentiel en 2022 ?

Santé publique France a actualisé la liste de l'OMS à partir des connaissances scientifiques récentes. Le référentiel de 2022 distingue trois **catégories** (cognitives, émotionnelles, sociales), **9 CPS générales** et des CPS **spécifiques**. Il insiste sur le fait que les CPS se renforcent entre elles et qu'elles s'apprennent tout au long de la vie. Une **instruction interministérielle du 19 août 2022** fixe l'objectif que toute une génération d'enfants bénéficie d'interventions de développement des CPS d'ici 2037.

Ce qui rend un programme CPS efficace

Une méta-analyse de 213 programmes scolaires de développement des compétences sociales et émotionnelles (Durlak et collaborateurs, 2011), portant sur plus de 270 000 élèves, a montré une amélioration des compétences, des comportements et même des résultats scolaires. Les programmes efficaces respectaient quatre critères, résumés par l'acronyme anglais **SAFE**.

Critère SAFE	Signification	Traduction pour une action nutrition
Sequenced (séquencé)	Des activités organisées en progression, de séance en séance	Un cycle de 8 à 10 séances, chacune s'appuyant sur la précédente, plutôt qu'une intervention isolée
Active (actif)	Des méthodes où l'on pratique	Jeux de rôle, cuisine, analyse de publicités, plutôt qu'un exposé
Focused (centré)	Un temps suffisant consacré à chaque compétence	Une ou deux CPS ciblées par séance, explicitement travaillées
Explicit (explicite)	Des objectifs de compétence clairs et annoncés	« Aujourd'hui, nous apprenons à dire non à une proposition sans vexer la personne. »

Des programmes validés utilisés en France

Programme	Public	Principe
PSFP (Programme de soutien aux familles et à la parentalité)	Familles avec enfants de 3 à 11 ans	Adaptation française d'un programme américain (*Strengthening Families Program*) : 14 séances réunissant parents et enfants, d'abord séparément puis ensemble
GBG (*Good Behavior Game*, jeu du comportement favorable)	Élèves d'école élémentaire	Jeu d'équipe en classe qui renforce les comportements favorables et l'autorégulation
Unplugged	Collégiens de 12 à 14 ans	12 séances interactives de prévention des conduites addictives, centrées sur les CPS et la correction des fausses croyances sur les normes (« tout le monde boit »)
Tina et Toni	Enfants de 4 à 6 ans	Programme d'origine suisse fondé sur des histoires et des jeux autour des émotions et des relations

Lien diététique – Place du diététicien

Ces programmes ne sont pas centrés sur l'alimentation, mais ils montrent ce qui marche : durée, interactivité, formation des intervenants. Le diététicien peut s'associer à un programme CPS existant dans une école ou un centre social, en y apportant des séances sur le goût, le marketing alimentaire ou le repas familial, plutôt que de créer une intervention isolée.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.12

Une infirmière scolaire propose au diététicien une intervention unique d'une heure en classe de 5e, sous forme d'exposé sur « les dangers du sucre », pour « développer les compétences psychosociales ». a) Montrez, à l'aide des critères SAFE, que ce projet n'est pas une action CPS. b) Proposez une version améliorée en trois séances, en indiquant pour chacune la CPS visée et une activité.

Corrigé

a) Une séance unique n'est pas **séquencée** ; un exposé n'est pas **actif** ; aucune compétence n'est ciblée (**F**) ni annoncée (**E**) : c'est une action d'information. **b)** Séance 1, **pensée critique** : analyser en groupe trois publicités pour des boissons sucrées (cible, promesse, ce qui est caché). Séance 2, **prise de décision** : composer un goûter avec un budget de 1,50 € et justifier le choix devant la classe. Séance 3, **communication constructive** : jeux de rôle « refuser une boisson énergisante proposée par un ami » et retour sur les ressentis. Chaque séance commence par l'annonce de la compétence travaillée et se termine par un temps de retour.

3.3.6 Image corporelle, émotions, estime de soi

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Définition – Image corporelle

Représentation mentale que l'on se fait de son propre corps : perception (taille, forme), pensées et croyances, émotions qu'il suscite, et comportements qui en découlent. L'**insatisfaction corporelle** est l'écart entre le corps perçu et le corps idéal ; elle est fréquente dès l'enfance, influencée par les normes de minceur ou de muscularité diffusées par les médias et les réseaux sociaux, et constitue un **facteur de risque** de restrictions alimentaires, de régimes répétés et de troubles du comportement alimentaire (TCA).

Définition – Émotions

Réactions brèves et intenses à une situation, associant des manifestations physiologiques, des expressions et des tendances à l'action. Paul Ekman décrit six émotions de base universelles : joie, tristesse, colère, peur, dégoût, surprise. Le **dégoût** joue un rôle central dans les refus alimentaires ; la **peur** de la nouveauté dans la néophobie. L'**alimentation émotionnelle** désigne le fait de manger en réponse à des émotions plutôt qu'à la faim.

Définition – Estime de soi et confiance en soi

- L'**estime de soi** est la valeur qu'une personne s'attribue (Rosenberg, 1965) ; elle conditionne la capacité à prendre soin de soi.
- La **confiance en soi** porte sur la capacité perçue à agir ; elle est proche du **sentiment d'efficacité personnelle** de Bandura (« je suis capable de cuisiner ce plat »).

Attention – Prévenir sans nuire

- Ne jamais **peser** ni commenter le corps des participants en public.
- Éviter les messages centrés sur le **poids** et l'apparence ; centrer sur la santé, le plaisir, l'énergie, la convivialité.
- Ne pas présenter d'aliments comme « interdits » ou « mauvais » : cela renforce la culpabilité et les restrictions.
- Repérer les signes d'alerte de TCA (restriction importante, préoccupation excessive pour le poids, vomissements, hyperphagie) et **orienter** vers le médecin ou une structure spécialisée (BC1), sans poser de diagnostic.

Évaluer l'image du corps et l'estime de soi : deux outils

Dans un diagnostic ou une évaluation, on peut mesurer l'image du corps et l'estime de soi avec des outils validés. Le diététicien ne pose aucun diagnostic psychologique : il utilise ces outils pour **décrire un groupe** et adapter l'action, avec l'accord des personnes et de façon anonyme.

Définition – L'échelle des silhouettes (Stunkard, Sørensen et Schulsinger, 1983)

Neuf dessins de silhouettes, de la plus mince (1) à la plus corpulente (9). La personne indique la silhouette qui lui ressemble le plus (silhouette **perçue**) et celle qu'elle aimerait avoir (silhouette **idéale**). L'écart **perçue moins idéale** mesure l'insatisfaction : un écart positif signale un désir de minceur, un écart négatif un désir d'être plus fort ou plus musclé (fréquent chez les garçons), un écart nul l'absence d'insatisfaction.

Calcul détaillé – L'insatisfaction corporelle dans une classe de 3e (données fictives, 24 élèves)

Écart perçue − idéale	Filles (n = 12)	Garçons (n = 12)
−2	0	2
−1	1	4
0	3	4
+1	5	2
+2	3	0

- Filles insatisfaites (écart différent de 0) : 12 − 3 = 9, soit 9 / 12 = **75,0 %** ; dont désir de minceur : 5 + 3 = 8,

soit **66,7 %**.

- Garçons insatisfaits : 12 − 4 = 8, soit **66,7 %** ; dont désir d'être plus fort : 2 + 4 = 6, soit **50,0 %**.
- Écart moyen des filles : (−1 × 1 + 0 × 3 + 1 × 5 + 2 × 3) / 12 = (−1 + 0 + 5 + 6) / 12 = 10 / 12 = **+0,83**.
- Écart moyen des garçons : (−2 × 2 − 1 × 4 + 0 × 4 + 1 × 2) / 12 = (−4 − 4 + 0 + 2) / 12 = −6 / 12 = **−0,50**.

Lecture : l'insatisfaction concerne les deux sexes, mais dans des directions opposées. Une moyenne proche de zéro peut cacher des insatisfactions fortes dans les deux sens : il faut toujours regarder la **répartition**. Les actions porteront sur la diversité des corps et la critique des images des réseaux sociaux, pour les filles comme pour les garçons, sans parler de poids.

Définition – L'échelle d'estime de soi de Rosenberg (1965)

Dix affirmations, cotées de 1 (« tout à fait en désaccord ») à 4 (« tout à fait en accord »). Cinq affirmations sont positives (« Je pense que je possède un certain nombre de belles qualités ») et cinq négatives (« J'aimerais avoir plus de respect pour moi-même »). Les affirmations négatives sont **inversées** (score inversé = 5 − réponse). Le score total va de **10 à 40** : plus il est élevé, plus l'estime de soi est forte. L'échelle existe en version française validée (Vallières et Vallerand, 1990).

Calcul détaillé – Le score d'estime de soi de Lina, 15 ans

Réponses aux 5 items positifs : 3, 2, 3, 2, 3 ; total = **13**.

Réponses aux 5 items négatifs : 3, 4, 2, 3, 3 ; scores inversés : 5 − 3 = 2 ; 5 − 4 = 1 ; 5 − 2 = 3 ; 5 − 3 = 2 ; 5 − 3 = 2 ; total = **10**.

Score total : 13 + 10 = **23 sur 40**, soit, ramené sur 100 : (23 − 10) / (40 − 10) × 100 = 13 / 30 × 100 = **43 / 100**.

Lecture : estime de soi plutôt basse. Le score ne sert pas à « étiqueter » Lina : il aide l'équipe à prévoir des activités valorisantes. Un score très bas associé à d'autres signes (isolement, restriction alimentaire) justifie d'en parler à l'infirmière ou au psychologue scolaire.

Repérer les signaux d'alerte de troubles du comportement alimentaire

Méthode pas à pas – Le questionnaire SCOFF-F

Le questionnaire SCOFF (Morgan et collaborateurs, 1999), validé en français sous le nom de SCOFF-F, est cité par la HAS (recommandation sur l'anorexie mentale, 2010) comme outil de **repérage**. Il comporte cinq questions fermées :

1. Vous faites-vous vomir parce que vous vous sentez mal d'avoir trop mangé ?
2. Vous inquiétez-vous d'avoir perdu le contrôle de ce que vous mangez ?
3. Avez-vous récemment perdu plus de 6 kg en 3 mois ?
4. Pensez-vous que vous êtes gros(se) alors que d'autres vous trouvent trop mince ?
5. Diriez-vous que la nourriture domine votre vie ?

Deux réponses positives ou plus font suspecter un TCA. Le repérage est suivi d'une **orientation** vers le médecin traitant ou une structure spécialisée ; il ne s'agit jamais d'un diagnostic.

Attention – En action collective

On ne fait pas remplir de questionnaire de repérage des TCA dans un atelier collectif sans cadre médical, sans information des personnes et sans circuit d'orientation prévu. En action collective, le diététicien observe, écoute et oriente individuellement et discrètement si une personne l'inquiète.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.13

Dans un groupe de 10 lycéennes, les écarts silhouette perçue moins silhouette idéale sont : +2, +1, 0, +3, +1, +2, 0, +1, +2, +1. a) Calculez le pourcentage de jeunes filles qui souhaitent être plus minces et l'écart moyen. b) Une élève (écart +3) dit qu'elle saute le dîner depuis deux mois. Que faites-vous ? c) Proposez un thème d'atelier adapté au groupe.

Corrigé

a) Écarts positifs : 8 sur 10, soit **80 %**. Écart moyen : (2 + 1 + 0 + 3 + 1 + 2 + 0 + 1 + 2 + 1) / 10 = 13 / 10 = **+1,3**. **b)** Écouter sans juger, ne pas commenter son poids, lui dire que l'on s'inquiète pour elle et l'**orienter** vers l'infirmière scolaire ou le médecin, en respectant la confidentialité ; prévenir l'infirmière selon les règles de l'établissement. **c)** Un atelier sur les images retouchées et les réseaux sociaux (pensée critique), suivi d'un atelier « petit-déjeuner et énergie » centré sur le plaisir et la performance scolaire, sans aucune référence au poids.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.5 et 3.3.6 – Compétences psychosociales, image du corps, estime de soi

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les trois catégories de CPS du référentiel de Santé publique France (2022) et le nombre de CPS générales.
2. Que signifie l'acronyme SAFE ?
3. Comment calcule-t-on l'insatisfaction corporelle avec l'échelle de Stunkard ?
4. Quelle est l'étendue du score de l'échelle de Rosenberg ? Comment traite-t-on les items négatifs ?
5. Combien de réponses positives au SCOFF-F font suspecter un TCA ? Que fait-on ensuite ?
6. Citez deux règles pour « prévenir sans nuire » en atelier.

Corrigé – Point d'étape 3.3.5 et 3.3.6

1. Cognitives, émotionnelles, sociales ; 9 CPS générales (3 par catégorie).
2. Séquencé, actif, centré, explicite (*Sequenced*, *Active*, *Focused*, *Explicit*) : critères des programmes efficaces (Durlak, 2011).
3. Silhouette perçue moins silhouette idéale : un écart positif traduit un désir de minceur, un écart négatif un désir d'être plus fort.
4. De 10 à 40 ; les items négatifs sont inversés (5 − réponse) avant l'addition.
5. Deux ou plus ; on oriente vers le médecin ou une structure spécialisée, sans poser de diagnostic.
6. Ne jamais peser ni commenter le corps en public ; centrer sur la santé, le plaisir et la convivialité ; ne pas parler d'aliments interdits ; repérer et orienter.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.7 Connaître les publics et comprendre le changement de comportement

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M5 S2 §3 (p. 38 et 39)

Les spécificités des publics

Public	Caractéristiques	Adaptations de l'action
Jeunes enfants (2-6 ans)	Néophobie alimentaire maximale ; apprentissage par l'imitation et l'exposition répétée ; pensée concrète	Jeux sensoriels, manipulations, expositions répétées sans forcer, implication des parents
Enfants (6-11 ans)	Curiosité, goût du défi, influence de l'école et des pairs, sensibilité à la publicité	Ateliers pratiques, quiz, défis, classes du goût, projets de classe
Adolescents	Construction de l'identité, influence des pairs et des réseaux, autonomie, préoccupations corporelles	Pairs ambassadeurs, débats, réseaux sociaux, respect de l'autonomie, prévention de la stigmatisation
Adultes	Contraintes (temps, budget, travail), habitudes installées, rôle de « nourricier » pour la famille	Solutions concrètes et rapides, partage d'expériences, valorisation des savoir-faire
Personnes âgées	Baisse de l'appétit et du goût, isolement, troubles de la mastication, habitudes anciennes, peur de la maladie	Convivialité, repas partagés, textures adaptées, réminiscence, rythme lent, gros caractères
Personnes en précarité	Contraintes budgétaires, stress, parfois honte, défiance envers les institutions	Gratuité, non-jugement, valorisation des compétences, recettes à petit prix
Personnes allophones ou migrantes	Langue, codes culturels, produits inconnus, parcours parfois traumatique	Interprétariat, supports visuels, recettes du pays, posture interculturelle
Personnes en situation de handicap	Besoins variables (moteurs, sensoriels, cognitifs, psychiques)	FALC, matériel adapté, pictogrammes, rythme individualisé, accessibilité des locaux

Les modèles du changement de comportement

Définition – Modèle des croyances relatives à la santé (Health Belief Model, Rosenstock, Becker, années 1950-1970)

Une personne adopte un comportement de santé si elle se perçoit **vulnérable** au problème, si elle le juge **grave**, si elle perçoit des **bénéfices** supérieurs aux **obstacles**, en présence d'un **déclencheur** (incitation à l'action) et avec un sentiment d'**efficacité personnelle**.

Composante du modèle des croyances relatives à la santé	Question que se pose la personne	Exemple : dépistage du diabète chez des adultes de 50 ans	Levier pour l'action
Vulnérabilité perçue	« Est-ce que cela peut m'arriver ? »	« Le diabète, c'est pour les gros, pas pour moi. »	Présenter les facteurs de risque concrets (âge, antécédents familiaux, sédentarité)
Gravité perçue	« Est-ce grave si cela m'arrive ? »	« Un peu de sucre dans le sang, ce n'est rien. »	Témoignage d'un pair sur les complications évitées grâce à un repérage précoce
Bénéfices perçus	« Qu'est-ce que j'y gagne ? »	« Savoir tôt permet d'agir par l'alimentation. »	Montrer ce qui change concrètement après un dépistage
Obstacles perçus	« Qu'est-ce que cela me coûte ? »	Peur de la piqûre, temps, déplacement	Test capillaire gratuit sur le marché, sans rendez-vous
Incitation à l'action	« Qu'est-ce qui me décide maintenant ? »	Courrier, conseil du médecin, stand en pharmacie	Rappel par SMS, présence d'un stand lors d'un événement
Efficacité personnelle (ajoutée en 1988)	« Suis-je capable de le faire ? »	« Je ne saurai pas changer mon alimentation. »	Atelier culinaire, petits objectifs réalisables

Attention – Les limites du modèle

Le modèle des croyances relatives à la santé décrit une personne **rationnelle** qui pèse le pour et le contre. Il prédit mal les comportements **habituels** et automatiques (grignoter, boire un soda), et il donne peu de place aux **normes sociales** et aux émotions. Il est surtout utile pour des comportements ponctuels et délibérés : se faire dépister, se faire vacciner, consulter.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.14

Un centre de santé constate que peu de femmes enceintes du quartier participent à l'atelier gratuit « bien manger pendant la grossesse ». Voici ce qu'elles disent : « J'ai déjà eu deux enfants, je sais faire » ; « Le diabète de grossesse, ma cousine l'a eu, ce n'était pas grave » ; « L'atelier est à 9 h, je dépose les enfants à l'école » ; « Si la sage-femme me le conseillait, j'irais ». a) Associez chaque phrase à une composante du modèle. b) Proposez une action pour chacune.

Corrigé

a) « Je sais faire » : **vulnérabilité perçue** faible (« cela ne me concerne pas ») et confiance élevée ; « ce n'était pas grave » : **gravité perçue** faible ; « l'atelier est à 9 h » : **obstacle perçu** ; « si la sage-femme me le conseillait » : **incitation à l'action**. **b)** Valoriser l'expérience des mères (elles peuvent témoigner et aider les autres) tout en présentant ce qui est nouveau à chaque grossesse ; inviter une mère ou une sage-femme à expliquer simplement les conséquences du diabète gestationnel pour la mère et le bébé, sans dramatiser ; déplacer l'atelier à 10 h ou proposer une garde d'enfants ; demander aux sages-femmes de remettre une invitation personnalisée en consultation.

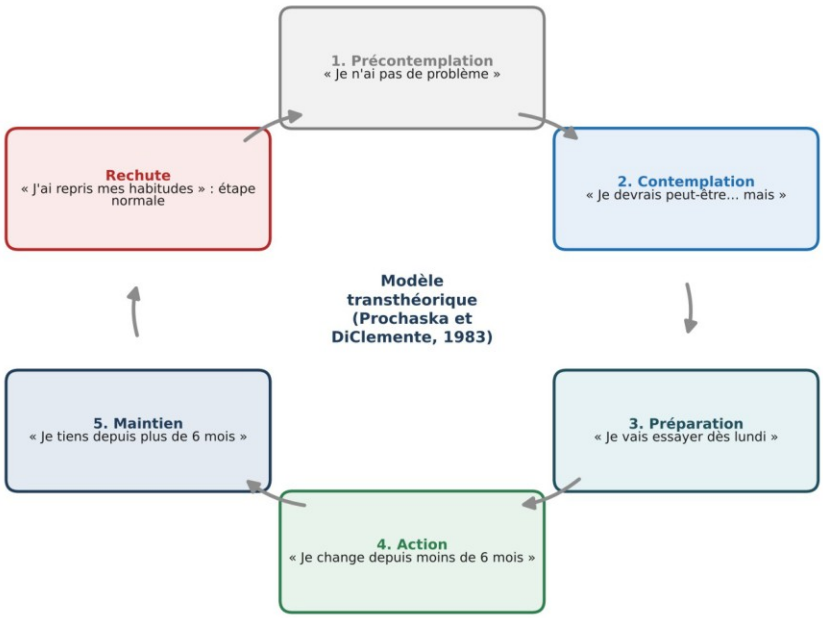


Figure 3.4 – Les étapes du changement selon Prochaska et DiClemente (1983)

Comprendre le schéma – Figure 3.4

1. Précontemplation : la personne n'envisage pas de changer (« je n'ai pas de problème ») ; objectif : informer sans braquer, susciter la réflexion.

2. Contemplation : elle envisage le changement mais reste ambivalente (« je devrais, mais… ») ; objectif : explorer les avantages et les inconvénients (balance décisionnelle).

3. Préparation : elle prévoit d'agir à court terme ; objectif : aider à fixer un objectif concret et réaliste.

4. Action : elle a changé depuis moins de 6 mois ; objectif : soutenir, valoriser, aider à surmonter les obstacles.

5. Maintien : le changement dure depuis plus de 6 mois ; objectif : prévenir la rechute.

6. Rechute : retour aux anciennes habitudes, considéré comme une étape **normale** du processus, qui permet d'apprendre ; on repart dans le cycle.

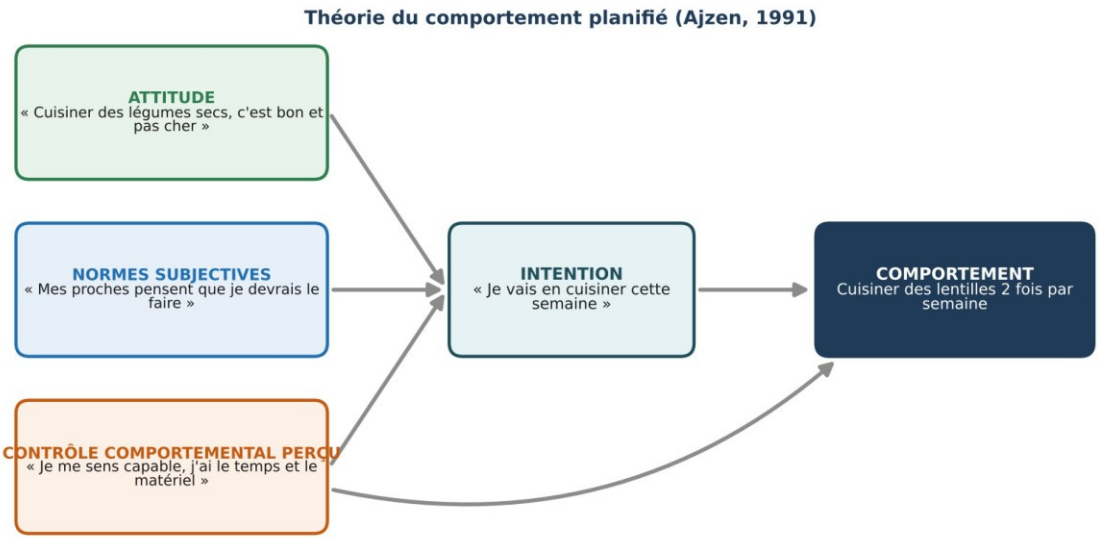


Figure 3.5 – La théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991), appliquée aux légumes secs

Comprendre le schéma – Figure 3.5

1. L'**attitude** : ce que la personne pense du comportement (positif ou négatif).
2. Les **normes subjectives** : ce qu'elle pense que ses proches attendent d'elle.
3. Le **contrôle comportemental perçu** : sa capacité perçue à réaliser le comportement (temps, argent, compétences).
4. Ces trois éléments déterminent l'**intention**, qui précède le **comportement**.
5. Le contrôle perçu agit aussi **directement** sur le comportement (flèche courbe) : même avec une bonne intention, sans compétences ni moyens, le comportement n'a pas lieu. D'où l'intérêt de faire **cuisiner** en atelier.

Définition – Sentiment d'efficacité personnelle (Albert Bandura, 1977)

Croyance d'une personne en sa capacité à réaliser une action précise. Il se développe par quatre sources : les **expériences de réussite** personnelles (la plus puissante), l'**observation** de pairs qui réussissent (apprentissage vicariant), la **persuasion** verbale (encouragements), et l'état **physiologique et émotionnel** (se sentir détendu).

Lien diététique – L'entretien motivationnel (lien BC1)

Développé par William Miller et Stephen Rollnick (1983, 2013), l'entretien motivationnel est une méthode de communication centrée sur la personne qui vise à **renforcer sa motivation propre** au changement en explorant son **ambivalence**. Ses outils (questions ouvertes, valorisation, reflets, résumés) sont utiles aussi en animation de groupe. Il est approfondi dans le BC1.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.15

Identifiez l'étape du changement et proposez une réponse adaptée : a) « Les légumes, chez nous, personne n'aime, et on n'a jamais été malades. » b) « J'aimerais bien cuisiner plus, mais je n'ai jamais le temps. » c) « Depuis l'atelier, je fais des lentilles tous les lundis, ça fait deux mois. » d) « J'avais arrêté les sodas, mais avec les vacances j'ai repris. »

Corrigé

a) Précontemplation : ne pas argumenter de front ; poser une question ouverte (« qu'est-ce que vous aimez cuisiner ? »), proposer de goûter sans engagement. **b) Contemplation** : explorer l'ambivalence (« qu'est-ce qui vous donnerait envie ? qu'est-ce qui bloque ? ») ; proposer des recettes en 15 minutes. **c) Action** (moins de 6 mois) : valoriser, féliciter, aider à varier pour maintenir la motivation. **d) Rechute** : la dédramatiser (étape normale), analyser la situation déclenchante, aider à reprendre un objectif réaliste.

Intégration, pauvreté, exclusion : le vocabulaire de la sociologie

Notion	Définition simple	Auteur repère
Intégration	Façon dont les personnes sont reliées entre elles et à la société	Durkheim (*De la division du travail social*, 1893)
Lien social	Ensemble des liens familiaux, sociaux, culturels et économiques qui assurent la cohésion de la société ; il découle de la socialisation	Durkheim ; Serge Paugam
Exclusion sociale	Cumul de difficultés (chômage durable, rupture familiale, perte du logement) qui éloigne la personne de la vie sociale	René Lenoir (*Les Exclus*, 1974)
Disqualification sociale	Affaiblissement puis rupture des liens, avec perte de protection et de reconnaissance ; trois phases : fragilité, dépendance aux aides, rupture	Serge Paugam (1991)
Désaffiliation	Suite de décrochages (travail, famille, entourage) ; trois zones : intégration, vulnérabilité, désaffiliation	Robert Castel (1995)
Classes sociales	Groupes définis par leur place dans la production ; conscience de classe et conflit	Karl Marx
Stratification	Hiérarchie de positions (richesse, prestige, pouvoir) sans frontière nette entre les strates	Max Weber
Capitaux	Capital **économique** (revenus, patrimoine), **culturel** (diplômes, savoirs), **social** (relations), qui expliquent les goûts et les pratiques	Pierre Bourdieu (1979)

Définition – Pauvreté monétaire (Insee)

Une personne est **pauvre** au sens monétaire quand son **niveau de vie** est inférieur à **60 % du niveau de vie médian**. C'est une pauvreté **relative** : elle mesure l'écart avec le reste de la population, et non l'impossibilité de survivre. Le niveau de vie est le revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'**unités de consommation** (UC) : 1 UC pour le premier adulte, 0,5 pour chaque autre personne de 14 ans ou plus, 0,3 pour chaque enfant de moins de 14 ans.

À retenir – Les chiffres en vigueur (Insee, publication du 9 juillet 2026)

En **2024**, le seuil de pauvreté à 60 % est de **1 337 € par mois** pour une personne seule. Le taux de pauvreté atteint **15,4 %** de la population (France métropolitaine), soit **9,8 millions** de personnes.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.16

Un couple avec deux enfants de 6 et 10 ans dispose d'un revenu disponible de 2 600 € par mois. a) Calculez le nombre d'UC et le niveau de vie mensuel. b) Ce ménage est-il sous le seuil de pauvreté de 2024 ? c) Quel revenu lui faudrait-il pour atteindre ce seuil ?

Corrigé

a) UC = 1 + 0,5 + 0,3 + 0,3 = **2,1** ; niveau de vie = 2 600 / 2,1 = **1 238 €** par mois. b) Oui : 1 238 € < 1 337 €. c) 1 337 × 2,1 = **2 808 €** par mois (2 807,70 €), soit 208 € de plus. Pour l'atelier, cela oriente vers des menus à petit budget, l'aide alimentaire et l'épicerie solidaire, sans stigmatiser la famille.

Entre l'intention et le comportement : un écart

Les modèles d'Ajzen et de Prochaska accordent une place centrale à l'**intention**. Or vouloir ne suffit pas. Une synthèse de méta-analyses (Sheeran, 2002) estime que l'intention n'explique qu'environ **28 %** des différences de comportement entre les personnes. Une autre méta-analyse d'études expérimentales (Webb et Sheeran, 2006) montre qu'un changement important de l'intention ne produit qu'un changement **petit à moyen** du comportement. C'est l'**écart intention-comportement** : beaucoup de personnes qui veulent manger plus de légumes n'y arrivent pas.

Cause de l'écart	Exemple	Ce qui aide
Oublier d'agir au bon moment	« J'avais prévu de prendre des fruits, mais j'ai oublié en faisant les courses. »	Une liste de courses, un rappel, une intention de mise en œuvre
Ne pas savoir par où commencer	« Je veux cuisiner plus, mais quoi ? »	Un objectif précis et une recette simple
Se laisser détourner par une tentation	Le distributeur de la salle de pause	Modifier l'environnement, prévoir une collation
Retomber dans une habitude	Le soda pris automatiquement en rentrant	Remplacer l'habitude par une autre, déclenchée par le même signal

Définition – Les intentions de mise en œuvre (Gollwitzer, 1999)

Une **intention de mise en œuvre** est un plan de la forme **« Si (situation), alors (action) »** : « Si je fais les courses le samedi, alors je prends un sachet de lentilles corail » ; « Si j'ai envie de grignoter devant la télévision, alors je me sers un verre d'eau et une pomme ». Elle relie un signal précis à une action, ce qui rend l'action plus automatique. Une méta-analyse de 94 études (Gollwitzer et Sheeran, 2006) a montré un effet **moyen à fort** de cette technique sur l'atteinte des objectifs.

Définition – Habitude

Une **habitude** est un comportement déclenché **automatiquement** par un signal du contexte (un lieu, une heure, une personne, une émotion), sans réflexion, parce qu'il a été répété souvent dans ce contexte. Une grande partie de l'alimentation quotidienne est faite d'habitudes : elles relèvent de la **motivation automatique** du modèle COM-B (section 3.3.13).

Exemple – Combien de temps faut-il pour créer une habitude ? (Lally et collaborateurs, 2010)

Quatre-vingt-seize volontaires londoniens ont choisi un nouveau comportement de santé à réaliser chaque jour dans le même contexte (par exemple manger un fruit au déjeuner). Ils ont noté chaque jour à quel point l'action leur paraissait automatique. Le temps pour atteindre 95 % du plateau d'automaticité était de **66 jours**

en valeur médiane, avec une très grande variation selon les personnes et les comportements (de **18 à 254 jours**). Oublier une journée n'empêchait pas l'habitude de se former.

Leçons : l'idée répandue qu'« il faut 21 jours pour créer une habitude » n'a pas de base solide ; il faut plutôt compter **plusieurs semaines à plusieurs mois** ; un écart ponctuel n'est pas un échec. Un cycle d'ateliers doit donc prévoir un suivi après la dernière séance.

Méthode pas à pas – Aider un groupe à passer de l'intention à l'action

1. Faire choisir à chacun **un seul** objectif précis et réaliste (« deux fois par semaine, un plat avec des légumes secs »).
2. Faire écrire une intention de mise en œuvre : « Si..., alors... ».
3. Repérer à l'avance un **obstacle** probable et sa solution (« Si je rentre trop tard, alors je réchauffe les lentilles cuisinées la veille »).
4. Attacher le nouveau comportement à une habitude existante (après le café du matin, au retour des courses).
5. Prévoir un **suivi** : retour à la séance suivante, message de rappel, carnet de suivi.
6. Dédramatiser les écarts : l'habitude se construit sur la répétition, pas sur la perfection.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.17

À la fin d'un atelier, M. K., chauffeur routier, déclare : « Il faut vraiment que je mange mieux. » Il prend souvent un sandwich et un soda à la station-service. a) Pourquoi cette intention risque-t-elle de ne pas se traduire en comportement ? b) Aidez-le à formuler deux intentions de mise en œuvre. c) Combien de temps faut-il prévoir avant que le nouveau comportement devienne automatique ?

Corrigé

a) L'intention est **vague** (que signifie « mieux » ?), aucun moment ni action précise n'est prévu, et le comportement actuel est une **habitude** déclenchée par un contexte fort (la pause à la station). **b)** « Si je m'arrête à la station-service, alors je prends une bouteille d'eau à la place du soda » ; « Si je pars le matin, alors je mets dans ma glacière une boîte de taboulé préparée la veille et un fruit ». **c)** Plusieurs semaines à plusieurs mois : 66 jours en valeur médiane dans l'étude de Lally (2010), avec de fortes différences d'une personne à l'autre. Un oubli ponctuel n'est pas grave.

Renforcer le sentiment d'efficacité personnelle en atelier

Le sentiment d'efficacité personnelle (Bandura, 1977) est l'une des variables les plus liées au changement durable. Il ne se décrète pas : il se construit à partir de ses **quatre sources**.

Source (de la plus forte à la plus faible)	Mécanisme	Application concrète en atelier culinaire
Expériences de réussite	« Je l'ai fait, donc je peux le refaire. »	Chaque participant réalise lui-même une étape ; recette simple au début, difficulté progressive ; on repart avec son plat
Expériences vicariantes (observation)	« Quelqu'un comme moi y arrive, donc moi aussi. »	Démonstration par un pair plutôt que par un chef ; témoignage d'un participant des cycles précédents
Persuasion verbale	« On me dit que j'en suis capable. »	Encouragements précis et sincères (« votre découpe est régulière ») plutôt que des compliments vagues

Source (de la plus forte à la plus faible)	Mécanisme	Application concrète en atelier culinaire
États physiologiques et émotionnels	« Je me sens détendu, donc capable. »	Accueil chaleureux, pas de chronomètre, droit à l'erreur, ambiance détendue

Définition – Mesurer l'efficacité personnelle

Le sentiment d'efficacité personnelle se mesure soit de façon **spécifique** à un comportement (« Je me sens capable de cuisiner un plat de légumes secs en moins de 30 minutes », de 1 à 5), ce qui est le plus pertinent pour évaluer un atelier, soit de façon **générale**. L'échelle d'auto-efficacité générale de Schwarzer et Jerusalem (1995), traduite en français, comporte **10 items** notés de 1 (« pas du tout vrai ») à 4 (« totalement vrai ») ; le score va de **10 à 40**.

Calcul détaillé – Le score de Mme A. à l'échelle générale

Réponses aux 10 items : 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2.

- Score total : 2 + 3 + 2 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 2 + 2 = **22 sur 40**.
- Position sur l'étendue : (22 − 10) / (40 − 10) × 100 = 12 / 30 × 100 = **40 / 100**.

Lecture : sentiment d'efficacité générale plutôt bas. Pour évaluer l'effet d'un atelier, on préfère une question **spécifique** au comportement travaillé, posée avant et après, car l'efficacité générale évolue lentement.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.18

M. D., 68 ans, veuf depuis un an, dit : « C'est ma femme qui faisait la cuisine, moi je ne sais rien faire, je mange des plats tout prêts. » a) Quelle variable psychosociale est en jeu ? b) Proposez une action pour chacune des quatre sources. c) Rédigez une question pour mesurer l'effet de l'atelier sur cette variable.

Corrigé

a) Un faible **sentiment d'efficacité personnelle** pour cuisiner (« je ne sais rien faire »), dans un contexte de deuil et de rupture des rôles. **b) Réussite** : lui faire préparer seul une omelette aux légumes, puis une soupe, en augmentant progressivement la difficulté. **Observation** : le faire cuisiner aux côtés d'un autre homme âgé qui a appris récemment. **Persuasion** : encouragements précis (« vos légumes sont bien coupés, la cuisson est parfaite »). **État émotionnel** : petit groupe, ambiance conviviale, aucune pression de temps ; prendre en compte le deuil (écoute, orientation si besoin). **c)** « Je me sens capable de préparer un repas simple et complet pour moi le soir », de 1 (« pas du tout ») à 5 (« tout à fait »), posée au premier et au dernier atelier.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.7 – Connaître les publics et comprendre le changement

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les composantes du modèle des croyances relatives à la santé.
2. Pour quel type de comportement ce modèle est-il le plus utile ? Pourquoi ?
3. Nommez les six étapes de Prochaska et DiClemente et donnez la durée qui sépare action et maintien.
4. Quels sont les trois déterminants de l'intention selon Ajzen ? Lequel agit aussi directement sur le comportement ?
5. Qu'est-ce qu'une intention de mise en œuvre ? Donnez un exemple.
6. Combien de temps faut-il pour qu'une habitude devienne automatique selon Lally (2010) ?

Corrigé – Point d'étape 3.3.7

1. Vulnérabilité perçue, gravité perçue, bénéfices perçus, obstacles perçus, incitation à l'action, efficacité personnelle.
2. Les comportements ponctuels et délibérés (dépistage, vaccination), car il décrit une décision rationnelle et prend peu en compte les habitudes et les normes.
3. Précontemplation, contemplation, préparation, action, maintien, rechute ; 6 mois.
4. L'attitude, la norme subjective et le contrôle comportemental perçu ; c'est le contrôle perçu qui agit aussi directement.
5. Un plan « si (situation), alors (action) » : « Si je fais les courses le samedi, alors je prends des lentilles » (Gollwitzer, 1999).
6. 66 jours en valeur médiane, avec une grande variation (de 18 à 254 jours).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.8 Communiquer et écouter : les bases de la relation éducative

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : Synthèse M5 S2 §2 (p. 36 à 38)

La communication interpersonnelle

Communiquer, ce n'est pas seulement transmettre une information : c'est établir une **relation**. L'école de **Palo Alto** (Watzlawick, Beavin et Jackson, *Une logique de la communication*, 1967) a formulé plusieurs principes devenus classiques, dont deux sont essentiels en éducation pour la santé : « **on ne peut pas ne pas communiquer** » (un silence, un regard, une posture disent quelque chose) et « toute communication comporte un **contenu** et une **relation** » (la même phrase peut être reçue comme un conseil ou comme un jugement selon le ton et la relation).

Composante	Exemples en atelier
Verbale	Choix des mots (« légumes secs » plutôt que « légumineuses »), clarté, phrases courtes (chapitre 5)
Paraverbale	Ton, débit, volume, silences ; un ton enjoué et posé rassure
Non verbale	Regard, sourire, posture ouverte, gestes, distance ; se placer à hauteur des personnes assises ; éviter les bras croisés
Contexte	Lieu, disposition de la salle (cercle plutôt que rangées), horaires, présence d'enfants

Attention – La « règle des 7 %, 38 %, 55 % » : un mythe

On lit souvent que 93 % de la communication serait non verbale. Ces chiffres viennent d'expériences d'Albert Mehrabian (1967) portant sur des mots isolés exprimant des **sentiments**, quand le ton et le visage contredisaient le mot ; ils ne s'appliquent pas à la communication en général. Retenez seulement que le non-verbal **renforce ou contredit** le message verbal, et qu'en cas de contradiction, c'est souvent lui que l'on croit.

L'écoute active

Définition – Écoute active (Carl Rogers)

Attitude d'écoute centrée sur la personne, fondée sur trois conditions décrites par le psychologue Carl **Rogers**

(années 1950-1960) : l'**empathie** (comprendre le point de vue de l'autre de l'intérieur, sans le partager forcément), l'**acceptation inconditionnelle** (accueillir la personne sans la juger) et la **congruence** (être authentique, en accord entre ce que l'on ressent et ce que l'on exprime). Elle s'appuie sur des techniques : questions ouvertes, reformulation, silences, synthèse.

Technique	Définition	Exemple
Question ouverte	Question qui ne se répond pas par oui ou non	« Comment se passent les repas à la maison ? »
Reformulation simple	Redire avec d'autres mots ce que la personne a dit	« Si je comprends bien, le soir vous manquez de temps. »
Reformulation reflet	Exprimer le sentiment perçu	« Ça a l'air de vous inquiéter que votre fils ne mange pas de légumes. »
Silence	Laisser un temps après une question ou une confidence	(attendre 3 à 5 secondes)
Valorisation	Reconnaître un effort, une compétence	« Vous avez déjà trouvé une astuce avec la soupe, c'est intéressant. »
Synthèse	Résumer les points importants	« Nous avons parlé du budget, du temps et des goûts des enfants. »

Attention – Les attitudes spontanées qui bloquent l'échange (Porter, 1950)

Le psychologue Elias Porter a décrit six attitudes : **évaluation** (juger : « Ce n'est pas bien de donner des sodas »), **interprétation** (« Vous dites ça parce que vous êtes fatiguée »), **soutien** (consoler, minimiser : « Ce n'est pas grave »), **enquête** (questions en rafale), **solution** (donner tout de suite un conseil) et **compréhension** (reformuler). Seule la **compréhension** favorise l'expression ; les autres sont parfois utiles, mais, utilisées d'emblée, elles ferment le dialogue. Le diététicien a souvent le réflexe de la « solution » : il gagne à écouter et reformuler d'abord.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.19

Une mère dit en atelier : « De toute façon, mes enfants ne mangent que des pâtes, j'ai tout essayé. » Proposez une réponse pour chaque attitude de Porter et indiquez laquelle choisir.

Corrigé

Évaluation : « Il faut quand même varier. » Interprétation : « Vous avez peut-être abandonné trop vite. » Soutien : « Ne vous inquiétez pas, c'est normal. » Enquête : « Depuis quand ? Quels légumes ? Combien de fois ? » Solution : « Mettez des légumes dans les pâtes. » **Compréhension** : « Vous avez l'impression d'avoir tout essayé et c'est décourageant. » C'est la compréhension qu'on choisit d'abord ; une fois que la personne se sent entendue, on peut explorer (« Qu'est-ce qui a marché, même un peu ? ») puis proposer des pistes avec elle.

Le schéma de la communication et ses obstacles

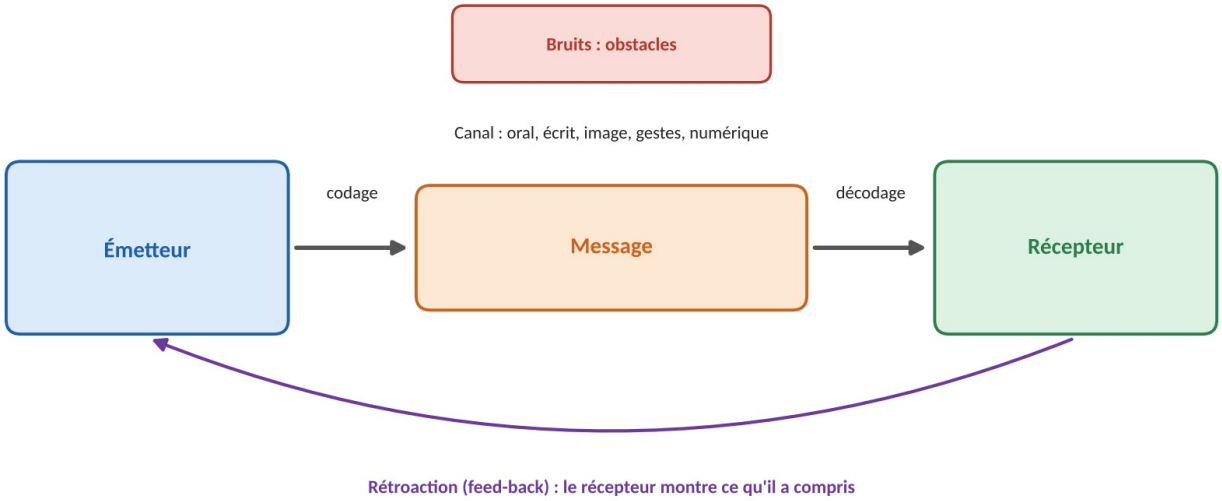


Figure 3.5 bis – Le schéma de la communication interpersonnelle

Comprendre le schéma – Figure 3.5 bis

1. L'**émetteur** a une idée qu'il **code** en mots, en images ou en gestes ; ce code forme le **message**.
2. Le message passe par un **canal** : la voix, un écrit, une image, un geste, un écran.
3. Le **récepteur décode** le message avec ses propres connaissances, sa langue, sa culture et ses émotions : ce qu'il comprend n'est jamais exactement ce que l'émetteur voulait dire.
4. Des **bruits** gênent la transmission à chaque étape.
5. La **rétroaction** (le *feed-back*) permet de vérifier ce qui a été compris et de corriger. Ce schéma vient du modèle technique de Shannon et Weaver (1949), complété par les apports de la psychologie : sans rétroaction, on informe, on ne communique pas.

Type de bruit	Exemples en atelier ou en consultation collective	Comment le réduire
Physique	Bruit de la hotte, salle mal éclairée, masque qui cache la bouche	Couper les appareils pendant les consignes, se placer face au groupe, parler plus lentement
Linguistique	Mots techniques (« glucides complexes », « densité énergétique »), langue étrangère	Mots simples, images, aliments réels, interprète professionnel (chapitre 5)
Culturel	Le geste « pouce levé » ou le contact visuel n'ont pas le même sens partout ; « léger » ne veut pas dire la même chose pour tous	Demander, observer, ne pas supposer
Psychologique	Fatigue, inquiétude pour un enfant, sentiment d'être jugé, préjugés envers le professionnel	Accueil chaleureux, non-jugement, pause
Sensoriel ou cognitif	Baisse d'audition, de vision, troubles de la mémoire	Gros caractères, supports visuels, répétition, phrases courtes

Vérifier la compréhension : la méthode « dites-le-moi avec vos mots »

Définition – Teach-back (« dites-le-moi avec vos mots »)

Méthode qui consiste à demander à la personne de **réexpliquer avec ses propres mots** ce qu'elle a compris, puis à reformuler et compléter si besoin. Elle est recommandée pour les personnes ayant une faible littératie en santé (chapitre 5), mais elle est utile avec tous les publics. La responsabilité de la compréhension est

portée par le professionnel : on ne demande pas « Avez-vous compris ? » (presque tout le monde répond oui), mais « Pour être sûr d'avoir été clair, pouvez-vous me dire comment vous allez préparer les lentilles ce soir ? ».

Méthode pas à pas – Utiliser le teach-back en groupe

1. Donner **deux ou trois messages** au maximum, avec un support concret (l'aliment, l'emballage, une photo).
2. Demander à un volontaire, ou à un binôme, de réexpliquer à un autre participant : « Comment expliqueriez-vous à votre voisine de palier comment faire tremper les pois chiches ? »
3. Écouter sans corriger tout de suite ; repérer ce qui manque ou ce qui est faux.
4. Réexpliquer autrement le point mal compris (autre mot, autre image, démonstration).
5. Vérifier de nouveau.
6. Remercier : la personne a aidé le groupe, et vous a aidé à mieux expliquer.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.20

Dans un atelier en EHPAD, une diététicienne présente l'enrichissement des purées pendant que l'aide-cuisinière utilise un mixeur. À la fin, elle demande « Tout le monde a compris ? » et plusieurs résidents hochent la tête. Le lendemain, aucun n'a demandé de fromage râpé sur sa purée. a) Repérez trois bruits dans cette situation. b) Pourquoi la question finale ne permettait-elle pas de vérifier la compréhension ? c) Réécrivez la fin de l'atelier.

Corrigé

a) Bruit **physique** (le mixeur couvre la voix) ; bruit **sensoriel** probable (baisse d'audition fréquente chez les résidents) ; bruit **linguistique** possible (« enrichissement » est un mot technique) ; on peut aussi penser à un bruit **psychologique** (gêne de demander un supplément). **b)** C'est une question fermée qui appelle un « oui » de politesse ; elle ne donne aucune **rétroaction** sur ce qui a été compris. **c)** Couper le mixeur, montrer un bol de purée et le fromage râpé, puis demander : « Imaginons que vous êtes au repas de midi : qu'allez-vous demander au serveur pour votre purée ? » ; reformuler la réponse, répéter le message en une phrase simple et laisser une petite carte illustrée sur la table.

3.3.9 L'esprit de l'entretien motivationnel appliqué au collectif

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

L'**entretien motivationnel** (Miller et Rollnick, 1983, puis 2013 pour la 3e édition) est un style de conversation collaboratif qui vise à renforcer la **motivation propre** d'une personne au changement, en explorant et en résolvant son **ambivalence**. Développé pour les addictions, il est très utilisé en nutrition (BC1). Ses principes inspirent aussi l'animation de groupes en santé publique.

Principe	Traduction
Esprit	Partenariat (pas d'expert qui sait tout), acceptation (respect de l'autonomie), compassion (agir pour le bien de la personne), évocation (faire émerger les raisons de la personne plutôt que d'imposer les siennes)
Ambivalence	La personne veut et ne veut pas changer en même temps (« Je voudrais cuisiner plus, mais je n'ai pas le temps ») : c'est normal, on l'explore sans la combattre
Réflexe correcteur	Tendance du professionnel à argumenter pour le changement ; elle provoque souvent la résistance (« Oui, mais… ») : il faut la freiner

Principe	Traduction
Discours-changement	Phrases où la personne exprime son désir, sa capacité, ses raisons, son besoin, puis son engagement à changer ; le professionnel les repère et les renforce

Méthode pas à pas – Les quatre savoir-faire de base (OuVER)

- **Questions Ouvertes** : « Qu'est-ce qui serait le plus facile à changer pour vous ? »
- **Valorisation** : souligner les forces et les efforts.
- **Écoute réflective** (reflets) : reformuler, refléter les sentiments et le discours-changement.
- **Résumés** : rassembler les éléments, en particulier les raisons de changer.

En anglais, l'acronyme est **OARS** (*Open questions*, *Affirmations*, *Reflections*, *Summaries*).

La balance décisionnelle

Exemple – Calcul détaillé : une balance décisionnelle pondérée

Un participant hésite à préparer lui-même ses déjeuners au travail. On lui demande de lister avantages et inconvénients du changement et de noter leur importance de 1 (faible) à 5 (forte).

Élément	Note	Côté
Économiser de l'argent (environ 5 € par jour)	5	Pour
Manger plus de légumes	3	Pour
Mieux digérer l'après-midi	2	Pour
Temps de préparation le soir	4	Contre
Moqueries possibles des collègues	2	Contre
Pas de micro-ondes au travail	3	Contre

- Total « pour » : 5 + 3 + 2 = **10** ; total « contre » : 4 + 2 + 3 = **9**.
- Écart : 10 − 9 = **1** : la balance est presque équilibrée, signe d'**ambivalence** ; ce n'est pas le moment de « pousser », mais d'explorer.
- **Piste** : agir sur les inconvénients modifiables (« contre ») : préparation en 10 minutes en cuisinant le double au dîner (temps : 4 → 2), boîte isotherme et plat froid (micro-ondes : 3 → 0). Nouveau total « contre » : 2 + 2 + 0 = **4** ; écart : 10 − 4 = **6** en faveur du changement.

Leçon : la balance aide la personne à **voir** ses raisons ; le professionnel n'ajoute pas ses propres arguments dans la colonne « pour » et ne juge pas les « contre » : il aide à trouver des solutions pour les réduire.

Attention – Entretien motivationnel et santé publique

En groupe, on ne mène pas un entretien motivationnel individuel, mais on en garde l'**esprit** : laisser les participants exprimer leurs raisons, éviter les leçons, valoriser, proposer des choix (« Lequel de ces trois petits changements vous semble faisable cette semaine ? »). Le diététicien formé à l'entretien motivationnel l'utilise en consultation (BC1).

Les quatre processus de l'entretien motivationnel

Dans la troisième édition de leur ouvrage (2013), Miller et Rollnick décrivent l'entretien motivationnel comme une suite de **quatre processus**. Ils se suivent et s'emboîtent : on ne planifie pas avec quelqu'un avec qui l'on n'a pas créé de relation.

Processus	Question centrale	En séance collective
Engager	Pouvons-nous travailler ensemble ?	Accueil, présentation de chacun, règles du groupe, questions ouvertes sur les habitudes
Focaliser	Sur quoi travaillons-nous ?	Choix avec le groupe d'un thème parmi plusieurs (petit-déjeuner, goûters, courses)
Évoquer	Quelles sont les raisons de la personne de changer ?	Faire exprimer ce que chacun aurait à y gagner ; repérer et renforcer le discours-changement
Planifier	Comment va-t-on s'y prendre ?	Chacun choisit un petit objectif et un plan « si…, alors… » (section 3.3.7)

Repérer le discours-changement

Le **discours-changement** regroupe les phrases où la personne parle en faveur du changement. Miller et Rollnick distinguent le discours **préparatoire** (désir, capacité, raisons, besoin) et le discours de **mobilisation** (engagement, activation, premiers pas). Le **discours-maintien** regroupe les phrases en faveur du statu quo (« De toute façon, chez nous on a toujours mangé comme ça »). Le professionnel ne le combat pas : il le reflète et revient au discours-changement.

Catégorie	Exemple entendu en atelier
Désir	« J'aimerais que mes enfants mangent plus de légumes. »
Capacité	« La soupe, je saurais la faire. »
Raisons	« Ça me ferait faire des économies. »
Besoin	« Il faut que je fasse quelque chose, le médecin m'a parlé de mon cholestérol. »
Engagement	« Je vais faire le gratin de lentilles dimanche. »
Activation	« Je suis prête à essayer. »
Premiers pas	« J'ai déjà acheté des pois chiches cette semaine. »

Donner une information sans réflexe correcteur

Méthode pas à pas – Demander, informer, demander (ou explorer, partager, explorer)

1. **Demander** la permission et ce que la personne sait déjà : « Voulez-vous que je vous donne quelques idées sur les goûters ? Qu'est-ce que vous en savez déjà ? »
2. **Informer** brièvement, de façon neutre, en offrant des choix : « Certains parents mettent un fruit et du pain avec un carré de chocolat ; d'autres préparent un laitage… »
3. **Demander** ce que la personne en pense : « Qu'est-ce qui vous paraît faisable chez vous ? »

On évite ainsi la leçon. La personne garde le contrôle et retient mieux ce qu'elle a choisi.

Évaluer sa pratique : quelques repères chiffrés

L'outil d'évaluation de la qualité de la pratique de l'entretien motivationnel, le **MITI** (*Motivational Interviewing Treatment Integrity*, version 4, Moyers et collaborateurs, 2016), compte les questions et les reflets du professionnel sur un enregistrement. Deux repères sont simples à utiliser pour s'auto-évaluer en formation :

- le **rapport reflets / questions** : au moins **1** reflet par question pour une pratique correcte, **2** pour une bonne pratique ;
- la **part de reflets complexes** (qui ajoutent un sens ou un sentiment) parmi tous les reflets : au moins **40 %** pour une pratique correcte, **50 %** pour une bonne pratique.

Calcul détaillé – L'auto-évaluation de Clara, étudiante en BTS

Clara enregistre (avec l'accord des participants) dix minutes d'un échange collectif. Elle compte : **18 questions** (dont 11 ouvertes), **12 reflets simples** et **8 reflets complexes**.

- Nombre total de reflets : 12 + 8 = **20**.
- Rapport reflets / questions : 20 / 18 = **1,11** : pratique correcte, mais pas encore bonne (objectif 2).
- Part de reflets complexes : 8 / 20 = **40 %** : seuil d'une pratique correcte tout juste atteint.
- Part de questions ouvertes : 11 / 18 = **61,1 %**.

Objectif d'amélioration : poser moins de questions et refléter davantage. Pour atteindre un rapport de 2 avec 18 questions, il faudrait 36 reflets ; plus réaliste : passer à 12 questions et 24 reflets, dont au moins la moitié de reflets complexes.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.21

Classez chaque phrase dans une catégorie du discours-changement ou dans le discours-maintien, puis proposez un reflet pour la phrase f. a) « Je pourrais remplacer le soda par de l'eau pétillante. » b) « Je veux pouvoir jouer au foot avec mon fils sans être essoufflé. » c) « J'ai acheté une gourde hier. » d) « Le soda, c'est mon seul plaisir de la journée. » e) « Je vais essayer dès lundi. » f) « Je sais qu'il faudrait, mais avec mon travail de nuit, c'est compliqué. »

Corrigé

a) Capacité. **b)** Raison (ou désir). **c)** Premiers pas. **d)** Discours-maintien. **e)** Engagement. **f)** Ambivalence : besoin (« il faudrait ») et discours-maintien (« c'est compliqué »). Reflet complexe possible : « Vous sentez que ce serait important pour vous, et en même temps vos horaires de nuit rendent les choses difficiles. » Le reflet reprend les deux côtés, en terminant par celui du changement si possible : « Vos horaires compliquent les choses, et pourtant vous sentez que ce serait important pour vous. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.8 et 3.3.9 – Communiquer, écouter, esprit de l'entretien motivationnel

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez deux principes de l'école de Palo Alto.
2. Pourquoi la « règle des 7 %, 38 %, 55 % » est-elle un mythe ?
3. Quelles sont les trois conditions de l'écoute selon Rogers ?
4. Citez les six attitudes de Porter. Laquelle favorise le plus l'expression ?
5. Nommez les quatre processus de l'entretien motivationnel (2013).
6. Quels sont les deux repères du MITI 4 pour une bonne pratique ?

Corrigé – Point d'étape 3.3.8 et 3.3.9

1. « On ne peut pas ne pas communiquer » ; « toute communication a un contenu et une relation ».
2. Les chiffres de Mehrabian (1967) portent sur des mots isolés exprimant des sentiments, quand le ton et le visage contredisaient le mot.
3. L'empathie, l'acceptation inconditionnelle, la congruence.
4. Évaluation, interprétation, soutien, enquête, solution, compréhension ; c'est la compréhension.
5. Engager, focaliser, évoquer, planifier.
6. Au moins 2 reflets par question et au moins 50 % de reflets complexes.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.10 Animer un groupe : étapes, rôles et styles d'animation

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

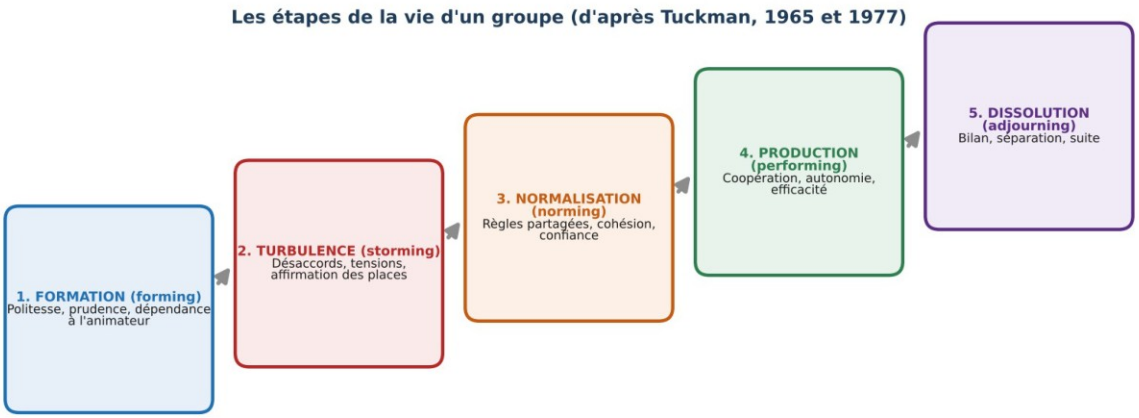


Figure 3.6 – Les étapes de la vie d'un groupe

Comprendre le schéma – Figure 3.6

1. Formation : au début, les participants sont polis et prudents ; ils attendent beaucoup de l'animateur ; c'est le moment de présenter le cadre (règles, confidentialité), de faire se connaître les personnes (brise-glace).

2. Turbulence : des désaccords apparaissent (sur les recettes, les horaires, les façons de faire) ; ils sont **normaux** et signent l'implication ; l'animateur les accueille et aide à les dépasser.

3. Normalisation : le groupe se dote de règles et d'habitudes (« chacun apporte une boîte pour les restes ») ; la cohésion augmente.

4. Production : le groupe coopère, prend des initiatives, l'animateur peut s'effacer (les participants animent une partie de la séance).

5. Dissolution : en fin de cycle, il faut préparer la séparation : bilan, restitution, suite possible (nouveau groupe, autonomie).

6. Dans un cycle de 6 ateliers, ces étapes se succèdent souvent rapidement ; les connaître aide à ne pas s'inquiéter d'une séance tendue (étape 2) et à prévoir la fin (étape 5).

Les rôles dans un groupe

Benne et Sheats (1948) ont distingué trois familles de rôles : les rôles **centrés sur la tâche** (proposer, informer, résumer, organiser), les rôles **centrés sur l'entretien du groupe** (encourager, concilier, faciliter la parole des autres, détendre) et les rôles **individualistes** (monopoliser la parole, bloquer, chercher la reconnaissance, se retirer). L'animateur s'appuie sur les premiers, encourage les seconds et régule les troisièmes.

Situation	Conduite à tenir
Une personne monopolise la parole	Remercier, reformuler brièvement, puis donner la parole aux autres (« J'aimerais entendre ceux qui ne se sont pas encore exprimés ») ; tour de table ; bâton de parole

Situation	Conduite à tenir
Une personne ne parle pas	Ne pas la forcer ; travail en binôme ; supports non verbaux (cartes, gommettes) ; valoriser sa participation pratique
Une personne conteste tout	Accueillir l'objection, la reformuler, la renvoyer au groupe (« Qu'en pensent les autres ? »), s'appuyer sur des données, rappeler l'objectif
Conflit entre deux participants	Rappeler les règles, recentrer sur l'activité, si besoin en parler à part après la séance
Retards répétés	Rappeler les horaires, comprendre les contraintes, adapter l'organisation (accueil café de 15 minutes)
Confidence personnelle difficile	Écouter, remercier, protéger la personne (ne pas laisser le groupe commenter), proposer un échange en privé et une orientation

Les styles d'animation

Exemple – L'expérience de Lewin, Lippitt et White (1939)

Des groupes d'enfants animés selon trois styles ont été comparés. Avec un style **autoritaire** (l'adulte décide de tout), la production était élevée en sa présence, mais l'hostilité et la dépendance aussi, et l'activité s'arrêtait en son absence. Avec un style **démocratique** (décisions discutées, adulte qui guide), la production était bonne, la motivation et la cohésion plus fortes, et le travail continuait sans l'adulte. Avec le style « **laisser-faire** » (adulte passif), la production et la satisfaction étaient les plus faibles. En éducation pour la santé, on privilégie un style **participatif** (démocratique), tout en restant **directif sur le cadre** (sécurité, hygiène, horaires).

Choisir une technique d'animation selon l'objectif

Le style d'animation dit **comment** l'animateur se situe ; la technique dit **ce que** le groupe fait. Le choix dépend de l'objectif de la séquence et de l'étape de vie du groupe. Les techniques sont détaillées au chapitre 14 ; ce tableau en donne la logique psychosociale.

Objectif de la séquence	Technique	Principe	Intérêt psychosocial
Faire connaissance (étape de formation)	Brise-glace, jeu des prénoms, « ce que j'aime manger »	Chacun se présente de façon ludique	Diminue l'anxiété, crée l'appartenance
Recueillir les représentations	Photolangage	Chacun choisit une photo qui évoque pour lui un thème (« bien manger ») et explique son choix	Permet de parler de soi à travers une image, sans être jugé
Produire beaucoup d'idées	Remue-méninges (*brainstorming*, Osborn, 1953)	Toutes les idées sont notées sans critique, puis triées	Limite l'autocensure et l'influence des « experts »
Faire participer un grand groupe	Phillips 6-6	Sous-groupes de 6 personnes, 6 minutes, puis mise en commun	Chacun parle ; on évite la monopolisation
Faire émerger les désaccords	Débat mouvant, abaque de Régnier	Les participants se placent physiquement ou votent par couleur selon leur accord avec une affirmation	Rend visibles les positions ; chacun argumente
Faire décider le groupe	Vote pondéré, consensus	Chacun répartit des gommettes entre plusieurs choix	Engagement collectif (effet Lewin)
S'exercer à une compétence sociale	Jeu de rôle	On joue une situation, puis on en parle	Expérience sans risque, apprentissage par observation

Objectif de la séquence	Technique	Principe	Intérêt psychosocial
Faire le bilan	Cible, « météo », tour de table « un mot »	Chacun s'exprime brièvement sur la séance	Rétroaction, sentiment d'avoir été entendu

Méthode pas à pas – Mener un photolangage

1. Préparer 30 à 50 photos variées (plats, scènes de repas, marchés, publicités), sans texte, en nombre largement supérieur au nombre de participants.
2. Poser une question ouverte : « Choisissez une photo qui représente pour vous "bien manger". »
3. Laisser un temps de choix en silence (5 minutes).
4. Faire un tour de parole : chacun montre sa photo et dit pourquoi il l'a choisie ; les autres écoutent sans commenter.
5. Reformuler et noter les idées qui reviennent (éléments partagés) et celles qui sont isolées.
6. Faire une synthèse avec le groupe, qui servira de point de départ au cycle d'ateliers.

Définition – Le jeu de rôle et le débriefing

Le **jeu de rôle** fait vivre une situation proche de la réalité (dire non à une invitation au fast-food, demander un conseil au boucher). Il comporte trois temps : la **consigne** (situation, rôles, durée), le **jeu** (quelques minutes), le **débriefing**. Le débriefing est la partie la plus importante : on demande d'abord à l'acteur ce qu'il a ressenti, puis aux observateurs ce qu'ils ont vu de positif, puis ce qu'on pourrait essayer autrement. On ne juge jamais la personne, seulement la stratégie utilisée. Un participant qui ne veut pas jouer peut observer.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.22

Vous animez la première séance d'un cycle de six ateliers avec 14 adultes d'une association d'insertion. Vos objectifs sont : faire connaissance, recueillir leurs représentations de l'alimentation à petit budget, et choisir avec eux les thèmes des cinq séances suivantes. a) Choisissez une technique pour chaque objectif et justifiez. b) À quelle étape de la vie du groupe êtes-vous ? Quelle attitude adoptez-vous ?

Corrigé

a) Faire connaissance : un **brise-glace** (« mon prénom et un plat qui me rappelle mon enfance ») : rapide, ludique, il crée du lien et valorise l'identité de chacun. Représentations : un **photolangage** sur « manger bien avec peu d'argent » : l'image facilite la parole, sans mise en échec. Choix des thèmes : un **vote par gommettes** parmi 8 thèmes proposés (dont certains issus du photolangage) : la décision collective engage le groupe. **b)** Étape de **formation** : les participants sont prudents et attendent des repères ; l'animateur est plutôt directif sur le cadre (horaires, règles, confidentialité), chaleureux et rassurant, et laisse progressivement la place aux décisions du groupe.

Quatre phénomènes de groupe à connaître

Le travail en groupe n'a pas que des avantages. La psychologie sociale a décrit des phénomènes qui expliquent pourquoi un groupe peut produire moins, ou décider moins bien, que la somme de ses membres.

Phénomène	Ce qui se passe	Origine	Prévention en atelier ou en réunion de projet
Cohésion	Force des liens qui retiennent les membres dans le groupe ; elle favorise la participation et la persévérance	Festinger, Schachter et Back (1950)	Rituels d'accueil, tâches en commun, règles décidées ensemble, repas partagé à la fin

Phénomène	Ce qui se passe	Origine	Prévention en atelier ou en réunion de projet
Paresse sociale	Chacun fournit moins d'effort quand la contribution individuelle n'est pas visible	Ringelmann (fin du XIXe siècle, traction d'une corde) ; Latané, Williams et Harkins (1979)	Donner à chacun un rôle identifiable (éplucher, peser, dresser) ; petits sous-groupes
Pensée de groupe	Un groupe très soudé cherche l'unanimité et écarte les avis contraires, au risque d'une mauvaise décision	Irving Janis (1972)	Demander des avis contraires, désigner un « avocat du diable », consulter des personnes extérieures
Polarisation de groupe	Après discussion, la position du groupe devient plus extrême que la moyenne des positions individuelles	Moscovici et Zavalloni (1969)	Apporter des données, faire voter individuellement avant la discussion

Exemple – La pensée de groupe dans un comité de pilotage

Le comité de pilotage d'un projet de quartier réunit depuis trois ans les mêmes cinq professionnels, très liés. Il décide de reconduire à l'identique les ateliers « équilibre alimentaire », malgré une fréquentation en baisse (de 14 à 5 participants). Personne n'ose dire que les ateliers ne répondent plus aux attentes ; les quelques remarques des habitants sont jugées « marginales ». On retrouve les signes décrits par Janis : **illusion d'unanimité**, **autocensure**, mise à l'écart des informations dérangeantes. **Remède** : présenter les données de fréquentation, inviter deux habitants au comité, faire un tour de table où chacun dit une critique avant la décision.

Définition – Le leadership dans un groupe

Le **leader** est la personne qui influence le plus le groupe à un moment donné. Ce n'est pas forcément l'animateur. On distingue un leadership **orienté vers la tâche** (organiser, décider, faire avancer) et un leadership **orienté vers les relations** (rassurer, encourager, apaiser). Dans un atelier, un participant leader peut être un allié précieux (il goûte en premier, il entraîne les autres) ou un frein (il se moque, il décourage). L'animateur s'appuie sur les leaders positifs, en leur confiant un rôle, et régule les autres sans les mettre en échec devant le groupe.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.23

Dans un atelier culinaire de 12 adultes, l'animatrice répartit les participants en deux équipes de 6 pour préparer un couscous de légumes. Elle remarque que, dans chaque équipe, deux personnes font tout pendant que les autres discutent. a) Quel phénomène observe-t-elle ? Citez son origine. b) Proposez deux changements d'organisation. c) Comment la cohésion du groupe peut-elle aussi être renforcée à cette occasion ?

Corrigé

a) La **paresse sociale** : dans un grand sous-groupe, la contribution de chacun est peu visible, donc l'effort individuel baisse (Ringelmann ; Latané, Williams et Harkins, 1979). **b)** Former des **binômes** ou des trinômes avec une tâche précise chacun (légumes, semoule, bouillon, épices, dressage) ; afficher le **plan de travail** avec le prénom de chacun en face de sa tâche. **c)** Terminer par un **repas partagé** où chaque binôme présente sa partie, remercier chacun pour sa contribution, et faire choisir au groupe la recette de la séance suivante.

Gérer un désaccord ou un conflit : deux méthodes

Les désaccords sont normaux dans un groupe (étape de turbulence). Ils deviennent un problème quand ils se transforment en attaques personnelles. Deux méthodes simples aident l'animateur à exprimer une difficulté sans agresser et à aider les participants à le faire.

Méthode pas à pas – La méthode DESC (Bower et Bower, 1976)

D – Décrire les faits, sans jugement : « Depuis le début de la séance, le téléphone a sonné quatre fois. »

E – Exprimer ce que l'on ressent ou les conséquences : « J'ai du mal à garder l'attention du groupe, et les autres n'entendent pas les consignes de sécurité. »

S – Suggérer une solution précise : « Je vous propose de le mettre en silencieux et de sortir si vous devez répondre. »

C – Conclure sur les conséquences positives : « Comme ça, tout le monde pourra profiter de l'atelier, et vous ne manquerez pas d'appel important. »

Définition – La communication non violente (Marshall Rosenberg, 1999)

Démarche de communication en quatre étapes, proche de la méthode DESC : **observation** des faits sans évaluation, expression du **sentiment**, expression du **besoin** à l'origine du sentiment, formulation d'une **demande** concrète, réalisable et négociable. Elle aide à transformer un reproche (« Vous ne respectez rien ») en une demande que l'autre peut entendre (« Quand vous arrivez après le début de la recette [observation], je suis inquiète [sentiment] car j'ai besoin que chacun entende les consignes d'hygiène [besoin]. Pourriez-vous arriver à 14 h la prochaine fois, ou me prévenir ? [demande] »).

Erreur fréquente	Pourquoi elle aggrave le conflit	Formulation alternative
Généraliser (« Vous êtes toujours en retard »)	La personne se défend contre l'étiquette, pas sur les faits	« Vous êtes arrivé après le début les deux dernières fois. »
Parler à la place de l'autre (« Vous vous en fichez »)	Interprétation, attitude de Porter qui ferme le dialogue	« Je me demande si l'horaire vous convient. »
Recadrer devant tout le groupe	Menace pour l'image de la personne, risque d'humiliation	Un mot bref en séance, puis un échange à part
Laisser faire	Le groupe perçoit que les règles ne comptent pas	Rappeler calmement la règle décidée ensemble

À vous de jouer – Exercice d'application 3.24

Pendant un atelier, deux participantes se disputent : l'une reproche à l'autre de « tout faire à sa façon » et de ne pas la laisser cuisiner. Le ton monte. a) Que faites-vous immédiatement ? b) Rédigez, selon la méthode DESC, ce que vous direz à la participante qui accapare la tâche, en aparté. c) Quelle règle proposer au groupe pour la suite ?

Corrigé

a) Interrompre calmement, rappeler les règles du groupe (bienveillance, chacun participe), **recentrer** sur la tâche en répartissant les rôles (« Mme X, vous vous occupez de la sauce ; Mme Y, des légumes »), et proposer d'en reparler après la séance. **b)** « Tout à l'heure, vous avez pris en charge la découpe et la cuisson pendant que Mme Y attendait (D). Je vois que vous savez bien cuisiner, mais Mme Y n'a pas pu pratiquer, et elle est venue pour apprendre (E). La prochaine fois, je vous propose de lui montrer un geste puis de la laisser faire (S) : votre savoir-faire servira à tout le groupe et l'ambiance sera meilleure (C). » **c)** Une règle de **rotation des tâches** décidée avec le groupe et affichée : chacun réalise au moins une étape de la recette.

3.3.11 La motivation et les biais de décision

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

La théorie de l'autodétermination

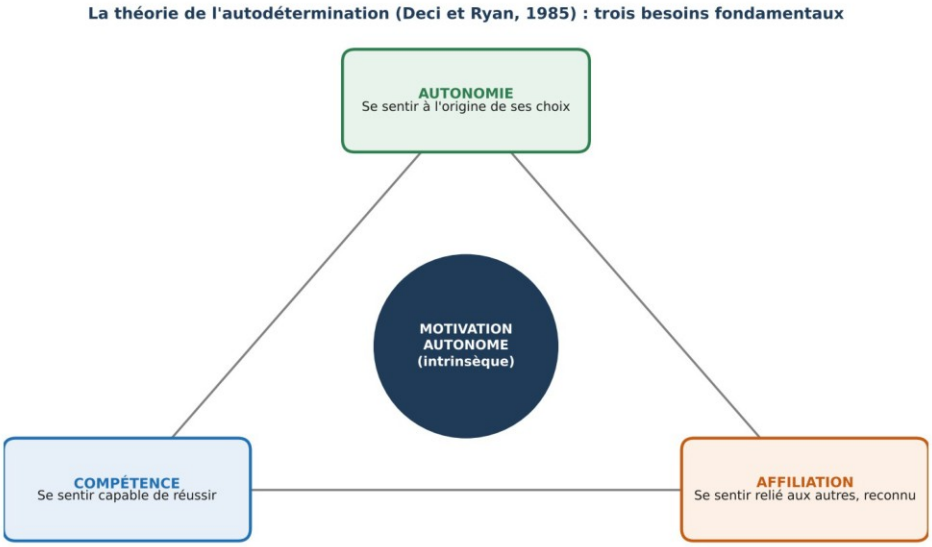


Figure 3.7 – Les trois besoins psychologiques fondamentaux

Comprendre le schéma – Figure 3.7

1. Deci et Ryan (1985) distinguent la motivation **intrinsèque** (agir pour le plaisir ou l'intérêt de l'activité), la motivation **extrinsèque** (agir pour une récompense, éviter une sanction, faire plaisir à quelqu'un) et l'**amotivation**.
2. Les motivations les plus durables sont **autonomes** : intrinsèques ou extrinsèques mais **intériorisées** (« Je cuisine parce que c'est important pour moi d'élever mes enfants en bonne santé »).
3. Elles sont favorisées par la satisfaction de trois besoins : **autonomie** (choisir), **compétence** (réussir), **affiliation** (se sentir relié aux autres).
4. Conséquences pour l'animation : laisser choisir (recettes, défis), proposer des tâches réalisables et valoriser les réussites, créer de la convivialité ; éviter les récompenses et les menaces qui affaiblissent la motivation intrinsèque (« Si tu finis tes légumes, tu auras un dessert » apprend à l'enfant que le légume est une corvée et le dessert une récompense).

Les biais cognitifs et les choix alimentaires

Le psychologue Daniel **Kahneman** (prix Nobel d'économie 2002) distingue un **système 1**, rapide, automatique et émotionnel, et un **système 2**, lent, réfléchi et coûteux en effort (*Système 1 / Système 2 : les deux vitesses de la pensée*, 2011). Une grande partie des choix alimentaires quotidiens, rapides et répétés, relève du système 1 : d'où les **biais**, utilisés par le marketing et, à l'inverse, par les **nudges** (chapitre 6).

Biais	Exemple alimentaire et usage en prévention
Préférence pour le présent	Le plaisir immédiat (dessert) l'emporte sur un bénéfice futur (santé dans 20 ans) : valoriser les bénéfices immédiats (énergie, goût, économies)
Effet de cadrage	« 95 % sans matière grasse » paraît plus sain que « 5 % de matière grasse » ; présenter les messages de façon positive

Biais	Exemple alimentaire et usage en prévention
Effet de halo	Un produit étiqueté « bio » ou « naturel » paraît moins calorique ; apprendre à lire l'étiquette entière
Biais de statu quo / option par défaut	On garde l'option proposée d'office : servir les légumes par défaut, l'eau en carafe
Ancrage	Le premier prix vu sert de référence ; une grande portion servie devient la norme (chapitre 4)
Biais d'optimisme	« Les maladies, ça arrive aux autres » : limite des messages fondés sur la peur
Preuve sociale	On imite ce que font les autres : normes descriptives positives (« 7 familles sur 10 ont goûté… »)

Le continuum de l'autodétermination

Deci et Ryan ne se contentent pas d'opposer motivation intrinsèque et extrinsèque. Ils décrivent un **continuum** : la motivation extrinsèque peut être plus ou moins **intériorisée**, c'est-à-dire faire plus ou moins partie des valeurs de la personne.

Type de motivation	Régulation	Ce que dit la personne	Durabilité
Amotivation	Aucune	« Je ne vois pas à quoi ça sert. »	Nulle
Extrinsèque	Externe	« Je mange des légumes pour que le médecin arrête de me sermonner. »	Faible : s'arrête avec la pression
Extrinsèque	Introjectée	« Je me sentirais coupable de ne pas en manger. »	Faible à moyenne : liée à la culpabilité
Extrinsèque	Identifiée	« C'est important pour ma santé, j'en vois l'intérêt. »	Bonne
Extrinsèque	Intégrée	« Cuisiner frais fait partie de qui je suis, comme parent. »	Très bonne
Intrinsèque	Intrinsèque	« J'adore cuisiner les légumes, c'est un plaisir. »	Très bonne

Exemple – L'effet de surjustification (Lepper, Greene et Nisbett, 1973)

Dans une école maternelle, des enfants qui aimaient spontanément dessiner avec des feutres ont été répartis en trois groupes. Le premier savait qu'il recevrait un diplôme s'il dessinait ; le deuxième l'a reçu par surprise ; le troisième n'a rien reçu. Une à deux semaines plus tard, pendant le temps libre, les enfants du premier groupe ont passé environ **deux fois moins de temps** à dessiner que ceux des deux autres groupes (environ 9 % du temps libre contre 17 à 18 %).

Explication : la récompense **attendue** a transformé une activité plaisante en « travail » fait pour obtenir quelque chose. **Leçon** : récompenser un enfant parce qu'il a goûté un légume risque de diminuer son envie d'en manger quand il n'y a plus de récompense. La reconnaissance **verbale**, sincère et inattendue, ne produit pas cet effet.

Les nudges et leurs limites éthiques

Définition – Nudge (Thaler et Sunstein, 2008)

Un **nudge** (« coup de pouce ») est une modification de l'**architecture du choix** qui oriente le comportement de façon prévisible, **sans interdire** aucune option et **sans changer** significativement les incitations financières. Mettre les fruits à hauteur des yeux est un nudge ; interdire les sodas n'en est pas un.

Exemple – Plus d'options végétariennes, plus de repas végétariens (Garnett et collaborateurs, 2019)

Dans les cafétérias de l'université de Cambridge, des chercheurs ont fait varier la part des plats végétariens proposés. En passant d'une option végétarienne sur quatre à **deux sur quatre**, les ventes de plats végétariens ont augmenté de **40 à 80 %** selon les cafétérias, sans baisse des ventes totales. Les clients qui mangeaient le moins souvent végétarien étaient les plus sensibles au changement (étude publiée dans *PNAS*). C'est un levier de l'**opportunité physique** (modèle COM-B), cohérent avec l'obligation d'un menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire posée par la loi EGalim (2018) et pérennisée par la loi Climat et résilience (2021).

Critère éthique	Question à se poser	Exemple
Transparence	La personne pourrait-elle repérer le nudge et le comprendre si on le lui expliquait ?	Une affiche « Ce mois-ci, le plat du jour est végétarien » est transparente
Liberté de choix	Toutes les options restent-elles accessibles sans effort excessif ?	Les desserts restent proposés, mais en fin de ligne
Intérêt de la personne	Le nudge sert-il la santé de la personne plutôt qu'un intérêt commercial ?	Mettre en avant l'eau plutôt que le soda à forte marge
Équité	Le nudge bénéficie-t-il aussi, et même surtout, aux plus défavorisés ?	Une option par défaut équilibrée profite à tous, sans effort ni coût
Respect	Le nudge évite-t-il la honte et la stigmatisation ?	Pas de messages culpabilisants sur les plateaux

Attention – Un nudge ne remplace pas une politique

Les nudges ont souvent des effets **modestes** et variables d'un lieu à l'autre. Ils ne corrigent pas les inégalités de revenus, de temps ou d'accès aux commerces. Ils complètent l'éducation pour la santé et les mesures structurelles (réglementation, prix, offre) ; ils ne s'y substituent pas (chapitres 1 et 6).

À vous de jouer – Exercice d'application 3.25

Un restaurant d'entreprise envisage trois mesures : A) placer les crudités en début de ligne et les frites en fin de ligne ; B) supprimer les desserts ; C) offrir un dessert gratuit pour chaque plateau « équilibré » validé par une application. a) Laquelle est un nudge au sens strict ? Justifiez pour chacune. b) Que prévoit la théorie de l'autodétermination pour la mesure C ? c) Vérifiez l'éthique de la mesure A avec deux critères.

Corrigé

a) A est un nudge : on modifie l'ordre de présentation, toutes les options restent accessibles, les prix ne changent pas. **B** n'est pas un nudge : c'est une **restriction** (une option est supprimée). **C** n'est pas un nudge : c'est une **incitation financière** (un avantage matériel). **b)** La récompense attendue risque de déplacer la motivation vers une **régulation externe** : les salariés composent un plateau « équilibré » pour le dessert gratuit et risquent d'arrêter quand l'offre s'arrête (effet de surjustification). **c) Transparence** : le placement est visible et peut être expliqué par une affiche. **Liberté** : les frites restent disponibles au même prix. La mesure sert l'intérêt des salariés et ne stigmatise personne.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.10 et 3.3.11 – Animer un groupe, motivation, biais

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les cinq étapes de la vie d'un groupe selon Tuckman.
2. Quelles sont les trois familles de rôles de Benne et Sheats ?
3. Quel style d'animation l'expérience de Lewin, Lippitt et White (1939) recommande-t-elle ? Pourquoi ?

4. Rangez du moins au plus autodéterminé : régulation identifiée, régulation externe, motivation intrinsèque, régulation introjectée.
5. Qu'est-ce que l'effet de surjustification ? Citez l'expérience qui l'a montré.
6. Donnez la définition d'un nudge et un exemple.

Corrigé – Point d'étape 3.3.10 et 3.3.11

1. Formation, turbulence (tension), normalisation, production, dissolution.
2. Les rôles centrés sur la tâche, centrés sur l'entretien du groupe, individualistes.
3. Le style démocratique (participatif) : bonne production, motivation et cohésion fortes, travail qui continue sans l'adulte.
4. Régulation externe, régulation introjectée, régulation identifiée, motivation intrinsèque.
5. Une récompense attendue diminue la motivation intrinsèque pour une activité plaisante (Lepper, Greene et Nisbett, 1973 : enfants et feutres).
6. Une modification de l'architecture du choix qui oriente le comportement sans interdire d'option ni changer les incitations financières (Thaler et Sunstein, 2008) : fruits à hauteur des yeux.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.12 Mesurer attitudes et représentations

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Les représentations et les attitudes (3.3.3, 3.3.4) peuvent être **recueillies** et **mesurées** pour le diagnostic et l'évaluation. Trois méthodes sont simples à utiliser sur le terrain.

L'échelle de Likert

Méthode pas à pas – Construire et calculer un score d'attitude

Une échelle de **Likert** (1932) propose des affirmations avec lesquelles la personne indique son degré d'accord, généralement de 1 (« pas du tout d'accord ») à 5 (« tout à fait d'accord »). On mélange des affirmations **positives** et **négatives** pour limiter les réponses automatiques, et l'on **inverse** le score des affirmations négatives (score inversé = 6 − réponse) avant d'additionner.

Exemple – Calcul détaillé : score d'attitude envers les légumes secs

Affirmations : A1 « Les légumes secs sont bons pour la santé » (+) ; A2 « Les légumes secs sont difficiles à cuisiner » (−) ; A3 « Mes enfants aimeraient les légumes secs » (+) ; A4 « Les légumes secs, c'est un plat du pauvre » (−) ; A5 « J'aimerais en cuisiner plus souvent » (+). Réponses de Mme D. : A1 = 4 ; A2 = 5 ; A3 = 2 ; A4 = 3 ; A5 = 4.

- Inversion des items négatifs : A2 : 6 − 5 = **1** ; A4 : 6 − 3 = **3**.
- Score total : 4 + 1 + 2 + 3 + 4 = **14** sur un maximum de 5 × 5 = **25** (minimum 5).
- Score ramené sur 100 : (14 − 5) / (25 − 5) × 100 = 9 / 20 × 100 = **45 / 100**.
- **Lecture** : attitude plutôt neutre, avec un frein majeur sur la **difficulté perçue** (A2 = 1 après inversion) : un atelier pratique renforçant le sentiment d'efficacité personnelle (Bandura) est prioritaire ; l'image « plat

du pauvre » (A4) appelle des recettes valorisantes.
Après le cycle d'ateliers : A1 = 5 ; A2 = 2 ; A3 = 3 ; A4 = 2 ; A5 = 5. Inversions : A2 : 6 − 2 = 4 ; A4 : 6 − 2 = 4.
Total : 5 + 4 + 3 + 4 + 5 = **21** ; sur 100 : (21 − 5) / 20 × 100 = **80 / 100** (+ 35 points).

L'évocation hiérarchisée et l'analyse prototypique

Méthode pas à pas – Recueillir une représentation sociale par évocation (Vergès, 1992)

1. Poser une consigne d'**association libre** : « Quels sont les 3 à 5 mots qui vous viennent à l'esprit quand on dit "manger équilibré" ? »
2. Noter les mots dans l'**ordre** où ils sont cités (rang 1, 2, 3…).
3. Regrouper les mots de même sens (« cher », « coûte cher », « prix »).
4. Calculer pour chaque mot sa **fréquence** (nombre de personnes qui le citent) et son **rang moyen** d'apparition.
5. Fixer deux seuils : une fréquence (souvent la fréquence médiane ou un seuil choisi) et le rang moyen général.
6. Classer les mots dans un tableau à quatre cases : le **noyau central** probable (mots fréquents et cités tôt), les périphéries, les éléments contrastés.

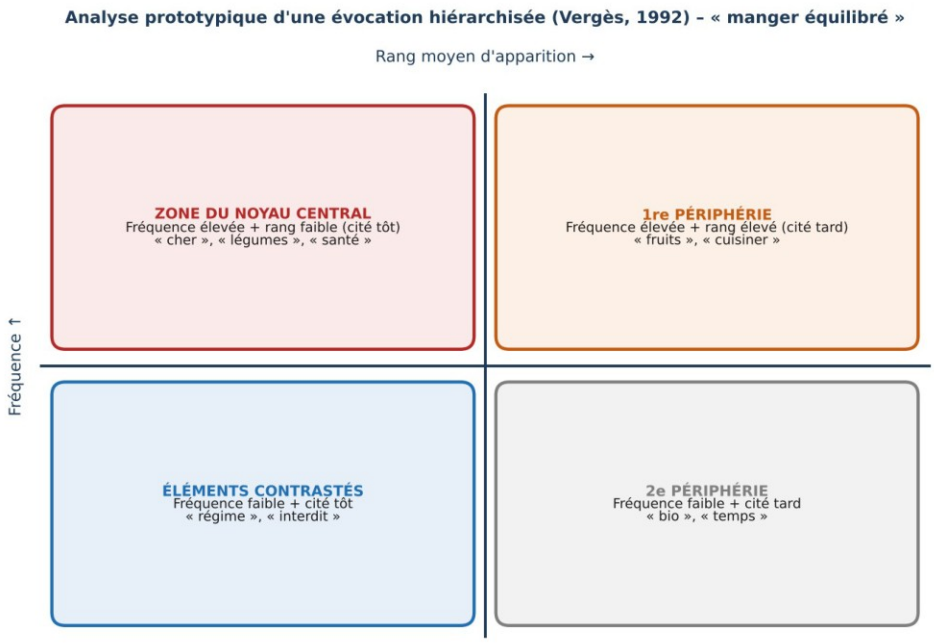


Figure 3.8 – L'analyse prototypique d'une évocation

Exemple – Calcul détaillé : la représentation de « manger équilibré » chez 30 parents

Mot (regroupé)	Fréquence	Rang moyen	Fréquence × rang
cher	21	1,6	33,6
légumes	18	1,9	34,2
fruits	16	2,9	46,4
santé	15	2,1	31,5
cuisiner	13	3,2	41,6
régime	6	1,8	10,8
interdit	5	2,0	10,0

Mot (regroupé)	Fréquence	Rang moyen	Fréquence × rang
temps	5	3,1	15,5
bio	4	3,4	13,6
Total	103		237,2

- Rang moyen général = somme (fréquence × rang) / somme des fréquences = 237,2 / 103 = **2,30**.
- Seuil de fréquence retenu : **10** (au moins un tiers des personnes).
- **Noyau central** probable (fréquence ≥ 10 et rang < 2,30) : **cher** (1,6), **légumes** (1,9), **santé** (2,1).
- **1re périphérie** (fréquence ≥ 10 et rang ≥ 2,30) : **fruits** (2,9), **cuisiner** (3,2).
- **Éléments contrastés** (fréquence < 10 et rang < 2,30) : **régime** (1,8), **interdit** (2,0) : une minorité associe l'équilibre à la privation.
- **2e périphérie** : **temps** (3,1), **bio** (3,4).

Interprétation : pour ces parents, « manger équilibré » est d'abord lié au **coût** et à la **santé** : le projet doit démontrer qu'on peut manger équilibré à petit prix (argument central), sans moraliser ; les éléments « régime » et « interdit » signalent un risque de restriction cognitive chez quelques personnes (chapitre 4). Le noyau central étant stable et résistant, on ne cherche pas à le « supprimer » mais à le **faire évoluer** par l'expérience (calcul du coût par portion en atelier).

Attention – Limites

L'analyse prototypique repère un noyau central **probable** ; sa confirmation demande d'autres méthodes (questionnaires de mise en cause). Sur de petits effectifs, les seuils sont fragiles : présentez les fréquences et restez prudent.

Le différenciateur sémantique

Définition – Différenciateur sémantique (Osgood, Suci et Tannenbaum, 1957)

Outil qui mesure la **signification** et l'**image** d'un objet (un aliment, un lieu, une action) à l'aide de paires d'adjectifs opposés placés aux deux extrémités d'une échelle, en général en 7 points. La personne coche la case qui correspond à son impression. On obtient un **profil** que l'on peut comparer entre groupes ou avant et après une action.

Calcul détaillé – L'image du « restaurant scolaire » chez 20 collégiens, avant et après un projet participatif (données fictives)

Échelle de 1 (adjectif de gauche) à 7 (adjectif de droite). Moyennes du groupe :

Paire d'adjectifs	Avant	Après	Évolution
Bruyant – calme	2,1	3,4	+1,3
Pas bon – bon	3,0	4,6	+1,6
Ennuyeux – convivial	3,5	4,9	+1,4
Imposé – choisi	2,4	4,2	+1,8
Pour les petits – pour les grands	2,8	3,1	+0,3

- Moyenne générale avant : (2,1 + 3,0 + 3,5 + 2,4 + 2,8) / 5 = 13,8 / 5 = **2,76**.
- Moyenne générale après : (3,4 + 4,6 + 4,9 + 4,2 + 3,1) / 5 = 20,2 / 5 = **4,04**, soit **+1,28** point.

Lecture : la plus forte évolution porte sur « imposé – choisi » (+1,8), cohérente avec un projet où les élèves

ont participé au choix des menus (besoin d'**autonomie**, section 3.3.11). L'image « pour les petits » a très peu changé : c'est une piste pour la suite (repas à thème choisis par les 3e, décoration). Sur 20 élèves, ces écarts restent des **tendances** à confirmer.

Exploiter des réponses libres : l'analyse de contenu

Les entretiens, les groupes de parole et les questions ouvertes produisent des **réponses libres**. Pour les exploiter, on réalise une **analyse de contenu** (Bardin, 1977).

Méthode pas à pas – Réaliser une analyse de contenu thématique simple

1. **Retranscrire** fidèlement les réponses ou les notes, en anonymisant.
2. **Lire** l'ensemble une première fois sans rien coder (lecture flottante).
3. **Découper** le texte en unités de sens (une idée par unité).
4. **Construire une grille de thèmes** à partir des objectifs et de ce qui ressort (coût, temps, goût des enfants, santé, culture…).
5. **Coder** chaque unité dans un thème ; compter le nombre de personnes qui évoquent chaque thème.
6. **Illustrer** chaque thème par une ou deux citations courtes et anonymes.
7. **Interpréter** en lien avec les modèles (COM-B, croyances relatives à la santé) et faire relire le codage par une autre personne si possible.

Les qualités d'un outil de mesure

Qualité	Question	Comment la vérifier simplement
Validité	L'outil mesure-t-il bien ce qu'il prétend mesurer ?	Utiliser un outil déjà validé ; faire relire par des experts ; vérifier que les items couvrent tout le concept
Fidélité	Donne-t-il des résultats stables ?	Faire répondre deux fois les mêmes personnes à quelques jours d'écart (test-retest) ; vérifier la cohérence des items entre eux (alpha de Cronbach, Cronbach 1951 : une valeur d'au moins 0,70 est souvent jugée acceptable)
Sensibilité	Détecte-t-il un changement ?	Éviter les échelles trop courtes ; vérifier qu'au départ les réponses ne sont pas toutes au maximum (effet plafond)
Acceptabilité	Le public peut-il y répondre facilement ?	Pré-test, durée de passation, vocabulaire

Méthode pas à pas – Pré-tester un questionnaire d'attitudes

1. Faire passer le questionnaire à 5 à 10 personnes semblables au public visé, mais qui ne feront pas partie de l'enquête.
2. Chronométrer la passation.
3. Demander après chaque question : « Comment avez-vous compris cette question ? » (entretien cognitif).
4. Repérer les mots incompris, les questions qui orientent la réponse, les doubles questions (« Aimez-vous les fruits et les légumes ? »), les réponses manquantes.
5. Corriger puis, si les changements sont importants, refaire un court pré-test.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.26

Une étudiante prépare une échelle de Likert pour mesurer l'attitude de parents envers la cantine. Voici trois

items : 1) « Les repas de la cantine sont bons et équilibrés. » 2) « Ne pensez-vous pas que les enfants gaspillent trop ? » 3) « La cantine est bien. » a) Repérez le défaut de chaque item. b) Réécrivez-les. c) Comment vérifier que l'échelle est acceptable avant l'enquête ?

Corrigé

a) Item 1 : **double question** (on peut trouver les repas bons mais pas équilibrés). Item 2 : question **orientée** et posée sous forme interrogative alors qu'une échelle de Likert demande une affirmation. Item 3 : formulation **vague** (« bien » ne dit pas sur quoi porte le jugement). **b)** « Les repas de la cantine ont bon goût. » ; « Les repas de la cantine sont équilibrés. » ; « Les enfants laissent beaucoup de nourriture dans leur assiette. » ; « Mon enfant est content de manger à la cantine. » **c)** Par un **pré-test** auprès de 5 à 10 parents qui ne participeront pas à l'enquête : durée, compréhension de chaque item, vocabulaire, puis correction.

3.3.13 Un modèle intégrateur : COM-B et la roue du changement de comportement

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Les modèles présentés (croyances relatives à la santé, comportement planifié, étapes du changement, efficacité personnelle) éclairent chacun une partie du changement. Susan **Michie** et ses collègues (2011) ont proposé, à partir d'une revue de 19 modèles, un cadre **intégrateur** très utilisé en santé publique : le modèle **COM-B**, au cœur de la « roue du changement de comportement » (*Behaviour Change Wheel*).

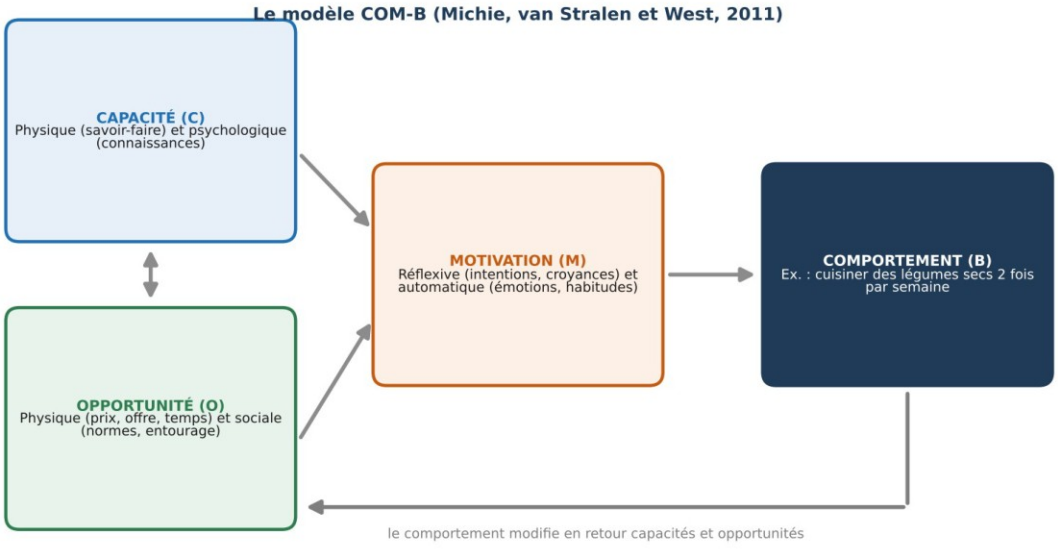


Figure 3.9 – Le modèle COM-B

Comprendre le schéma – Figure 3.9

1. Un **comportement** (B, *behaviour*) se produit quand trois conditions sont réunies : la **capacité** (C), l'**opportunité** (O) et la **motivation** (M).

2. Capacité : physique (savoir cuisiner, éplucher, utiliser un four) et psychologique (connaissances, compréhension, mémoire, organisation).

3. Opportunité : physique (prix, offre disponible, temps, équipement, accès) et sociale (normes, soutien de l'entourage, culture).

4. Motivation : réflexive (intentions, croyances, objectifs, identité) et automatique (émotions, désirs, habitudes, impulsions).

5. Capacité et opportunité influencent la motivation ; le comportement, une fois installé, renforce en retour

les capacités et les opportunités (on sait mieux faire, on achète autrement).

6. Intérêt : le diagnostic identifie **quelle composante manque** ; l'action est choisie en conséquence. Si le frein est l'opportunité (pas de commerce, pas de cuisine), une action purement informative (capacité psychologique) échouera.

Composante en défaut	Fonction d'intervention (roue du changement)	Exemple en nutrition
Capacité psychologique	Éducation (informer, faire comprendre)	Repères, lecture d'étiquettes
Capacité physique	Formation (apprendre des savoir-faire)	Atelier culinaire, gestes de découpe
Motivation réflexive	Persuasion, incitation	Témoignages, arguments d'économie, défis
Motivation automatique	Modélisation, aménagement de l'environnement, habitudes	Plats déjà prêts à goûter, routines (« légumes à chaque repas »)
Opportunité physique	Restructuration de l'environnement, facilitation	Fruits à la récréation, épicerie solidaire, micro-ondes en salle de pause
Opportunité sociale	Modélisation, soutien social, normes	Mamans relais, repas partagés, normes descriptives positives

Exemple – Analyse COM-B : pourquoi les familles ne cuisinent-elles pas de légumes secs ?

- **Capacité psychologique** : connaissances limitées sur la cuisson et l'intérêt nutritionnel (58 % « ne savent pas les cuisiner », chapitre 1).
- **Capacité physique** : peu de pratique (trempage, cuisson).
- **Opportunité physique** : produits disponibles à l'épicerie solidaire et peu chers (0,16 € la portion) : **pas de frein majeur** ; temps de cuisson perçu comme long (lentilles corail : 15 minutes).
- **Opportunité sociale** : représentation « plat du pauvre », enfants peu habitués.
- **Motivation** : réflexive favorable (envie d'économiser, 54 % demandent des ateliers) ; automatique défavorable (habitude des pâtes, des plats préparés).

Conclusion : les fonctions prioritaires sont la **formation** (atelier pratique), la **modélisation** (dégustation, mamans relais) et la **création d'habitudes** (recette « du mardi »), plutôt que l'information seule.

La roue du changement de comportement en entier

Le modèle COM-B est le **moyeu** d'une roue à trois anneaux (Michie, van Stralen et West, 2011). Autour de lui, **neuf fonctions d'intervention** ; à l'extérieur, **sept catégories de politiques** qui permettent de les mettre en œuvre.

Fonction d'intervention	Définition	Exemple en nutrition
Éducation	Augmenter les connaissances ou la compréhension	Atelier de lecture d'étiquettes
Persuasion	Utiliser la communication pour susciter des émotions positives ou négatives, ou stimuler l'action	Témoignage d'un pair qui a changé ses goûters
Incitation	Créer une attente de récompense	Chèques fruits et légumes dans une épicerie solidaire
Coercition	Créer une attente de sanction ou de coût	Taxe sur les boissons sucrées (créée en 2012, rendue progressive selon le sucre en 2018, relevée le 1er mars 2025)
Formation	Transmettre des savoir-faire	Atelier culinaire

Fonction d'intervention	Définition	Exemple en nutrition
Restriction	Utiliser des règles pour réduire les occasions d'un comportement	Interdiction des distributeurs automatiques payants dans les écoles (loi de 2004)
Restructuration de l'environnement	Changer le contexte physique ou social	Fontaines à eau, carafes sur les tables
Modélisation	Fournir un exemple à imiter	Animateur et parents qui goûtent devant les enfants
Facilitation	Réduire les obstacles ou augmenter les moyens	Garde d'enfants pendant l'atelier, transport

Catégorie de politique	Exemple
Communication et marketing	Campagnes « Manger Bouger »
Lignes directrices	Recommandations du PNNS, guide du GEM-RCN
Mesures fiscales	Taxe soda
Réglementation	Encadrement de la publicité alimentaire destinée aux enfants
Législation	Loi EGalim (2018) : 50 % de produits durables dont 20 % bio en restauration collective
Aménagement de l'environnement et de l'espace social	Jardins partagés, aménagement des selfs
Prestation de services	Consultations diététiques, ateliers de quartier

La taxonomie des techniques de changement de comportement

Pour décrire précisément ce que contient une intervention, Michie et ses collègues ont publié en 2013 une **taxonomie** de **93 techniques de changement de comportement** (en anglais *BCT Taxonomy v1*), regroupées en **16 groupes**. Elle permet de comparer les interventions et de savoir quels « ingrédients actifs » sont efficaces.

Exemple de technique (groupe)	Ce que fait l'intervenant
Fixation d'objectif comportemental (objectifs et planification)	Aide la personne à fixer un objectif précis
Planification de l'action (objectifs et planification)	Fait préciser quand, où et comment agir (« si..., alors... »)
Résolution de problèmes (objectifs et planification)	Fait identifier les obstacles et leurs solutions
Auto-surveillance du comportement (rétroaction et surveillance)	Propose un carnet pour noter les portions de légumes
Soutien social pratique (soutien social)	Organise un binôme de courses
Démonstration du comportement (modélisation)	Montre la découpe des légumes
Répétition et entraînement (répétition et substitution)	Fait refaire la recette plusieurs fois
Restructuration de l'environnement physique (antécédents)	Aide à ranger les fruits en vue dans la cuisine
Récompense non spécifique (récompense et menace)	Félicite le groupe

Méthode pas à pas – Concevoir une intervention avec la roue (huit étapes résumées)

1. Définir le problème en termes de comportement (qui doit faire quoi, où, quand).
2. Choisir le comportement cible le plus prometteur.
3. Le décrire précisément.
4. Identifier ce qui doit changer à l'aide de COM-B (diagnostic).
5. Choisir les fonctions d'intervention adaptées.
6. Choisir les catégories de politiques mobilisables.

7. Choisir les techniques de changement de comportement.
8. Choisir le mode de mise en œuvre (face-à-face, groupe, numérique, affichage).

À vous de jouer – Exercice d'application 3.27

Dans une résidence étudiante, le diagnostic montre que les étudiants mangent peu de légumes : ils disent ne pas savoir les cuisiner (1), la cuisine collective n'a qu'une plaque qui fonctionne (2), et « personne ne cuisine ici, on commande » (3). a) Classez chaque frein dans une composante de COM-B. b) Proposez une fonction d'intervention et une technique de changement de comportement pour chacun. c) Quelle catégorie de politique relève du gestionnaire de la résidence ?

Corrigé

a) (1) **Capacité physique** (savoir-faire) et psychologique ; (2) **opportunité physique** ; (3) **opportunité sociale** (norme du groupe), qui joue aussi sur la motivation automatique. **b)** (1) **Formation** : atelier « légumes en 15 minutes » ; techniques : démonstration du comportement, répétition et entraînement. (2) **Restructuration de l'environnement** et **facilitation** : réparer les plaques, fournir des ustensiles ; technique : restructuration de l'environnement physique. (3) **Modélisation** et soutien social : soirées « cuisine partagée » animées par des étudiants relais ; techniques : soutien social pratique, démonstration par des pairs. **c)** La **prestation de services** et l'**aménagement de l'environnement** (équipement de la cuisine, organisation de soirées) relèvent du gestionnaire.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.12 et 3.3.13 – Mesurer, et le modèle COM-B

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi mélange-t-on des affirmations positives et négatives dans une échelle de Likert ?
2. Dans une analyse prototypique, comment repère-t-on le noyau central probable ?
3. Distinguez validité et fidélité d'un outil de mesure.
4. Citez les trois composantes du modèle COM-B et leurs deux sous-composantes.
5. Citez cinq des neuf fonctions d'intervention de la roue du changement.
6. Combien de techniques compte la taxonomie de Michie (2013) ? À quoi sert-elle ?

Corrigé – Point d'étape 3.3.12 et 3.3.13

1. Pour limiter les réponses automatiques (tout cocher « d'accord ») ; on inverse les items négatifs avant le calcul.
2. Les mots à la fois fréquents (au-dessus du seuil de fréquence) et cités tôt (rang moyen inférieur au rang moyen général).
3. Validité : l'outil mesure bien ce qu'il prétend mesurer. Fidélité : il donne des résultats stables et cohérents.
4. Capacité (physique, psychologique), opportunité (physique, sociale), motivation (réflexive, automatique).
5. Éducation, persuasion, incitation, coercition, formation, restriction, restructuration de l'environnement, modélisation, facilitation.
6. 93 techniques en 16 groupes ; elle sert à décrire précisément le contenu d'une intervention et à comparer les interventions.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.

Mon score	Ce que je fais
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.14 Adapter l'approche psychosociale aux publics

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M5 S3 (p. 40 à 43) ; Synthèse M5 S4 (p. 44 à 46)

Public	Spécificités psychosociales	Leviers
Jeunes enfants (3-6 ans)	Néophobie, imitation, besoin de répétition et de jeu, dépendance aux adultes	Exposition répétée sans pression, éducation sensorielle, modèles adultes, implication des parents
Enfants (6-11 ans)	Curiosité, besoin de compétence, influence de l'école et des pairs	Activités pratiques, défis, jardinage, cuisine, valorisation
Adolescents	Autonomie, identité, appartenance au groupe, image corporelle, sensibilité au marketing	Pair-éducation, littératie critique, choix, pas de moralisation, vigilance TCA
Jeunes adultes, étudiants	Première autonomie alimentaire, budget, temps, isolement	Cuisine rapide et économique, convivialité, numérique accompagné
Parents	Préoccupation pour les enfants, culpabilité possible, contraintes de temps et de budget	Valoriser leurs compétences, solutions pratiques, déculpabiliser
Personnes âgées	Perte d'appétit, deuil, isolement, habitudes anciennes, peur de la dépendance	Lien social, plaisir, respect des habitudes, enrichissement, repérage de la dénutrition
Personnes en précarité	Priorités de survie, stress, honte, méfiance envers les institutions, faible pouvoir d'agir	Accueil inconditionnel, gratuité, concret, participation, pas de jugement, orientation vers les droits
Personnes migrantes	Acculturation, langue, attachement aux plats d'origine, nouveaux produits	Interculturalité, valorisation des cuisines d'origine, interprétariat, pictogrammes
Personnes en situation de handicap	Besoins spécifiques (cognitifs, moteurs, sensoriels), dépendance à l'entourage	FALC, adaptation du matériel, implication des aidants et des éducateurs

À vous de jouer – Exercice d'application 3.28

Un groupe de parole avec des parents d'adolescents révèle : « Mon fils mange tout le temps des chips devant ses jeux vidéo » ; « Ma fille ne mange plus le soir, elle veut maigrir » ; « Ils achètent des boissons énergisantes avec leur argent de poche ». Analysez chaque situation avec COM-B et proposez une fonction d'intervention.

Corrigé

a) Chips devant les jeux : **motivation automatique** (habitude, grignotage associé à l'écran) et **opportunité physique** (chips disponibles à la maison) → **restructuration de l'environnement** (collations disponibles : fruits, fromage, pain ; pas de stock de chips) et habitudes (pause collation hors écran). **b)** Restriction pour maigrir : **motivation réflexive** (désir de minceur, normes corporelles) avec risque de TCA → pas d'intervention éducative ciblée sur le poids ; **orientation** vers l'infirmière scolaire ou le médecin, travail des parents sur la non-stigmatisation et le plaisir du repas familial (chapitres 4 et 6). **c)** Boissons énergisantes : **opportunité sociale** (normes du groupe, marketing) et **motivation automatique** → **modélisation** et **persuasion** par des pairs, littératie critique du marketing, alternatives appréciées (eaux aromatisées maison).

Le développement de la personne, de l'enfance à la vieillesse

La **psychologie du développement** étudie l'évolution psychologique de la personne tout au long de la vie, de la période fœtale au vieillissement : développement moteur, cognitif, du langage, de l'identité, affectif et social.

Courant	Auteur repère	Idée principale
Maturationniste	Arnold Gesell	Le développement suit surtout un programme biologique
Béhavioriste	John B. Watson	L'environnement et les apprentissages façonnent le comportement
Psychanalytique	Sigmund Freud	Les relations et les expériences de l'enfance construisent le psychisme
Éthologique	Harry Harlow, John Bowlby	Le besoin de contact et d'attachement est inné, indépendant de la faim
Cognitivo-constructiviste	Jean Piaget	L'enfant construit son intelligence en agissant ; la maturation est nécessaire mais pas suffisante
Psychosocial	Henri Wallon	Aspects cognitifs, affectifs et sociaux sont liés

Aujourd'hui, la plupart des chercheurs ont une vision **modulaire** : chaque fonction (mémoire, langage, émotions, relations) a son propre rythme, et la prise en charge cherche les différents facteurs en cause.

- **Stades de Piaget** : sensori-moteur (0 à 2 ans), préopératoire (2 à 7 ans), opératoire concret (7 à 11 ans), opératoire formel (à partir de 11-12 ans).
- **Stade du miroir** (Jacques Lacan, 1936 et 1949), entre 6 et 18 mois environ : l'enfant prend son reflet pour un autre enfant (le **réel**), puis comprend que c'est une image (l'**imaginaire**), enfin la reconnaît comme la sienne (le **symbolique**). Il se distingue de sa mère et construit son **schéma corporel**.
- **Relation mère-enfant** (Winnicott) : dépendance absolue (premiers mois), dépendance relative, puis marche vers l'indépendance.
- **Adolescence** : remaniement biologique, psychique et social ; prise de distance avec les parents ; recours possible au passage à l'acte ou à l'idéalisation.
- **Adulte et personne âgée** : l'intelligence générale change peu jusqu'à 60 ou 70 ans ; la vitesse diminue, mais la **plasticité** permet d'apprendre à tout âge. Avec l'âge, la vulnérabilité augmente et l'adaptation devient plus difficile.

> **Lien diététique – Adapter l'éducation nutritionnelle à l'âge**
>
> Avant 7 ans, on passe par les sens, le jeu et la répétition ; entre 7 et 11 ans, par des manipulations concrètes (trier, peser, cuisiner) ; à partir de 12 ans, on peut discuter de notions abstraites et d'arguments ; chez l'adolescent, on respecte le besoin d'autonomie et le rôle des pairs ; chez la personne âgée, on s'appuie sur l'expérience et on laisse du temps.

La maladie, le stress et la fin de vie

- Le **diagnostic** change le statut de la personne (« je suis diabétique ») et peut bouleverser son équilibre psychique et social.
- L'approche **psychosomatique** (du grec *psyché*, l'esprit, et *soma*, le corps) étudie l'influence de l'esprit sur le corps.
- **Stress** : Hans Selye (1936) décrit le **syndrome général d'adaptation** en trois phases : **alarme** (adrénaline, cœur et respiration accélérés), **résistance** (cortisol, mobilisation du glucose), **épuisement** si le stress dure. Sur le plan digestif : « boule au ventre », nausées, troubles du transit, et souvent changement de l'appétit.
- **Faire face** (*coping*, Lazarus et Folkman, 1984) : agir sur la **cause** du stress (stratégie centrée sur le problème) ou réguler ses **émotions** (stratégie centrée sur l'émotion).

- **La mort** : autrefois à domicile et entourée de rites, elle se déroule aujourd'hui surtout à l'hôpital ; elle est plus « cachée ».

Lien diététique – Le rôle du diététicien auprès des malades et en fin de vie

Prendre conscience de ses propres représentations de la maladie et de la mort ; écouter les peurs et les souffrances de la personne ; en soins palliatifs, l'objectif n'est plus de corriger un état nutritionnel mais de préserver le **confort** et le **plaisir** de manger, en respectant les choix du patient et de ses proches.

3.3.15 Concevoir une séance qui développe les compétences psychosociales en nutrition

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Les compétences psychosociales (3.3.5) se développent par des **activités expérientielles** structurées, répétées sur plusieurs séances, et non par un discours. Santé publique France (2022) recommande des programmes d'au moins une dizaine de séances, conduits par des intervenants formés, avec des méthodes interactives. Une séance « nutrition » peut cibler explicitement une ou deux CPS.

Exemple – Conducteur d'une séance CPS « Je choisis mon goûter » (élèves de CM1, 1 h 15)

Durée	Étape et CPS visée	Déroulement	Matériel
10 min	Accueil – conscience de soi	Météo des émotions : chaque élève place son prénom sur un visage (content, fatigué, inquiet…) ; on explique que la faim et les émotions peuvent se confondre	Affiche des émotions
15 min	Ressentir – conscience de soi	Échelle de la faim (chapitre 4) : chaque élève situe sa faim avant le goûter ; échange sur « faim » et « envie »	Échelle illustrée
20 min	Analyser – pensée critique	Par groupes, comparaison de 4 emballages de goûters : ce que dit la publicité, ce que dit l'étiquette (sucres en morceaux de sucre)	Emballages, morceaux de sucre
15 min	Décider – prise de décision	Chaque groupe compose un goûter « qui donne de l'énergie, qui fait plaisir, qui coûte peu » parmi des cartes-aliments, et justifie son choix	Cartes-aliments, prix
10 min	Communiquer – affirmation de soi	Jeu de rôle : refuser poliment une boisson sucrée proposée par un camarade, proposer une alternative	Scénarios
5 min	Bilan – conscience de soi	« Ce que j'ai appris, ce que je ferai » ; feuille d'engagement facultative	Fiches

Pourquoi cette séance travaille des CPS : les élèves identifient leurs émotions et sensations (compétences **cognitives et émotionnelles** : conscience de soi), exercent leur **pensée critique** face au marketing, prennent une **décision** argumentée en groupe et s'**affirment** face à la pression des pairs (compétences **sociales**). La séance s'inscrit dans un **programme** (plusieurs séances) mené avec l'enseignant, et non dans une intervention isolée.

Attention – Ce qui n'est pas une séance CPS

Une conférence sur l'équilibre alimentaire, un quiz de connaissances ou une distribution de dépliants ne développent pas de compétences psychosociales : ils transmettent des informations. Une séance CPS fait **vivre** et **pratiquer** une compétence (identifier, analyser, décider, dire non, coopérer), dans un climat bienveillant, avec un temps de retour sur l'expérience.

3.3.16 Fil rouge : les représentations et les dynamiques du groupe des Tilleuls

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès a observé et comment elle l'a utilisé

- **Représentations recueillies** (photolangage « bien manger pour moi », 8 parents) : « bien manger = de la viande tous les jours » (noyau central fortement partagé) ; « les légumes coûtent cher » ; « les lentilles, c'est pour les gens pauvres » (représentation dévalorisante) ; « cuisiner prend du temps ».
- **Usage** : Inès n'a pas contredit ces représentations ; elle a agi sur les éléments **périphériques** : montrer un plat complet sans viande apprécié de tous (parmentier de lentilles, 4,3/5 en dégustation), calculer ensemble le coût par portion (1,38 € le repas complet), proposer des recettes de 20 minutes.
- **Dynamique de groupe** : une participante, Mme D., très appréciée, a goûté la première le dahl de lentilles (influence d'un « leader » positif) ; les autres ont suivi (conformisme favorable).
- **Engagement** : à la fin de chaque atelier, chacun choisissait librement une recette à refaire et l'annonçait au groupe ; à l'atelier suivant, les essais étaient valorisés.
- **CPS travaillées** : prise de décision (menu à 10 €), communication (cuisiner en binôme), estime de soi (photos des plats exposées au centre social, avec accord).
- **Interculturalité** : l'atelier 6 « recettes du monde » a permis à trois mères de transmettre un plat de leur pays (tiep, chorba, dal) : valorisation identitaire et stratégie d'**intégration**.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : mesures et animation du groupe des Tilleuls

- **Évocation hiérarchisée** : en complément du photolangage, Inès a recueilli les mots associés à « manger équilibré » auprès de **30 parents** lors de la passation du questionnaire (analyse détaillée en 3.3.12 : noyau central probable « cher », « légumes », « santé »). Les deux méthodes convergent : la question du **coût** est centrale, et la **viande** reste, pour beaucoup, la marque d'un « vrai repas ».
- **Score d'attitude** envers les légumes secs (échelle de Likert à 5 items, sur 100) : moyenne des 12 participants **48/100** au 1er atelier, **74/100** au 6e (+ 26 points) ; l'item « difficiles à cuisiner » est celui qui a le plus progressé, ce qui confirme l'effet des ateliers pratiques sur le **sentiment d'efficacité personnelle**.
- **Étapes du groupe** : l'atelier 2 a connu une phase de **turbulence** (désaccord sur le partage des tâches et sur l'usage du téléphone) ; Inès a proposé au groupe d'établir lui-même ses règles (« téléphone en silencieux, chacun goûte s'il le souhaite, on range ensemble ») : **normalisation** dès l'atelier 3 ; à l'atelier 5, deux mamans ont animé seules la préparation du crumble (**production**) ; l'atelier 6 et le temps fort ont préparé la **dissolution** (bilan, suite avec les mamans relais).
- **Style d'animation** : participatif pour les contenus (choix des recettes du monde), directif pour le cadre (hygiène, sécurité au four).
- **Écoute active** : face à une mère répétant « mes enfants ne mangent que des pâtes », Inès a d'abord reformulé (« c'est décourageant ») avant de proposer, avec le groupe, des « pâtes cachées aux légumes » : la mère a refait la recette deux fois.

3.3.17 Trois cas guidés pour s'entraîner à l'analyse psychosociale

Module · Référentiel et guide : voir 3.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Ces trois cas reprennent les notions du chapitre dans l'ordre où le jury les attend : décrire la situation, la relier à un modèle, calculer et lire des indicateurs, puis proposer une action argumentée. Essayez de répondre avant de lire chaque corrigé.

Cas guidé 1 – L'épicerie solidaire de Montclair (données fictives)

Une épicerie solidaire accueille 120 foyers. La conseillère en économie sociale et familiale constate que les

légumes frais proposés à petit prix partent mal. Elle sollicite un diététicien. Un questionnaire est rempli par **40 bénéficiaires** volontaires.

- Étapes du changement pour « cuisiner des légumes frais au moins 4 fois par semaine » : précontemplation 10 ; contemplation 14 ; préparation 8 ; action 5 ; maintien 3.
- Scores moyens (échelle de 1 à 5) : attitude envers les légumes 4,1 ; norme subjective 3,6 ; intention 3,0. Contrôle perçu, trois items : « J'ai le temps de les cuisiner » 2,6 ; « J'ai le matériel nécessaire » 2,4 ; « Je sais comment les cuisiner » 1,6.
- Verbatims : « Les légumes, je ne sais pas quoi en faire à part la soupe » ; « Mes enfants veulent des frites » ; « Chez moi, il n'y a qu'une plaque électrique ».

Questions – Cas guidé 1

1. Calculez la répartition des 40 bénéficiaires selon les étapes du changement et le score moyen de contrôle perçu.
2. Interprétez les résultats avec la théorie du comportement planifié.
3. Analysez la situation avec le modèle COM-B.
4. Proposez deux actions, en précisant les fonctions d'intervention et l'étape du changement visée.

Corrigé – Cas guidé 1

1. Précontemplation 10 / 40 = **25,0 %** ; contemplation 14 / 40 = **35,0 %** ; préparation 8 / 40 = **20,0 %** ; action 5 / 40 = **12,5 %** ; maintien 3 / 40 = **7,5 %**. Contemplation et préparation réunissent 22 personnes, soit **55,0 %** : plus de la moitié du groupe envisage de changer sans être passée à l'action. Contrôle perçu moyen : (2,6 + 2,4 + 1,6) / 3 = 6,6 / 3 = **2,2 sur 5**.

2. L'**attitude** est favorable (4,1) et la **norme subjective** plutôt favorable (3,6), mais le **contrôle perçu** est faible (2,2), surtout pour le savoir-faire (1,6). Selon Ajzen, le contrôle perçu limite l'intention (3,0, moyenne) et agit aussi directement sur le comportement : informer sur les bienfaits des légumes (attitude) serait inutile, puisque les bénéficiaires en sont déjà convaincus.

3. **Capacité physique et psychologique** insuffisante (« je ne sais pas quoi en faire ») ; **opportunité physique** limitée (une seule plaque, peu de matériel) ; **opportunité sociale** en partie défavorable (préférences des enfants) ; **motivation réflexive** plutôt favorable ; **motivation automatique** orientée par les habitudes (frites, soupe).

4. Action 1 : **atelier culinaire** « légumes avec une seule plaque » (poêlées, légumes râpés, gratins au four de l'épicerie si possible) : fonctions **formation** et **facilitation** ; techniques : démonstration, répétition, plan « si…, alors… » ; public visé : étapes de **contemplation** et de **préparation**. Action 2 : **dégustations** à l'épicerie avec fiches-recettes illustrées et prêt d'ustensiles, enfants invités à participer : fonctions **modélisation**, **restructuration de l'environnement** et facilitation ; elle touche aussi les personnes en **précontemplation**, sans exiger d'engagement.

Cas guidé 2 – Une séance qui dérape (extrait)

Lors de la deuxième séance d'un cycle avec 10 parents d'un quartier prioritaire, une animatrice stagiaire aborde les boissons sucrées. Voici un extrait de l'échange.

1. **Animatrice** : « Qui boit du soda à la maison ? »
2. **M. B.** : « Nous, tous les jours. Les enfants adorent. »
3. **Animatrice** : « Ce n'est vraiment pas bien, un litre de soda contient environ 100 grammes de sucre. »
4. **Mme L.** : « Oui mais l'eau du robinet, chez nous, elle a un goût. »
5. **Animatrice** : « Vous pouvez la mettre au frigo dans une carafe, c'est simple. Et vous savez que c'est mauvais pour les dents ? »

6. M. B. : « De toute façon, on a toujours fait comme ça et personne n'est malade. »
7. Mme T. (qui ne parlait pas) : « Moi j'ai arrêté les sodas, je fais de l'eau avec du citron. »
8. Animatrice : « Très bien ! Voilà, vous voyez, c'est possible. »
9. M. B. se tait et regarde son téléphone jusqu'à la fin.

Questions – Cas guidé 2

1. Identifiez l'attitude de Porter utilisée en 3 et en 5.
2. Quel phénomène décrit par l'entretien motivationnel se produit entre 3 et 6 ? Comment se manifeste-t-il ?
3. À quelle étape de la vie du groupe sommes-nous ? Le désaccord est-il un problème ?
4. Comptez les questions et les reflets de l'animatrice et calculez le rapport reflets / questions. Commentez.
5. Réécrivez les répliques 3, 5 et 8 dans l'esprit de l'entretien motivationnel.

Corrigé – Cas guidé 2

1. En 3 : **évaluation** (jugement : « ce n'est vraiment pas bien ») suivie d'une information non demandée. En 5 : **solution** (conseil immédiat), puis question fermée orientée qui sonne comme un nouveau jugement.

2. Le **réflexe correcteur** de l'animatrice provoque la **résistance** et le **discours-maintien** (« de toute façon, on a toujours fait comme ça ») ; M. B. finit par se retirer de l'échange (réplique 9), ce qui est aussi une forme de résistance. Plus l'animatrice argumente pour le changement, plus le parent défend le statu quo.

3. Deuxième séance : fin de la **formation** et début de la **turbulence** (Tuckman). Le désaccord est **normal** et signe l'implication ; le problème vient de la façon dont il est traité (jugement), qui risque de faire perdre un participant.

4. Questions : répliques 1 et 5, soit **2** questions. Reflets : **aucun** (la réplique 8 est une valorisation, pas un reflet). Rapport reflets / questions = 0 / 2 = **0** : très loin du repère d'au moins 1 (MITI 4). L'animatrice informe et juge au lieu d'écouter.

5. Réplique 3 : « Les sodas font partie des habitudes de la famille, les enfants y sont attachés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? » Réplique 5 : « Le goût de l'eau vous gêne. Voulez-vous que je vous donne quelques idées que d'autres familles utilisent ? » (demander la permission, puis informer). Réplique 8 : valoriser sans opposer : « Merci, Mme T. Vous avez trouvé votre façon de faire. Chaque famille a ses habitudes ; qu'est-ce qui pourrait être faisable chez vous, même un petit peu ? », en s'adressant au groupe et non à M. B. seul.

Cas guidé 3 – Évaluer un cycle d'ateliers en résidence autonomie (données fictives)

Une diététicienne anime un cycle de 6 ateliers sur 3 mois avec 10 résidents d'une résidence autonomie. L'objectif est de favoriser un **dîner complet** (avec une source de protéines), car beaucoup de résidents se contentent d'une soupe ou d'un café au lait le soir. Avant le premier et après le dernier atelier, chaque résident répond à une échelle de Likert de 5 items (score de 5 à 25) sur son attitude envers le dîner complet, et indique son étape du changement.

- Scores avant : 12, 15, 9, 18, 11, 14, 16, 10, 13, 17.
- Scores après : 17, 18, 15, 19, 12, 20, 21, 11, 18, 22.
- Étapes avant : précontemplation 3, contemplation 4, préparation 2, action 1, maintien 0.
- Étapes après : précontemplation 1, contemplation 2, préparation 3, action 4, maintien 0.

Questions – Cas guidé 3

1. Calculez le score moyen avant et après, son évolution, et les scores moyens ramenés sur 100.
2. Calculez la médiane avant et après. Combien de résidents ont progressé de plus de 1 point ?

3. Décrivez l'évolution des étapes du changement. Pourquoi aucun résident n'est-il au stade du maintien ?

4. Citez quatre limites de cette évaluation.

Corrigé – Cas guidé 3

1. Somme avant : 135, moyenne **13,5** ; somme après : 173, moyenne **17,3** ; évolution **+3,8 points**. Sur 100 : avant (13,5 − 5) / 20 × 100 = **42,5** ; après (17,3 − 5) / 20 × 100 = **61,5** ; soit **+19 points** sur 100.

2. Scores avant rangés : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ; médiane = (13 + 14) / 2 = **13,5**. Scores après rangés : 11, 12, 15, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22 ; médiane = (18 + 18) / 2 = **18,0**. Les écarts individuels sont 5, 3, 6, 1, 1, 6, 5, 1, 5, 5 : les 10 résidents ont progressé, mais **3** seulement de 1 point ; **7 sur 10** ont progressé de plus de 1 point.

3. Les personnes en précontemplation passent de 3 à 1 et celles en action de 1 à 4 : le groupe a globalement **avancé** dans le cycle. Aucun résident n'est en **maintien**, car ce stade suppose un changement installé depuis **plus de 6 mois** et le cycle n'a duré que 3 mois ; il faudra une nouvelle mesure à 6 mois au moins.

4. Effectif très faible (10 personnes) : on parle de **tendances** ; **pas de groupe témoin** (l'évolution pourrait être due à autre chose, par exemple un changement de menu à la résidence) ; **désirabilité sociale** (les résidents peuvent répondre ce qu'ils pensent que la diététicienne attend) ; mesure de l'**attitude** et de l'étape déclarée, pas du comportement réel (il faudrait un relevé des dîners) ; pas de recul sur la durée.

3.4 Approfondissements

3.4.1 Néophobie alimentaire et exposition répétée

La **néophobie alimentaire** (réticence à goûter des aliments nouveaux) est maximale entre 2 et 6 ans ; elle est normale et adaptative (protection contre les aliments dangereux). Elle diminue avec l'**exposition répétée** : proposer un aliment 8 à 15 fois, sans pression, en petites quantités, dans un contexte agréable, augmente son acceptation. La **pression** (« finis ton assiette ») et la **récompense** par un dessert (« si tu manges tes légumes, tu auras un gâteau ») sont contre-productives : elles dévalorisent l'aliment cible et valorisent l'aliment récompense. Le modèle parental (manger soi-même les légumes) et l'**éducation sensorielle** (toucher, sentir, décrire) sont efficaces.

Exemple – Exposition ou récompense ? (Wardle et collaborateurs, 2003)

Des enfants de 5 à 7 ans ont goûté chaque jour, pendant 8 jours, un légume qu'ils aimaient peu (du poivron rouge cru). Un groupe le goûtait simplement (exposition) ; un autre recevait un autocollant à chaque fois (exposition et récompense) ; un groupe témoin ne le goûtait pas. L'appréciation et la quantité consommée ont augmenté dans le groupe **exposition seule** ; l'ajout de la récompense n'a pas apporté de bénéfice supplémentaire clair. **Leçon** : la répétition, sans pression et sans récompense, suffit ; la récompense n'est pas nécessaire et peut même nuire à long terme (effet de surjustification, section 3.3.11).

Définition – Néophobie et sélectivité alimentaire

- La **néophobie** est le refus des aliments **nouveaux** ou inconnus.
- La **sélectivité** (en anglais *picky eating*) est le refus d'une partie des aliments **familiers**, avec un répertoire alimentaire restreint.

Les deux sont fréquentes chez le jeune enfant et diminuent en général avec l'âge. Une sélectivité très marquée, avec perte de poids, retard de croissance ou détresse importante, doit faire penser à un trouble (par exemple le trouble d'évitement et de restriction de l'apport alimentaire, ARFID) et justifie une **orientation** médicale.

Calcul détaillé – L'échelle de néophobie alimentaire de Pliner et Hobden (1992)

L'échelle comporte **10 affirmations** notées de 1 (« pas du tout d'accord ») à 7 (« tout à fait d'accord »). Cinq affirmations expriment la néophobie (« Je n'aime pas les aliments que je ne connais pas ») ; cinq expriment l'ouverture (« J'aime goûter des aliments d'autres pays »). Les affirmations d'ouverture sont inversées (score inversé = 8 − réponse). Le score total va de **10 à 70** : plus il est élevé, plus la personne est néophobe.

Réponses de M. R., 45 ans, à un questionnaire d'atelier : items néophobes 6, 5, 6, 4, 5 (total **26**) ; items d'ouverture 2, 3, 1, 3, 2, inversés en 6, 5, 7, 5, 6 (total **29**).

- Score total : 26 + 29 = **55 sur 70**.
- Position sur l'étendue : (55 − 10) / (70 − 10) × 100 = 45 / 60 × 100 = **75 / 100**.

Lecture : M. R. est plutôt néophobe. Dans l'atelier, on lui propose de goûter en petite quantité, avec un aliment familier à côté, et on présente les nouveautés à partir de saveurs connues (épices douces, plats de son enfance revisités).

Méthode pas à pas – Organiser une exposition répétée en crèche ou à l'école

1. Choisir un aliment cible (un légume peu consommé) et prévoir **8 à 15** présentations.
2. Le proposer en **petite quantité**, à côté d'aliments connus, sous la même forme au début.
3. Laisser l'enfant le **toucher**, le sentir, le décrire, le recracher dans une serviette s'il le souhaite.
4. Montrer l'exemple : l'adulte en mange avec plaisir à la même table.
5. Ne jamais forcer, ne pas récompenser, ne pas punir ; féliciter simplement la curiosité.
6. Noter à chaque fois l'acceptation (refus, touche, goûte, mange) pour voir la progression et rassurer l'équipe et les parents.

3.4.2 Les normes sociales comme levier

Les campagnes fondées sur les **normes descriptives** (« 8 élèves sur 10 de ce collège boivent de l'eau à la récréation ») peuvent être plus efficaces que les injonctions, à condition que la norme présentée soit favorable et **vraie** : diffuser « 60 % des jeunes boivent des sodas tous les jours » risque au contraire de **normaliser** le comportement à éviter (effet boomerang).

Exemple – L'effet boomerang des normes descriptives (Schultz et collaborateurs, 2007)

Près de 300 foyers californiens ont reçu une information sur leur consommation d'électricité comparée à la moyenne de leur quartier (norme **descriptive**). Les foyers qui consommaient **plus** que la moyenne ont réduit leur consommation. Mais ceux qui consommaient **moins** l'ont augmentée : ils se sont rapprochés de la norme (effet **boomerang**). Lorsqu'on ajoutait un petit visage souriant pour les foyers économes (norme **injonctive** : approbation), l'effet boomerang disparaissait.

En nutrition : dire à des familles qui servent déjà des légumes chaque jour que « la moyenne des familles en sert 3 fois par semaine » peut les inciter à en servir moins. On associe toujours la norme descriptive à une **approbation** (« Bravo, vous faites partie des familles qui… »).

Exemple – Le parc de la forêt pétrifiée (Cialdini, 2003)

Dans un parc national américain, des visiteurs emportaient des morceaux de bois fossilisé. Un panneau indiquant que « de nombreux visiteurs ont emporté du bois pétrifié » (norme descriptive négative) a été associé à **7,92 %** de vols dans la zone test, contre **1,67 %** avec un panneau demandant simplement de ne pas emporter de bois (norme injonctive). **Leçon** : un message qui insiste sur le fait que « beaucoup de gens font le mauvais choix » rend ce choix normal. Les campagnes qui répètent que « la majorité des jeunes ne mangent

pas assez de fruits » risquent le même effet.

Méthode pas à pas – Construire un message fondé sur les normes sociales

1. Mesurer la pratique réelle du public (enquête, chapitre 18) et la **norme perçue** (« Selon vous, combien d'élèves de votre classe boivent de l'eau à la récréation ? »).
2. Repérer l'écart : le public surestime souvent les comportements défavorables de ses pairs.
3. Diffuser la pratique **réelle et favorable** (« 7 élèves sur 10 de ce collège boivent de l'eau à la récréation »), avec une source.
4. Ajouter une **approbation** et un moyen d'agir (« Des fontaines sont à votre disposition dans la cour »).
5. Évaluer : la norme perçue et la pratique ont-elles changé ?

À vous de jouer – Exercice d'application 3.29

Dans un lycée, une enquête montre que 62 % des élèves prennent un petit-déjeuner tous les jours, mais que les élèves pensent en moyenne que seulement 30 % de leurs camarades le font. Une affiche est en préparation : « Près de 4 lycéens sur 10 ne prennent pas de petit-déjeuner ! ». a) Quel est le risque de cette affiche ? b) Proposez un autre message. c) Quel indicateur suivre pour évaluer la campagne ?

Corrigé

a) Elle met en avant une norme descriptive **défavorable** (38 % sans petit-déjeuner) et renforce la fausse croyance que sauter le petit-déjeuner est courant : risque d'effet boomerang. **b)** « 6 lycéens sur 10 commencent la journée par un petit-déjeuner. Et vous ? Des idées rapides au foyer du lycée » (norme réelle, favorable, avec un moyen d'agir). **c)** La **norme perçue** (pourcentage estimé de camarades qui prennent un petit-déjeuner, qui devrait se rapprocher de 62 %) et la **pratique déclarée** avant et après la campagne.

3.4.3 L'influence des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux participent désormais à la socialisation alimentaire des jeunes : influenceurs promouvant des produits ou des régimes, images corporelles retouchées, défis alimentaires. Développer la **pensée critique** (CPS) et l'**éducation aux médias** fait partie de l'éducation pour la santé. Le diététicien, lorsqu'il communique lui-même sur les réseaux, veille à son **identité numérique** et à l'indépendance de ses messages (chapitre 15).

À retenir – Ce que dit la loi française

- Depuis le **1er octobre 2017** (décret n° 2017-738 du 4 mai 2017), les photographies publicitaires dont la silhouette d'un mannequin a été modifiée par logiciel doivent porter la mention « **photographie retouchée** ».
- La **loi n° 2023-451 du 9 juin 2023** encadre l'influence commerciale sur les réseaux sociaux : l'influenceur doit signaler clairement le partenariat (« publicité » ou « collaboration commerciale ») et indiquer « **image retouchée** » ou « **image virtuelle** » quand un visage ou une silhouette ont été modifiés ou créés par un logiciel. Elle interdit notamment la promotion de la chirurgie esthétique et de pratiques qui détournent des soins.

Mécanisme psychosocial	Sur les réseaux sociaux	Ce que l'on peut travailler en atelier
Comparaison sociale (Festinger, 1954)	On se compare à des images sélectionnées, retouchées et filtrées	Comparer une photo « avant » et « après » retouche ; parler de mise en scène
Identification au modèle (Bandura)	L'influenceur paraît proche et sincère, comme un ami	Repérer les partenariats commerciaux et les codes promotionnels

Mécanisme psychosocial	Sur les réseaux sociaux	Ce que l'on peut travailler en atelier
Preuve sociale	Nombre de « j'aime » et de vues	Rappeler que la popularité ne prouve pas la véracité
Algorithme et bulle	Plus on regarde des contenus « minceur », plus on en reçoit	Montrer comment varier son fil, se désabonner, signaler
Biais de confirmation	On croit ce qui conforte nos idées	Vérifier une information sur deux sources fiables (chapitre 19)

Méthode pas à pas – Analyser une publication d'influenceur avec des adolescents

1. **Qui parle ?** Un professionnel de santé, une marque, un particulier ? A-t-il un intérêt commercial ?
2. **Que vend-on ?** Un produit, un régime, un mode de vie, une image du corps ?
3. **Quelles preuves ?** Une étude citée, un avant-après, un témoignage unique ?
4. **Quelles émotions ?** Envie, peur de manquer, culpabilité, admiration ?
5. **Qu'est-ce qui est absent ?** Le prix, les effets indésirables, la retouche, le sponsoring ?
6. **Qu'est-ce que j'en fais ?** Partager, ignorer, vérifier, en parler ?

À vous de jouer – Exercice d'application 3.30

Une influenceuse suivie par 400 000 abonnés publie une vidéo « Ma détox 3 jours aux jus pour un ventre plat », avec un code promo pour une marque de jus et une photo d'elle avant et après. a) Repérez trois mécanismes psychosociaux mis en jeu. b) Quelles obligations légales doit-elle respecter ? c) Proposez une activité de 20 minutes avec des élèves de seconde.

Corrigé

a) Identification au modèle (proximité, mise en scène de sa vie), **comparaison sociale** (photo avant-après, idéal du « ventre plat »), **preuve sociale** (400 000 abonnés). **b)** Indiquer clairement le partenariat (« publicité » ou « collaboration commerciale ») et la mention « image retouchée » si la photo a été modifiée (loi du 9 juin 2023). **c)** En petits groupes, les élèves appliquent la grille en six questions à la vidéo, puis comparent le prix de la cure à celui de fruits frais et d'eau ; la mise en commun porte sur le message « pour un ventre plat » (aucune base scientifique, corps idéal unique) et sur ce que l'on peut faire (ne pas partager, signaler, en parler).

3.4.4 La pair-éducation et les personnes relais

La **pair-éducation** consiste à confier une partie de l'action éducative à des personnes **du même groupe** que le public (âge, situation, culture) : lycéens ambassadeurs, mamans relais, étudiants relais santé, médiateurs pairs. Elle s'appuie sur la crédibilité et la proximité des pairs (normes sociales, identification) et favorise la participation. Ses conditions de réussite : recrutement volontaire, **formation** des pairs (contenus et posture), accompagnement régulier par un professionnel, reconnaissance (attestation, valorisation), limites claires (le pair n'est pas un professionnel de santé et oriente).

Méthode pas à pas – Monter un projet de pair-éducation en nutrition

1. **Définir le rôle des pairs** : informer ? animer un stand ? accompagner un groupe ? Le rôle reste limité et clair.
2. **Recruter** des volontaires, reconnus par le groupe (et pas seulement les « bons élèves »), avec l'accord des parents s'ils sont mineurs.
3. **Former** sur quelques messages simples, sur la posture (écoute, non-jugement, confidentialité) et sur les limites : savoir orienter vers un adulte ou un professionnel.

4. **Coconstruire** les outils avec les pairs : ils connaissent les codes et le langage du groupe.
5. **Accompagner** : temps de retour réguliers, soutien en cas de difficulté.
6. **Reconnaître** : attestation, valorisation dans le parcours scolaire ou professionnel, rétribution si c'est prévu.
7. **Évaluer** : nombre de pairs formés, actions réalisées, perception du public, effets sur les pairs eux-mêmes (estime de soi, compétences).

Atout de la pair-éducation	Limite ou risque	Réponse
Crédibilité et proximité culturelle	Diffusion de messages inexacts	Formation, supports validés, relecture
Langage adapté	Pression sur le pair, qui devient « le spécialiste »	Rôle limité, soutien d'un professionnel
Effet sur les normes du groupe	Recrutement biaisé (toujours les mêmes)	Recrutement ouvert, diversité des profils
Bénéfices pour les pairs eux-mêmes	Épuisement, départs	Reconnaissance, rotation, binômes

À vous de jouer – Exercice d'application 3.31

Une mission locale veut former 6 jeunes « ambassadeurs de l'alimentation » parmi les jeunes accompagnés. a) Expliquez pourquoi des pairs peuvent être plus efficaces qu'un professionnel, en citant deux notions du chapitre. b) Donnez trois contenus de leur formation. c) Citez deux limites et la façon de les prévenir.

Corrigé

a) Les pairs appartiennent au **groupe de référence** des jeunes : l'**identification** et l'apprentissage par **observation** (Bandura) sont plus forts ; ils font évoluer les **normes** du groupe de l'intérieur ; leur message ne déclenche pas la **menace identitaire** que peut provoquer un discours d'« expert ». **b)** Quelques messages simples sur les repas à petit budget ; l'écoute active (questions ouvertes, reformulation) ; les limites de leur rôle et les adresses vers lesquelles orienter (infirmière, médecin, aide alimentaire). **c)** Messages inexacts : formation et supports validés par le diététicien ; surcharge ou isolement des ambassadeurs : binômes, réunion mensuelle avec un professionnel, reconnaissance (attestation de compétences).

3.4.5 La motivation des enfants et des adolescents

Chez l'**enfant**, l'imitation des adultes et des pairs, l'exposition répétée, le jeu et le plaisir sensoriel priment sur l'information ; les récompenses alimentaires et la pression (« finis ton assiette ») sont contre-productives. Chez l'**adolescent**, la recherche d'**autonomie**, l'appartenance au groupe et l'image de soi dominent : les messages de santé à long terme le touchent peu ; on mise sur l'autonomie (choisir, cuisiner seul), la critique du marketing (« ne pas se faire manipuler »), la performance sportive ou l'énergie, et la participation des jeunes à la conception de l'action.

Le modèle du **partage des responsabilités** d'Ellyn Satter (le parent décide quoi, quand et où ; l'enfant décide s'il mange et combien) est présenté au chapitre 4 (section 4.3.9). La psychologie sociale explique pourquoi certaines stratégies parentales très répandues produisent l'effet inverse de celui recherché : elles agissent sur la **motivation** de l'enfant et sur le **sens** qu'il donne aux aliments.

Stratégie parentale fréquente	Effet probable	Alternative
« Finis ton assiette. »	Apprend à ignorer la sensation de rassasiement	« Tu as encore faim ? » ; servir de petites portions, se resservir si besoin
« Si tu manges tes légumes, tu auras un dessert. »	Le légume devient une corvée, le dessert une récompense	Servir le dessert prévu sans condition ; proposer le légume régulièrement

Stratégie parentale fréquente	Effet probable	Alternative
« Tu ne sortiras pas de table tant que… »	Associe le repas à la contrainte et à la colère	Repas d'une durée raisonnable, sans conflit
Interdire totalement les sucreries	Augmente l'envie et la consommation quand l'aliment est disponible	Les intégrer de façon prévisible (au goûter du mercredi)
Laisser l'enfant choisir tout son repas	Répertoire restreint, conflits	Proposer un choix limité (« carottes ou haricots ? »)

Lien diététique – L'adolescent, entre autonomie et appartenance

Avec les adolescents, on transforme le besoin d'autonomie en levier : leur confier un vrai **rôle** (choisir et cuisiner le repas de la classe, gérer un budget), leur donner des arguments pour **ne pas se faire manipuler** par le marketing, parler des bénéfices **immédiats** (énergie, sport, concentration) plutôt que de la santé dans trente ans, et les associer à la **conception** des actions qui leur sont destinées. On évite toute référence au poids et toute moralisation.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.32

Au cours d'un atelier parents-enfants, une mère dit : « Mon fils de 5 ans ne mange rien à table, alors je lui promets des bonbons s'il finit ses haricots. » a) Analysez cette stratégie avec deux notions du chapitre. b) Proposez trois conseils fondés sur le partage des responsabilités. c) Quelle posture adoptez-vous pour formuler ces conseils ?

Corrigé

a) La récompense crée une **motivation extrinsèque** et un effet de **surjustification** : l'enfant apprend que les haricots sont une corvée et les bonbons un trésor ; « finir » l'assiette l'éloigne de ses sensations de **rassasiement**. **b)** Servir de petites portions et laisser l'enfant décider combien il mange ; proposer les haricots régulièrement, sans pression, en en mangeant soi-même (**exposition répétée**, modélisation) ; servir le dessert prévu sans condition et ne pas utiliser les bonbons comme récompense. **c)** Une posture d'**écoute** et de non-jugement : reformuler d'abord la difficulté (« ces repas sont fatigants pour vous »), demander la permission avant d'informer, et s'appuyer sur ce que la mère réussit déjà.

3.4.6 Les émotions dans l'apprentissage

Les émotions **positives** (plaisir, fierté, convivialité) favorisent la mémorisation et l'envie de refaire ; la **peur** et la **honte** peuvent provoquer l'évitement (ne plus venir, ne plus parler). Les messages fondés sur la peur ne sont efficaces que si la personne se sent capable d'agir (sentiment d'efficacité) ; en nutrition, ils sont à éviter auprès des publics vulnérables (stigmatisation, chapitre 6).

Définition – Le modèle des processus parallèles étendu (Witte, 1992)

Face à un message qui fait peur, la personne évalue d'abord la **menace** (est-ce grave ? suis-je concerné ?), puis son **efficacité** (la solution proposée marche-t-elle ? suis-je capable de l'appliquer ?).

- Menace **forte** et efficacité **forte** : la personne cherche à **contrôler le danger** (elle change).
- Menace **forte** et efficacité **faible** : elle cherche à **contrôler sa peur** (déni, évitement, rejet du message, « de toute façon, on mourra tous de quelque chose »).
- Menace **faible** : le message est ignoré.

Conséquence : un message qui fait peur doit toujours être accompagné d'une solution concrète, à la portée de la personne. En nutrition, auprès des publics vulnérables, on préfère les messages positifs.

3.4.7 Précarité alimentaire : honte, dignité et pouvoir d'agir

La précarité ne se réduit pas au manque d'argent : elle a des effets **psychosociaux** qui conditionnent la participation aux actions de prévention.

Effet psychosocial	Manifestation	Conséquence pour l'action
Honte et peur du jugement	Ne pas oser dire qu'on manque, cacher le recours à l'aide alimentaire	Accueil discret, non-jugement, pas de questions intrusives devant le groupe
Stigmatisation	Être vu comme « assisté », « mauvais gestionnaire »	Valoriser les compétences (gérer avec peu est une compétence)
Charge mentale et stress	Préoccupations multiples (logement, dettes), moins de disponibilité pour planifier	Actions courtes, concrètes, peu de prérequis
Préférence pour le présent	Priorité à ce qui est sûr et rassasiant aujourd'hui	Recettes nourrissantes et appréciées, résultats immédiats
Non-recours aux droits	Ne pas demander une aide à laquelle on a droit (complexité, honte, méconnaissance)	Informer sur les droits, orienter, accompagner les démarches avec les travailleurs sociaux
Faible pouvoir d'agir	Sentiment de ne rien pouvoir changer	Participation aux décisions, choix, valorisation des réussites

Lien diététique – Les dispositifs qui préservent la dignité

Les **épiceries solidaires**, où l'on choisit ses produits et où l'on paie une petite participation, sont souvent préférées aux colis imposés, car elles respectent l'**autonomie** et la dignité. Les ateliers culinaires y trouvent toute leur place : ils partent des produits réellement disponibles et valorisent les savoir-faire des personnes.

3.4.8 Le numérique dans l'accompagnement du changement

Applications de suivi alimentaire, objets connectés, groupes de discussion en ligne, vidéos de recettes : le numérique offre de nouveaux outils pour accompagner le changement, avec des atouts et des risques.

Outil	Mécanisme psychosocial	Atout	Risque ou limite
Application de suivi des repas	Auto-surveillance, rétroaction	Prise de conscience, suivi des objectifs	Comptage obsessionnel, culpabilité, données personnelles de santé
Défis et badges (« ludification »)	Récompense, compétition	Motivation à court terme	Motivation externe, abandon rapide
Groupe de messagerie d'un atelier	Soutien social, normes du groupe	Lien entre les séances, partage de photos de plats	Confidentialité, horaires, exclusion des personnes peu équipées
Vidéos de recettes courtes	Modélisation, apprentissage par observation	Accessibles, visuelles, multilingues possibles	Recettes parfois peu réalistes, marketing caché
Téléconsultation de groupe	Accès facilité	Moins de déplacements	Fracture numérique, moindre convivialité

Attention – Numérique et inégalités

Une partie de la population n'a pas d'équipement adapté, de connexion suffisante ou de compétences numériques (illectronisme, chapitre 15). Un dispositif uniquement numérique creuse les inégalités sociales de santé. On propose toujours une alternative non numérique, et l'on respecte les règles de protection des données de santé (RGPD, chapitre 20).

À vous de jouer – Exercice d'application 3.33

Pour prolonger un cycle d'ateliers avec des familles d'un quartier prioritaire, une animatrice veut créer un groupe de messagerie et proposer une application qui attribue des points à chaque repas « équilibré ». a) Quels mécanismes psychosociaux sont mobilisés par chaque outil ? b) Citez deux risques pour chacun. c) Que proposez-vous pour les familles qui n'ont pas de smartphone ?

Corrigé

a) Le groupe de messagerie mobilise le **soutien social** et les **normes** du groupe ; l'application mobilise l'**auto-surveillance** et la **récompense**. **b)** Groupe : diffusion d'informations personnelles (confidentialité) et sollicitations à toute heure ou exclusion de ceux qui sont moins actifs ; application : motivation **externe** qui s'arrête avec les points, culpabilité ou comptage excessif, collecte de données de santé par un éditeur privé. **c)** Une rencontre mensuelle au centre social, des fiches-recettes papier et un affichage dans le hall, pour que personne ne soit exclu.

3.4.9 Les personnes âgées : vieillissement, isolement et plaisir de manger

Avec l'âge, les dimensions psychosociales de l'alimentation prennent une place majeure. Le repas structure la journée, maintient le lien social et l'identité ; sa perte de sens est un facteur de **dénutrition**, qui touche une part importante des personnes âgées vivant à domicile et davantage encore en établissement (HAS et FFAMCO, recommandations sur la dénutrition de la personne âgée, 2021).

Facteur psychosocial	Effet sur l'alimentation	Levier
Veuvage, deuil	Perte de l'envie de cuisiner « pour soi seul », perte du rôle de cuisinier ou absence de savoir-faire chez celui qui ne cuisinait pas	Repas partagés, ateliers « cuisiner pour une personne », soutien et écoute
Isolement social	Repas sautés ou réduits, monotonie	Restaurants seniors, portage de repas avec visite, activités collectives
Dépression	Perte d'appétit et de plaisir	Repérage et orientation vers le médecin
Perte d'autonomie	Difficulté à faire les courses, à porter, à cuisiner	Aide à domicile, livraison, ustensiles adaptés
Représentations	« À mon âge, on n'a plus besoin de manger beaucoup » ; peur du cholestérol ou du sucre héritée de régimes anciens	Information sur les besoins, levée des régimes restrictifs inutiles (avis médical)
Identité et habitudes	Attachement aux plats de toujours, refus de la nouveauté	Partir des plats familiers, valoriser l'expérience culinaire (réminiscence)

Lien diététique – L'atelier de réminiscence culinaire

Un atelier de **réminiscence** invite les personnes âgées à évoquer les plats de leur enfance, les fêtes, les marchés d'autrefois, à partir d'objets, de photos ou d'odeurs, puis à réaliser ensemble une recette d'antan, éventuellement enrichie (fromage, œuf, lait en poudre). Il mobilise l'**identité**, la **mémoire** et le **sentiment de compétence** (« je sais faire »), favorise le lien entre les participants et redonne du sens au repas. Il convient aussi aux personnes ayant des troubles cognitifs légers, avec un rythme adapté.

Attention – Âgisme

Les stéréotypes liés à l'âge (« les vieux ne changent pas », « ils ne comprennent rien au numérique ») sont une forme de **stigmatisation**. Ils conduisent à infantiliser (tutoiement, voix forte, « ma petite dame ») et à moins proposer d'activités. Les personnes âgées peuvent apprendre et changer : on s'adresse à elles comme à

des adultes, on respecte leurs choix et leur rythme.

3.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – La théorie de l'identité sociale (Tajfel et Turner, 1979)

Les individus cherchent une identité sociale positive en se comparant favorablement à d'autres groupes (favoritisme intra-groupe). Les expériences du « paradigme des groupes minimaux » ont montré qu'une catégorisation arbitraire suffit à créer une préférence pour son groupe. En alimentation, les pratiques (végétarisme, « manger local », cuisine d'origine) peuvent devenir des marqueurs de frontière entre groupes ; un message perçu comme venant d'un autre groupe (« les experts », « les bobos ») peut être rejeté pour des raisons identitaires plus que rationnelles.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Habitus et goûts de classe (Bourdieu, 1979)

Pour Pierre Bourdieu, l'**habitus** est un système de dispositions durables, acquis par la socialisation, qui oriente les goûts et les pratiques. Le « goût de nécessité » des classes populaires (aliments nourrissants, abondants, conviviaux) s'oppose au « goût de liberté » des classes favorisées (légèreté, forme, distinction). Ces analyses invitent à ne pas imposer aux classes populaires des normes nutritionnelles qui reflètent les goûts des classes favorisées, mais à partir de leurs propres valeurs (convivialité, générosité du repas).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le paradoxe de l'omnivore et la gastro-anomie (Fischler, 1990)

Le mangeur humain est pris entre **néophilie** (besoin de variété) et **néophobie** (méfiance) ; les cuisines et les règles culturelles résolvent ce paradoxe en encadrant ce qui est mangeable. Dans les sociétés modernes, l'affaiblissement des règles collectives (repas destructurés, offre surabondante, discours contradictoires des experts, des médias et de l'industrie) produit une **gastro-anomie** : le mangeur, laissé seul juge, devient anxieux. Le diététicien peut contribuer à **re-socialiser** l'alimentation (repas partagés, transmission culinaire) plutôt qu'à multiplier les injonctions.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les limites des modèles individuels du changement

Les modèles HBM, transthéorique ou du comportement planifié expliquent une part limitée des comportements (souvent moins de 30 à 40 % de la variance de l'intention et moins encore du comportement réel). Ils sous-estiment les **habitudes** (comportements automatiques déclenchés par le contexte), les **émotions** et les **déterminants sociaux**. Les approches récentes (modèle COM-B de Michie et coll., 2011 : capacité, opportunité, motivation) intègrent explicitement l'environnement (opportunité) et orientent vers des interventions combinant éducation, modification de l'environnement et incitations.

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'identité sociale (Tajfel et Turner, 1979)

La théorie de l'**identité sociale** explique que chacun tire une partie de son estime de soi de son appartenance à des **groupes** et tend à favoriser son groupe (favoritisme endogroupe). En alimentation, les pratiques signalent l'appartenance (« chez nous, on mange comme ça ») : un message perçu comme venant d'un groupe extérieur (« les diététiciens des beaux quartiers ») peut être rejeté pour préserver l'identité. D'où l'intérêt des pairs, de la valorisation des cultures d'origine et des recettes construites **avec** les participants.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Goût de nécessité et goût de liberté (Bourdieu, 1979)

Dans *La Distinction* (1979), Pierre Bourdieu montre que les goûts alimentaires sont socialement construits par l'**habitus** : les classes populaires valorisent un **goût de nécessité** (nourriture abondante, consistante, qui « tient au corps », convivialité), les classes favorisées un **goût de liberté** (légèreté, forme, raffinement, santé). Les messages nutritionnels, souvent produits par des professionnels issus des classes moyennes et supérieures, risquent d'imposer implicitement une norme de classe. Le diététicien gagne à reconnaître la légitimité de ces goûts (repas copieux et conviviaux) et à construire l'équilibre **à partir** d'eux.

3.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Consultation et étape du changement

Un patient diabétique dit : « De toute façon, je n'y arriverai jamais. » Le diététicien repère un faible **sentiment d'efficacité personnelle** et une étape de **contemplation** ; il fixe avec lui un objectif très accessible (expérience de réussite) et utilise les techniques de l'entretien motivationnel.

Situation bc2 – Introduire un nouveau plat en restauration scolaire

Un plat de légumineuses est refusé par les élèves. En s'appuyant sur la néophobie et l'exposition répétée, le diététicien propose de le servir régulièrement en petite quantité, de l'accompagner d'une animation (dégustation, nom attractif, implication d'élèves ambassadeurs) et d'observer le gaspillage sur plusieurs semaines.

Situation bc3 – Atelier avec des adolescents

Lors d'un atelier, des adolescents se moquent d'un camarade en surpoids. L'animateur intervient immédiatement pour rappeler les règles du groupe (respect, non-jugement), puis recentre l'activité sur le plaisir et les compétences, sans parler de poids : il prévient la **stigmatisation** et protège l'estime de soi de chacun.

Situation bc3 – Projet interculturel

Dans un centre d'hébergement, le diététicien conçoit un livret de recettes avec les résidents, à partir des plats de leurs pays adaptés aux produits disponibles : il favorise l'**intégration** (Berry) et l'**action communautaire** (Ottawa).

Situation bc1 – Écoute active en consultation

Un patient répond « oui, mais » à chaque conseil. Le diététicien repère son réflexe correcteur, passe à l'écoute réflective et à la balance décisionnelle ; le patient formule lui-même un premier objectif.

Situation bc3 – Un groupe en turbulence

Lors du 2e atelier d'un cycle pour des salariés, deux participants contestent les repères et se moquent des « recettes de régime ». Le diététicien accueille l'objection, la renvoie au groupe, rappelle le cadre et propose une dégustation comparée : la séance suivante, le groupe fixe ses propres règles.

Méthode 1 – Justifier un choix d'animation par un modèle, à l'oral

À l'oral de l'épreuve E5, le jury demande souvent : « Pourquoi avez-vous choisi cette technique ? » ou « Sur quel modèle vous êtes-vous appuyé ? ». Une réponse qui cite un modèle **sans le relier** au public et à l'action ne convainc pas.

Méthode pas à pas – La réponse en 4 temps

1. Le constat : ce que le diagnostic a montré sur le public (un chiffre, une citation).

2. Le modèle : son nom, son auteur, son année, et la composante qui éclaire le constat.

3. Le choix : la technique ou l'action retenue, et pourquoi elle agit sur cette composante.

4. La preuve : ce qui a été observé ou mesuré pendant ou après l'action.

À l'oral – Exemple de réponse

« Au questionnaire, les 18 parents interrogés trouvaient les légumes secs bons pour la santé, avec un score moyen de 4,2 sur 5, mais seulement 2,1 sur 5 pour l'affirmation "je sais les cuisiner". Selon la théorie du comportement planifié d'Ajzen (1991), c'est le contrôle perçu qui bloquait, pas l'attitude. J'ai donc choisi un atelier où chaque parent cuisinait lui-même un plat, plutôt qu'une présentation des bienfaits des légumineuses : c'est l'expérience de réussite, la source la plus forte du sentiment d'efficacité personnelle selon Bandura. À la fin du cycle, le score "je sais les cuisiner" est passé à 3,8 sur 5, et 11 parents sur 18 ont dit avoir refait une recette chez eux. » (Données de l'exemple fictives.)

Ce que le jury attend – Les erreurs fréquentes

- Réciter un modèle (les six étapes de Prochaska) sans dire à quoi il a servi dans le projet.
- Confondre **attitude** (ce que je pense) et **comportement** (ce que je fais), ou **norme descriptive** et **norme injonctive**.
- Annoncer une action « participative » alors que la séance était un exposé suivi de questions.
- Parler d'« éduquer » ou de « faire prendre conscience » sans dire quelle **compétence** a été travaillée.
- Oublier la **posture** : non-jugement, respect de l'autonomie, absence de stigmatisation.

Méthode 2 – Analyser une situation de groupe en quatre questions

Les sujets proposent souvent un extrait d'échange ou la description d'une séance difficile. Cette grille permet de ne rien oublier.

Question	Notions à mobiliser
1. Où en est le groupe ?	Étapes de Tuckman, rôles de Benne et Sheats, normes du groupe
2. Quelles influences jouent ?	Conformisme, leader, influence minoritaire, normes sociales, identité de groupe
3. Comment l'animateur communique-t-il ?	Attitudes de Porter, écoute active, réflexe correcteur, rapport reflets / questions, style d'animation
4. Que proposer ?	Technique d'animation adaptée, reformulation de la réplique, règle du groupe, suite de la séance

Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve

À vous de jouer – Vrai ou faux commentés

Pour chaque affirmation, dites si elle est vraie ou fausse et justifiez en une phrase.

1. « Une représentation sociale est une opinion personnelle. »
2. « Le noyau central d'une représentation change facilement. »
3. « Dans l'expérience de Lewin (1943), les conférences ont été plus efficaces que les discussions de groupe. »
4. « Une norme descriptive dit ce que l'on doit faire. »
5. « La dissonance cognitive conduit toujours à changer de comportement. »
6. « Un acte libre et public engage davantage qu'un acte contraint et privé. »
7. « La stigmatisation du poids motive les personnes à maigrir. »
8. « Les compétences psychosociales se développent par une information claire sur la santé. »
9. « La rechute fait partie du modèle de Prochaska et DiClemente. »
10. « Une forte intention garantit le comportement. »
11. « Il faut 21 jours pour créer une habitude. »
12. « 93 % de la communication est non verbale. »
13. « Récompenser un enfant qui goûte un légume augmente durablement son goût pour ce légume. »
14. « Un nudge peut supprimer une option pour orienter le choix. »
15. « Une échelle de Likert mélange des affirmations positives et négatives. »

Corrigé – Vrai ou faux commentés

1. Faux : c'est une connaissance **partagée** par un groupe, construite socialement (Moscovici, 1961).
2. Faux : il est stable et résistant ; ce sont les éléments périphériques qui changent d'abord (Abric).
3. Faux : environ 3 % contre 32 % ; la discussion et la décision de groupe ont été bien plus efficaces.
4. Faux : elle dit ce que **font** les autres ; c'est la norme injonctive qui dit ce qu'il faut faire.
5. Faux : la personne peut aussi changer sa croyance ou ajouter une justification, ce qui est souvent plus facile.
6. Vrai : liberté, caractère public, répétition et coût augmentent l'engagement (Kiesler ; Joule et Beauvois).
7. Faux : elle augmente le stress, l'évitement des soins et l'hyperphagie (Puhl et Heuer, 2009).
8. Faux : elles se développent par des activités **pratiques**, structurées et répétées (critères SAFE).
9. Vrai : elle est considérée comme une étape normale du processus.
10. Faux : il existe un écart intention-comportement ; les plans « si…, alors… » aident à le réduire (Gollwitzer, 1999).
11. Faux : 66 jours en valeur médiane, de 18 à 254 jours selon les personnes (Lally, 2010).
12. Faux : les chiffres de Mehrabian (1967) portent sur l'expression des sentiments dans des conditions très particulières.
13. Faux : la récompense attendue diminue la motivation intrinsèque (Lepper, Greene et Nisbett, 1973 ; Wardle, 2003).
14. Faux : un nudge laisse toutes les options accessibles ; supprimer une option est une restriction.
15. Vrai : cela limite les réponses automatiques ; les affirmations négatives sont inversées avant le calcul.

Mon score	Ce que je fais
14 ou 15 sur 15	Je suis prêt pour les sujets d'entraînement.
10 à 13 sur 15	Je relis les sections des affirmations manquées.
Moins de 10 sur 15	Je reprends les encadrés « À retenir » du chapitre et je refais les points d'étape.

3.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Concepts

- **Psychologie** (individu), **sociologie** (groupes, faits sociaux), **anthropologie** (cultures) ; la **psychologie sociale** étudie l'influence des autres sur l'individu.
- Repères : Lévi-Strauss (1964), Bourdieu (1979), **Fischler** (1990 : paradoxe de l'omnivore, incorporation, gastro-anomie), **Poulain** (2002 : espace social alimentaire).
- **Identité** individuelle et sociale (Tajfel et Turner, 1979) ; **socialisation** primaire (famille) et secondaire (école, pairs, travail, médias).
- **Représentations sociales** (Moscovici, 1961 ; noyau central et périphérie, Abric) ; **normes** descriptives et injonctives ; **valeurs** ; **attitudes**.
- **Culture**, **interculturalité** (décentration), **acculturation** spontanée / planifiée (Bastide) ; stratégies de **Berry** (1997) : intégration, assimilation, séparation, marginalisation.

À retenir – Groupe, CPS, changement

- **Lewin (1943)** : la discussion de groupe et la décision collective changent davantage les pratiques (≈ 32 %) que la conférence (≈ 3 %).
- **Conformisme** (Asch), **dissonance cognitive** (Festinger, 1957), **engagement** (Kiesler ; Joule et Beauvois), **stigmatisation** (Goffman, 1963).
- **CPS** (Santé publique France, 2022) : 3 catégories (cognitives, émotionnelles, sociales) × 3 CPS générales.
- **Image corporelle**, insatisfaction corporelle, **émotions** (Ekman), **estime de soi** (Rosenberg), **efficacité personnelle** (Bandura, 1977).
- **Modèles du changement** : HBM ; Prochaska et DiClemente (1983) : précontemplation, contemplation, préparation, action, maintien, rechute ; Ajzen (1991) : attitude, normes subjectives, contrôle perçu → intention → comportement.
- **Néophobie** : maximale de 2 à 6 ans ; 8 à 15 expositions sans pression ; éviter la récompense alimentaire.

À retenir – Compléments : communication, motivation, animation, mesure

- **Palo Alto** : on ne peut pas ne pas communiquer ; contenu et relation. **Mehrabian** : pas de « 93 % de non-verbal » en général.
- **Écoute active** (Rogers) : empathie, acceptation, congruence ; questions ouvertes, reformulation, reflets, silences, synthèse ; **Porter** : 6 attitudes, privilégier la compréhension.
- **Entretien motivationnel** (Miller et Rollnick) : partenariat, acceptation, compassion, évocation ; ambivalence ; réflexe correcteur ; OuVER ; **balance décisionnelle**.
- **Groupe** : Tuckman (formation, turbulence, normalisation, production, dissolution) ; rôles (Benne et Sheats) ; styles (Lewin, Lippitt et White : démocratique > autoritaire > laisser-faire).
- **Motivation** : autodétermination (autonomie, compétence, affiliation) ; éviter les récompenses alimentaires ; **biais** (présent, cadrage, halo, défaut, ancrage, optimisme, preuve sociale).
- **Mesure** : Likert (inverser les items négatifs : 6 − réponse) ; évocation hiérarchisée et analyse prototypique (fréquence × rang moyen ; noyau central probable).

3.8 Entraînement

3.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – La psychologie sociale étudie :

a) l'influence des autres sur les pensées et les comportements de l'individu **b)** uniquement les maladies mentales **c)** les interactions entre l'individu et le groupe **d)** la composition des aliments

QCM 2 – La socialisation primaire se fait principalement :

a) au travail **b)** dans la famille **c)** par les réseaux sociaux à l'âge adulte **d)** pendant l'enfance

QCM 3 – Le « paradoxe de l'omnivore » a été décrit par :

a) Claude Fischler **b)** Kurt Lewin **c)** Albert Bandura **d)** John Berry

QCM 4 – Une représentation sociale :

a) est une connaissance socialement élaborée et partagée **b)** comporte un noyau central stable **c)** est toujours fausse **d)** oriente les comportements

QCM 5 – Dans le modèle de Berry, conserver ses pratiques d'origine tout en adoptant celles du pays d'accueil correspond à :

a) l'assimilation **b)** l'intégration **c)** la séparation **d)** la marginalisation

QCM 6 – Dans l'expérience de Lewin (1943), le changement le plus important a été obtenu par :

a) une conférence d'expert **b)** une discussion de groupe suivie d'une décision collective **c)** une affiche **d)** une sanction

QCM 7 – La dissonance cognitive :

a) est un inconfort lié à des cognitions contradictoires **b)** peut conduire à rationaliser plutôt qu'à changer **c)** est renforcée par des messages culpabilisants **d)** a été décrite par Festinger

QCM 8 – Les compétences psychosociales selon Santé publique France (2022) sont classées en :

a) cognitives, émotionnelles, sociales **b)** physiques, mentales, sociales **c)** primaires, secondaires, tertiaires **d)** individuelles et collectives uniquement

QCM 9 – Réguler ses émotions est une CPS :

a) cognitive **b)** émotionnelle **c)** sociale **d)** physique

QCM 10 – Dans le modèle de Prochaska et DiClemente, une personne qui a changé de comportement depuis 3 mois est au stade :

a) de contemplation **b)** de préparation **c)** d'action **d)** de maintien

QCM 11 – Selon Ajzen, l'intention dépend :

a) de l'attitude **b)** des normes subjectives **c)** du contrôle comportemental perçu **d)** de l'IMC

QCM 12 – La source la plus puissante du sentiment d'efficacité personnelle est :

a) la persuasion verbale **b)** l'expérience de réussite personnelle **c)** la peur **d)** la sanction

QCM 13 – Face à la néophobie d'un enfant de 4 ans, il est recommandé :

a) de forcer à finir l'assiette **b)** de proposer l'aliment à plusieurs reprises sans pression **c)** de promettre un dessert en récompense **d)** de manger soi-même l'aliment devant l'enfant

QCM 14 – La stigmatisation du poids :

a) motive les personnes à perdre du poids **b)** augmente le stress et l'évitement des soins **c)** est un facteur de risque de comportements alimentaires désordonnés **d)** a été théorisée sous le nom de stigmate par Goffman

QCM 15 – Une norme descriptive :

a) décrit ce que font la plupart des gens **b)** dit ce qu'il faut faire **c)** peut normaliser un comportement à éviter si elle est mal utilisée **d)** est toujours inefficace

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c. 2. **b, d**. 3. **a** (*L'Homnivore*, 1990). 4. **a, b, d** : une représentation n'est pas « fausse », elle a une cohérence pour le groupe. 5. **b**. 6. **b** (≈ 32 % contre ≈ 3 %). 7. **a, b, c, d**. 8. **a**. 9. **b**. 10. **c** (moins de 6 mois). 11. **a, b, c**. 12. **b** (Bandura). 13. **b, d** : la pression et la récompense sont contre-productives. 14. **b, c, d** : la stigmatisation ne motive pas, elle nuit. 15. **a, c**.

QCM 16 – Parmi les attitudes de Porter, celle qui favorise le plus l'expression est :

a) l'évaluation **b)** la solution **c)** la compréhension **d)** l'enquête

QCM 17 – L'esprit de l'entretien motivationnel comprend :

a) le partenariat **b)** l'évocation **c)** la confrontation **d)** l'acceptation

QCM 18 – Selon Tuckman, la phase où apparaissent les désaccords est :

a) la formation **b)** la turbulence **c)** la normalisation **d)** la production

QCM 19 – Dans la théorie de l'autodétermination, les trois besoins fondamentaux sont :

a) autonomie **b)** compétence **c)** affiliation **d)** récompense

QCM 20 – Dans une échelle de Likert de 1 à 5, la réponse 4 à un item négatif devient après inversion :

a) 1 **b)** 2 **c)** 4 **d)** 5

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires

16. c. 17. **a, b, d**. 18. **b**. 19. **a, b, c**. 20. **b** (6 − 4 = 2).

3.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les stratégies d'acculturation

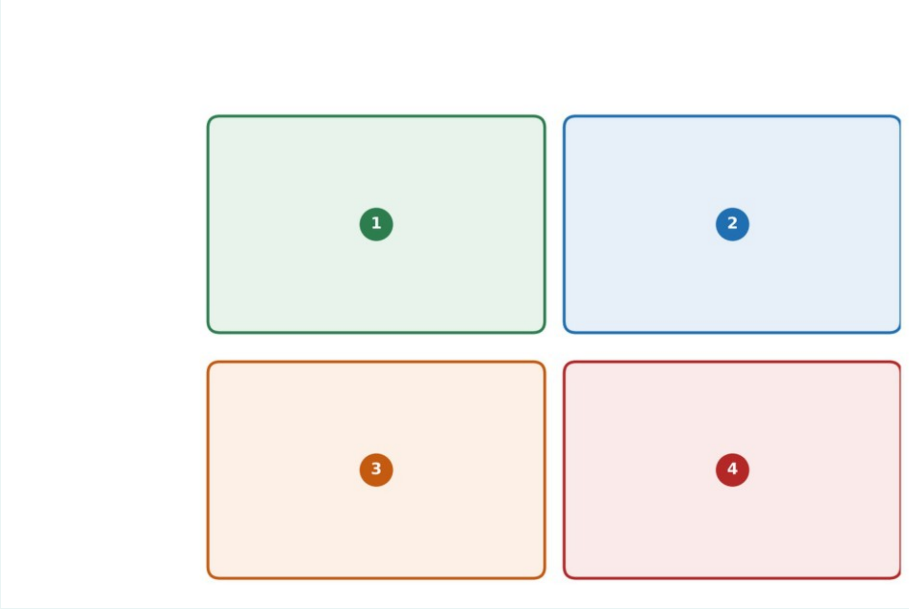


Figure 3.10 – Schéma à légender

Nommez le modèle, l'auteur et la date ; légendez les cases 1 à 4 et donnez un exemple alimentaire pour

chacune.

Corrigé

Stratégies d'acculturation de **John Berry (1997)**. 1. **Intégration** : une famille marocaine cuisine le tajine et adopte la ratatouille. 2. **Assimilation** : abandon des plats d'origine au profit de plats industriels du pays d'accueil. 3. **Séparation** : maintien exclusif des plats d'origine, achats uniquement dans des épiceries communautaires. 4. **Marginalisation** : perte des repères culinaires d'origine sans adoption de nouveaux, alimentation désorganisée (repas sautés, produits transformés).

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les étapes du changement

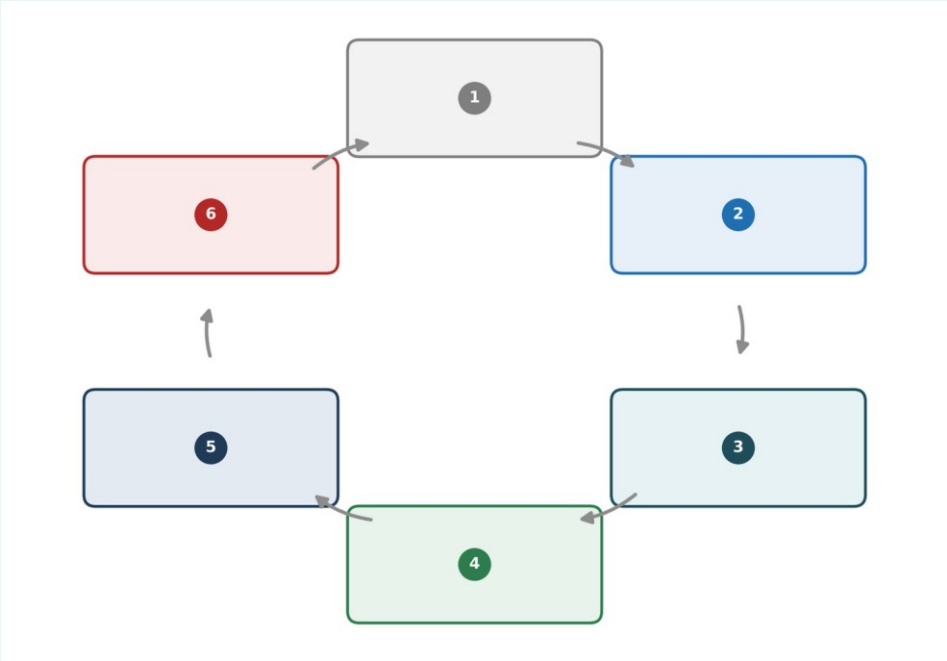


Figure 3.11 – Schéma à légender

Légendez les étapes 1 à 6 et proposez pour chacune une attitude de l'éducateur.

Corrigé

1. Précontemplation : informer sans braquer, susciter la curiosité. 2. **Contemplation** : explorer l'ambivalence (avantages / inconvénients). 3. **Préparation** : aider à fixer un objectif concret. 4. **Action** : soutenir, valoriser, résoudre les obstacles. 5. **Maintien** : prévenir la rechute, varier. 6. **Rechute** : dédramatiser, analyser, relancer le cycle.

À vous de jouer – Exercice 3 – Classer des CPS

Classez dans les trois catégories : a) dire non à un soda proposé par un ami ; b) repérer qu'on mange par ennui ; c) analyser une publicité ; d) gérer le stress d'un examen sans grignoter ; e) cuisiner en équipe ; f) choisir un menu équilibré dans un budget.

Corrigé

Cognitives : c) pensée critique ; f) prise de décision. **Émotionnelles** : b) conscience de ses émotions ; d) gestion du stress. **Sociales** : a) communication constructive (affirmation de soi) ; e) relations constructives

(coopération).

À vous de jouer – Exercice 4 – Identifier des représentations

Voici des propos recueillis lors d'un photolangage : « Le bio, c'est pour les riches » ; « Un bon repas, c'est avec de la viande » ; « Les surgelés, c'est mauvais » ; « Le pain, ça fait grossir ». Pour chacune, proposez une façon de la faire évoluer sans la disqualifier.

Corrigé

- « Le bio, c'est pour les riches » : reconnaître que certains produits bio sont plus chers ; montrer que des produits bio de saison ou en vrac (pommes, lentilles) sont abordables ; calculer le coût par portion.
- « Un bon repas, c'est avec de la viande » : valoriser la convivialité et la générosité du repas (noyau), proposer un plat sans viande copieux et apprécié (périphérie), puis parler de complémentarité des protéines.
- « Les surgelés, c'est mauvais » : distinguer légumes surgelés nature (intéressants nutritionnellement et économiquement) et plats préparés ; faire goûter.
- « Le pain fait grossir » : rappeler que le pain, surtout complet, est un féculent recommandé ; ce sont surtout les quantités et ce qu'on met dessus qui comptent.

À vous de jouer – Exercice 5 – Appliquer la théorie d'Ajzen

Mme K. pense que les légumes secs sont bons pour la santé (attitude positive), mais son mari dit qu'« un repas sans viande n'est pas un repas » et elle ne sait pas les cuisiner. Analysez avec le modèle d'Ajzen et proposez une action pour chaque composante.

Corrigé

Attitude : favorable → la renforcer (goût, économie). **Normes subjectives** : défavorables (le mari) → inviter le conjoint à la dégustation, proposer des plats mixtes (légumineuses + un peu de viande). **Contrôle perçu** : faible (ne sait pas cuisiner) → atelier pratique, recette simple, conserves de légumineuses pour gagner du temps. L'intention, aujourd'hui faible malgré l'attitude positive, augmentera si les normes et le contrôle perçu deviennent favorables.

À vous de jouer – Exercice 6 – Repérer les erreurs d'animation

Dans un atelier pour enfants, l'animatrice dit : « Celui qui ne goûte pas les épinards n'aura pas de gâteau », puis « Regardez Lucas, il est trop gros, il doit faire attention ». Identifiez les erreurs et proposez une autre formulation.

Corrigé

Erreur 1 : **récompense alimentaire** et pression, qui dévalorisent les épinards et survalorisent le gâteau. Reformulation : « Qui veut découvrir la couleur, l'odeur et le goût des épinards ? On a le droit de ne pas aimer, on peut juste toucher ou sentir. » Erreur 2 : **stigmatisation** publique d'un enfant, atteinte à l'estime de soi et au respect de la vie privée. Il ne faut jamais commenter le corps d'un participant ; la règle de respect s'applique à tous.

À vous de jouer – Exercice 7 – Adapter une action au public

Une même action « découvrir les légumineuses » doit être proposée à : a) des enfants de 5 ans ; b) des adolescents de 15 ans ; c) des résidents d'EHPAD. Proposez une adaptation pour chacun.

Corrigé

a) Jeu sensoriel (toucher, trier des lentilles de couleurs), fabrication d'un houmous coloré, exposition répétée, parents invités. b) Défi « burger végétal » en équipes, vidéo réalisée par les élèves, arguments planète et sport, respect de leurs choix. c) Atelier réminiscence (« les lentilles de mon enfance »), velouté de lentilles à texture adaptée, repas partagé, rythme lent.

À vous de jouer – Exercice 8 – Normes descriptives

Un collège veut afficher : « 65 % des élèves ne prennent pas de petit-déjeuner ! ». Est-ce une bonne idée ? Proposez une alternative.

Corrigé

Non : ce message présente le comportement à éviter comme **majoritaire** et risque de le normaliser (effet boomerang). Si 35 % des élèves prennent un petit-déjeuner, on peut valoriser une norme favorable vraie sur un autre aspect, par exemple « 8 élèves sur 10 boivent de l'eau à la récréation », ou une norme dynamique : « de plus en plus d'élèves prennent un petit-déjeuner » (si c'est vrai), accompagnée d'actions concrètes (petit-déjeuner au collège).

À vous de jouer – Exercice 9 – Analyser une situation de dissonance

Un salarié dit : « Je sais que je mange trop de sucre, mais avec mon travail, je n'ai pas le choix, et puis il faut bien se faire plaisir. » Identifiez la dissonance et la stratégie de réduction utilisée. Comment réagir ?

Corrigé

Dissonance entre « je mange trop de sucre » et « le sucre en excès est mauvais pour la santé ». Stratégie : **rationalisation** (justification par le travail et le plaisir) plutôt que changement. Réaction : ne pas culpabiliser ; reconnaître la contrainte et le besoin de plaisir ; explorer avec lui des solutions compatibles (collation plaisir moins sucrée, aménagement de la pause) ; renforcer son sentiment d'efficacité par un petit objectif.

À vous de jouer – Exercice 10 – Recueillir des représentations

Rédigez la consigne et le déroulé d'un photolangage de 30 minutes pour un groupe de 8 parents sur le thème « bien manger pour ma famille ».

Corrigé

Préparation : 40 photos variées (repas, aliments, scènes de repas, marché, cuisine, fast-food, fête). **Consigne** : « Choisissez une photo qui représente pour vous "bien manger pour ma famille", et une photo qui représente ce qui est difficile. » **Déroulé** : 5 min de choix en silence ; 20 min de tour de table (chacun explique, l'animateur reformule sans juger, note les mots-clés) ; 5 min de synthèse (regroupement des idées : plaisir, santé, prix, temps, enfants). **Règles** : bienveillance, droit de ne pas parler, confidentialité. **Exploitation** : les thèmes deviennent des objectifs d'atelier.

3.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

En quoi votre propre culture alimentaire peut-elle influencer votre pratique professionnelle ?

Corrigé

Chacun juge l'alimentation des autres à travers ses propres normes (horaires, plats, valeurs) : risque d'**ethnocentrisme** (considérer sa culture comme la référence). La **décentration** consiste à prendre conscience de ses propres valeurs et préjugés (par exemple, penser qu'un repas « normal » comporte entrée, plat, dessert) pour accueillir d'autres pratiques sans les juger, en ne retenant que les critères nutritionnels réellement importants. Le guide du BTS invite explicitement l'apprenant à « s'interroger sur son système de valeurs et à le confronter à celui des autres ».

À vous de jouer – Question 2

Pourquoi une conférence sur l'équilibre alimentaire change-t-elle rarement les comportements ?

Corrigé

Parce que l'information agit surtout sur les **connaissances** et l'**attitude**, peu sur les **normes** du groupe, le **contrôle perçu** (compétences, moyens) et les **habitudes** ; elle ne crée pas d'**engagement**. Lewin a montré que la discussion de groupe et la décision collective étaient bien plus efficaces ; Bandura, que l'expérience de réussite développe l'efficacité personnelle. Une action participative et pratique (atelier culinaire) est donc préférable.

À vous de jouer – Question 3

Les techniques d'engagement sont-elles une forme de manipulation ?

Corrigé

Elles peuvent l'être si elles sont utilisées à l'insu de la personne et contre son intérêt (marketing). En éducation pour la santé, leur usage est **éthique** si l'objectif est l'intérêt de la personne, si elle reste **libre** (sentiment de liberté explicite), si le professionnel est **transparent** sur ses intentions et si l'objectif est choisi par la personne elle-même. C'est la différence entre manipulation et accompagnement du pouvoir d'agir.

3.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Un club de football de jeunes

L'éducateur d'un club de football (garçons et filles de 13 à 16 ans) observe : boissons énergisantes avant les matchs, une joueuse qui « saute des repas pour être plus légère », moqueries sur le poids d'un gardien, défis alimentaires repris des réseaux sociaux. Il vous sollicite.

1. Identifiez les phénomènes psychosociaux en jeu.
2. Quelles CPS faudrait-il développer chez ces jeunes ?
3. Proposez une action en 3 séances.
4. Que faites-vous concernant la joueuse qui saute des repas ?
5. Comment impliquer les parents et l'éducateur ?

Corrigé

1. Influence des pairs et **conformisme** (boissons énergisantes, défis), **socialisation secondaire** par les réseaux sociaux, **insatisfaction corporelle** et risque de restriction (joueuse), **stigmatisation** du poids (gardien), construction de l'**identité** adolescente.

2. Pensée critique (analyser publicités et défis), **affirmation de soi** et communication constructive (refuser), **conscience et régulation des émotions**, **estime de soi**, **relations constructives** (respect dans l'équipe).

3. Séance 1 « Mon carburant » : besoins du sportif, collation avant l'effort (atelier pratique), hydratation. Séance 2 « Décrypter » : analyse d'une publicité et d'un défi viral, débat, élaboration de règles de l'équipe. Séance 3 « Respect » : jeu de rôle sur les moqueries, charte d'équipe signée par tous (engagement), valorisation des forces de chacun.

4. Ne pas en parler devant le groupe ; signaler la situation à l'éducateur et aux parents avec tact, en conseillant une consultation (médecin, diététicien, médecin du sport), car il peut s'agir d'un signe de **trouble du comportement alimentaire** ou de déficit énergétique ; je ne pose pas de diagnostic.

5. Réunion d'information des parents (collations, boissons, repérage des signes d'alerte), outils pour l'éducateur (charte, consignes sur les commentaires corporels), éventuellement un temps convivial avec dégustation de collations.

3.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Un participant refuse de goûter : « Chez nous, on ne mange pas ça. »

Corrigé

Je respecte son refus sans insister, je lui demande ce qu'on mange chez lui et s'il veut partager une recette ; je lui propose un rôle (préparer, sentir, décrire) ; la porte reste ouverte pour une prochaine fois.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Qu'est-ce que la socialisation secondaire ? Exemple dans votre projet. »

Corrigé

La socialisation qui se poursuit après l'enfance par l'école, les pairs, le travail, les médias. Dans mon projet, les enfants réclamaient des produits vus à la cantine et chez les copains : c'est la socialisation secondaire qui influence la famille.

Mise en situation – MSE 3

Une mère dit avoir honte de « mal nourrir » ses enfants.

Corrigé

J'écoute, je reformule son émotion (« vous vous inquiétez pour vos enfants »), je valorise ce qu'elle fait déjà de favorable, je propose des solutions concrètes et accessibles ; je ne renforce pas la culpabilité.

Mise en situation – MSE 4

Comment développer le sentiment d'efficacité personnelle en atelier ?

Corrigé

Faire réaliser la recette par les participants (expérience de réussite), montrer des pairs qui réussissent (témoignages), encourager, créer un climat détendu, choisir des recettes simples au début.

Mise en situation – MSE 5

Un adolescent se moque du poids d'un camarade pendant l'atelier.

Corrigé

J'interviens immédiatement et calmement pour rappeler la règle de respect, je recentre l'activité, je reparle à l'adolescent en aparté, et je veille à ce que le camarade ne soit pas exposé.

Mise en situation – MSE 6

Quelle est la différence entre acculturation spontanée et planifiée ?

Corrigé

Spontanée : changement non dirigé, par le contact quotidien (adopter les produits du supermarché). Planifiée : changement organisé volontairement par une institution (programme d'éducation alimentaire, cantine).

Mise en situation – MSE 7

Votre tutrice veut afficher « 70 % des enfants du quartier sont en mauvaise santé à cause de leur alimentation ».

Corrigé

Ce message est stigmatisant et probablement inexact ; je propose un message positif fondé sur une norme favorable ou un conseil concret (« les goûters maison, c'est bon et pas cher »), et je vérifie la donnée.

Mise en situation – MSE 8

Pourquoi ne pas utiliser le dessert comme récompense ?

Corrigé

Parce que cela valorise le dessert et dévalorise l'aliment à manger « pour avoir droit » au dessert ; à long terme, l'enfant préfère encore plus l'aliment récompense.

Mise en situation – MSE 9

Qu'est-ce que l'écoute active ?

Corrigé

Écouter avec attention, sans juger ni interrompre, en montrant qu'on a compris (reformulation, questions ouvertes, attention au non verbal) ; elle fait partie des CPS sociales et des indicateurs de C3.5.

Mise en situation – MSE 10

Le jury vous demande quel modèle du changement vous avez utilisé.

Corrigé

Par exemple Ajzen : j'ai agi sur l'attitude (dégustation), les normes (décision en groupe, conjoints invités) et surtout le contrôle perçu (cuisiner soi-même, recettes rapides et peu coûteuses).

Mise en situation – MSE 11

Une résidente d'EHPAD ne mange plus depuis l'entrée en établissement.

Corrigé

Je pense aux dimensions psychosociales (perte de repères, tristesse, isolement, perte de l'identité de « cuisinière ») ; je propose avec l'équipe de recueillir ses goûts, de l'associer à une activité culinaire, de favoriser la convivialité, et je signale la perte d'appétit (risque de dénutrition, dépistage).

Mise en situation – MSE 12

Un collègue dit : « Les gens savent ce qu'il faut manger, ils ne font pas d'efforts. »

Corrigé

Savoir ne suffit pas : le comportement dépend aussi des normes, des émotions, des habitudes, du contrôle perçu et des déterminants sociaux. Je propose de s'appuyer sur des approches participatives et sur l'environnement plutôt que sur la volonté individuelle.

3.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – Calculer des scores de Likert

Échelle de 4 items (1 à 5) sur l'attitude envers l'eau du robinet : I1 « L'eau du robinet est bonne pour la santé » (+) ; I2 « L'eau du robinet a mauvais goût » (−) ; I3 « Je fais confiance à l'eau de ma commune » (+) ; I4 « L'eau en bouteille est plus sûre » (−). Réponses de 3 personnes : P1 : 4, 2, 4, 2 ; P2 : 2, 5, 1, 5 ; P3 : 3, 3, 4, 3. Calculez les scores sur 100 et la moyenne.

Corrigé

Inversion des items négatifs (6 − réponse). P1 : 4 + (6 − 2) + 4 + (6 − 2) = 4 + 4 + 4 + 4 = **16** ; sur 100 : (16 − 4) / (20 − 4) × 100 = 12 / 16 × 100 = **75**. P2 : 2 + 1 + 1 + 1 = **5** ; (5 − 4) / 16 × 100 = **6,25**. P3 : 3 + 3 + 4 + 3 = **13** ; (13 − 4) / 16 × 100 = **56,25**. Moyenne : (75 + 6,25 + 56,25) / 3 = 137,5 / 3 = **45,8 / 100**. P2 est très défavorable : l'écouter sur ses raisons (goût de chlore, méfiance) avant d'informer (qualité contrôlée, carafe au réfrigérateur pour atténuer le goût).

À vous de jouer – Exercice 12 – Reformuler

Proposez une reformulation simple et une reformulation reflet pour : a) « Je n'ai pas le temps de cuisiner le soir, je rentre à 19 h » ; b) « Mon médecin m'a dit de perdre du poids, mais j'en ai marre des régimes » ; c) « Les enfants préfèrent la cantine à ce que je fais. »

Corrigé

a) Simple : « Vous rentrez tard et le temps manque pour cuisiner. » Reflet : « Ça a l'air épuisant, ces soirées. » b) Simple : « On vous a conseillé de perdre du poids, et les régimes ne vous conviennent plus. » Reflet : « Vous semblez découragé(e) par les régimes. » c) Simple : « Vos enfants apprécient les repas de la cantine. » Reflet : « Ça vous peine un peu qu'ils préfèrent la cantine. »

À vous de jouer – Exercice 13 – Balance décisionnelle

Une étudiante hésite à remplacer son soda quotidien par de l'eau aromatisée maison. Pour : économie (4), moins de sucre (3), meilleure peau (1). Contre : perte du plaisir (4), habitude avec les amis (3), préparer la bouteille (2). Calculez la balance, interprétez et proposez deux actions sur les « contre ».

Corrigé

Pour : 4 + 3 + 1 = **8** ; contre : 4 + 3 + 2 = **9** ; écart : 8 − 9 = **− 1** : légère dominante du statu quo, ambivalence. Actions : réduire la perte de plaisir (eau pétillante citron-menthe, soda gardé le week-end) : 4 → 2 ; préparer 3 bouteilles le dimanche : 2 → 1. Nouveau total « contre » : 2 + 3 + 1 = **6** ; écart : 8 − 6 = **+ 2**. C'est elle qui choisit ; on valorise son choix, même partiel.

À vous de jouer – Exercice 14 – Gérer des participants

Pour chaque situation, proposez une réponse d'animateur : a) M. P. coupe la parole à chaque intervention ; b) Mme S. ne dit rien depuis trois séances mais cuisine avec soin ; c) un participant affirme : « Les diététiciens disent n'importe quoi, ça change tout le temps. »

Corrigé

a) « Merci, M. P., votre expérience est précieuse ; j'aimerais maintenant entendre d'autres personnes » ; tour de parole ; lui confier un rôle (chronométrer, servir). b) Respecter son rythme ; valoriser son plat devant le groupe avec son accord ; lui proposer une question en binôme ; support non verbal (gommette). c) Accueillir : « Vous avez l'impression que les conseils changent souvent. » Puis expliquer que les repères évoluent avec les connaissances (exemple des repères de 2019) et que l'essentiel reste stable (fruits, légumes, légumes secs) ; renvoyer au groupe.

À vous de jouer – Exercice 15 – Repérer des biais dans une publicité

Une publicité pour des biscuits affiche « Source de céréales complètes – 30 % de sucres en moins » avec un sportif souriant. Identifiez les biais exploités et rédigez deux questions pour un atelier de littératie critique.

Corrigé

Effet de halo (céréales complètes, sportif → produit perçu comme sain) ; **cadrage** (« 30 % de sucres en moins » par rapport à un produit très sucré, sans valeur absolue) ; **preuve sociale** et identification. Questions : « 30

% de moins que quoi ? Combien de sucres pour 100 g ? » ; « Comparez le Nutri-Score avec celui d'une tartine de pain et de fromage. »

À vous de jouer – Exercice 16 – Motivation et récompenses

Un animateur de centre de loisirs promet un bonbon aux enfants qui goûtent la soupe. Analysez avec la théorie de l'autodétermination et proposez une alternative.

Corrigé

La récompense est une **motivation extrinsèque** : elle peut faire goûter une fois, mais elle associe la soupe à une corvée et le bonbon au plaisir, et affaiblit l'envie de goûter pour elle-même. Alternative : satisfaire l'**autonomie** (choisir entre deux soupes, se servir), la **compétence** (préparer la soupe, reconnaître les légumes) et l'**affiliation** (l'animateur goûte avec les enfants, on décrit ensemble les saveurs), avec exposition répétée et sans pression.

3.9 Glossaire

Terme	Définition
Acculturation	Changements résultant du contact continu entre groupes de cultures différentes (spontanée ou planifiée)
Attitude	Disposition favorable ou défavorable envers un objet (cognitive, affective, conative)
Compétences psychosociales	Capacités cognitives, émotionnelles et sociales qui augmentent le pouvoir d'agir et le bien-être
Conformisme	Alignement de son jugement ou comportement sur celui du groupe
Culture	Manières de penser, sentir et agir apprises et partagées, transmises entre générations
Dissonance cognitive	Inconfort lié à des cognitions contradictoires
Engagement	Lien entre une personne et ses actes, renforcé par la liberté, la publicité, la répétition
Estime de soi	Valeur qu'une personne s'attribue
Gastro-anomie	Perte des règles collectives de l'alimentation laissant le mangeur seul face à des injonctions contradictoires (Fischler)
Identité sociale	Partie de l'image de soi issue de l'appartenance à des groupes
Image corporelle	Représentation mentale de son corps (perception, pensées, émotions, comportements)
Interculturalité	Relations et échanges entre personnes de cultures différentes, fondés sur la reconnaissance mutuelle
Néophobie alimentaire	Réticence à goûter des aliments nouveaux, maximale entre 2 et 6 ans
Norme sociale	Règle de conduite attendue dans un groupe (descriptive ou injonctive)
Représentation sociale	Connaissance socialement élaborée et partagée, organisée autour d'un noyau central
Sentiment d'efficacité personnelle	Croyance en sa capacité à réaliser une action (Bandura)

Terme	Définition
Socialisation	Intériorisation des normes, valeurs et pratiques d'une société (primaire, secondaire)
Stigmatisation	Processus qui disqualifie une personne en la réduisant à un attribut (Goffman)
Syncrétisme culinaire	Combinaison d'éléments de cultures culinaires différentes
Valeur	Idéal collectif qui oriente les jugements
Ambivalence	Fait de vouloir et de ne pas vouloir changer en même temps
Balance décisionnelle	Outil listant et pondérant avantages et inconvénients d'un changement
Biais cognitif	Déviation systématique du jugement, liée aux raccourcis de pensée
Écoute active	Écoute centrée sur la personne : empathie, acceptation, congruence, reformulation
Entretien motivationnel	Style de conversation collaboratif renforçant la motivation propre au changement
Évocation hiérarchisée	Recueil de mots associés à un objet, dans leur ordre d'apparition
Habitus	Dispositions durables acquises par la socialisation, qui orientent les goûts (Bourdieu)
Motivation intrinsèque	Agir pour l'intérêt ou le plaisir de l'activité elle-même
Pair-éducation	Action éducative menée par des membres du groupe cible formés
Reformulation	Redire avec d'autres mots ce que la personne a exprimé
Style d'animation	Manière de conduire un groupe : autoritaire, démocratique, laisser-faire

3.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Sociologie et anthropologie de l'alimentation	[1] Fischler ; [2] Poulain ; [3] Lévi-Strauss ; [4] Bourdieu
Identité, représentations, influence	[5] Tajfel et Turner ; [6] Moscovici ; [7] Abric ; [8] Lewin ; [9] Festinger ; [10] Joule et Beauvois
Culture et acculturation	[11] Berry ; [12] Cohen-Emerique
CPS	[13] Santé publique France 2022 ; [14] OMS 1993
Image corporelle, émotions, stigmatisation	[15] Goffman ; [16] Rubino et coll.
Changement de comportement	[17] Prochaska et DiClemente ; [18] Ajzen ; [19] Bandura ; [20] Miller et Rollnick ; [21] Michie et coll.

3.12 Bibliographie numérotée

1. Fischler C. *L'Homnivore*. Paris, Odile Jacob, 1990.

2. Poulain J.-P. *Sociologies de l'alimentation*. Paris, PUF, 2002 (rééd. 2017).

3. Lévi-Strauss C. *Mythologiques I. Le cru et le cuit*. Paris, Plon, 1964.

4. Bourdieu P. *La Distinction. Critique sociale du jugement*. Paris, Minuit, 1979.

5. Tajfel H., Turner J. « An integrative theory of intergroup conflict », in Austin W., Worchel S. (dir.), *The Social Psychology of Intergroup Relations*, 1979.

6. Moscovici S. *La psychanalyse, son image et son public*. Paris, PUF, 1961.

7. Abric J.-C. (dir.). *Pratiques sociales et représentations*. Paris, PUF, 1994.

8. Lewin K. « Forces behind food habits and methods of change ». *Bulletin of the National Research Council*, 1943, n° 108, p. 35-65.

9. Festinger L. *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford University Press, 1957.

10. Joule R.-V., Beauvois J.-L. *Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens*. Grenoble, PUG, 1987 (rééd.).

11. Berry J. W. « Immigration, acculturation, and adaptation ». *Applied Psychology*, 1997, 46 (1), p. 5-34.

12. Cohen-Emerique M. *Pour une approche interculturelle en travail social*. Rennes, Presses de l'EHESP, 2011.

13. Santé publique France. *Les compétences psychosociales : un référentiel pour un déploiement auprès des enfants et des jeunes*. 2022.

14. OMS. *Life skills education for children and adolescents in schools*. Genève, 1993.

15. Goffman E. *Stigmate*. Paris, Minuit, 1975 (éd. originale 1963).

16. Rubino F. et coll. « Joint international consensus statement for ending stigma of obesity ». *Nature Medicine*, 2020, 26, p. 485-497.

17. Prochaska J. O., DiClemente C. C. « Stages and processes of self-change of smoking ». *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 1983, 51 (3), p. 390-395.

18. Ajzen I. « The theory of planned behavior ». *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 1991, 50 (2), p. 179-211.

19. Bandura A. « Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change ». *Psychological Review*, 1977, 84 (2), p. 191-215.

20. Miller W. R., Rollnick S. *L'entretien motivationnel*. 2e éd. française, Paris, InterÉditions, 2013.

21. Michie S., van Stralen M. M., West R. « The behaviour change wheel ». *Implementation Science*, 2011, 6:42.

22. Watzlawick P., Beavin J. H., Jackson D. D. *Une logique de la communication*. Paris, Seuil, 1972 (éd. originale 1967).

23. Rogers C. R. *Le développement de la personne*. Paris, Dunod, 1968 (éd. originale 1961).

24. Porter E. H. *An Introduction to Therapeutic Counseling*. Boston, Houghton Mifflin, 1950.

25. Miller W. R., Rollnick S. *L'entretien motivationnel : aider la personne à engager le changement*. Paris, InterÉditions, 2e éd. française 2013.

26. Tuckman B. W. « Developmental sequence in small groups ». *Psychological Bulletin*, 1965, 63 (6), p. 384-399.

27. Lewin K., Lippitt R., White R. K. « Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates ». *Journal of Social Psychology*, 1939, 10, p. 271-299.

28. Deci E. L., Ryan R. M. *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. New York, Plenum, 1985.

29. Kahneman D. *Système 1 / Système 2 : les deux vitesses de la pensée*. Paris, Flammarion, 2012.

30. Vergès P. « L'évocation de l'argent : une méthode pour la définition du noyau central d'une représentation ». *Bulletin de psychologie*, 1992, 45 (405), p. 203-209.

31. Tajfel H., Turner J. C. « An integrative theory of intergroup conflict ». In Austin W. G., Worchel S. (dir.), *The Social Psychology of Intergroup Relations*, 1979.

32. Bourdieu P. *La Distinction. Critique sociale du jugement*. Paris, Minuit, 1979.

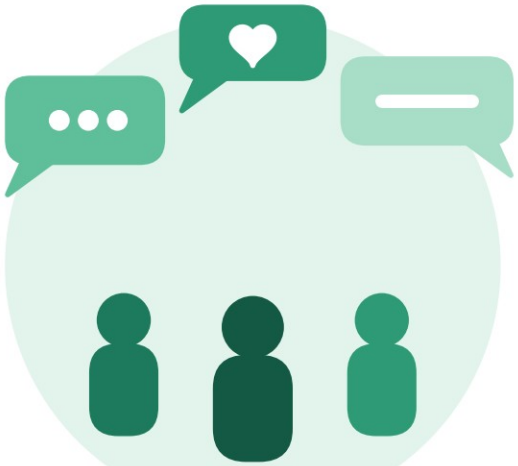
Cours du CNED (contrôle de conformité, section 3.2.2)

33. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE



CHAPITRE

03

Éléments de psychologie sociale

Psychologie | Sociologie | Anthropologie de l'alimentation

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

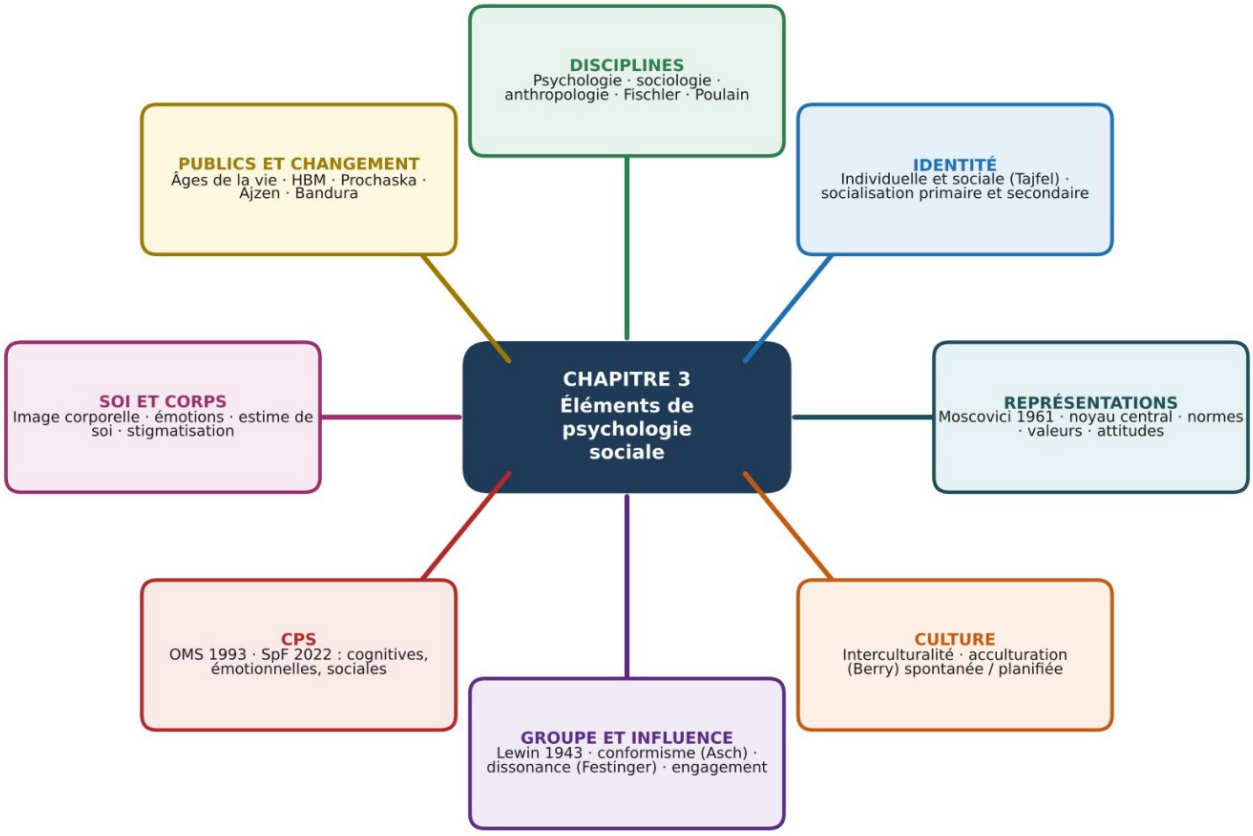
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 3 102
1. Les définitions à savoir 102
2. Les modèles à connaître 103
3. Les 9 CPS générales (Santé publique France, 2022) 103
4. Les pièges 103
5. Auto-test 103
6. Flashcards 104
Compléments du chapitre enrichi 104

Fiches-outils du chapitre 3 104
O3.1 – Recueil et analyse des représentations 105
O3.2 – Profil du public et adaptations 105
O3.3 – Grille « étapes du changement » 105
O3.4 – Planifier le développement des CPS 105
O3.5 – Règles du groupe et charte de bienveillance 106
O3.6 – Auto-observation de ma posture interculturelle 106

Fiche de révision du chapitre 3

Éléments de psychologie sociale



Carte mentale du chapitre 3

1. Les définitions à savoir

Notion	Définition	Auteur
Psychologie sociale	Influence des autres sur pensées, sentiments, comportements	Allport, 1954
Identité sociale	Partie de l'image de soi issue des groupes d'appartenance	Tajfel et Turner, 1979
Socialisation primaire / secondaire	Famille, enfance / école, pairs, travail, médias	–
Représentation sociale	Connaissance partagée ; noyau central + périphérie	Moscovici 1961, Abric
Acculturation	Changements liés au contact entre cultures ; spontanée / planifiée	Bastide ; Berry 1997
Dissonance cognitive	Inconfort de cognitions contradictoires → changement ou rationalisation	Festinger, 1957
Engagement	Lien entre la personne et ses actes (liberté, public, répété)	Kiesler ; Joule et Beauvois
CPS	Capacités cognitives, émotionnelles, sociales	Santé publique France, 2022
Efficacité personnelle	Croyance en sa capacité d'agir	Bandura, 1977

Notion	Définition	Auteur
Stigmatisation	Réduction d'une personne à un attribut disqualifiant	Goffman, 1963

2. Les modèles à connaître

Modèle	Contenu
Berry (1997)	Intégration, assimilation, séparation, marginalisation
Prochaska et DiClemente (1983)	Précontemplation, contemplation, préparation, action, maintien, rechute
Ajzen (1991)	Attitude + normes subjectives + contrôle perçu → intention → comportement
HBM	Vulnérabilité, gravité, bénéfices, obstacles, déclencheur, efficacité
Lewin (1943)	Discussion de groupe + décision collective ≈ 32 % vs conférence ≈ 3 %
Poulain (2002)	Espace social alimentaire : mangeable, système alimentaire, culinaire, consommation, temporalité, différenciation sociale

3. Les 9 CPS générales (Santé publique France, 2022)

- **Cognitives** : conscience de soi ; maîtrise de soi ; décisions constructives.
- **Émotionnelles** : conscience de ses émotions et de son stress ; régulation des émotions ; gestion du stress.
- **Sociales** : communication constructive ; relations constructives ; résolution des difficultés.

4. Les pièges

Attention

- Traiter une représentation comme une simple « erreur » à corriger.
- Imposer une **assimilation** (« manger à la française »).
- Utiliser des récompenses alimentaires ou forcer à goûter (néophobie).
- Parler de poids, peser en public, stigmatiser.
- Croire qu'informer suffit à faire changer.
- Afficher une norme descriptive défavorable (effet boomerang).

5. Auto-test

1. Qui a décrit le paradoxe de l'omnivore ? 2. Différence socialisation primaire / secondaire ? 3. Les 4 stratégies de Berry ? 4. Résultat de l'expérience de Lewin ? 5. Qu'est-ce que la dissonance cognitive ? 6. Les 3 catégories de CPS ? 7. Étape du changement d'une personne qui a changé depuis 2 mois ? 8. Les 3 déterminants de l'intention selon Ajzen ? 9. Combien d'expositions pour accepter un aliment ? 10. Source la plus puissante d'efficacité personnelle ? *Réponses : 1. Fischler (1990) – 2. Famille et enfance / école, pairs, travail, médias – 3. Intégration, assimilation, séparation, marginalisation – 4. ≈ 32 % (groupe) contre ≈ 3 % (conférence) – 5. Inconfort de cognitions contradictoires – 6. Cognitives, émotionnelles, sociales – 7. Action – 8. Attitude, normes subjectives, contrôle perçu – – 9. 8 à 15 – 10. Les expériences de réussite.*

6. Flashcards

Recto : Noyau central d'une représentation ?	Verso : Éléments stables et partagés, difficiles à changer ; on agit d'abord sur la périphérie
Recto : Acculturation planifiée ?	Verso : Changement culturel organisé par une institution (programme, cantine)
Recto : Pied-dans-la-porte ?	Verso : Obtenir un petit acte avant une demande plus importante
Recto : Néophobie : âge maximal ?	Verso : 2 à 6 ans
Recto : COM-B ?	Verso : Capacité, Opportunité, Motivation → Comportement (Michie, 2011)
Recto : Norme injonctive ?	Verso : Ce qu'il faut faire selon le groupe

Compléments du chapitre enrichi

Notion	À retenir
Communication	Palo Alto : on ne peut pas ne pas communiquer ; contenu et relation ; Mehrabian : pas de règle générale des 93 %
Écoute active	Rogers : empathie, acceptation, congruence ; reformulation, reflet, silence, synthèse ; Porter : 6 attitudes, privilégier la compréhension
Entretien motivationnel	Partenariat, acceptation, compassion, évocation ; ambivalence ; réflexe correcteur ; OuVER ; balance décisionnelle
Groupe	Tuckman : formation, turbulence, normalisation, production, dissolution ; Benne et Sheats ; Lewin, Lippitt et White
Motivation	Autodétermination : autonomie, compétence, affiliation ; éviter les récompenses alimentaires ; biais (présent, cadrage, halo, défaut)
Mesure	Likert (inverser : 6 – réponse) ; évocation hiérarchisée (fréquence, rang moyen ; noyau central probable)
COM-B	Capacité + opportunité + motivation → comportement ; fonctions : éducation, formation, persuasion, modélisation, environnement
L3	Identité sociale (Tajfel et Turner) ; goût de nécessité / de liberté (Bourdieu)

Fiches-outils du chapitre 3

Outil	Intitulé	Utilité
O3.1	Recueil et analyse des représentations d'un groupe	Partir des représentations du public
O3.2	Profil du public et adaptations	Adapter l'action à l'âge, la culture, la situation
O3.3	Grille « étapes du changement » et réponses éducatives	Adapter son discours à chaque personne
O3.4	Planifier le développement des CPS dans une action	Intégrer les CPS au projet
O3.5	Règles du groupe et charte de bienveillance	Créer un climat sécurisant
O3.6	Auto-observation de ma posture interculturelle	Décentration, C3.5

O3.1 – Recueil et analyse des représentations

Groupe, date, effectif

Technique utilisée (associations libres, photolangage, abaque de Régnier, classement)

Consigne donnée

Mots, idées, propos recueillis (sans nom)	Thème (prix, plaisir, santé, temps, culture, corps…)	Noyau (partagé) ou périphérie (variable) ?

Conséquences pour mes messages et mes activités

O3.2 – Profil du public et adaptations

Caractéristique	Ce que j'ai observé	Adaptation prévue
Âge, stade de développement		
Cultures, langues, pratiques religieuses		
Situation sociale et économique		
Compétences culinaires, équipement		
Littératie, rapport à l'écrit et au numérique		
Handicap, besoins particuliers		
Représentations dominantes		
Dynamique du groupe (leaders, tensions)		

O3.3 – Grille « étapes du changement »

Étape	Indices (ce que dit la personne)	Réponse éducative adaptée
Précontemplation	« Je n'ai pas de problème »	Informer sans braquer, susciter la curiosité
Contemplation	« Je devrais, mais… »	Explorer l'ambivalence, balance décisionnelle
Préparation	« Je vais commencer… »	Objectif concret, plan, ressources
Action (< 6 mois)	« Je fais… depuis… »	Valoriser, résoudre les obstacles
Maintien (> 6 mois)	« Je continue »	Prévenir la rechute, varier
Rechute	« J'ai repris… »	Dédramatiser, analyser, relancer

O3.4 – Planifier le développement des CPS

Catégorie	CPS visée	Activité prévue (séance, durée)	Indicateur d'observation
Cognitive			
Cognitive			
Émotionnelle			
Émotionnelle			
Sociale			
Sociale			

O3.5 – Règles du groupe et charte de bienveillance

Consigne

Construisez les règles **avec** le groupe lors de la première séance ; affichez-les ; rappelez-les si besoin.

☐	On a le droit de ne pas aimer et de ne pas goûter.
☐	On ne se moque pas : ni des goûts, ni du corps, ni de la façon de parler.
☐	Ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe.
☐	Chacun parle à son tour ; on écoute.
☐	On respecte les pratiques et les cultures de chacun.
☐	Pas de photo sans accord.
☐	On respecte les règles d'hygiène et de sécurité.
☐	(règle ajoutée par le groupe)
☐	(règle ajoutée par le groupe)

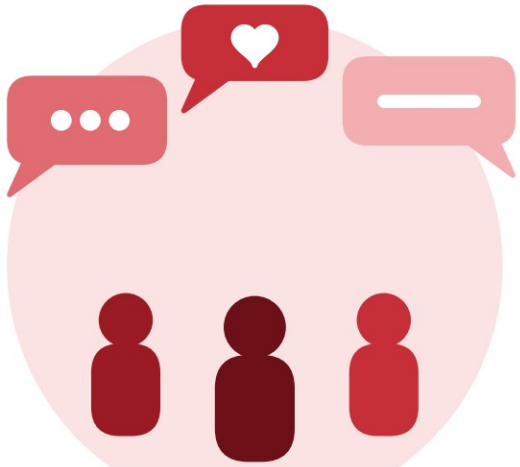
O3.6 – Auto-observation de ma posture interculturelle

Question	Ma réponse
Quelles sont mes propres normes alimentaires (repas «	
normal », horaires, aliments) ?	
Quelle situation m'a surpris(e) ou choqué(e) ? Pourquoi ?	
(décentration)	
Qu'ai-je appris de la culture de l'autre ? Comment me	
suis-je renseigné(e) ?	
Quel compromis ai-je négocié entre recommandations et	
pratiques de la personne ?	
Ce que je ferai différemment la prochaine fois	

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



CHAPITRE

03

Éléments de psychologie sociale

Psychologie | Sociologie | Anthropologie de l'alimentation

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 3 110
Mode d'emploi du cahier 110
Partie 1 – Regards sur le mangeur, socialisation et identité 111
Exercice 3.1 – Légender les trois regards sur le mangeur (8 points) 112
Exercice 3.2 – Le paradoxe de l'omnivore et le principe d'incorporation (10 points) 113
Exercice 3.3 – Légender la socialisation alimentaire (8 points) 115
Exercice 3.4 – L'espace social alimentaire de Poulain (10 points) 117
Exercice 3.5 – Repas en famille et position sociale (12 points) 118
Exercice 3.6 – L'internat d'un lycée agricole (16 points) 120
Corrigés de la partie 1 122
Partie 2 – Représentations, normes, valeurs et culture 125
Exercice 3.7 – Représentations sociales : définition, formation, fonctions (10 points) 126
Exercice 3.8 – Normes descriptives et injonctives (10 points) 127
Exercice 3.9 – Légender les stratégies d'acculturation (10 points) 128
Exercice 3.10 – Analyse prototypique : « manger bio » chez des étudiants (14 points) 130
Exercice 3.11 – Une situation interculturelle à la cantine (12 points) 132
Exercice 3.12 – Questionnaire de mise en cause : qu'est-ce qu'un « vrai repas » ? (16 points) 133
Corrigés de la partie 2 135
Partie 3 – Influence sociale, attitudes et stigmatisation 138
Exercice 3.13 – Les grandes expériences de l'influence sociale (10 points) 139
Exercice 3.14 – L'expérience de Lewin (1943) et le travail en groupe (12 points) 140
Exercice 3.15 – Légender la dissonance cognitive (10 points) 142
Exercice 3.16 – Engagement et pied-dans-la-porte (12 points) 144
Exercice 3.17 – Légender stéréotype, préjugé, discrimination (12 points) 146
Exercice 3.18 – Mesurer les attitudes envers les personnes obèses (16 points) 148
Corrigés de la partie 3 150
Partie 4 – Compétences psychosociales, émotions, image du corps et estime de soi 153
Exercice 3.19 – Légender les compétences psychosociales (12 points) 154
Exercice 3.20 – Construire une séance CPS « explicite » (12 points) 156
Exercice 3.21 – Estime de soi : coter une échelle (12 points) 157
Exercice 3.22 – Insatisfaction corporelle et silhouettes (14 points) 158
Exercice 3.23 – Faim physiologique et faim émotionnelle (10 points) 160
Exercice 3.24 – Un programme CPS et nutrition au collège (16 points) 161
Corrigés de la partie 4 163
Partie 5 – Les modèles du changement de comportement 166
Exercice 3.25 – Légender les stades du changement (12 points) 167
Exercice 3.26 – Légender la théorie du comportement planifié (10 points) 169
Exercice 3.27 – Le modèle des croyances relatives à la santé (10 points) 171
Exercice 3.28 – Les quatre sources du sentiment d'efficacité personnelle (10 points) 172
Exercice 3.29 – Légender COM-B et choisir des fonctions d'intervention (14 points) 173
Exercice 3.30 – Évaluer un programme avec les stades du changement (16 points) 175
Corrigés de la partie 5 177
Partie 6 – Communiquer, écouter, accompagner la motivation 180
Exercice 3.31 – Légender le schéma de la communication (10 points) 181
Exercice 3.32 – Reconnaître les attitudes de Porter (12 points) 183
Exercice 3.33 – Questions ouvertes et reformulations (12 points) 184
Exercice 3.34 – Discours-changement et esprit de l'entretien motivationnel (12 points) 186
Exercice 3.35 – Construire une balance décisionnelle (12 points) 188

Exercice 3.36 – Analyser un entretien avec des indicateurs (16 points) 190
Corrigés de la partie 6 192

Partie 7 – Animer un groupe, motiver, tenir compte des biais de décision 194
Exercice 3.37 – Légender les étapes de la vie d'un groupe (10 points) 195
Exercice 3.38 – Les rôles dans un groupe (10 points) 197
Exercice 3.39 – Styles d'animation et participation (12 points) 198
Exercice 3.40 – Choisir une technique d'animation (12 points) 199
Exercice 3.41 – Motivation, biais et coups de pouce à la cantine (14 points) 200
Exercice 3.42 – Animer un groupe difficile (16 points) 202
Corrigés de la partie 7 203

Partie 8 – Mesurer les attitudes et les représentations ; cas complet 206
Exercice 3.43 – Repérer les erreurs dans des items (10 points) 207
Exercice 3.44 – Coter une échelle de Likert (12 points) 208
Exercice 3.45 – Le différenciateur sémantique : légumineuses et pâtes (12 points) 209
Exercice 3.46 – Analyse de contenu d'entretiens (12 points) 211
Exercice 3.47 – Comparer deux proportions avant et après un cycle d'ateliers (12 points) 213
Exercice 3.48 – Cas complet : les gardes de nuit d'une caserne de sapeurs-pompiers (40 points) 214
Corrigés de la partie 8 217

Bilan : grille d'auto-évaluation 220

Cahier d'exercices – Chapitre 3

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 3 : regards de la psychologie, de la sociologie et de l'anthropologie sur le mangeur, socialisation et identité, représentations, normes et valeurs, culture et interculturalité, influence sociale, attitudes et dissonance, stéréotypes et stigmatisation, compétences psychosociales, image corporelle et estime de soi, modèles du changement de comportement, communication et écoute, entretien motivationnel, animation de groupe, motivation et biais de décision (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition » et C3.5 « Communiquer et interagir dans un contexte d'intervention en santé », savoirs associés « Psychologie sociale » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : trois regards sur le mangeur, socialisation, stratégies d'acculturation de Berry, dissonance cognitive, stéréotype-préjugé-discrimination, compétences psychosociales, stades du changement, théorie du comportement planifié, modèle COM-B, schéma de la communication, étapes de la vie d'un groupe.
- Recueillir et analyser des représentations et des attitudes : évocation hiérarchisée, questionnaire de mise en cause, échelle de Likert, échelle d'estime de soi, silhouettes, différenciateur sémantique, analyse de contenu.
- Choisir des leviers d'action cohérents avec un diagnostic psychosocial, sans culpabiliser ni stigmatiser.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits d'entretiens), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes et chiffres des enquêtes locales sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les auteurs, les théories, les textes officiels et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026 ; chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés.

Méthode – Utiliser un concept de psychologie sociale à l'examen

Pour chaque concept, écrivez trois éléments : la définition avec l'auteur et l'année, l'application à la situation (une citation ou un chiffre du document), puis la conséquence pour l'action (« donc je propose… »). Un concept cité sans application ne rapporte presque pas de points ; une action proposée sans concept non plus.

Partie 1 – Regards sur le mangeur, socialisation et identité

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer les regards de la psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie et de la psychologie sociale sur l'alimentation.
- Expliquer le paradoxe de l'omnivore et le principe d'incorporation (Fischler, 1990), l'espace social alimentaire (Poulain, 2002).
- Définir la socialisation primaire et secondaire et l'identité sociale ; les relier aux pratiques alimentaires d'un public.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Psychologie sociale : étude de la façon dont les pensées, les émotions et les comportements d'une personne sont influencés par la présence réelle, imaginée ou implicite des autres (Allport, 1954).
- Paradoxe de l'omnivore (Fischler, 1990) : l'être humain a besoin de varier son alimentation (néophilie) mais se méfie des aliments inconnus (néophobie). Principe d'incorporation : « on devient ce que l'on mange » ; manger un aliment, c'est faire entrer en soi ses qualités réelles ou imaginées.
- Espace social alimentaire (Poulain, 2002) : six dimensions qui montrent la liberté et les contraintes du mangeur : l'ordre du mangeable, le système alimentaire, l'espace culinaire, l'espace des habitudes de consommation, la temporalité alimentaire, l'espace de différenciation sociale.
- Socialisation : processus par lequel une personne apprend et intériorise les normes et les valeurs de son groupe. Primaire (enfance : famille, école) ; secondaire (vie adulte : pairs, travail, couple, médias).
- Identité sociale (Tajfel et Turner, 1979) : partie de l'image de soi qui vient de l'appartenance à des groupes ; on cherche à valoriser son groupe (endogroupe) par rapport aux autres (exogroupes).

Exercice 3.1 – Légender les trois regards sur le mangeur (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous présentez le chapitre « psychologie sociale » à des étudiants de première année en santé. Vous voulez leur montrer qu'un même comportement alimentaire peut être étudié par plusieurs disciplines.

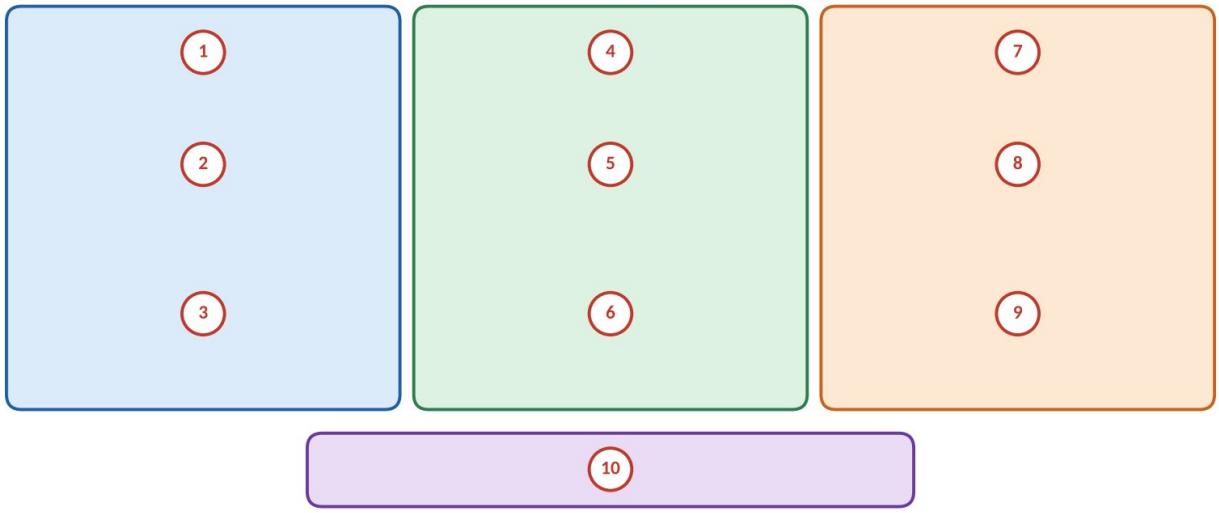


Figure 3.1 – Document 1 – Trois regards sur le mangeur (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (5 pts)
2. Pour le comportement « une adolescente refuse de manger à la cantine », formulez une question que poserait chacune des trois disciplines. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.2 – Le paradoxe de l'omnivore et le principe d'incorporation (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez un stage dans une crèche municipale. Les auxiliaires de puériculture vous rapportent des remarques d'enfants et de parents pendant la semaine du goût.

Document 1 – Ce qu'on entend à la crèche

a) Léna, 3 ans, repousse la purée de patate douce : « C'est orange, je veux pas. »

b) Un père : « Mon fils mange de la viande rouge pour devenir costaud. »

c) Malik, 4 ans, goûte le fenouil pour la troisième fois et dit : « Ça, j'aime bien maintenant. »

d) Une mère : « Je ne lui donne pas de lapin, c'est un animal de compagnie chez nous. »

e) Une auxiliaire : « Les enfants veulent tous goûter le plat que la cuisinière a appelé "la potion du dragon". »

f) Une mère végétarienne : « Je ne veux pas que mon enfant mange de la souffrance animale. »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez le paradoxe de l'omnivore en citant l'auteur et l'année. (2 pts)
2. Classez chaque situation du document 1 : néophobie, néophilie ou exposition répétée, principe d'incorporation, ordre du mangeable. (4 pts)
3. Proposez deux pratiques de la crèche qui s'appuient sur ces notions pour faire accepter un légume nouveau. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi il ne faut pas forcer un enfant à finir un aliment nouveau. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.3 – Légender la socialisation alimentaire (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une conseillère en économie sociale et familiale vous demande d'expliquer pourquoi des jeunes qui quittent le domicile familial changent si vite d'habitudes alimentaires.

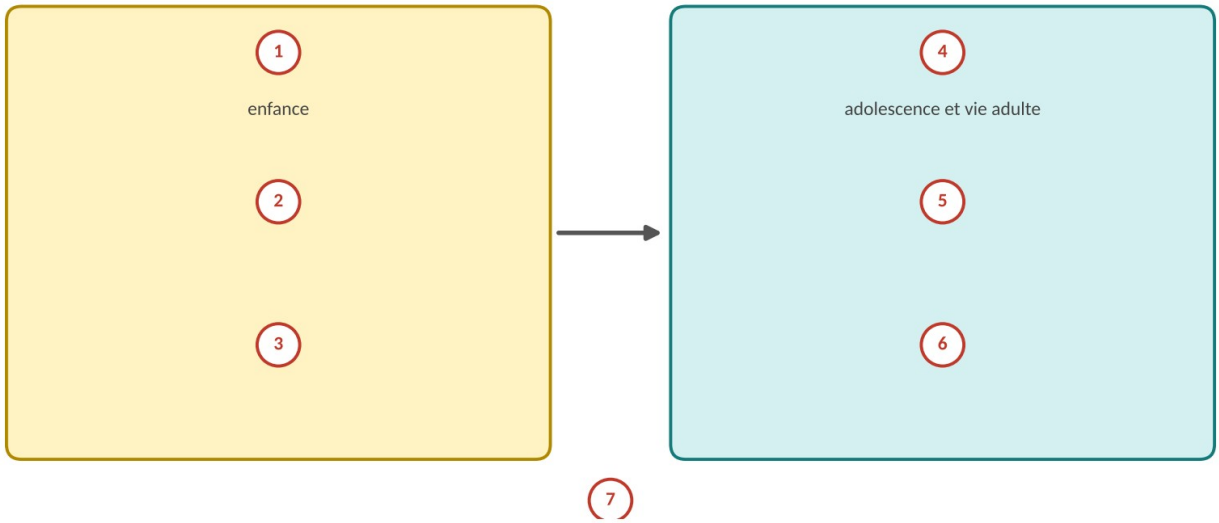


Figure 3.2 – Document 1 – Socialisation primaire et secondaire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)
2. Classez les agents suivants en agents de socialisation primaire ou secondaire : grands-parents, collègues de travail, assistante maternelle, influenceur culinaire, conjoint, cantine de l'école élémentaire, club de sport. (2,5 pts)
3. Expliquez, avec ce schéma, le changement d'habitudes d'un étudiant qui quitte ses parents pour une résidence universitaire. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.4 – L'espace social alimentaire de Poulain (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un atelier dans un foyer de travailleurs migrants qui accueille principalement des hommes de 45 à 70 ans, originaires d'Afrique de l'Ouest. Le responsable vous a transmis ses observations.

Document 1 – Observations du responsable du foyer

a) Les résidents ne mangent jamais de porc ; certains évitent aussi le gibier.

b) Les produits de base (riz brisé, huile d'arachide, poisson séché) sont achetés dans deux épiceries spécialisées du quartier.

c) Les plats sont cuisinés en grande marmite dans la cuisine collective, souvent par les plus âgés.

d) On mange en groupe, autour d'un plat commun, assis par terre ou à la table de la salle commune.

e) Le repas principal est pris tard le soir, après le travail ; pendant le ramadan, les horaires changent.

f) Les résidents disent que manger « comme au pays » les distingue des jeunes du quartier, qui mangent « des sandwichs ».

À vous de jouer – Questions

1. Citez les six dimensions de l'espace social alimentaire (Poulain, 2002). (3 pts)
2. Associez chaque observation du document 1 à une dimension. (3 pts)
3. Montrez en quoi ce modèle aide à éviter un atelier « hors sol ». Donnez deux adaptations concrètes. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.5 – Repas en famille et position sociale (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre d'un projet « bien manger » d'une école élémentaire, l'association des parents d'élèves a fait remplir un questionnaire par les familles. Vous êtes chargé d'analyser une question.

Document 1 – « Dans votre foyer, prenez-vous le repas du soir ensemble, à table, au moins 5 soirs sur 7 ? » (données fictives)

Profession de la personne de référence du foyer	Familles répondantes	Réponses « oui »
Cadres et professions intellectuelles supérieures	80	62
Employés	110	70
Ouvriers	90	48
Sans emploi	60	30
Total	340	210

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de « oui » dans chaque groupe et pour l'ensemble. (3 pts)
2. Calculez le rapport entre le pourcentage des cadres et celui des ouvriers ; rédigez une phrase d'interprétation. (2 pts)
3. Proposez trois explications sociologiques de ces écarts (horaires, conditions de travail, logement, normes). Évitez toute explication qui culpabilise les familles. (4 pts)
4. Indiquez deux limites de ces données. (2 pts)
5. Indiquez ce que ce résultat change pour le projet de l'école. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.6 – L'internat d'un lycée agricole (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au lycée agricole de Montfaucon (données fictives). Le service de restauration constate que les 120 élèves internes de seconde, arrivés en septembre, laissent beaucoup de nourriture, surtout les jours où les plats sont nouveaux pour eux. L'infirmière signale des élèves qui « ne mangent que du pain » et qui disent avoir le mal du pays. Le chef de cuisine vous demande une analyse avant de changer les menus.

Document 1 – Pesées des restes dans les assiettes, septembre et octobre (données fictives)

Type de plat principal	Nombre de repas observés	Restes totaux	Exemples
Plats connus des élèves	1 200	108 kg	steak haché-frites, pâtes bolognaise, poulet rôti
Plats nouveaux pour eux	960	201,6 kg	tajine de légumes, gratin de blettes, poisson en sauce

Document 2 – Ce que disent des internes

« Chez moi, on ne mange jamais de poisson. » « Ma mère fait le poulet comme personne. » « Ici on mange à 18 h 45, chez moi c'est 20 h devant la télé. » « Si tu prends les blettes, les autres rigolent. » « Le dimanche soir, j'ai le cafard. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les restes moyens par repas pour chaque type de plat (en grammes), puis le rapport entre les deux. (3 pts)
2. Analysez la situation avec trois notions : néophobie, socialisation primaire (repères familiaux), influence des pairs. Appuyez-vous sur le document 2. (5 pts)
3. Expliquez le lien entre le mal du pays et l'alimentation (fonction identitaire et affective des aliments). (2 pts)
4. Proposez quatre actions qui réduisent le gaspillage sans renoncer à la diversité des menus ; justifiez chacune par une notion. (4 pts)
5. Proposez un indicateur pour évaluer l'effet de vos actions en fin d'année. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 3.1

1. Légendes : 1 Psychologie ; 2 l'individu : perceptions, émotions, motivations, apprentissages ; 3 Pourquoi cette personne refuse-t-elle les légumes ? ; 4 Sociologie ; 5 les groupes sociaux : normes, classes sociales, genre, âge ; 6 Pourquoi les ouvriers mangent-ils moins de fruits que les cadres ? ; 7 Anthropologie ; 8 les cultures : symboles, rituels, interdits, manières de table ; 9 Pourquoi le repas partagé compte-t-il autant en France ? ; 10 Psychologie sociale : l'individu dans ses relations aux autres.
2. Psychologie : quelles émotions, quels dégoûts ou quelle image de son corps expliquent son refus ? Sociologie : le refus est-il plus fréquent dans certains milieux sociaux, chez les filles, à certains âges, et que dit-il des normes du groupe ? Anthropologie : quels aliments servis à la cantine sont jugés « mangeables » ou interdits dans sa culture familiale ? On peut ajouter la psychologie sociale : l'adolescente refuse-t-elle pour se conformer à son groupe d'amies ?

Corrigé – Exercice 3.2

1. Claude Fischler (L'Homnivore, 1990) : l'omnivore dépend d'une grande variété d'aliments, ce qui le pousse à essayer du nouveau (néophilie) ; mais tout aliment inconnu peut être dangereux, ce qui le rend prudent (néophobie). Cette tension crée une anxiété que la culture apaise en disant ce qui se mange et comment.
2. a) néophobie (refus lié à l'aspect, sans avoir goûté) ; b) principe d'incorporation (on attend de la viande qu'elle transmette la force) ; c) exposition répétée : l'acceptation augmente avec le nombre de dégustations ; d) ordre du mangeable : un animal de compagnie n'est pas « mangeable » dans cette culture familiale ; e) néophilie favorisée par un nom ludique et la curiosité ; f) principe d'incorporation dans sa dimension morale (on ne veut pas faire entrer en soi la souffrance), et ordre du mangeable.
3. Proposer le légume plusieurs fois (8 à 10 expositions sont souvent nécessaires) en petites quantités, sans pression ; le faire manipuler, sentir et nommer de façon ludique ; montrer les adultes et d'autres enfants qui en mangent avec plaisir (modèle).
4. La contrainte associe l'aliment à une émotion négative et renforce le refus ; elle peut créer un dégoût durable. Elle apprend aussi à l'enfant à ne plus écouter ses signaux de faim et de satiété. La règle conseillée est « on goûte, on n'est pas obligé de finir ».

Corrigé – Exercice 3.3

1. Légendes : 1 Socialisation primaire ; 2 Agents : famille, école maternelle et élémentaire ; 3 Ce qui est appris : goûts, manières de table, rythme des repas, ce qui « se mange » ; 4 Socialisation secondaire ; 5 Agents : pairs, travail, couple, médias, réseaux sociaux ; 6 Ce qui change : pratiques du groupe d'appartenance, horaires de travail, nouveaux aliments ; 7 Identité : ce que je mange dit qui je suis et à quel groupe j'appartiens.
2. Primaire : grands-parents, assistante maternelle, cantine de l'école élémentaire. Secondaire : collègues de travail, influenceur culinaire, conjoint, club de sport.
3. Chez ses parents, les repas suivaient les règles apprises pendant la socialisation primaire (horaires, plats, repas à table). En résidence, il n'a plus ce cadre ; les nouveaux agents (amis étudiants, horaires des cours, réseaux sociaux, petit budget, cuisine partagée) imposent d'autres normes : repas décalés ou sautés, plats rapides, repas pris en groupe le soir. Les habitudes de l'enfance ne disparaissent pas : elles reviennent souvent quand l'étudiant s'installe en couple ou devient parent.

Corrigé – Exercice 3.4

1. L'ordre du mangeable ; le système alimentaire ; l'espace culinaire ; l'espace des habitudes de consommation ; la temporalité alimentaire ; l'espace de différenciation sociale.
2. a) ordre du mangeable (interdits religieux et culturels) ; b) système alimentaire (filières

d'approvisionnement, commerces) ; c) espace culinaire (où et qui cuisine, techniques) ; d) habitudes de consommation (manières de table, plat commun) ; e) temporalité alimentaire (horaires, calendrier religieux) ; f) différenciation sociale (l'alimentation marque l'appartenance à un groupe et la distinction des autres).

3. Le modèle oblige à partir des pratiques réelles, de leurs contraintes et de leur sens avant de proposer quelque chose. Un atelier « hors sol » proposerait par exemple une recette avec du porc, un repas à midi un jour de ramadan ou des produits introuvables dans le quartier. Adaptations : partir d'un plat que les résidents cuisinent déjà (mafé, thieboudienne) et travailler avec eux une version moins grasse ou moins salée en gardant le goût (huile, cube de bouillon) ; organiser l'atelier le soir, en grande marmite, avec les cuisiniers du foyer, et acheter les produits dans les épiceries du quartier. On valorise ainsi leur identité au lieu de la nier.

Corrigé – Exercice 3.5

1. Cadres : 62 / 80 × 100 = 77,5 % ; employés : 70 / 110 × 100 = 63,6 % ; ouvriers : 48 / 90 × 100 = 53,3 % ; sans emploi : 30 / 60 × 100 = 50,0 % ; ensemble : 210 / 340 × 100 = 61,8 %.

2. 77,5 / 53,3 = 1,45. Dans cette école, les familles de cadres déclarent 1,45 fois plus souvent que les familles d'ouvriers un repas du soir pris ensemble au moins 5 soirs sur 7.

3. Horaires et conditions de travail : travail posté, de nuit ou en horaires décalés plus fréquent chez les ouvriers et certains employés, qui empêche d'être présent le soir. Logement : logements plus petits, sans place pour une table commune, repas pris à tour de rôle. Organisation familiale : familles monoparentales, plusieurs emplois. Normes : le repas familial à table est une norme très valorisée dans les milieux favorisés, qui peuvent aussi mieux la respecter ; dans d'autres milieux, le repas devant la télévision ou en décalé n'a pas le même sens. Ces explications portent sur les conditions de vie, pas sur la « volonté » des parents.

4. Données déclaratives (désirabilité sociale : le repas en famille est une norme, on peut surestimer) ; familles volontaires, sans taux de réponse connu ; petits effectifs ; une seule profession par foyer ; pas de test statistique.

5. Ne pas faire du « repas en famille » une injonction qui culpabiliserait les parents qui travaillent tard ; proposer plutôt des idées de repas rapides à partager quand c'est possible, et valoriser d'autres moments (petit-déjeuner, week-end).

Corrigé – Exercice 3.6

1. Plats connus : 108 kg = 108 000 g ; 108 000 / 1 200 = 90 g par repas. Plats nouveaux : 201 600 / 960 = 210 g par repas. Rapport : 210 / 90 = 2,33. Les plats nouveaux laissent 2,3 fois plus de restes que les plats connus.

2. Néophobie : les plats inconnus (tajine de légumes, blettes, poisson en sauce) inquiètent ; les élèves préfèrent ce qui est familier, surtout dans une période de stress (arrivée à l'internat). Socialisation primaire : les repères familiaux restent forts (« chez moi, on ne mange jamais de poisson », horaires de 20 h, poulet « de ma mère ») ; le changement d'horaires et de plats bouleverse leurs habitudes. Influence des pairs : à 15 ans, le regard du groupe compte beaucoup (« si tu prends les blettes, les autres rigolent ») ; personne ne veut être le premier à goûter.

3. Les aliments familiaux sont associés à la maison, à la mère, à la sécurité affective ; manger « comme chez soi » rassure et confirme son identité. Loin de chez eux, les élèves recherchent ce qui est connu (pain, plats habituels) et refusent ce qui rappelle qu'ils sont ailleurs.

4. Exemples : proposer chaque nouveau plat en petite portion à côté d'un plat connu, et le reproposer plusieurs fois (exposition répétée) ; organiser une dégustation commentée par le chef, avec un nom attractif (néophilie) ; faire participer des élèves volontaires à l'élaboration d'un menu par mois (implication, engagement) ; impliquer des élèves de terminale comme modèles (influence des pairs, norme descriptive) ; proposer un « plat de chez nous » choisi par les élèves une fois par semaine

(identité, sécurité affective).

5. Restes moyens par repas pour les plats nouveaux, mesurés avec la même méthode en mai : objectif de passer de 210 g à moins de 150 g ; ou la part des élèves qui goûtent un plat nouveau, relevée lors de dégustations.

Partie 2 – Représentations, normes, valeurs et culture

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir une représentation sociale, ses processus de formation (objectivation, ancrage) et ses fonctions ; distinguer noyau central et éléments périphériques.
- Distinguer norme, valeur et attitude ; norme descriptive et norme injonctive.
- Analyser une situation interculturelle (Berry, Cohen-Emerique) sans ethnocentrisme.
- Réaliser une analyse prototypique et un questionnaire de mise en cause.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Représentation sociale : forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, qui vise un but pratique et contribue à construire une réalité commune à un groupe (Jodelet, 1989, d'après Moscovici, 1961).
- Objectivation : rendre concret une notion abstraite (« manger sain » devient « manger des légumes verts »). Ancrage : rattacher la nouveauté à des catégories déjà connues (« le bio, c'est comme les produits de la ferme »).
- Fonctions (Abric, 1994) : de savoir, identitaire, d'orientation des conduites, justificatrice.
- Théorie du noyau central (Abric, 1976, 1994) : le noyau, stable et consensuel, donne le sens ; la périphérie, souple, s'adapte aux situations et protège le noyau.
- Norme : règle de conduite partagée par un groupe. Norme descriptive : ce que font la plupart des gens. Norme injonctive : ce qu'il faut faire, ce qui est approuvé (Cialdini, Reno et Kallgren, 1990). Valeur : idéal qui oriente les choix (santé, plaisir, partage, économie).
- Acculturation (Berry, 1997) : intégration, assimilation, séparation, marginalisation.
- Démarche interculturelle (Cohen-Emerique) : décentration, découverte du cadre de référence de l'autre, négociation.

Exercice 3.7 – Représentations sociales : définition, formation, fonctions (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un centre de santé vous demande pourquoi certains patients disent : « Les féculents font grossir, je les ai supprimés. » Elle veut comprendre d'où viennent ces idées avant sa prochaine séance collective.

Document 1 – Extraits d'entretiens avec des patients

a) « Pour moi, maigrir, c'est manger de la salade et du blanc de poulet. »

b) « Le pain, c'est comme le sucre, ça se transforme en gras. »

c) « Dans ma famille, on a toujours dit que les pâtes, c'est pour les sportifs. »

d) « Si je mange des pâtes le soir, je me sens coupable, alors je les évite pour être tranquille. »

e) « Moi je fais attention, pas comme les gens qui mangent n'importe quoi. »

À vous de jouer – Questions

1. Définissez une représentation sociale en citant deux auteurs. (2 pts)
2. Montrez dans le document 1 un exemple d'objectivation et un exemple d'ancrage. (2 pts)
3. Associez les extraits c), d) et e) à une fonction des représentations (Abric, 1994). (3 pts)
4. Expliquez pourquoi une simple information (« les féculents ne font pas grossir ») a peu de chances de changer ces représentations, et proposez une autre démarche. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.8 – Normes descriptives et injonctives (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une entreprise veut inciter ses salariés à prendre le plat végétarien du restaurant d'entreprise. Le service communication a proposé plusieurs affiches et vous demande votre avis.

Document 1 – Projets d'affiches

A. « Il faut manger moins de viande pour la planète. »

B. « Seuls 8 % des salariés choisissent le plat végétarien : ne soyez pas comme les autres ! »

C. « Cette semaine, 1 salarié sur 3 a choisi le plat végétarien. Et vous ? »

D. « Vos collègues trouvent que le plat végétarien du jeudi est le meilleur de la semaine (note moyenne : 4,3 sur 5). »

E. « Le plat végétarien : délicieux, rassasiant, et préparé ici avec des produits locaux. »

À vous de jouer – Questions

1. Définissez norme, valeur et attitude. (3 pts)
2. Classez chaque affiche : norme injonctive, norme descriptive, ou message qui ne s'appuie pas sur une norme. (2,5 pts)
3. Expliquez pourquoi l'affiche B risque d'avoir l'effet inverse de celui recherché (effet « boomerang »). (2,5 pts)
4. Choisissez l'affiche la plus efficace et justifiez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.9 – Légender les stratégies d'acculturation (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez des ateliers dans un centre d'accueil de personnes réfugiées. La coordinatrice vous présente quatre résidents.

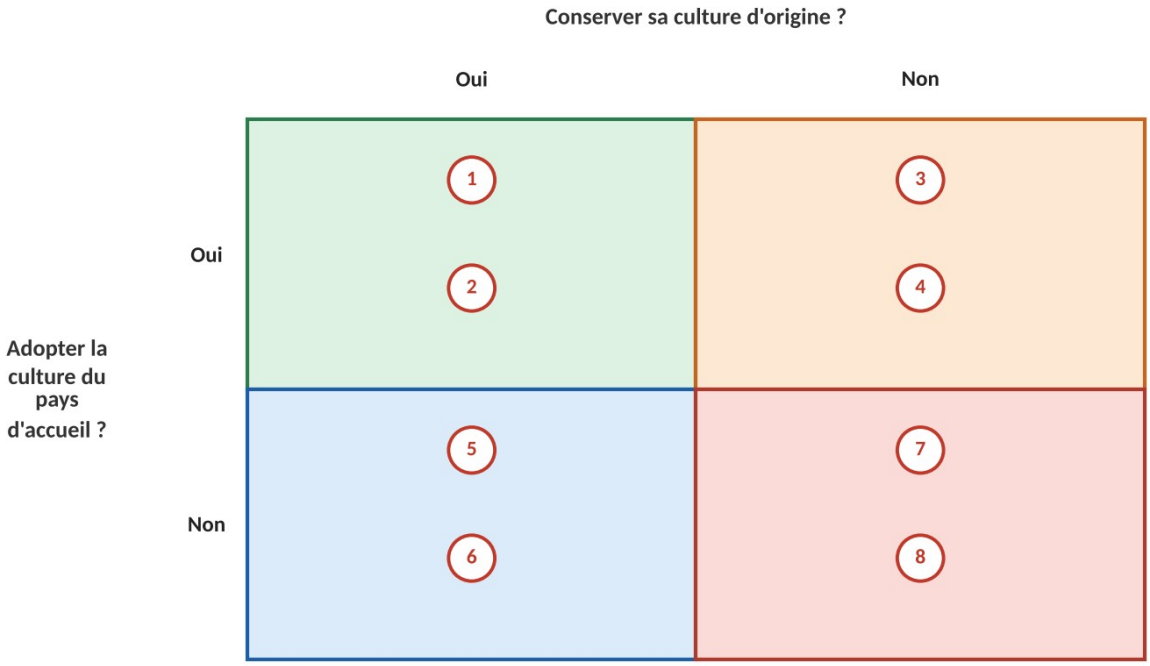


Figure 3.3 – Document 1 – Les stratégies d'acculturation de Berry (schéma à légender)

Document 2 – Quatre résidents

a) Nour, 34 ans, cuisine les plats syriens de sa mère et a appris à faire les gratins avec ses voisines.

b) Arman, 52 ans, ne mange que des produits de son pays, achetés dans une épicerie spécialisée ; il refuse la cantine de l'entreprise.

c) Yusuf, 19 ans, dit qu'il « ne mange plus comme là-bas » mais qu'il ne sait pas cuisiner « à la française » : il vit de sandwichs.

d) Aïcha, 27 ans, mange comme ses collègues françaises et a cessé de préparer les plats de son enfance.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Associez chaque résident à une stratégie. (2 pts)
3. Indiquez la situation la plus à risque pour la santé et expliquez pourquoi. (2 pts)
4. Indiquez ce que doit viser un atelier pour ce public, d'après ce modèle. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.10 – Analyse prototypique : « manger bio » chez des étudiants (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé étudiante d'une université veut développer l'offre de produits biologiques à la cafétéria. Vous avez recueilli les représentations de 90 étudiants par évocation hiérarchisée : « Quels sont les cinq mots qui vous viennent à l'esprit quand on vous dit "manger bio" ? Classez-les du plus important (1) au moins important (5). »

Document 1 – Résultats (données fictives)

Catégorie	Nombre de citations	Rang moyen
Santé	54	2,0
Cher	49	2,3
Nature	36	2,9
Sans pesticides	33	2,5
Local	25	3,6
Goût	22	3,4
Mode, « bobo »	18	2,6
Marketing	12	3,8

Seuils : moyenne des citations et moyenne des rangs moyens des huit catégories.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les deux seuils. (2 pts)

2. Construisez le tableau à quatre zones et placez chaque catégorie. (4 pts)

3. Interprétez la représentation : sens du noyau, rôle de la périphérie, zone contrastée. (4 pts)

4. Déduisez-en deux recommandations pour l'offre de la cafétéria et sa communication. (2 pts)

5. Indiquez comment vérifier qu'un élément appartient vraiment au noyau. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.11 – Une situation interculturelle à la cantine (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans un service municipal de restauration scolaire. Une animatrice périscolaire vous raconte : « Une maman est venue se plaindre parce que sa fille ne mange rien les jours où il y a de la viande. Je lui ai dit qu'en France, on mange de tout et que sa fille devait s'adapter. Elle est partie en colère. » La commune propose déjà un menu sans viande une fois par semaine.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez l'ethnocentrisme et le relativisme culturel. (2 pts)
2. Analysez la réaction de l'animatrice : quelle attitude montre-t-elle ? Quelles conséquences pour l'enfant et pour la relation avec la famille ? (3 pts)
3. Présentez les trois étapes de la démarche interculturelle de Margalit Cohen-Emerique et appliquez-les à cette situation. (5 pts)
4. Proposez deux solutions concrètes qui respectent le cadre de la restauration scolaire et les besoins de l'enfant. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.12 – Questionnaire de mise en cause : qu'est-ce qu'un « vrai repas » ? (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de quartier veut lancer des ateliers « repas rapides et équilibrés » pour des parents qui travaillent. Lors d'une première enquête par évocation, les mots « plat chaud », « à table », « en famille », « pain » et « dessert » sont apparus dans la zone du noyau. Pour vérifier leur centralité, vous réalisez un questionnaire de mise en cause auprès de 120 habitants.

Document 1 – Résultats du questionnaire de mise en cause (données fictives)

Question posée pour chaque élément : « Un repas peut-il être un vrai repas s'il… »

Élément mis en cause	Réponses « non » (n = 120)
… ne comporte pas de plat chaud ?	98
… n'est pas pris assis à table ?	101
… est pris seul ?	88
… ne comporte pas de pain ?	52
… ne comporte pas de dessert ?	31

Règle de décision : un élément est considéré comme central si au moins 75 % des personnes refusent qu'on puisse le retirer (réponse « non »).

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez le principe du questionnaire de mise en cause. (2 pts)
2. Calculez le pourcentage de « non » pour chaque élément et appliquez la règle de décision. (5 pts)
3. Interprétez : quels éléments font partie du noyau, lesquels sont périphériques ? Discutez le cas de « pris seul ». (3 pts)
4. Déduisez-en deux conséquences pour les ateliers « repas rapides ». (4 pts)
5. Indiquez deux limites de cette méthode. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 3.7

1. Selon Denise Jodelet (1989), qui prolonge les travaux de Serge Moscovici (1961), une représentation sociale est une forme de connaissance socialement élaborée et partagée, qui a un but pratique et contribue à construire une réalité commune à un groupe. C'est une « théorie du sens commun » qui guide les conduites.
2. Objectivation : a) « maigrir, c'est manger de la salade et du blanc de poulet » rend concrète l'idée abstraite de régime. Ancrage : b) « le pain, c'est comme le sucre » rattache le pain, mal connu, à une catégorie déjà connue et jugée négative.
3. c) fonction de savoir (et identitaire : un savoir transmis dans la famille) ; d) fonction justificatrice (l'évitement est justifié après coup, pour se sentir en accord avec soi) ; e) fonction identitaire (se situer dans le groupe de « ceux qui font attention », se distinguer des autres).
4. Une représentation n'est pas une simple erreur de connaissance : elle est partagée, elle a un sens pour le groupe et elle protège l'identité ; le noyau résiste aux contre-arguments. On peut plutôt partir de ce que pensent les patients (photolangage, débat), les faire expérimenter (une assiette avec féculents, sensation de satiété), utiliser des pairs qui ont réussi, et agir d'abord sur les éléments périphériques (« le soir, une petite portion de féculents aide à éviter le grignotage »).

Corrigé – Exercice 3.8

1. Norme : règle de conduite partagée par un groupe, dont le non-respect entraîne une sanction sociale (moquerie, rejet). Valeur : idéal collectif qui oriente les choix et donne du sens (santé, écologie, plaisir). Attitude : disposition interne, plus ou moins favorable, envers un objet (j'aime ou je n'aime pas les plats végétariens), qui prépare à agir.
2. A : norme injonctive (ce qu'il faut faire). B : norme descriptive négative (ce que fait la majorité : ne pas choisir le plat végétarien). C : norme descriptive positive et en progression. D : norme injonctive sociale (ce qu'approuvent les collègues). E : message centré sur les qualités du plat, sans norme sociale.
3. L'affiche B dit que 92 % des salariés ne prennent pas le plat végétarien : elle installe une norme descriptive contraire au but. Les gens ont tendance à se conformer à ce que fait la majorité ; ceux qui en prenaient déjà pourraient même en prendre moins. Les travaux de Cialdini (1990) et de Schultz et ses collègues (2007) montrent cet effet boomerang lorsqu'on décrit un comportement indésirable comme fréquent.
4. L'affiche C (ou D) : elle montre qu'un comportement est fréquent et approuvé par les collègues, ce qui active la norme descriptive et la norme injonctive dans le même sens. On peut combiner C et E pour ajouter le plaisir. L'affiche A, moralisatrice, risque de provoquer un rejet (réactance).

Corrigé – Exercice 3.9

1. Légendes : 1 Intégration ; 2 garder ses pratiques et adopter celles du pays d'accueil ; 3 Assimilation ; 4 abandonner ses pratiques pour celles du pays d'accueil ; 5 Séparation ; 6 garder ses pratiques sans adopter celles du pays d'accueil ; 7 Marginalisation ; 8 perdre ses pratiques sans adopter celles du pays d'accueil.
2. a) Nour : intégration ; b) Arman : séparation ; c) Yusuf : marginalisation ; d) Aïcha : assimilation.
3. La marginalisation (Yusuf) : il a perdu ses repères culinaires sans en acquérir de nouveaux ; son alimentation est monotone et dépend de produits tout prêts ; elle s'accompagne souvent d'un isolement social et d'une perte d'estime de soi. L'assimilation peut aussi exposer à une alimentation plus industrialisée, alors que certaines alimentations d'origine sont riches en légumineuses et en légumes.
4. Favoriser l'intégration : valoriser les savoir-faire d'origine (recettes, épices, légumineuses) et donner accès aux produits et repères du pays d'accueil (où acheter, à quel prix, comment cuisiner un légume local). Un atelier où chacun apporte une recette de chez lui et découvre une recette locale est un bon exemple.

Corrigé – Exercice 3.10

1. Total des citations : 54 + 49 + 36 + 33 + 25 + 22 + 18 + 12 = 249 ; seuil de fréquence = 249 / 8 = 31,1 citations. Somme des rangs : 2,0 + 2,3 + 2,9 + 2,5 + 3,6 + 3,4 + 2,6 + 3,8 = 23,1 ; seuil de rang = 23,1 / 8 = 2,89.

2. Zone du noyau (fréquence ≥ 31,1 et rang < 2,89) : santé (54 ; 2,0), cher (49 ; 2,3), sans pesticides (33 ; 2,5). Première périphérie (fréquence ≥ 31,1 et rang ≥ 2,89) : nature (36 ; 2,9). Zone contrastée (fréquence < 31,1 et rang < 2,89) : mode, « bobo » (18 ; 2,6). Seconde périphérie (fréquence < 31,1 et rang ≥ 2,89) : local (25 ; 3,6), goût (22 ; 3,4), marketing (12 ; 3,8).

3. Pour ces étudiants, manger bio, c'est d'abord manger sain, sans pesticides, mais cher : le noyau associe un bénéfice (santé) et un frein majeur (prix). La périphérie (nature, local, goût, marketing) est moins partagée ; elle montre des éléments qui peuvent évoluer, et une méfiance (marketing). La zone contrastée révèle un sous-groupe qui associe le bio à une mode sociale (« bobo ») : pour lui, manger bio marque une distinction sociale qu'il rejette peut-être.

4. Agir sur le prix, frein central : un plat bio au même prix que le plat habituel, des produits bruts bio peu chers (légumineuses, pommes) ; communiquer sur la santé et l'absence de pesticides, qui ont du sens pour eux, et éviter un discours « tendance » qui renforcerait l'image « bobo » ; montrer la provenance locale pour répondre à la méfiance envers le marketing.

5. Utiliser une seconde technique : questionnaire de mise en cause (« Peut-on parler de bio si ce n'est pas bon pour la santé ? »), schèmes cognitifs de base, ou entretiens. Un élément central est massivement refusé quand on le met en cause.

Corrigé – Exercice 3.11

1. Ethnocentrisme : tendance à juger les pratiques des autres groupes à partir des normes de son propre groupe, considérées comme les seules normales. Relativisme culturel : attitude qui considère que chaque pratique a un sens dans sa culture et qu'il faut la comprendre avant de la juger.

2. L'animatrice montre une attitude ethnocentrique (« en France, on mange de tout ») et une injonction à l'assimilation. Conséquences : l'enfant ne mange pas, peut avoir faim l'après-midi et se sentir rejetée ; la mère se sent jugée, la confiance avec l'école est rompue, la famille peut retirer l'enfant de la cantine, alors que la cantine est souvent le repas le plus complet de la journée pour certains enfants.

3. Décentration : l'animatrice prend conscience de son propre cadre de référence (pour elle, manger de tout est une valeur d'éducation et d'égalité) et de ses réactions. Découverte du cadre de référence de l'autre : elle écoute la mère, sans supposer : la viande est-elle refusée pour des raisons religieuses (viande non certifiée), végétariennes, de goût ? Négociation : chercher une solution acceptable pour les deux parties, dans le cadre du règlement de la cantine (par exemple, proposer à l'enfant les accompagnements en plus grande quantité et le menu sans viande de la semaine).

4. Servir systématiquement à l'enfant une double portion d'accompagnement (légumes, féculents) et le laitage les jours de viande, en lien avec la cuisine ; informer la famille du menu à l'avance ; étudier avec la commune une alternative protéique (œuf, poisson, légumineuses) lorsque c'est possible. La décision appartient à la commune, mais la relation de confiance dépend de la façon d'en parler.

Corrigé – Exercice 3.12

1. On présente chaque élément supposé central et on demande si l'objet existe encore sans lui (Moliner, 1988). Si une large majorité répond que non, l'élément est indispensable au sens de l'objet : il est central. Si beaucoup acceptent qu'on le retire, il est périphérique.

2. Plat chaud : 98 / 120 × 100 = 81,7 % ; assis à table : 101 / 120 × 100 = 84,2 % ; pris seul : 88 / 120 × 100 = 73,3 % ; pain : 52 / 120 × 100 = 43,3 % ; dessert : 31 / 120 × 100 = 25,8 %. Au seuil de 75 % : plat chaud et à table sont centraux ; pris seul, pain et dessert ne sont pas centraux.

3. Le noyau du « vrai repas » pour ces habitants est un plat chaud pris assis à table. Le pain et le dessert sont périphériques : ils sont fréquents mais on peut s'en passer. « Pris seul » (73,3 %) est juste sous le seuil : la

dimension sociale du repas est forte mais pas unanime ; c'est un élément à la frontière, que d'autres techniques devraient confirmer.

4. Les repas « rapides » doivent rester chauds et pris à table pour être acceptés comme de vrais repas : proposer des plats chauds en 15 minutes (omelette, poêlées, soupes-repas) plutôt que des sandwichs ou des salades froides. On peut alléger les éléments périphériques sans heurter la représentation (dessert remplacé par un fruit, pain non obligatoire) ; on encourage le repas à table même quand il est court.

5. Les réponses dépendent de la formulation de la question ; le seuil de 75 % est conventionnel ; l'échantillon n'est peut-être pas représentatif (habitants qui fréquentent la maison de quartier) ; la mise en cause ne dit pas pourquoi un élément est central.

Partie 3 – Influence sociale, attitudes et stigmatisation

Objectifs – Objectifs de la partie

- Présenter les grandes expériences sur l'influence sociale : normalisation (Sherif), conformisme (Asch), influence minoritaire (Moscovici), décision de groupe (Lewin).
- Expliquer la dissonance cognitive (Festinger) et la théorie de l'engagement (Kiesler ; Joule et Beauvois), et les utiliser de façon éthique.
- Distinguer stéréotype, préjugé, discrimination et stigmatisation ; prévenir la stigmatisation liée au poids.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Normalisation (Sherif, 1935) : face à une situation ambiguë, un groupe construit une norme commune. Conformisme (Asch, 1951) : un individu se range à l'avis faux d'une majorité unanime. Influence minoritaire (Moscovici, 1969) : une minorité cohérente et constante peut faire évoluer la majorité.
- Décision de groupe (Lewin, 1943) : une décision prise après discussion en groupe change davantage les comportements qu'une conférence. Les ménagères sont les « gardiennes du portail » (gatekeepers) de l'alimentation familiale.
- Dissonance cognitive (Festinger, 1957) : tension née de deux cognitions incompatibles ; on la réduit en changeant le comportement, la croyance, ou en ajoutant une justification.
- Engagement (Kiesler, 1971 ; Joule et Beauvois, 1998) : un acte libre, public, répété et coûteux engage la personne et rend plus probables des actes cohérents avec lui. Pied-dans-la-porte (Freedman et Fraser, 1966).
- Stéréotype (croyance), préjugé (jugement affectif), discrimination (acte) ; stigmate (Goffman, 1963) : attribut qui discrédite profondément une personne.

Exercice 3.13 – Les grandes expériences de l'influence sociale (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une fiche de révision pour vos camarades et vous voulez relier chaque expérience à une situation de terrain en nutrition.

Document 1 – Quatre situations de terrain

a) Dans un atelier, personne ne sait combien de sel mettre dans la soupe ; après quelques essais, tout le groupe adopte « une demi-cuillère ».

b) Dans une classe, tous les élèves disent que le plat de lentilles est « immangeable » ; Inès, qui l'aimait, dit qu'elle ne l'aime pas non plus.

c) Deux élèves végétariens défendent calmement et régulièrement le menu végétarien ; à la fin de l'année, plusieurs camarades le choisissent.

d) Après une discussion en petit groupe, chaque parent annonce ce qu'il va essayer à la maison ; deux semaines plus tard, beaucoup l'ont fait.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque situation à une expérience (auteur, année, notion). (4 pts)
2. Pour l'expérience d'Asch, indiquez deux conditions qui diminuent le conformisme. (2 pts)
3. Indiquez les trois qualités du comportement d'une minorité qui la rendent influente. (2 pts)
4. Montrez l'intérêt de la situation c) pour un projet de santé publique. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.14 – L'expérience de Lewin (1943) et le travail en groupe (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice de stage vous demande pourquoi vous préférez organiser des ateliers en petits groupes plutôt que des conférences. Vous vous appuyez sur une expérience historique.

Document 1 – L'expérience de Kurt Lewin (États-Unis, 1943)

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain veut que les familles consomment davantage d'abats (cœur, rognons, ris), alors peu appréciés, pour économiser la viande destinée aux soldats. Kurt Lewin compare deux méthodes auprès de groupes de ménagères : trois groupes écoutent une conférence attractive sur les qualités nutritionnelles et économiques des abats, avec des recettes ; trois autres groupes discutent, guidés par un animateur, des obstacles et des solutions, puis chaque participante indique à main levée si elle compte en servir. Une enquête est faite quelques jours plus tard. Résultat : 3 % des ménagères des groupes « conférence » ont servi un abat jamais servi auparavant, contre 32 % des ménagères des groupes « discussion et décision ».

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le rapport entre les deux pourcentages et rédigez une phrase d'interprétation. (2 pts)
2. Expliquez la notion de « gardien du portail » (gatekeeper) et son intérêt pour choisir un public cible. (2 pts)
3. Identifiez trois facteurs qui expliquent la supériorité de la décision de groupe (participation, engagement public, norme de groupe). (3 pts)
4. Indiquez deux limites de cette expérience (époque, méthode). (2 pts)
5. Transposez la méthode à un atelier actuel sur la consommation de légumineuses : décrivez le déroulé en trois temps. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.15 – Légender la dissonance cognitive (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un stand de prévention dans un centre commercial, un homme vous dit : « Je sais que les boissons sucrées favorisent le diabète, mais j'en bois un litre par jour. De toute façon, mon grand-père en buvait et il a vécu jusqu'à 90 ans. »

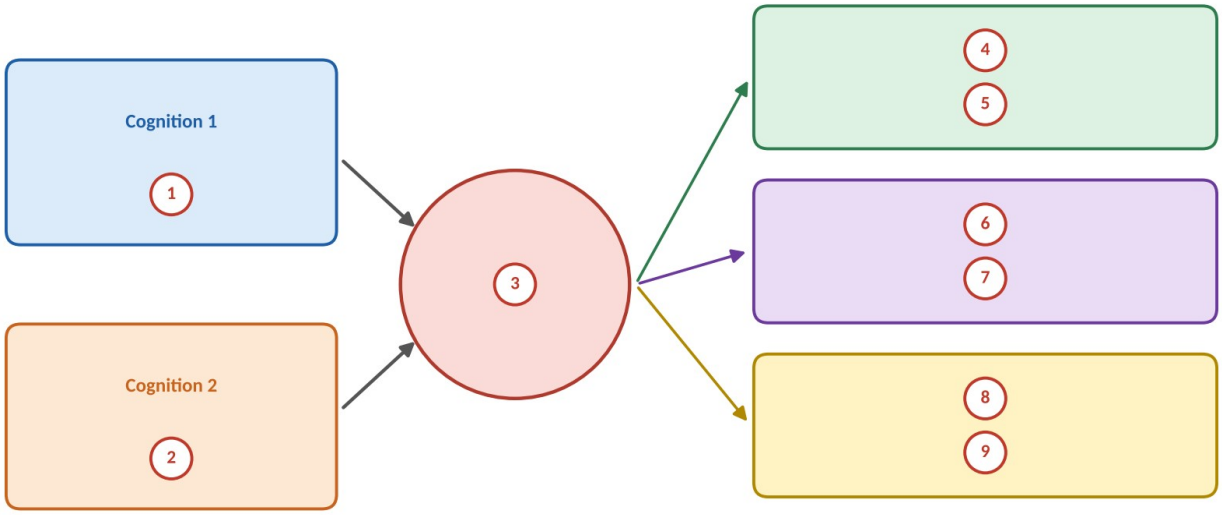


Figure 3.4 – Document 1 – La dissonance cognitive (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Identifiez la stratégie de réduction de la dissonance utilisée par cet homme. (1,5 pt)
3. Expliquez pourquoi un message qui fait peur (« vous allez devenir diabétique ») peut renforcer cette stratégie. (2 pts)
4. Proposez une réponse orale de professionnel qui aide l'homme à envisager un petit changement de comportement. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.16 – Engagement et pied-dans-la-porte (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de parents veut encourager les familles à préparer le goûter « fait maison » une fois par semaine. Un parent propose d'utiliser la technique du « pied-dans-la-porte ». Vous êtes chargé de vérifier que la démarche est efficace et éthique.

Document 1 – L'expérience de Freedman et Fraser (1966, États-Unis)

Des enquêteurs demandent à des propriétaires d'accepter l'installation, dans leur jardin, d'un grand panneau peu esthétique « Conduisez prudemment ». Dans le groupe témoin, environ 17 % acceptent (16,7 %). Dans un autre groupe, on avait demandé deux semaines plus tôt à chaque propriétaire de poser à sa fenêtre un petit autocollant de 8 cm « Soyez un conducteur prudent » ; presque tous avaient accepté. Dans ce groupe, environ 76 % acceptent ensuite le grand panneau.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le rapport entre les deux taux d'acceptation et l'écart en points ; interprétez. (2 pts)
2. Définissez l'engagement et citez quatre facteurs qui le renforcent. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi le sentiment de liberté est indispensable (citez l'expression de Joule et Beauvois). (2 pts)
4. Construisez une démarche d'engagement en deux étapes pour le goûter fait maison. (3 pts)
5. Indiquez la limite éthique de ces techniques et la façon de la respecter. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.17 – Légender stéréotype, préjugé, discrimination (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans un service de médecine du travail. Une salariée en situation d'obésité raconte qu'au restaurant d'entreprise ses collègues commentent son plateau, qu'elle a été écartée d'un poste d'accueil « pour l'image », et qu'elle ne va plus chez son médecin parce qu'il « ne parle que de son poids ».

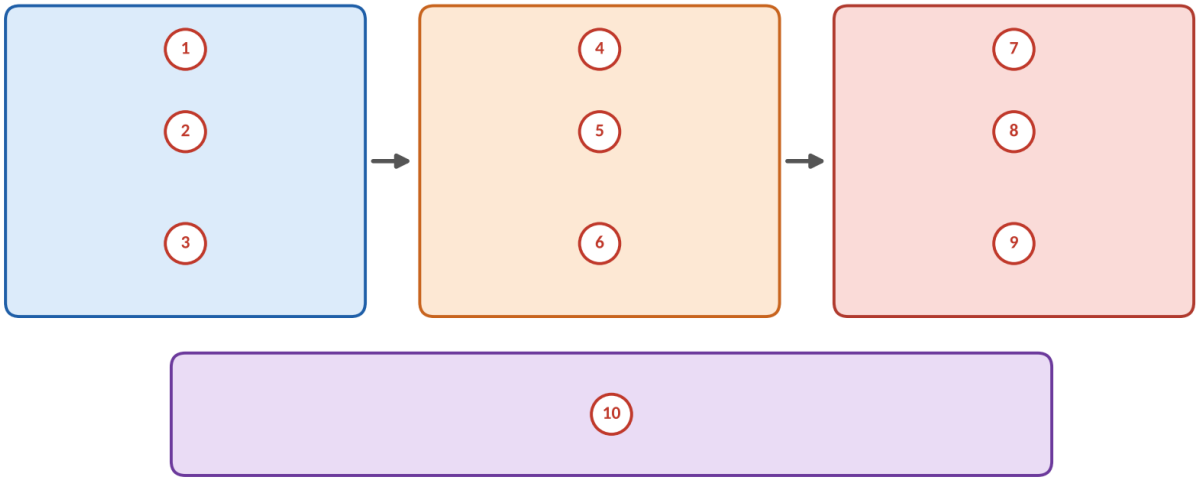


Figure 3.5 – Document 1 – Du stéréotype à la stigmatisation (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (5 pts)
2. Repérez dans la situation un exemple de préjugé, de discrimination et une conséquence de la stigmatisation sur la santé. (3 pts)
3. Indiquez si l'apparence physique est un critère de discrimination interdit en France et citez le texte. (2 pts)
4. Proposez deux règles de langage et de posture pour un professionnel de la nutrition. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.18 – Mesurer les attitudes envers les personnes obèses (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un institut de formation en soins infirmiers vous demande d'évaluer un module de 3 heures sur la stigmatisation liée au poids, destiné à 40 étudiants. Vous utilisez une échelle de 6 items, cotés de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (tout à fait d'accord), avant et après le module.

Document 1 – L'échelle (construite pour l'exercice)

Item	Sens
1. Les personnes obèses manquent de volonté.	stigmatisant
2. Le poids dépend de nombreux facteurs que l'on ne contrôle pas.	non stigmatisant
3. Je serais gêné(e) de travailler avec une personne obèse.	stigmatisant
4. Les personnes obèses méritent le même respect que les autres.	non stigmatisant
5. Si elles le voulaient vraiment, les personnes obèses maigriraient.	stigmatisant
6. Les moqueries sur le poids font du mal.	non stigmatisant

Score total de 6 à 30, calculé après inversion des items non stigmatisants (score inversé = 6 − réponse) : plus le score est élevé, plus l'attitude est stigmatisante.

Document 2 – Résultats (données fictives)

Réponses de l'étudiante E12 avant le module : item 1 = 4 ; item 2 = 2 ; item 3 = 3 ; item 4 = 4 ; item 5 = 5 ; item 6 = 4.

Score moyen du groupe : 18,6 avant le module ; 14,2 après. Part des étudiants dont le score est d'au moins 18 : 24 sur 40 avant ; 11 sur 40 après.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi certains items sont inversés. (2 pts)
2. Calculez le score de l'étudiante E12. (3 pts)
3. Calculez la baisse du score moyen en points et en pourcentage, et l'évolution de la part des scores d'au moins 18. (4 pts)
4. Interprétez ces résultats avec prudence : pourquoi ne peut-on pas conclure que les comportements des étudiants ont changé ? (4 pts)
5. Proposez une amélioration du protocole d'évaluation. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 3.13

1. a) Sherif (1935), normalisation : dans une situation ambiguë, le groupe construit une norme commune. b) Asch (1951), conformisme : un individu se range à l'avis d'une majorité unanime, même contre son propre jugement. c) Moscovici (1969), influence minoritaire : une minorité consistante fait évoluer la majorité. d) Lewin (1943), décision de groupe : la discussion suivie d'un engagement public change les comportements.
2. La présence d'un seul allié qui donne la bonne réponse ; une réponse écrite et anonyme plutôt qu'orale et publique ; un groupe plus petit ou non unanime ; une tâche moins ambiguë ou une forte confiance en soi.
3. La consistance (ou constance) dans le temps, la cohérence entre les membres de la minorité, et une attitude non rigide qui ne paraît pas dogmatique.
4. Un petit groupe de jeunes convaincus (ou de professionnels) peut faire évoluer une norme du groupe, à condition de garder un discours cohérent dans la durée. C'est le principe de la pair-éducation et des personnes relais : on n'a pas besoin de convaincre tout le monde au départ.

Corrigé – Exercice 3.14

1. 32 / 3 = 10,7. La décision de groupe a été près de 11 fois plus efficace que la conférence pour faire servir un abat nouveau (écart de 29 points).
2. Pour Lewin, les aliments passent par des « canaux » (achat, préparation, service) contrôlés par des personnes qui décident de ce qui entre dans la maison ; en 1943, les ménagères étaient ces gardiennes du portail. En santé publique, il est souvent plus efficace de cibler ces personnes clés (parents, cuisiniers de collectivité, responsables des achats) que l'ensemble des mangeurs.
3. Participation active : les ménagères ont formulé elles-mêmes les obstacles et les solutions. Engagement public : la décision annoncée à main levée devant le groupe engage. Norme de groupe : voir que d'autres décident aussi de servir des abats rend le comportement normal et partagé.
4. Contexte de guerre très particulier (patriotisme, rationnement) ; petits effectifs ; mesure déclarative quelques jours après, sans suivi à long terme ; rôle de la personnalité des animateurs ; public uniquement féminin, à une époque où les rôles de genre étaient très marqués.
5. Temps 1 (15 min) : en petit groupe, les participants listent ce qui les freine pour cuisiner des légumineuses (temps de cuisson, digestion, goût des enfants). Temps 2 (40 min) : dégustation et recherche collective de solutions (conserves, lentilles corail sans trempage, recettes appréciées des enfants), préparation d'une recette. Temps 3 (10 min) : chacun choisit librement ce qu'il essaiera dans la semaine et peut l'annoncer au groupe ; un message de rappel ou un point à la séance suivante.

Corrigé – Exercice 3.15

1. Légendes : 1 « Les boissons sucrées favorisent le diabète » ; 2 « J'en bois un litre par jour » ; 3 Dissonance : tension désagréable ; 4 Changer le comportement ; 5 réduire les boissons sucrées ; 6 Changer la croyance ; 7 « ce n'est pas si grave » ; 8 Ajouter une cognition ; 9 « je fais du sport, ça compense ».
2. Il ajoute une cognition consonante (« mon grand-père en buvait et il a vécu jusqu'à 90 ans ») qui minimise le risque : c'est une rationalisation, proche de la stratégie « changer la croyance ».
3. Un message qui fait peur augmente la tension ; si la personne ne se sent pas capable de changer, la façon la plus simple de réduire la dissonance est de rejeter le message (déni, minimisation, évitement de l'information). La peur n'est efficace que si l'on propose en même temps une solution facile, que la personne se sent capable d'appliquer.
4. Exemple : « Vous savez déjà beaucoup de choses sur les boissons sucrées. Si vous deviez changer une petite chose, qu'est-ce qui vous paraîtrait le plus facile : remplacer un verre par de l'eau pétillante, choisir une bouteille plus petite ? » La réponse respecte sa liberté, valorise ses connaissances et propose un

petit pas.

Corrigé – Exercice 3.16

1. Rapport : 76 / 16,7 = 4,55. Écart : 76 − 16,7 = 59,3 points. Les propriétaires qui avaient d'abord accepté un petit acte ont été environ 4,6 fois plus nombreux à accepter la demande coûteuse.
2. L'engagement est le lien qui unit une personne à ses actes (Kiesler, 1971) : plus on est engagé dans un acte, plus on tend à agir et à penser de façon cohérente avec lui. Facteurs : sentiment de liberté, caractère public de l'acte, répétition, coût de l'acte, irrévocabilité, explication par des causes internes (« vous êtes quelqu'un qui… »).
3. Joule et Beauvois parlent de « soumission librement consentie » (1998) : l'engagement ne fonctionne que si la personne a le sentiment d'avoir choisi ; sous la contrainte ou contre une récompense importante, elle attribue son acte à la pression extérieure et ne s'engage pas.
4. Étape 1 (acte peu coûteux) : à la sortie de l'école, proposer aux parents de goûter un goûter fait maison et de choisir une recette préférée parmi trois (vote libre). Étape 2 (acte plus coûteux) : proposer à ceux qui ont voté de s'inscrire, s'ils le souhaitent, au « défi goûter maison du mercredi » pendant un mois, avec leur prénom sur le tableau des familles participantes et un message de rappel. On rappelle à chaque étape qu'ils sont libres de refuser.
5. Ces techniques peuvent devenir manipulatrices si elles servent un but que la personne ne partagerait pas ou cachent l'objectif réel. On les respecte en annonçant clairement le but, en laissant une liberté réelle de refuser, en ne visant que des comportements favorables à la personne et en évitant toute pression ou toute stigmatisation des familles qui ne participent pas.

Corrigé – Exercice 3.17

1. Légendes : 1 Stéréotype ; 2 composante cognitive : une croyance ; 3 « Les personnes en surpoids manquent de volonté » ; 4 Préjugé ; 5 composante affective : un jugement ; 6 mépris, rejet, moquerie ; 7 Discrimination ; 8 composante comportementale : un acte ; 9 refus d'embauche, mise à l'écart ; 10 Stigmatisation : la personne est réduite à une caractéristique dévalorisée ; elle peut intérioriser le stigmate (Goffman, 1963).
2. Préjugé : les commentaires des collègues sur son plateau (jugement moral). Discrimination : l'éviction d'un poste d'accueil « pour l'image ». Conséquence sur la santé : elle renonce aux soins chez son médecin ; la stigmatisation entraîne aussi stress, honte, isolement et parfois alimentation émotionnelle.
3. Oui. Le code du travail (article L1132-1) et le code pénal (article 225-1) interdisent les discriminations fondées notamment sur l'apparence physique et l'état de santé. La salariée peut saisir le Défenseur des droits.
4. Parler de « personne en situation d'obésité » ou « personne qui vit avec une obésité » et non « d'obèse » ; ne pas parler du poids si la personne ne le souhaite pas et demander la permission (« Accepteriez-vous qu'on parle de… ? ») ; prévoir du matériel adapté (sièges, brassard de tension) ; centrer le discours sur les comportements favorables à la santé et non sur le chiffre de la balance.

Corrigé – Exercice 3.18

1. Pour que toutes les réponses aillent dans le même sens (un score élevé signifie toujours une attitude plus stigmatisante) et pour limiter le biais d'acquiescement : une personne qui répond « d'accord » à tout obtiendrait sinon un score artificiel.
2. Items stigmatisants (sans inversion) : 4 + 3 + 5 = 12. Items non stigmatisants inversés : item 2 : 6 − 2 = 4 ; item 4 : 6 − 4 = 2 ; item 6 : 6 − 4 = 2 ; total 8. Score de E12 = 12 + 8 = 20 sur 30 (score moyen par item : 20 / 6 = 3,33).
3. Baisse du score moyen : 18,6 − 14,2 = 4,4 points, soit 4,4 / 18,6 × 100 = 23,7 % de baisse. Part des scores

d'au moins 18 : avant 24 / 40 × 100 = 60,0 % ; après 11 / 40 × 100 = 27,5 % ; baisse de 32,5 points.

4. Les attitudes déclarées ont diminué juste après le module, mais : mesure immédiate (effet possiblement passager) ; désirabilité sociale (les étudiants savent ce que l'on attend d'eux après un module sur ce thème) ; pas de groupe témoin ; échelle non validée ; une attitude déclarée ne prédit pas toujours un comportement en situation de soin. On peut seulement dire que le module semble avoir fait évoluer les attitudes déclarées à court terme.

5. Ajouter une mesure à distance (3 mois) ; utiliser une échelle validée (par exemple une version française d'une échelle d'attitudes anti-gros validée) ; comparer avec un groupe témoin qui suit le module plus tard ; observer des comportements en stage (grille d'observation par les tuteurs) ; garantir l'anonymat avec un code pour apparier les questionnaires avant et après.

Partie 4 – Compétences psychosociales, émotions, image du corps et estime de soi

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer et classer les 9 compétences psychosociales générales (Santé publique France, 2022) ; concevoir une séance qui les développe.
- Mesurer et interpréter l'estime de soi et l'insatisfaction corporelle avec des outils simples.
- Distinguer faim physiologique et faim émotionnelle ; accompagner sans culpabiliser.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Compétences psychosociales (CPS) : ensemble cohérent et interrelié de capacités psychologiques (cognitives, émotionnelles et sociales) qui permettent d'augmenter l'autonomie et le pouvoir d'agir, de maintenir un état de bien-être et de favoriser des interactions constructives (Santé publique France, 2022). L'OMS en avait listé 10 en 1993.
- Stratégie nationale multisectorielle de développement des CPS chez les enfants et les jeunes 2022-2037 (instruction interministérielle du 19 août 2022).
- Interventions efficaces : critères SAFE (Durlak et ses collègues, 2011) : séquencées, actives, focalisées, explicites ; plusieurs séances, animateurs formés.
- Estime de soi : valeur qu'une personne s'accorde ; échelle de Rosenberg (1965), 10 items.
- Image corporelle : représentation mentale de son corps et sentiments qui y sont liés ; l'insatisfaction se mesure par exemple avec les silhouettes de Stunkard (1983).
- Faim émotionnelle : envie de manger déclenchée par une émotion (stress, ennui, tristesse), brutale, ciblée sur certains aliments, qui ne cesse pas avec la satiété.

Exercice 3.19 – Légender les compétences psychosociales (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une coordinatrice d'un projet éducatif de territoire vous demande de montrer que des ateliers de cuisine avec des enfants de 9 à 11 ans développent des CPS.

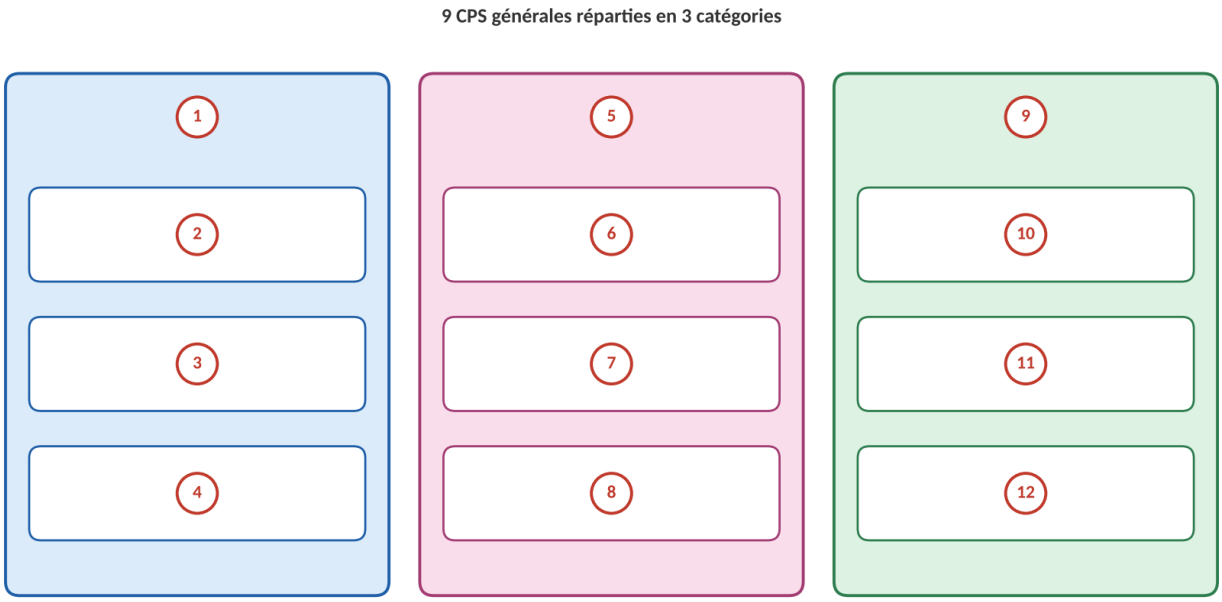


Figure 3.6 – Document 1 – Les compétences psychosociales générales (schéma à légender)

Document 2 – Moments de l'atelier cuisine

a) Les enfants se répartissent les tâches et règlent un désaccord sur le choix de la recette.

b) Un enfant qui n'aime pas l'odeur du poisson apprend à dire « je n'aime pas » sans crier « c'est dégueulasse ».

c) Les enfants comparent deux goûters et choisissent celui qu'ils prépareront, avec des arguments.

d) Avant de goûter, chaque enfant dit comment il se sent (curieux, inquiet, content) avec des cartes émotions.

e) Un enfant attend son tour pour utiliser le fouet au lieu de l'arracher.

f) Les enfants écoutent l'avis des autres sur la dégustation et donnent le leur avec respect.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)
2. Associez chaque moment du document 2 à une CPS générale. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi un atelier unique ne suffit pas à développer des CPS (critères d'efficacité). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.20 – Construire une séance CPS « explicite » (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – conception · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une maison des jeunes, vous animez un cycle de 6 séances « Mon assiette, mes choix » avec 12 adolescents de 13 à 15 ans. La séance 3 doit travailler la CPS « prendre des décisions constructives » à partir des choix d'achat en sortie de collège (boulangerie, épicerie, restauration rapide).

À vous de jouer – Questions

1. Présentez les critères SAFE et dites ce que chacun implique pour votre cycle. (4 pts)
2. Rédigez l'objectif de la séance 3 en termes de capacités observables. (2 pts)
3. Présentez le déroulé de 90 minutes en quatre temps, avec une technique active pour chaque temps. (4 pts)
4. Proposez un moyen d'évaluer la séance. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.21 – Estime de soi : coter une échelle (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un programme d'éducation thérapeutique pour des adultes vivant avec une obésité, la psychologue utilise une échelle d'estime de soi en début de programme. Elle vous demande de calculer le score d'une participante et de réfléchir à l'usage de ce résultat.

Document 1 – Échelle d'estime de soi en 10 items, inspirée de Rosenberg (1965)

Réponses de 1 (tout à fait en désaccord) à 4 (tout à fait d'accord). Les items 3, 5, 8, 9 et 10 sont formulés négativement (par exemple : « J'ai parfois l'impression de n'être bon(ne) à rien ») et doivent être inversés : score inversé = 5 − réponse. Score total de 10 à 40 ; plus il est élevé, plus l'estime de soi est haute.

Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Réponse de Mme V.	3	3	3	2	3	2	2	4	2	3

À vous de jouer – Questions

1. Définissez l'estime de soi. (1 pt)
2. Calculez le score total de Mme V. et son score moyen par item. (4 pts)
3. Indiquez sur quels items elle s'évalue le plus négativement. (2 pts)
4. Expliquez le lien possible entre stigmatisation du poids, estime de soi et comportements alimentaires. (3 pts)
5. Indiquez deux précautions dans l'usage de ce score par un diététicien. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.22 – Insatisfaction corporelle et silhouettes (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une infirmière scolaire de lycée a utilisé une échelle de 9 silhouettes (de 1, très mince, à 9, très corpulente), inspirée de Stunkard (1983), dans une classe de 30 élèves de seconde. Chaque élève a indiqué la silhouette qui lui ressemble (silhouette perçue) et celle qu'il voudrait avoir (silhouette désirée). Elle vous demande de traiter les résultats.

Document 1 – Écart entre silhouette perçue et silhouette désirée (perçue − désirée), données fictives

Écart	− 2	− 1	0	+ 1	+ 2	+ 3
Nombre d'élèves	2	4	9	8	5	2

Un écart positif signifie que l'élève voudrait être plus mince ; un écart négatif, plus corpulent.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des élèves satisfaits, de ceux qui veulent être plus minces et de ceux qui veulent être plus corpulents. (3 pts)
2. Calculez l'écart moyen de la classe. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi le désir d'être plus corpulent concerne souvent des garçons, et le désir de minceur souvent des filles (normes corporelles de genre, réseaux sociaux). (3 pts)
4. Indiquez les risques liés à une forte insatisfaction corporelle à l'adolescence. (2 pts)
5. Proposez deux actions de prévention qui ne parlent pas de poids. (2 pts)
6. Indiquez deux précautions éthiques pour ce type de recueil en classe. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.23 – Faim physiologique et faim émotionnelle (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un service de santé universitaire, une étudiante de 20 ans vous explique : « Le soir, après les cours, je rentre seule dans mon studio. Je n'ai pas vraiment faim, mais je mange un paquet de biscuits devant mon téléphone, et après je m'en veux. En période d'examens, c'est pire. »

À vous de jouer – Questions

1. Présentez quatre différences entre faim physiologique et faim émotionnelle. (4 pts)
2. Identifiez dans le témoignage les déclencheurs émotionnels et le cycle « émotion – prise alimentaire – culpabilité ». (2 pts)
3. Indiquez les CPS émotionnelles à développer et proposez deux pistes concrètes, sans interdits alimentaires. (3 pts)
4. Indiquez dans quel cas il faut orienter l'étudiante vers un autre professionnel. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.24 – Un programme CPS et nutrition au collège (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement (CESCE) d'un collège de 520 élèves vous confie la conception d'un programme pour les élèves de 5e. Le questionnaire réalisé en juin auprès des 132 élèves de 6e (futurs 5e) donne les résultats suivants (données fictives).

Document 1 – Résultats du questionnaire (n = 132)

Affirmation	Élèves « d'accord » ou « tout à fait d'accord »
Je mange parfois parce que je m'ennuie ou que je suis énervé(e).	59
J'ose dire non quand mes amis me proposent quelque chose que je ne veux pas manger ou boire.	71
Je me moque parfois du physique ou de ce que mangent les autres.	38
On s'est déjà moqué de mon physique ou de ce que je mange.	47
Je sais trouver quelqu'un à qui parler quand ça ne va pas.	84
J'aime mon corps tel qu'il est.	69

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages et identifiez les trois résultats les plus préoccupants. (4 pts)
2. Reliez chaque résultat préoccupant à une ou plusieurs CPS. (3 pts)
3. Proposez un programme de 5 séances de 55 minutes (titre, CPS travaillée, technique), conforme aux critères SAFE. (5 pts)
4. Proposez les partenaires et le rôle de chacun. (2 pts)
5. Proposez deux indicateurs d'évaluation. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 3.19

1. Légendes : 1 Compétences cognitives ; 2 Avoir conscience de soi ; 3 Capacité de maîtrise de soi ; 4 Prendre des décisions constructives ; 5 Compétences émotionnelles ; 6 Avoir conscience de ses émotions et de son stress ; 7 Réguler ses émotions ; 8 Gérer son stress ; 9 Compétences sociales ; 10 Communiquer de façon constructive ; 11 Développer des relations constructives ; 12 Résoudre des difficultés.
2. a) résoudre des difficultés (et communiquer de façon constructive) ; b) réguler ses émotions ; c) prendre des décisions constructives ; d) avoir conscience de ses émotions et de son stress ; e) capacité de maîtrise de soi ; f) communiquer de façon constructive (et développer des relations constructives).
3. Les CPS se développent par une pratique répétée et progressive. Selon les critères SAFE (Durlak et ses collègues, 2011), les programmes efficaces sont séquencés (séances qui s'enchaînent), actifs (mises en situation), focalisés (temps suffisant consacré aux CPS) et explicites (les CPS visées sont nommées). Un atelier unique peut sensibiliser mais ne transforme pas durablement les compétences ; il faut plusieurs séances, des adultes formés et un lien avec la vie quotidienne de l'enfant (classe, famille).

Corrigé – Exercice 3.20

1. Séquencé : les 6 séances suivent une progression (se connaître, émotions, décider, résister à la pression, communiquer, projet). Actif : chaque séance comporte une mise en situation (jeu de rôle, défi, enquête). Focalisé : au moins 40 minutes par séance consacrées à la compétence. Explicite : la CPS est annoncée au début (« aujourd'hui, on apprend à prendre une décision ») et reprise à la fin.
2. À la fin de la séance, chaque adolescent sera capable de citer les étapes d'une décision (identifier les choix, peser les avantages et inconvénients, décider, évaluer) et de les appliquer à un choix d'achat de goûter avec un budget de 3 €.
3. Temps 1 (15 min) : photolangage : chacun choisit une photo de ce qu'il achète en sortant du collège et dit pourquoi. Temps 2 (25 min) : enquête en binômes sur des emballages et des prix ; tableau « avantages, inconvénients » pour trois achats. Temps 3 (35 min) : jeu de rôle « devant la boulangerie avec les copains » : un jeune doit choisir en tenant compte de son budget, de sa faim et du groupe ; débriefing des étapes de la décision. Temps 4 (15 min) : chacun écrit une décision qu'il veut tester cette semaine (engagement libre) ; tour de parole sur ce qu'il a appris.
4. Questionnaire court en fin de séance : « Je sais citer les étapes d'une décision » (oui, un peu, non) ; observation du jeu de rôle avec une grille (le jeune a-t-il nommé au moins deux options et un critère ?) ; à la séance suivante, retour sur la décision testée.

Corrigé – Exercice 3.21

1. L'estime de soi est la valeur, positive ou négative, qu'une personne s'accorde globalement ; elle repose sur le sentiment d'être aimable, compétent et digne de respect.
2. Items positifs (1, 2, 4, 6, 7) : 3 + 3 + 2 + 2 + 2 = 12. Items négatifs inversés : item 3 : 5 − 3 = 2 ; item 5 : 5 − 3 = 2 ; item 8 : 5 − 4 = 1 ; item 9 : 5 − 2 = 3 ; item 10 : 5 − 3 = 2 ; total 10. Score total = 12 + 10 = 22 sur 40 ; score moyen par item = 22 / 10 = 2,2 sur 4, sous le milieu de l'échelle (2,5).
3. L'item 8 (score inversé de 1, le plus bas possible), puis les items 3, 4, 5, 6, 7 et 10 (score de 2).
4. La stigmatisation (moqueries, remarques, discriminations) abaisse l'estime de soi ; une faible estime de soi s'accompagne souvent de honte du corps, d'évitement des activités sociales et physiques, de régimes répétés et d'alimentation émotionnelle, qui peuvent favoriser la prise de poids. C'est un cercle vicieux que les programmes doivent briser en évitant tout discours culpabilisant.
5. Ce score ne sert pas à poser un diagnostic : il est interprété par la psychologue, avec la personne ; il reste confidentiel (donnée personnelle sensible) ; le diététicien en tient compte dans sa posture (valoriser les réussites, objectifs atteignables) et oriente vers la psychologue si la personne exprime une souffrance importante.

Corrigé – Exercice 3.22

1. Satisfaits (écart 0) : 9 / 30 × 100 = 30,0 %. Veulent être plus minces (écart positif) : (8 + 5 + 2) / 30 × 100 = 15 / 30 × 100 = 50,0 %. Veulent être plus corpulents (écart négatif) : (2 + 4) / 30 × 100 = 6 / 30 × 100 = 20,0 %. Au total, 70,0 % des élèves sont insatisfaits de leur silhouette.

2. Somme des écarts : (− 2 × 2) + (− 1 × 4) + (0 × 9) + (1 × 8) + (2 × 5) + (3 × 2) = − 4 − 4 + 0 + 8 + 10 + 6 = 16. Écart moyen = 16 / 30 = + 0,53 : en moyenne, la classe voudrait être un peu plus mince.

3. Les normes corporelles sont différentes selon le genre : idéal de minceur pour les filles, idéal de muscles et de force pour les garçons. Ces normes sont transmises par la famille, les pairs, la publicité et surtout les réseaux sociaux (photos retouchées, filtres, contenus « fitness »), qui renforcent la comparaison sociale à l'adolescence.

4. Régimes restrictifs sans avis médical, troubles du comportement alimentaire, consommation de compléments « pour prendre du muscle », baisse de l'estime de soi, anxiété, évitement du sport et des situations sociales, moqueries.

5. Ateliers d'éducation aux médias (repérer les retouches et les filtres, décrypter les contenus « fitness ») ; séances sur l'estime de soi et la gratitude envers son corps (ce que mon corps me permet de faire) ; activités physiques centrées sur le plaisir et non sur l'apparence.

6. Accord des élèves et information des parents ; anonymat (pas de nom, réponses glissées dans une urne) ; pas de pesée en classe ; présentation des résultats seulement à l'échelle de la classe ; possibilité de parler à l'infirmière après la séance.

Corrigé – Exercice 3.23

1. Faim physiologique : apparaît progressivement ; se ressent dans le corps (creux à l'estomac, baisse d'énergie) ; peut être satisfaite par des aliments variés ; s'arrête avec la satiété ; ne laisse pas de culpabilité. Faim émotionnelle : apparaît brutalement ; vient d'une émotion (ennui, solitude, stress) ; vise des aliments précis, souvent sucrés ou gras ; continue malgré la satiété ; suivie de culpabilité.

2. Déclencheurs : solitude du retour au studio, fatigue de la journée, stress des examens, écran. Cycle : émotion désagréable, biscuits mangés pour se soulager, soulagement court, puis culpabilité (« je m'en veux »), qui est elle-même une émotion désagréable et relance le cycle.

3. Avoir conscience de ses émotions et de son stress, réguler ses émotions, gérer son stress. Pistes : tenir quelques jours un carnet « ce que je ressens avant de manger » pour repérer les moments ; préparer une autre réponse aux émotions (appeler quelqu'un, sortir marcher dix minutes, une activité agréable) ; prévoir un vrai dîner ou une collation choisie, assise, sans écran, pour éviter d'arriver au studio affamée ; ne pas s'interdire les biscuits, ce qui renforcerait l'envie.

4. Si les prises alimentaires sont très importantes, avec perte de contrôle, fréquentes ou suivies de vomissements, ou si la souffrance est forte : orientation vers le médecin du service de santé universitaire et une psychologue (suspicion de trouble du comportement alimentaire).

Corrigé – Exercice 3.24

1. Mange par ennui ou énervement : 59 / 132 × 100 = 44,7 %. Ose dire non : 71 / 132 × 100 = 53,8 % (donc 46,2 % n'osent pas toujours). Se moque des autres : 38 / 132 × 100 = 28,8 %. A subi des moqueries : 47 / 132 × 100 = 35,6 %. Sait à qui parler : 84 / 132 × 100 = 63,6 %. Aime son corps : 69 / 132 × 100 = 52,3 %. Résultats les plus préoccupants : près d'un élève sur deux mange sous le coup d'une émotion (44,7 %) ; plus d'un sur trois a subi des moqueries (35,6 %) ; près d'un sur deux n'aime pas son corps (47,7 %, soit 100 − 52,3).

2. Manger par émotion : avoir conscience de ses émotions, réguler ses émotions, gérer son stress. Moqueries : communiquer de façon constructive, développer des relations constructives (empathie), résoudre des difficultés. Rapport au corps : avoir conscience de soi (estime de soi). Difficulté à dire non : capacité de

maîtrise de soi, communiquer de façon constructive (affirmation de soi).

3. Exemple. Séance 1 « Qui suis-je ? » : conscience de soi, portrait chinois et règles du groupe. Séance 2 « La météo de mes émotions » : conscience de ses émotions, cartes émotions et lien avec l'envie de manger. Séance 3 « Que faire quand ça déborde ? » : réguler ses émotions et gérer son stress, techniques de respiration et liste personnelle de « bonnes idées ». Séance 4 « Les mots qui blessent » : relations constructives et empathie, jeu de rôle sur une moquerie à la cantine. Séance 5 « Oser dire non » : communiquer de façon constructive, jeu de rôle d'affirmation de soi, bilan du cycle. Chaque séance annonce la CPS (explicite), comporte une mise en situation (actif), s'appuie sur la précédente (séquencé) et consacre la majeure partie du temps à la compétence (focalisé).

4. Infirmière scolaire (coordination, repérage, écoute individuelle) ; professeurs principaux et professeur d'éducation physique (continuité en classe) ; conseillère principale d'éducation (lutte contre le harcèlement) ; psychologue de l'éducation nationale (élèves en souffrance) ; structure de promotion de la santé (formation des animateurs) ; parents (information, réunion).

5. Évolution, entre juin et la fin de l'année de 5e, de la part des élèves qui ont subi des moqueries et de la part de ceux qui osent dire non, avec le même questionnaire anonyme ; nombre de séances réalisées et taux de présence ; satisfaction des élèves.

Partie 5 – Les modèles du changement de comportement

Objectifs – Objectifs de la partie

- Présenter et légender les stades du changement (Prochaska et DiClemente), la théorie du comportement planifié (Ajzen), le modèle des croyances relatives à la santé (Rosenstock) et le modèle COM-B (Michie).
- Expliquer le sentiment d'efficacité personnelle et ses quatre sources (Bandura).
- Utiliser un modèle pour diagnostiquer les freins d'un public et choisir des actions adaptées.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Modèle transthéorique (Prochaska et DiClemente, 1983) : précontemplation, contemplation, préparation, action, maintien ; la rechute fait partie du processus.
- Théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991) : l'intention dépend de l'attitude, de la norme subjective et du contrôle comportemental perçu ; l'intention prédit le comportement.
- Modèle des croyances relatives à la santé (Rosenstock, 1974 ; Becker, 1974) : vulnérabilité perçue, gravité perçue, bénéfices perçus, obstacles perçus, incitations à l'action, efficacité personnelle (ajoutée en 1988).
- Sentiment d'efficacité personnelle (Bandura, 1977) : croyance en sa capacité à réaliser une action ; quatre sources : expériences de maîtrise, expériences vicariantes, persuasion verbale, états physiologiques et émotionnels.
- COM-B (Michie, van Stralen et West, 2011) : un comportement apparaît si la personne en a la capacité, l'opportunité et la motivation ; la roue du changement de comportement propose 9 fonctions d'intervention.

Exercice 3.25 – Légender les stades du changement (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une association de patients diabétiques, vous rencontrez six adhérents qui parlent de leur activité physique et de leur consommation de boissons sucrées.

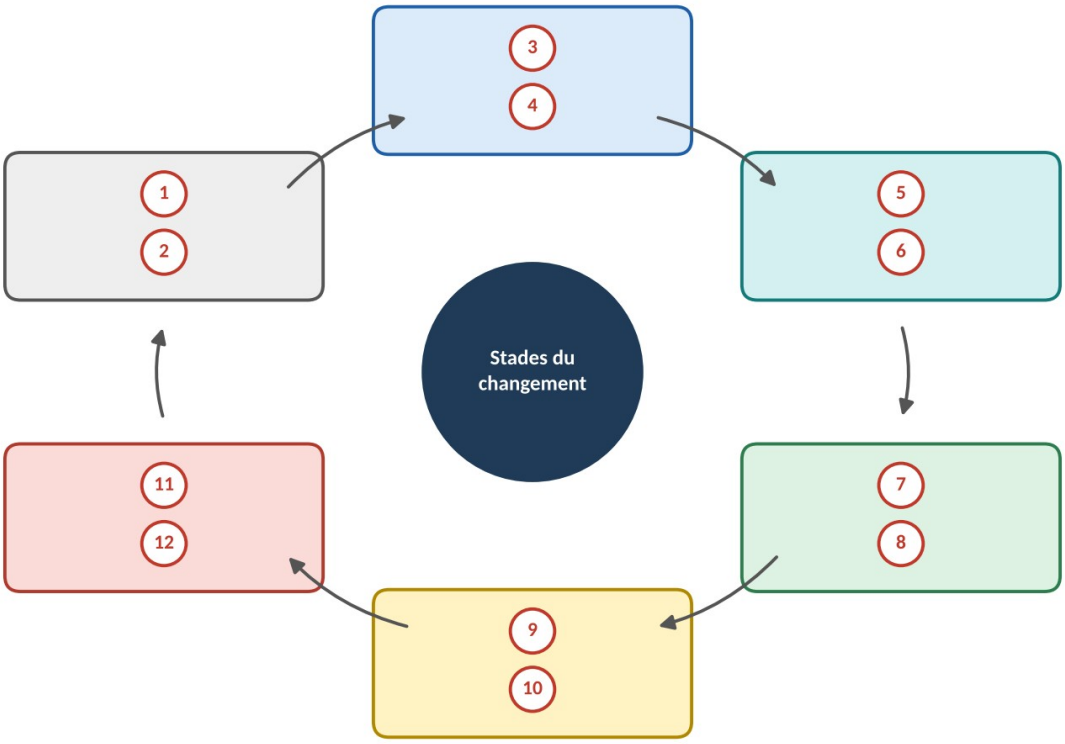


Figure 3.7 – Document 1 – Les stades du changement (schéma à légender)

Document 2 – Ce que disent les adhérents

a) « Ça fait un an que je ne bois plus de soda, j'ai même perdu l'envie. »

b) « Les boissons sucrées, ça ne me concerne pas, je ne suis pas gros. »

c) « J'ai acheté des baskets, je commence la marche lundi avec ma voisine. »

d) « Je sais que je devrais marcher, mais j'ai mal aux genoux et je n'ai pas le temps. »

e) « Depuis deux mois, je remplace le soda par de l'eau pétillante. »

f) « J'avais arrêté le soda pendant six mois, et cet été j'ai recommencé. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)
2. Placez chaque adhérent dans un stade. (3 pts)
3. Indiquez l'intervention la plus adaptée pour les adhérents b), d) et f). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.26 – Légender la théorie du comportement planifié (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un questionnaire pour comprendre pourquoi les salariés d'une entreprise ne prennent pas de pause déjeuner.

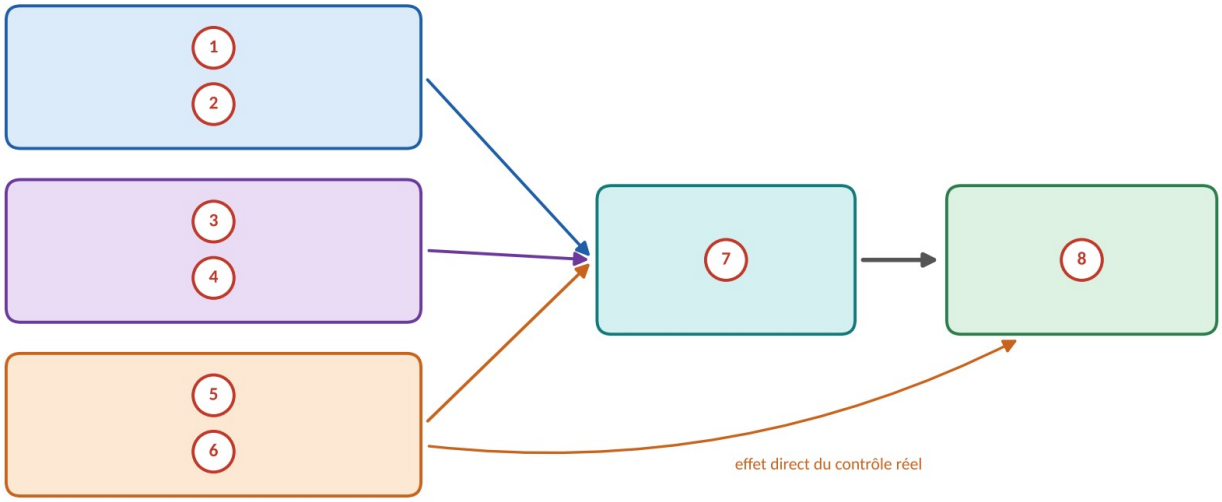


Figure 3.8 – Document 1 – La théorie du comportement planifié (schéma à légender)

Document 2 – Items proposés pour le questionnaire

a) « Prendre une vraie pause déjeuner me rendrait plus efficace l'après-midi. »

b) « Mon responsable trouve normal qu'on mange devant son écran. »

c) « Avec ma charge de travail, je ne peux pas m'arrêter 30 minutes. »

d) « La semaine prochaine, je compte prendre une pause déjeuner d'au moins 30 minutes trois jours sur cinq. »

e) « La plupart de mes collègues mangent à leur bureau. »

f) « Manger à son bureau, c'est mauvais pour la digestion. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Classez chaque item dans une composante du modèle. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi le contrôle perçu a deux flèches dans le modèle. (1 pt)
4. Indiquez une limite de ce modèle pour expliquer les comportements alimentaires. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.27 – Le modèle des croyances relatives à la santé (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une caisse d'assurance maladie organise des journées de dépistage du diabète dans des pharmacies. La participation est faible chez les hommes de 45 à 65 ans. Vous avez réalisé des entretiens.

Document 1 – Extraits d'entretiens

a) « Le diabète, c'est pour les gens qui mangent beaucoup de sucre. Moi, je n'en mange pas. »

b) « Mon frère est diabétique, il a été amputé d'un orteil l'an dernier. »

c) « Si je savais tôt, je pourrais faire attention avant que ce soit grave. »

d) « La pharmacie n'est ouverte que quand je travaille, et je n'aime pas les piqûres. »

e) « C'est le pharmacien qui m'en a parlé quand je suis allé chercher mes médicaments. »

f) « Je ne saurais pas quoi faire si on me disait que je suis diabétique. »

À vous de jouer – Questions

1. Présentez les six composantes du modèle et ses auteurs. (3 pts)
2. Associez chaque extrait à une composante. (3 pts)
3. Proposez trois actions pour augmenter la participation, chacune liée à une composante. (3 pts)
4. Indiquez une limite de ce modèle. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.28 – Les quatre sources du sentiment d'efficacité personnelle (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un cycle d'ateliers « cuisiner avec peu » pour des personnes accompagnées par un centre communal d'action sociale. Beaucoup disent : « Je ne suis pas capable de cuisiner. »

Document 1 – Ce que vous avez prévu

a) Chaque participant réalise lui-même une recette très simple dès la première séance, puis des recettes un peu plus difficiles.

b) Une ancienne participante, qui « ne savait rien faire » il y a un an, montre comment elle prépare un plat de lentilles.

c) Vous dites à chacun ce qu'il a réussi : « Votre découpe est très régulière. »

d) Vous commencez par un café et une présentation détendue, et vous dédramatisez les ratés.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez le sentiment d'efficacité personnelle (auteur, année). (2 pts)
2. Associez chaque élément du document 1 à une source du sentiment d'efficacité personnelle. (4 pts)
3. Indiquez la source la plus puissante et justifiez. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi une ancienne participante est un meilleur modèle qu'un chef cuisinier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.29 – Légender COM-B et choisir des fonctions d'intervention (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les aides-soignantes de nuit ne proposent presque jamais la collation nocturne prévue pour les résidents dénutris. Vous êtes chargé d'en comprendre les raisons.

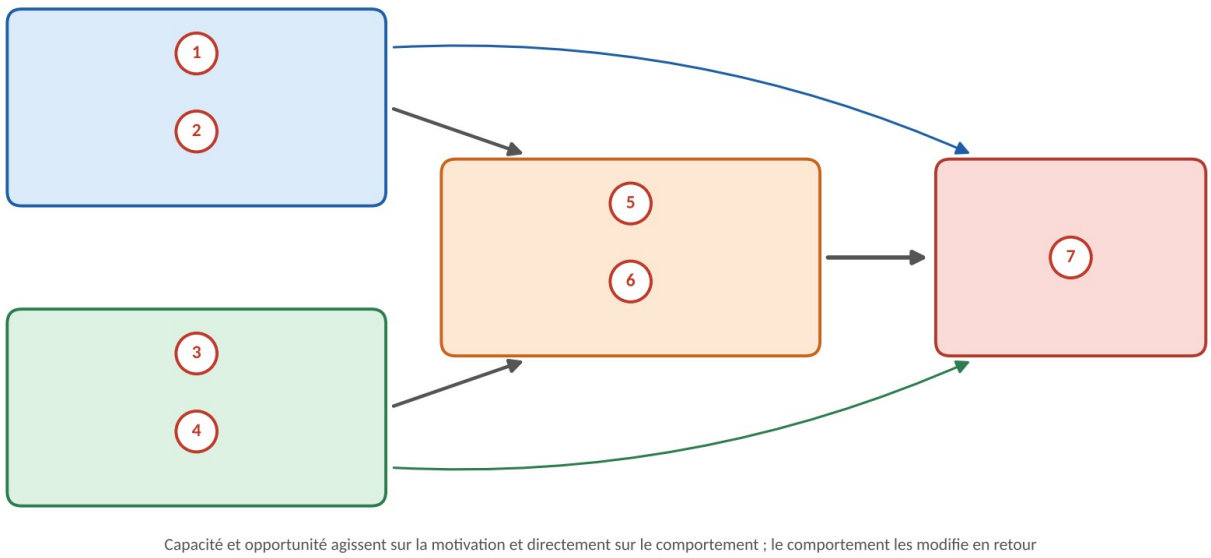


Figure 3.9 – Document 1 – Le modèle COM-B (schéma à légender)

Document 2 – Ce que disent les aides-soignantes de nuit

a) « Je ne savais pas que le jeûne nocturne devait être de moins de 12 heures. »

b) « Les collations sont dans la cuisine, fermée à clé la nuit. »

c) « Réveiller quelqu'un pour manger, ça me gêne, on nous a toujours dit de respecter le sommeil. »

d) « On est deux pour 80 résidents, on n'a pas le temps. »

e) « Mes collègues ne le font pas non plus. »

f) « Je pense que ça ne sert à rien, ils ne mangent pas. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)
2. Classez chaque extrait dans une composante de COM-B (capacité, opportunité physique ou sociale, motivation). (3 pts)
3. Citez les 9 fonctions d'intervention de la roue du changement de comportement. (2,5 pts)
4. Proposez trois actions, chacune associée à une fonction d'intervention et à une composante. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi une formation seule ne suffirait pas. (2 pts)

Ma réponse

.....

Exercice 3.30 – Évaluer un programme avec les stades du changement (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de santé au travail a proposé pendant six mois un programme « Plus de fruits et légumes au travail » à 80 salariés volontaires d'une entreprise : panier de fruits deux fois par semaine, ateliers, défi d'équipe. Vous évaluez l'évolution des stades du changement pour le comportement « manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour ».

Document 1 – Répartition des 80 salariés par stade (données fictives)

Stade	Avant le programme	Après 6 mois
Précontemplation	28	18
Contemplation	22	20
Préparation	14	16
Action	10	15
Maintien	6	11

Suivi individuel : 34 salariés ont progressé d'au moins un stade, 38 sont restés au même stade, 8 ont reculé.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages par stade avant et après. (4 pts)
2. Calculez la part des salariés en action ou en maintien avant et après, et l'évolution en points. (2 pts)
3. Calculez la part des salariés qui ont progressé, stagné et reculé ; vérifiez le total. (2 pts)
4. Interprétez : pourquoi ce type d'évaluation est-il plus fin qu'un simple « mange ou ne mange pas 5 portions » ? (3 pts)
5. Indiquez trois limites de cette évaluation. (3 pts)
6. Proposez une adaptation du programme pour les salariés restés en précontemplation. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 3.25

1. Légendes : 1 Précontemplation ; 2 pas d'intention de changer dans les 6 mois ; 3 Contemplation ; 4 intention de changer dans les 6 mois, ambivalence ; 5 Préparation ; 6 changement prévu dans le mois, premiers essais ; 7 Action ; 8 changement en cours depuis moins de 6 mois ; 9 Maintien ; 10 changement installé depuis plus de 6 mois ; 11 Rechute ; 12 retour à l'ancien comportement, puis nouvelle entrée dans le cycle.
2. a) maintien ; b) précontemplation ; c) préparation ; d) contemplation ; e) action ; f) rechute.
3. b) précontemplation : informer sans insister, faire réfléchir (« Que savez-vous des liens entre sucre et diabète ? »), respecter son choix, laisser une porte ouverte. d) contemplation : explorer l'ambivalence (balance avantages et inconvénients), chercher des solutions aux obstacles (marche courte, activité adaptée aux genoux comme l'aquagym). f) rechute : dédramatiser, valoriser les six mois réussis, analyser ce qui a provoqué la rechute (été, invitations) et préparer une nouvelle tentative.

Corrigé – Exercice 3.26

1. Légendes : 1 Attitude ; 2 ce que je pense des conséquences du comportement ; 3 Norme subjective ; 4 ce que pensent et font les personnes qui comptent pour moi ; 5 Contrôle comportemental perçu ; 6 ma capacité ressentie à réaliser le comportement ; 7 Intention ; 8 Comportement.
2. a) attitude ; b) norme subjective (injonctive) ; c) contrôle comportemental perçu ; d) intention ; e) norme (descriptive) ; f) attitude (croyance sur une conséquence).
3. Le contrôle perçu agit sur l'intention (je n'ai pas l'intention de faire ce que je me crois incapable de faire) et directement sur le comportement, parce qu'il reflète en partie le contrôle réel : même avec une forte intention, on ne peut pas faire ce que la situation empêche.
4. Le modèle suppose des décisions réfléchies ; or beaucoup de comportements alimentaires sont des habitudes automatiques, influencées par l'environnement, les émotions et l'offre. Il existe aussi un écart fréquent entre l'intention et le comportement.

Corrigé – Exercice 3.27

1. Rosenstock (1974) et Becker (1974) : la personne agit pour sa santé si elle se sent vulnérable (vulnérabilité perçue), si elle juge la maladie grave (gravité perçue), si elle pense que l'action est utile (bénéfices perçus) et que ses obstacles sont surmontables (obstacles perçus), si un événement la déclenche (incitations à l'action) et si elle se sent capable d'agir (efficacité personnelle, ajoutée en 1988 par Rosenstock, Strecher et Becker).
2. a) vulnérabilité perçue faible (fausse croyance) ; b) gravité perçue ; c) bénéfices perçus ; d) obstacles perçus ; e) incitation à l'action ; f) efficacité personnelle faible.
3. Vulnérabilité : informer que le diabète de type 2 est lié à l'âge, à l'hérédité, au poids et à la sédentarité, et pas seulement au sucre (affiches avec des hommes de 50 ans). Obstacles : proposer le dépistage le samedi ou sur le lieu de travail, expliquer que c'est une piqûre au bout du doigt. Incitation : invitation personnelle par le pharmacien ou par message de l'assurance maladie. On peut aussi agir sur l'efficacité personnelle : expliquer ce qui se passe après un résultat positif (accompagnement, programme d'éducation).
4. Le modèle ne tient pas compte des émotions, des habitudes, des normes sociales et des inégalités d'accès ; il suppose un calcul rationnel.

Corrigé – Exercice 3.28

1. Albert Bandura (1977) : croyance d'une personne en sa capacité à organiser et réaliser les actions nécessaires pour atteindre un but. Elle influence le choix des activités, l'effort fourni et la persévérance

face aux difficultés.

2. a) expériences de maîtrise (réussites personnelles, avec une difficulté progressive) ; b) expériences vicariantes (observer un modèle qui réussit) ; c) persuasion verbale (encouragements précis) ; d) états physiologiques et émotionnels (réduire l'anxiété pour que la personne n'interprète pas son stress comme un signe d'incapacité).

3. Les expériences de maîtrise : réussir soi-même est la preuve la plus convaincante de sa capacité. C'est pourquoi un atelier où l'on regarde une démonstration sans pratiquer renforce peu la confiance.

4. L'observateur se compare au modèle : plus le modèle lui ressemble (même situation, mêmes difficultés au départ), plus la réussite du modèle lui paraît accessible (« si elle y arrive, moi aussi »). Un chef cuisinier, perçu comme très différent, peut au contraire décourager.

Corrigé – Exercice 3.29

1. Légendes : 1 Capacité ; 2 physique (savoir-faire, force) et psychologique (connaissances, compétences) ; 3 Opportunité ; 4 physique (temps, argent, équipement, offre) et sociale (normes, soutien) ; 5 Motivation ; 6 réflexive (intentions, croyances) et automatique (habitudes, émotions) ; 7 Comportement.

2. a) capacité psychologique (connaissance) ; b) opportunité physique (accès aux collations) ; c) motivation automatique (habitude, gêne) et opportunité sociale (norme apprise) ; d) opportunité physique (temps, effectif) ; e) opportunité sociale (norme descriptive) ; f) motivation réflexive (croyance sur l'utilité).

3. Éducation, persuasion, incitation, coercition, formation, restriction, restructuration de l'environnement, modélisation (montrer l'exemple), facilitation.

4. Éducation (capacité) : courte formation sur le jeûne nocturne, la dénutrition et ses conséquences, avec des chiffres du service. Restructuration de l'environnement (opportunité physique) : un chariot de collations prêtes (laitages, compotes enrichies) dans le poste de soins, accessible la nuit, et la collation inscrite dans le plan de soins de chaque résident concerné. Modélisation et persuasion (opportunité sociale et motivation) : une aide-soignante référente montre comment proposer la collation sans réveiller (résidents déjà éveillés, au moment d'un change), et l'équipe partage les résultats (poids, prises alimentaires).

5. La formation agit seulement sur la capacité ; or les freins principaux sont des opportunités (cuisine fermée, temps, norme d'équipe) et la motivation (croyance que cela ne sert à rien). Sans changement de l'organisation et de l'environnement, les connaissances nouvelles ne se traduisent pas en comportement.

Corrigé – Exercice 3.30

1. Avant : précontemplation 28 / 80 = 35,0 % ; contemplation 22 / 80 = 27,5 % ; préparation 14 / 80 = 17,5 % ; action 10 / 80 = 12,5 % ; maintien 6 / 80 = 7,5 %. Après : précontemplation 18 / 80 = 22,5 % ; contemplation 20 / 80 = 25,0 % ; préparation 16 / 80 = 20,0 % ; action 15 / 80 = 18,8 % ; maintien 11 / 80 = 13,8 %. Les arrondis des valeurs « après » font 100,1 %.

2. Action ou maintien : avant (10 + 6) / 80 = 16 / 80 = 20,0 % ; après (15 + 11) / 80 = 26 / 80 = 32,5 % ; hausse de 12,5 points.

3. Progression : 34 / 80 = 42,5 % ; stabilité : 38 / 80 = 47,5 % ; recul : 8 / 80 = 10,0 % ; total 34 + 38 + 8 = 80, soit 100 %.

4. Un indicateur « oui ou non » ne verrait que les salariés qui atteignent 5 portions ; il ignorerait ceux qui passent de la précontemplation à la contemplation ou à la préparation, qui sont pourtant des progrès réels et des étapes nécessaires. Les stades permettent aussi de repérer les reculs (10 %) et d'adapter les actions à chaque stade.

5. Volontaires probablement déjà motivés (biais de sélection) ; données déclaratives (désirabilité sociale) ; pas de groupe témoin : l'évolution peut être due à la saison (été, fruits moins chers) ; stades mesurés par une seule question ; suivi court (6 mois ne permet pas de juger le maintien).

6. Pour la précontemplation : ne pas insister sur l'objectif de 5 portions ; susciter la curiosité et le plaisir

(dégustations de fruits de saison, défis d'équipe ludiques), informer sans culpabiliser, faire intervenir des collègues qui ont changé (modèles), et agir sur l'environnement (fruits disponibles et gratuits) qui touche tout le monde sans demander d'effort.

Partie 6 – Communiquer, écouter, accompagner la motivation

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender le schéma de la communication et repérer les obstacles (bruits) dans une situation professionnelle.
- Reconnaître les attitudes de Porter et utiliser l'écoute active (questions ouvertes, reformulation, résumé).
- Appliquer l'esprit et les outils de l'entretien motivationnel ; repérer le discours-changement ; construire une balance décisionnelle.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Schéma de la communication : émetteur, message, code, canal, récepteur, bruits, rétroaction (d'après Shannon et Weaver, 1949, complété par la rétroaction).
- Communication verbale (les mots), paraverbale (ton, débit, volume) et non verbale (posture, gestes, regard, distance).
- Attitudes de Porter (1950) : évaluation, interprétation, soutien, investigation, solution, compréhension. L'attitude de compréhension (reformulation) favorise le plus l'expression.
- Écoute active (Rogers) : empathie, acceptation inconditionnelle, authenticité ; questions ouvertes, reformulation, silence, résumé.
- Entretien motivationnel (Miller et Rollnick, 3e édition, 2013) : esprit fait de partenariat, acceptation, compassion et évocation ; quatre processus (engager, focaliser, évoquer, planifier) ; outils : questions ouvertes, valorisation, reflets, résumés. On repère le discours-changement (désir, capacité, raisons, besoin, engagement) et le discours-maintien.

Exercice 3.31 – Légender le schéma de la communication (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous avez animé une séance d'information sur l'allaitement dans une salle municipale. Votre tutrice a noté plusieurs problèmes pendant la séance.

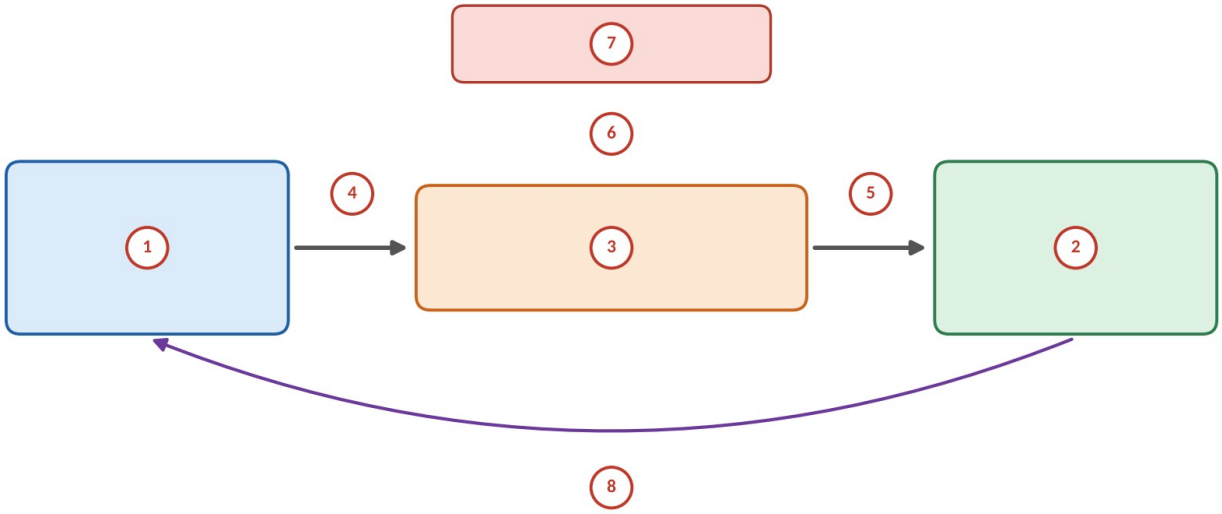


Figure 3.10 – Document 1 – Le schéma de la communication (schéma à légender)

Document 2 – Notes de la tutrice

a) Des travaux de voirie faisaient beaucoup de bruit pendant la première demi-heure.

b) Vous avez utilisé les mots « colostrum », « montée de lait » et « tire-allaitement » sans les expliquer.

c) Deux mamans ne parlaient que le tamoul.

d) Vous parliez vite en regardant vos diapositives.

e) Une maman pensait que l'allaitement « fait tomber les seins » et n'a rien entendu d'autre.

f) Vous n'avez pas demandé si les participantes avaient des questions.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Classez chaque note : bruit physique, bruit sémantique (code), bruit psychologique (représentations, émotions), défaut de rétroaction, problème de canal ou d'attitude non verbale. (3 pts)
3. Proposez une correction pour trois de ces problèmes. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.32 – Reconnaître les attitudes de Porter (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier pour des aidants, une femme dit : « Mon mari ne mange presque plus depuis qu'il est malade. Je lui prépare ce qu'il aimait, il repousse l'assiette. Je ne sais plus quoi faire, je suis épuisée. »

Document 1 – Six réponses possibles

a) « Vous devriez lui proposer des petites portions enrichies, plusieurs fois par jour. »

b) « Ce n'est pas bien de vous épuiser ainsi, il faut penser à vous. »

c) « Vous vous sentez démunie et fatiguée de voir vos efforts refusés. »

d) « Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger, beaucoup de malades retrouvent l'appétit. »

e) « Depuis quand ne mange-t-il plus ? A-t-il perdu du poids ? »

f) « En fait, vous culpabilisez parce que vous pensez que c'est votre cuisine qui ne va pas. »

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Associez chaque réponse à une attitude de Porter. (6 pts)
2. **2.** Indiquez les effets probables des réponses b) et d) sur la personne. (2 pts)
3. **3.** Expliquez pourquoi la réponse c) est la plus adaptée au début de l'échange. (2 pts)
4. **4.** Indiquez à quel moment l'attitude de solution devient utile. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.33 – Questions ouvertes et reformulations (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez la transcription d'un entretien que vous avez mené avec un jeune homme de 22 ans qui vient d'apprendre qu'il a un diabète de type 2. Votre tutrice vous demande de réécrire certaines de vos interventions.

Document 1 – Vos interventions

1. « Vous mangez des fruits tous les jours ? »
2. « Vous avez compris ce que vous a dit le médecin ? »
3. « Est-ce que vous faites du sport ? »
4. Le jeune homme : « Franchement, je ne vois pas comment je vais faire, je travaille en livraison toute la journée et je mange dans le camion. » Vous : « Il faut prévoir votre repas la veille. »
5. Le jeune homme : « Mon père aussi était diabétique, il est mort à 58 ans. » Vous : « D'accord. Et le soir, vous mangez quoi ? »

À vous de jouer – Questions

1. Distinguez question ouverte et question fermée ; transformez les interventions 1, 2 et 3 en questions ouvertes. (4 pts)
2. Pour l'intervention 4, proposez un reflet simple et un reflet complexe. (4 pts)
3. Pour l'intervention 5, expliquez l'erreur et proposez une meilleure réponse. (2 pts)
4. Rédigez un résumé de fin d'entretien de trois phrases. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.34 – Discours-changement et esprit de l'entretien motivationnel (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un groupe de parole dans un programme d'éducation thérapeutique pour des personnes ayant une hypertension. Vous notez des phrases des participants.

Document 1 – Phrases entendues

a) « J'aimerais bien manger moins salé. »

b) « Je pourrais remplacer le cube de bouillon par des herbes. »

c) « Si je mange moins salé, je pourrai peut-être diminuer un médicament. »

d) « Il faut que je fasse quelque chose, ma tension est trop haute. »

e) « Cette semaine, je ne rachète pas de chips. »

f) « Sans sel, tout est fade, je n'y arriverai jamais. »

g) « Mon père salait tout et il est mort vieux. »

À vous de jouer – Questions

1. Présentez les quatre éléments de l'esprit de l'entretien motivationnel. (4 pts)
2. Classez chaque phrase : discours-changement (désir, capacité, raison, besoin, engagement) ou discours-maintien. (4 pts)
3. Proposez une réponse en entretien motivationnel à la phrase f), sans argumenter contre la personne. (2 pts)
4. Expliquez le « réflexe correcteur » et pourquoi il faut l'éviter. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.35 – Construire une balance décisionnelle (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un entretien, M. T., 45 ans, chauffeur de bus, envisage d'arrêter de grignoter des viennoiseries pendant ses pauses. Vous construisez avec lui une balance décisionnelle et il note l'importance de chaque élément de 1 (peu important) à 5 (très important).

Document 1 – La balance de M. T.

Case	Éléments cités par M. T. (importance)
Avantages de continuer	plaisir de la pause (4) ; facilité, la boulangerie est au terminus (3)
Inconvénients de continuer	fatigue après le sucre (4) ; culpabilité (3) ; coût, environ 30 € par mois (2)
Avantages de changer	plus d'énergie l'après-midi (4) ; économies (3) ; meilleure glycémie, son médecin l'a alerté (5)
Inconvénients de changer	perte d'un moment de plaisir (4) ; il faut préparer une collation la veille (3)

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le total des éléments en faveur du changement (avantages de changer et inconvénients de continuer) et le total en faveur du statu quo. (3 pts)
2. Interprétez le résultat ; dites dans quel stade du changement se trouve probablement M. T. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi il ne faut pas négliger les éléments en faveur du statu quo. (2 pts)
4. Proposez, avec lui, une solution qui garde le plaisir de la pause. (2 pts)
5. Indiquez la limite d'une balance chiffrée. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.36 – Analyser un entretien avec des indicateurs (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour progresser, vous avez enregistré (avec l'accord écrit de la personne) 12 minutes d'un entretien de suivi diététique. Votre tutrice code vos interventions avec une grille inspirée de l'outil MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity, version 4.2.1, Moyers et ses collègues, 2016).

Document 1 – Codage de vos interventions (12 minutes)

Type d'intervention	Nombre
Questions fermées	13
Questions ouvertes	5
Reflets simples	7
Reflets complexes	2
Valorisations	2
Conseils donnés sans demander la permission	4

Repères du MITI 4.2.1 : rapport reflets / questions « correct » à partir de 1 et « bon » à partir de 2 ; part des reflets complexes parmi les reflets « correcte » à partir de 40 % et « bonne » à partir de 50 %.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre total de questions et de reflets, le rapport reflets / questions, la part des reflets complexes et la part des questions ouvertes. (5 pts)
2. Comparez vos résultats aux repères et rédigez votre auto-évaluation. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi les conseils donnés sans permission posent problème, et comment demander la permission. (3 pts)
4. Fixez-vous trois objectifs chiffrés pour le prochain entretien enregistré. (3 pts)
5. Indiquez les règles éthiques de l'enregistrement d'un entretien. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 3.31

1. Légendes : 1 Émetteur ; 2 Récepteur ; 3 Message ; 4 codage ; 5 décodage ; 6 Canal : oral, écrit, image, gestes, numérique ; 7 Bruits : obstacles ; 8 Rétroaction (feed-back) : le récepteur montre ce qu'il a compris.
2. a) bruit physique ; b) bruit sémantique (code non partagé) ; c) bruit sémantique (langue) et problème de canal ; d) attitude non verbale et paraverbale (débit, regard) ; e) bruit psychologique (représentation, inquiétude) ; f) défaut de rétroaction.
3. b) expliquer chaque mot technique avec un exemple ou une image, ou utiliser des mots simples ; c) prévoir une interprète ou des supports illustrés traduits, vérifier les besoins linguistiques à l'inscription ; d) parler lentement, regarder le public, utiliser les diapositives comme appui ; e) partir des représentations au début de la séance (« Qu'avez-vous entendu dire sur l'allaitement ? ») ; f) prévoir des temps de questions et vérifier la compréhension (« Qu'est-ce que vous retenez ? »).

Corrigé – Exercice 3.32

1. a) solution ; b) évaluation (jugement moral) ; c) compréhension (reformulation empathique) ; d) soutien (réconfort, minimisation) ; e) investigation ; f) interprétation.
2. b) la personne se sent jugée et culpabilisée, elle peut se justifier ou se fermer. d) la personne se sent rassurée un moment mais non entendue ; son épuisement est minimisé et l'échange s'arrête.
3. La reformulation montre qu'on a compris ce qu'elle vit (empathie) sans juger ni conseiller ; elle l'invite à continuer à parler et à préciser elle-même la situation, ce qui permet ensuite de trouver des solutions adaptées.
4. Quand la personne a pu s'exprimer, que la situation est bien comprise et qu'elle demande des idées (ou accepte qu'on lui en propose) : on propose alors des solutions, en lui laissant le choix.

Corrigé – Exercice 3.33

1. Une question fermée appelle une réponse courte (oui, non, un chiffre) ; une question ouverte invite la personne à développer. Exemples : 1. « Comment se passent vos journées côté repas ? » ; 2. « Qu'avez-vous retenu de ce que vous a dit le médecin ? » ; 3. « Quelle place l'activité physique a-t-elle dans votre vie ? »
2. Reflet simple : « Vous ne voyez pas comment faire avec votre travail de livreur. » Reflet complexe : « Vous avez envie de prendre soin de votre santé, mais votre travail vous laisse très peu de place pour les repas. »
3. Le jeune homme exprime une émotion forte (la mort de son père, sans doute de la peur) ; la question suivante l'ignore. Meilleure réponse : « Vous avez vu ce que le diabète a fait à votre père, et vous avez peur pour vous. » puis laisser un silence.
4. Exemple : « Si je résume, vous venez d'apprendre votre diabète et cela vous fait penser à votre père. Votre travail en livraison rend les repas difficiles, mais vous voulez éviter ce qui lui est arrivé. On a parlé de deux idées de repas à emporter que vous allez essayer cette semaine ; est-ce que j'ai bien résumé ? »

Corrigé – Exercice 3.34

1. Partenariat : le professionnel et la personne collaborent, la personne est experte de sa vie. Acceptation : respect de la valeur de la personne, de son autonomie, empathie et valorisation. Compassion : agir pour le bien de la personne. Évocation : faire émerger les motivations et les ressources de la personne plutôt que de les lui apporter.
2. a) discours-changement : désir ; b) capacité ; c) raison ; d) besoin ; e) engagement ; f) discours-maintien (et

faible capacité perçue) ; g) discours-maintien.

3. Exemple : « Le goût compte beaucoup pour vous, et vous avez peur que les plats deviennent fades. En même temps, vous avez dit que vous aimeriez manger moins salé. Qu'est-ce qui pourrait donner du goût sans le sel ? »

4. Le réflexe correcteur est l'envie de corriger tout de suite la personne, de la convaincre ou de lui donner la solution. Il provoque souvent l'effet inverse : la personne défend l'autre côté de son ambivalence (discours-maintien) et se sent jugée. L'entretien motivationnel cherche au contraire à faire exprimer les raisons de changer par la personne elle-même.

Corrigé – Exercice 3.35

1. En faveur du changement : avantages de changer 4 + 3 + 5 = 12 ; inconvénients de continuer 4 + 3 + 2 = 9 ; total 12 + 9 = 21. En faveur du statu quo : avantages de continuer 4 + 3 = 7 ; inconvénients de changer 4 + 3 = 7 ; total 7 + 7 = 14.

2. La balance penche vers le changement (21 contre 14, soit 1,5 fois plus), mais les deux côtés restent présents : M. T. est ambivalent. Il est probablement en contemplation ou en préparation : il envisage le changement, il a des raisons fortes (alerte du médecin, importance 5), mais il n'a pas encore agi.

3. Les avantages du statu quo (plaisir, facilité) sont réels ; si on les ignore, le changement prévu les fera perdre sans compensation et la rechute est probable. Les reconnaître montre l'acceptation et aide à chercher une solution qui garde ce qui compte pour la personne.

4. Garder la pause et le moment de plaisir, mais changer le contenu : une collation choisie par lui et préparée la veille (fruit, pain et fromage, poignée d'oléagineux) ; ou une viennoiserie une fois par semaine au lieu de chaque jour ; ou partager la pause avec un collègue. C'est lui qui choisit.

5. Les notes sont subjectives et peuvent changer d'un jour à l'autre ; additionner des éléments très différents a peu de sens ; un seul élément très fort (alerte du médecin, plaisir) peut peser plus que tous les autres. La balance sert surtout à faire parler la personne, pas à prendre la décision à sa place.

Corrigé – Exercice 3.36

1. Questions : 13 + 5 = 18. Reflets : 7 + 2 = 9. Rapport reflets / questions = 9 / 18 = 0,5. Part des reflets complexes = 2 / 9 × 100 = 22,2 %. Part des questions ouvertes = 5 / 18 × 100 = 27,8 %.

2. Le rapport de 0,5 est sous le seuil « correct » de 1 : je pose deux fois plus de questions que je ne fais de reflets. La part de reflets complexes (22,2 %) est sous le seuil de 40 %. J'utilise surtout des questions fermées (72,2 %) : l'entretien ressemble à un interrogatoire et la personne parle peu. J'ai cependant valorisé deux fois la personne, ce qui est un point d'appui.

3. Un conseil non demandé place le professionnel en expert qui sait mieux que la personne ; il provoque souvent de la résistance (« oui, mais… ») et réduit l'autonomie. Demander la permission : « Est-ce que vous voulez que je vous donne quelques idées que d'autres personnes ont trouvées utiles ? », puis laisser la personne choisir ce qui lui convient (« Qu'est-ce qui vous paraît possible pour vous ? »).

4. Exemples : au moins autant de reflets que de questions (rapport d'au moins 1) ; au moins 40 % de reflets complexes ; au moins la moitié de questions ouvertes ; aucun conseil sans permission.

5. Accord écrit et libre de la personne, après une information claire sur le but (formation), l'usage et la durée de conservation ; possibilité de refuser ou d'arrêter l'enregistrement sans conséquence sur la prise en charge ; stockage sécurisé, accès limité à la tutrice, suppression après l'analyse ; anonymisation de la transcription.

Partie 7 – Animer un groupe, motiver, tenir compte des biais de décision

Objectifs – Objectifs de la partie

- Reconnaître les étapes de la vie d'un groupe (Tuckman), les rôles des membres (Benne et Sheats) et les styles d'animation (Lewin, Lippitt et White).
- Choisir une technique d'animation adaptée à un objectif.
- Situer une motivation sur le continuum de l'autodétermination (Deci et Ryan) ; utiliser les biais cognitifs et les « coups de pouce » (nudges) de façon éthique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Étapes d'un groupe (Tuckman, 1965 ; Tuckman et Jensen, 1977) : formation, tension, normalisation, production, dissolution.
- Rôles (Benne et Sheats, 1948) : rôles centrés sur la tâche (proposer, informer, résumer), rôles centrés sur l'entretien du groupe (encourager, concilier, faciliter la parole), rôles individuels qui gênent le groupe (bloquer, dominer, se mettre en avant).
- Styles d'animation (Lewin, Lippitt et White, 1939) : autoritaire, démocratique (participatif), laisser-faire.
- Théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 1985 ; Ryan et Deci, 2000) : trois besoins (autonomie, compétence, appartenance) ; continuum : amotivation, régulation externe, introjectée, identifiée, intégrée, motivation intrinsèque.
- Biais cognitifs : biais du présent, statu quo et option par défaut, ancrage, effet de halo (un mot « santé » qui fait juger tout le produit sain). Nudge (Thaler et Sunstein, 2008) : modification de l'environnement de choix qui oriente sans interdire ni changer les prix.

Exercice 3.37 – Légender les étapes de la vie d'un groupe (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un cycle de 8 ateliers cuisine pour 10 adultes dans un centre social. Vous notez dans votre carnet de bord ce qui se passe à chaque séance.

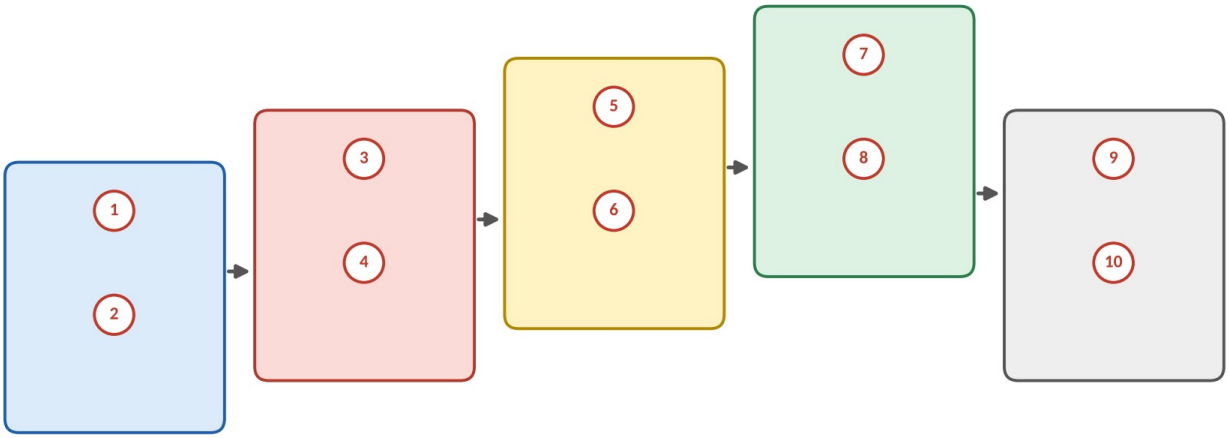


Figure 3.11 – Document 1 – Les étapes de la vie d'un groupe (schéma à légender)

Document 2 – Extraits du carnet de bord

a) Séance 1 : les participants sont polis, attendent mes consignes, parlent peu entre eux.

b) Séance 3 : deux participantes se disputent sur la façon de couper les légumes ; un participant dit que mes recettes « ne servent à rien ».

c) Séance 5 : le groupe a adopté ses règles (chacun goûte, on range ensemble) ; une bonne ambiance s'installe.

d) Séance 7 : les participants organisent eux-mêmes la répartition des tâches et proposent une recette.

e) Séance 8 : repas de fin de cycle, bilan, échange de numéros de téléphone.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (5 pts)
2. Associez chaque extrait du carnet à une étape. (2,5 pts)
3. Indiquez le rôle de l'animateur à l'étape de tension. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.38 – Les rôles dans un groupe (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous observez une réunion de 8 parents qui préparent une fête de quartier avec un buffet « sain et pas cher ».

Document 1 – Ce que font les parents

a) Mme A. propose de faire un buffet de crudités et de tartinades de légumineuses.

b) M. B. rappelle le budget et le nombre d'invités prévus.

c) Mme C. encourage Mme D., très timide, à donner son avis.

d) M. E. coupe la parole à tout le monde et raconte ses vacances.

e) Mme F. fait la synthèse des décisions à la fin de la réunion.

f) M. G. trouve une solution entre deux parents qui ne sont pas d'accord sur les boissons.

g) Mme H. rejette chaque proposition sans en faire aucune.

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Présentez les trois catégories de rôles de Benne et Sheats (1948). (3 pts)
2. **2.** Classez chaque comportement du document 1. (4 pts)
3. **3.** Proposez une façon de gérer M. E. et Mme H. sans les humilier. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.39 – Styles d'animation et participation (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une épicerie sociale, trois stagiaires ont animé chacune un atelier d'une heure sur les menus à petit budget, avec des groupes de 12 personnes. Une observatrice a mesuré leur temps de parole et compté les participants qui ont pris la parole au moins une fois.

Document 1 – Observations (données fictives)

Stagiaire	Temps de parole de l'animatrice (sur 60 min)	Participants qui ont pris la parole	Menus réalisés en fin d'atelier
Animatrice 1	42 min	3 sur 12	1 menu, rédigé par l'animatrice
Animatrice 2	18 min	11 sur 12	3 menus, rédigés par les sous-groupes
Animatrice 3	6 min	5 sur 12	aucun menu terminé

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part du temps de parole de chaque animatrice et la part des participants qui ont pris la parole. (3 pts)
2. Associez chaque animatrice à un style de Lewin, Lippitt et White (1939) et justifiez. (3 pts)
3. Présentez les effets connus de chaque style sur le groupe. (3 pts)
4. Indiquez dans quelle situation un style plus directif est justifié. (1 pt)
5. Indiquez une limite de cette observation. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.40 – Choisir une technique d'animation (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un cycle d'ateliers pour des étudiants en résidence universitaire. Vous avez cinq objectifs différents et une liste de techniques.

Document 1 – Objectifs et techniques

Objectifs : A. faire émerger les représentations du « repas étudiant » ; B. produire en 20 minutes une liste d'idées de repas à moins de 2 € ; C. faire prendre position sur la phrase « manger sain coûte cher » ; D. s'entraîner à refuser une soirée « fast-food » sans se fâcher avec ses amis ; E. classer et regrouper les idées produites par tout le groupe.

Techniques : photolangage ; brainstorming (remue-méninges) ; débat mouvant ; jeu de rôle ; métaplan.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque objectif à la technique la plus adaptée. (5 pts)
2. Décrivez le déroulement du débat mouvant et ses règles. (3 pts)
3. Indiquez deux précautions pour animer un jeu de rôle. (2 pts)
4. Indiquez l'intérêt d'alterner les techniques au cours d'un cycle. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.41 – Motivation, biais et coups de pouce à la cantine (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le restaurant universitaire d'un campus sert 1 600 repas par jour. Le plat végétarien était proposé en dernière position sur la ligne de self. Pendant un mois, l'équipe l'a placé en première position, lui a donné un nom appétissant et l'a servi en assiette déjà composée par défaut (l'autre plat restant disponible sur demande).

Document 1 – Résultats (données fictives, moyenne par jour)

Avant : 220 plats végétariens sur 1 600 repas. Pendant le mois de test : 512 plats végétariens sur 1 600 repas. Enquête auprès de 200 étudiants : 22 disent ne pas avoir remarqué de changement ; 9 disent s'être sentis « manipulés ».

Document 2 – Ce que disent des étudiants de leur alimentation

a) « Je mange des légumes parce que ma mère m'appelle tous les soirs pour vérifier. »

b) « J'adore cuisiner, c'est mon moment préféré de la journée. »

c) « Je mangerais mieux pour me sentir moins coupable. »

d) « Bien manger, c'est important pour réussir mes examens, j'ai compris pourquoi. »

e) « Manger équilibré, ça fait partie de qui je suis, comme le sport et l'écologie. »

f) « Je ne vois pas l'intérêt, je mange ce qui passe. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des plats végétariens avant et pendant le test, l'écart en points et le rapport. (3 pts)
2. Identifiez les trois leviers (biais) utilisés par l'équipe. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi cette démarche est un nudge, et discutez son caractère éthique en utilisant l'enquête. (3 pts)
4. Placez chaque phrase du document 2 sur le continuum de l'autodétermination. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi les formes de motivation les plus autonomes sont les plus durables. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.42 – Animer un groupe difficile (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans un établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) qui accueille en internat des jeunes de 17 à 25 ans. Vous animez un atelier de 2 heures sur l'alimentation avec 14 volontaires. Après 20 minutes, la situation se dégrade : trois jeunes discutent entre eux et rient, un jeune dit à voix haute que « la nutrition, c'est pour les meufs au régime », deux jeunes regardent leur téléphone, et une jeune femme ne dit rien et semble mal à l'aise. Votre tutrice est présente mais vous laisse gérer.

À vous de jouer – Questions

1. Analysez la situation avec trois notions du chapitre (étape du groupe, rôles, normes de genre, besoins de l'autodétermination). (5 pts)
2. Proposez une réponse immédiate pour reprendre le groupe, sans autoritarisme ni humiliation. (3 pts)
3. Proposez trois modifications de votre atelier pour la séance suivante, chacune justifiée. (4 pts)
4. Rédigez trois règles du groupe que vous ferez construire par les jeunes, et la façon de les construire. (2 pts)
5. Indiquez ce que vous faites pour la jeune femme silencieuse. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 3.37

1. Légendes : 1 Formation ; 2 on se découvre, on attend des consignes ; 3 Tension ; 4 désaccords, rivalités, contestation de l'animateur ; 5 Normalisation ; 6 règles acceptées, cohésion ; 7 Production ; 8 le groupe travaille de façon autonome ; 9 Dissolution ; 10 fin du groupe, bilan, séparation.
2. a) formation ; b) tension ; c) normalisation ; d) production ; e) dissolution.
3. Accepter les désaccords comme une étape normale ; faire exprimer les points de vue sans prendre parti ; rappeler et faire construire les règles du groupe ; reformuler les critiques (« vous avez besoin de recettes plus utiles pour votre quotidien ») et associer le groupe aux choix ; ne pas se sentir attaqué personnellement.

Corrigé – Exercice 3.38

1. Rôles centrés sur la tâche : ils font avancer le travail (proposer, informer, résumer, coordonner). Rôles centrés sur l'entretien du groupe : ils maintiennent de bonnes relations (encourager, concilier, faciliter la parole). Rôles individuels : ils servent les besoins personnels au détriment du groupe (dominer, bloquer, se mettre en avant, rechercher l'attention).
2. a) tâche (proposer) ; b) tâche (informer, rappeler les données) ; c) entretien (encourager, faciliter la parole) ; d) individuel (dominer, rechercher l'attention) ; e) tâche (résumer, synthétiser) ; f) entretien (concilier) ; g) individuel (bloquer).
3. M. E. : le remercier et recentrer (« Merci, revenons au buffet : qu'est-ce que vous pourriez apporter ? ») ; organiser des tours de parole ou un objet de parole ; lui confier une tâche (gardien du temps). Mme H. : reformuler ses objections et lui demander une proposition (« Qu'est-ce qui vous conviendrait mieux ? ») ; reconnaître ce qui la gêne (budget, temps) ; si le blocage continue, en parler avec elle en dehors du groupe.

Corrigé – Exercice 3.39

1. Temps de parole : animatrice 1 : 42 / 60 × 100 = 70,0 % ; animatrice 2 : 18 / 60 × 100 = 30,0 % ; animatrice 3 : 6 / 60 × 100 = 10,0 %. Participants qui ont parlé : 3 / 12 = 25,0 % ; 11 / 12 = 91,7 % ; 5 / 12 = 41,7 %.
2. Animatrice 1 : autoritaire (directif) : elle parle 70 % du temps et rédige elle-même le menu. Animatrice 2 : démocratique (participatif) : elle parle peu, presque tous les participants s'expriment, les sous-groupes produisent. Animatrice 3 : laisser-faire : elle intervient très peu, le groupe ne s'organise pas et ne termine rien.
3. Autoritaire : production rapide mais dépendante de l'animateur, faible participation, parfois tension ou passivité ; la production s'arrête quand l'animateur s'en va. Démocratique : participation, satisfaction et cohésion plus fortes, production de bonne qualité et plus autonome. Laisser-faire : désorganisation, faible production, insatisfaction.
4. Lorsqu'il y a un enjeu de sécurité (utilisation d'un couteau, d'une plaque chaude, règle d'hygiène), lorsque le temps est très court, ou au tout début d'un groupe qui a besoin de repères.
5. Une seule séance par animatrice ; groupes différents (participants plus ou moins à l'aise) ; observatrice qui connaît le but de l'observation ; le temps de parole ne mesure pas la qualité des interventions.

Corrigé – Exercice 3.40

1. A : photolangage ; B : brainstorming ; C : débat mouvant ; D : jeu de rôle ; E : métaplan.
2. L'animateur lit une affirmation volontairement discutable (« manger sain coûte cher ») ; les participants se placent d'un côté de la salle (d'accord) ou de l'autre (pas d'accord), sans position intermédiaire ; chaque camp donne à tour de rôle un argument ; on peut changer de côté si un argument nous convainc. Règles : écouter sans interrompre, parler de l'idée et pas de la personne, droit de changer d'avis. L'animateur fait

ensuite une synthèse et apporte des informations (prix au kilo, coût des légumineuses).

3. Laisser chacun libre de jouer ou d'observer ; définir clairement le scénario et les rôles ; sortir du rôle à la fin (« dérôler ») ; débriefing centré sur ce qui a fonctionné, sans juger la personne ; éviter les situations trop proches de la vie privée.
4. Varier les techniques maintient l'attention et la motivation, permet à des profils différents de s'exprimer (à l'oral, à l'écrit, par le corps), et correspond à des objectifs différents : faire émerger, produire, débattre, s'entraîner.

Corrigé – Exercice 3.41

1. Avant : 220 / 1 600 × 100 = 13,8 % ; pendant : 512 / 1 600 × 100 = 32,0 % ; écart : 32,0 − 13,8 = 18,2 points (18,25 points avec les valeurs exactes 13,75 % et 32,0 %) ; rapport : 512 / 220 = 2,33. La part des plats végétariens a été multipliée par 2,3.
2. Position (effet de primauté : on choisit plus souvent ce qu'on voit en premier) ; option par défaut (biais du statu quo : on garde ce qui est proposé) ; nom appétissant (cadrage, attractivité, effet de halo positif).
3. C'est un nudge parce que le choix reste libre (l'autre plat est disponible), le prix ne change pas et rien n'est interdit : seul l'environnement de choix est modifié (Thaler et Sunstein, 2008). Sur le plan éthique, 9 étudiants sur 200 (4,5 %) se sont sentis manipulés et 22 (11,0 %) n'ont rien remarqué : un nudge est plus acceptable s'il est transparent (affiche qui explique la démarche), s'il sert l'intérêt des personnes et s'il reste facile de choisir autrement. Des études réelles vont dans le même sens : dans des restaurants universitaires de Cambridge, doubler la part des plats végétariens proposés a augmenté leurs ventes de 40 à 80 % (Garnett et ses collègues, PNAS, 2019).
4. a) régulation externe (contrôle de la mère) ; b) motivation intrinsèque (plaisir de l'activité) ; c) régulation introjectée (éviter la culpabilité) ; d) régulation identifiée (importance personnelle comprise) ; e) régulation intégrée (cohérente avec son identité et ses valeurs) ; f) amotivation.
5. Les motivations autonomes (identifiée, intégrée, intrinsèque) viennent de la personne : elles ne dépendent ni d'une surveillance ni d'une récompense, elles résistent mieux aux difficultés et donnent du bien-être. Les motivations contrôlées s'arrêtent quand la contrainte disparaît (la mère n'appelle plus) ou s'accompagnent de culpabilité et d'anxiété.

Corrigé – Exercice 3.42

1. Étape du groupe : le groupe est en formation ou déjà en tension ; les jeunes testent le cadre et l'animatrice. Rôles individuels : rires et apartés (recherche d'attention), remarque provocatrice (dominer, bloquer), retrait (téléphone, silence). Normes de genre : « la nutrition, c'est pour les meufs » montre que s'intéresser à l'alimentation menace l'identité masculine dans ce groupe ; la remarque peut aussi blesser la jeune femme. Autodétermination : les besoins d'autonomie (ils subissent un contenu qu'ils n'ont pas choisi), de compétence (ils se sentent jugés sur un sujet « scolaire ») et d'appartenance (le groupe se fait contre l'animatrice) ne sont pas satisfaits.
2. Garder son calme, ne pas entrer dans le conflit ni humilier ; faire une pause active : « Je vois que ce que je propose ne vous parle pas beaucoup. Qu'est-ce qui vous intéresserait, vous, dans l'alimentation ? » ; reformuler la provocation en question ouverte (« Pour toi, la nutrition, c'est quoi ? Et pour un sportif ? ») ; passer à une activité en petits groupes avec une tâche concrète (défi « repas à moins de 3 € qui donne de la force »). Rappeler calmement la règle du respect si la remarque vise quelqu'un.
3. Partir de leurs intérêts (sport, budget, force, insertion professionnelle) en les interrogeant avant l'atelier ; proposer une activité pratique dès le début (cuisine, dégustation, défi) plutôt qu'un exposé ; donner des choix (autonomie) ; faire intervenir un modèle crédible (ancien jeune de l'EPIDE, sportif) ; prévoir des temps courts et rythmés ; former des sous-groupes mixtes et choisis.
4. Exemples : « On respecte les goûts et le corps de chacun, aucune moquerie » ; « Les téléphones restent dans le sac sauf pendant le défi photo » ; « On a le droit de ne pas être d'accord, en le disant poliment ». Construction : chacun écrit sur un post-it ce dont il a besoin pour se sentir bien dans le groupe, on

regroupe, on formule ensemble trois règles et on les affiche.

5. L'inclure sans la mettre en difficulté : travail en binôme ou en petit groupe, possibilité de s'exprimer par écrit ; aller la voir à la pause, lui demander comment elle a vécu la séance ; si la remarque sexiste l'a blessée, la reconnaître ; en parler avec la tutrice et l'équipe éducative si elle semble en souffrance.

Partie 8 – Mesurer les attitudes et les représentations ; cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Construire et coter une échelle de Likert ; utiliser un différenciateur sémantique ; réaliser une analyse de contenu simple.
- Comparer deux proportions avec leurs intervalles de confiance.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve E5 en mobilisant l'ensemble du chapitre.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Échelle de Likert (1932) : série d'affirmations avec des degrés d'accord (souvent 5) ; on inverse les items formulés dans l'autre sens ; on additionne ou on fait la moyenne des items d'une même dimension.
- Règles d'un bon item : une seule idée par item, pas de double négation, des mots simples, pas de jugement implicite, des items positifs et négatifs.
- Différenciateur sémantique (Osgood, Suci et Tannenbaum, 1957) : l'objet est évalué sur des paires d'adjectifs opposés (bon-mauvais, rapide-long), souvent sur 7 positions de − 3 à + 3.
- Analyse de contenu : découper les entretiens en unités de sens, les classer dans des catégories définies à l'avance ou construites à partir du texte, compter les fréquences, illustrer par des citations.
- Intervalle de confiance à 95 % d'une proportion p sur n personnes : p ± 1,96 × racine de (p × (1 − p) / n).

Exercice 3.43 – Repérer les erreurs dans des items (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une collègue a rédigé un questionnaire pour mesurer l'attitude de parents envers la cuisine faite maison. Elle vous demande de le relire.

Document 1 – Items proposés (réponses de « pas du tout d'accord » à « tout à fait d'accord »)

a) « Je n'ai pas l'impression de ne pas savoir cuisiner. »

b) « Cuisiner est rapide et économique. »

c) « Les parents responsables cuisinent pour leurs enfants. »

d) « J'utilise des légumineuses dans mes préparations culinaires hebdomadaires. »

e) « Je cuisine. »

f) « Cuisiner me fait plaisir. »

À vous de jouer – Questions

1. Identifiez l'erreur de chacun des items a) à e). (5 pts)

2. Réécrivez ces cinq items correctement. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.44 – Coter une échelle de Likert (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous utilisez une échelle de 5 items pour mesurer l'attitude envers la cuisine faite maison chez des parents (1 = pas du tout d'accord ; 5 = tout à fait d'accord). Les items 2 et 4 sont négatifs et doivent être inversés (score inversé = 6 − réponse).

Document 1 – Items et réponses de trois parents

Item	Sens	Parent 1	Parent 2	Parent 3
1. Cuisiner me fait plaisir.	positif	5	3	4
2. Cuisiner me prend trop de temps.	négatif	1	3	2
3. Je me sens capable de cuisiner un repas complet.	positif	4	2	5
4. Les plats tout prêts sont aussi bons que les plats maison.	négatif	2	4	1
5. Cuisiner permet de faire des économies.	positif	4	3	5

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le score total (sur 25) et le score moyen par item de chaque parent. (6 pts)

2. Calculez le score moyen des trois parents. (1 pt)

3. Interprétez le profil du parent 2 et proposez un levier d'action adapté. (3 pts)

4. Indiquez ce qu'il faudrait vérifier avant d'utiliser cette échelle à grande échelle. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.45 – Le différenciateur sémantique : légumineuses et pâtes (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant de lancer un atelier « légumineuses » dans une maison de quartier, vous avez demandé à 25 adultes d'évaluer les légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots secs) et les pâtes sur six paires d'adjectifs, de − 3 (adjectif de gauche) à + 3 (adjectif de droite).

Document 1 – Moyennes des 25 adultes (données fictives)

Paire d'adjectifs (− 3 à + 3)	Légumineuses	Pâtes
fade – savoureux	+ 0,4	+ 1,9
long à préparer – rapide	− 1,8	+ 2,3
cher – bon marché	+ 2,1	+ 2,0
indigeste – digeste	− 1,2	+ 0,8
démodé – moderne	− 0,9	+ 0,6
peu rassasiant – rassasiant	+ 1,6	+ 1,4

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le score moyen global de chaque aliment. (2 pts)
2. Calculez l'écart (pâtes − légumineuses) pour chaque paire et repérez les deux plus grands écarts. (3 pts)
3. Identifiez les points forts des légumineuses sur lesquels l'atelier peut s'appuyer. (2 pts)
4. Proposez une action pour chacun des deux freins principaux. (3 pts)
5. Expliquez l'intérêt de cet outil par rapport à une question « aimez-vous les légumineuses ? ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.46 – Analyse de contenu d'entretiens (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous avez réalisé 6 entretiens semi-directifs avec des parents d'une épicerie sociale sur les freins à la cuisine de légumes frais. Après transcription, vous avez découpé le texte en 120 unités de sens portant sur des freins.

Document 1 – Répartition des 120 unités de sens par catégorie de frein

Catégorie	Nombre d'unités	Exemple de citation
Prix	34	« Les légumes frais, c'est le premier truc que j'enlève du caddie. »
Temps	26	« Le soir, je n'ai pas la force d'éplucher. »
Goût des enfants	22	« Ils ne mangent pas, alors je jette. »
Transport	15	« Le marché, c'est à deux bus d'ici. »
Savoir-faire	14	« Le céleri, je ne sais pas quoi en faire. »
Équipement	9	« J'ai une seule plaque. »

À vous de jouer – Questions

1. Présentez les étapes d'une analyse de contenu. (3 pts)
2. Calculez la part de chaque catégorie et vérifiez le total. (3 pts)
3. Classez les freins selon le modèle COM-B. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi ces pourcentages ne peuvent pas être généralisés à tous les parents de l'épicerie. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.47 – Comparer deux proportions avant et après un cycle d'ateliers (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – recherche appliquée · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de quartier a mené une enquête avant puis après une année d'ateliers « légumineuses ». La question était : « Avez-vous cuisiné des légumineuses au moins une fois par semaine le mois dernier ? » Les personnes interrogées n'étaient pas les mêmes aux deux dates.

Document 1 – Résultats (données fictives)

Avant : 42 « oui » sur 120 personnes interrogées. Après : 63 « oui » sur 115 personnes interrogées.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les deux proportions et l'écart en points. (2 pts)
2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de chaque proportion. (4 pts)
3. Interprétez : peut-on dire que la proportion a augmenté ? (2 pts)
4. Peut-on attribuer cette évolution aux ateliers ? Justifiez. (2 pts)
5. Proposez un meilleur protocole. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.48 – Cas complet : les gardes de nuit d'une caserne de sapeurs-pompiers (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage auprès du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours. Le médecin-chef vous confie un projet pour le centre d'incendie et de secours de Saint-Avit (données fictives), qui compte 64 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Les gardes durent 12 ou 24 heures ; les repas sont préparés et pris en commun à la caserne. Le médecin constate une baisse des résultats aux tests annuels de condition physique et des grignotages importants pendant les gardes de nuit. Il précise : « Ici, la popote, c'est sacré. Il ne faut surtout pas que ça ressemble à un régime. »

Document 1 – Questionnaire anonyme (48 répondants sur 64, données fictives)

Question	Réponses « oui »
Grignote au moins trois fois pendant une garde de nuit	31
Boit des boissons sucrées ou énergisantes pendant les interventions de nuit	22
Prend ses repas en commun à la caserne pendant les gardes	40

Stades du changement pour « réduire le grignotage pendant les gardes de nuit » : précontemplation 14 ; contemplation 16 ; préparation 10 ; action 5 ; maintien 3.

Échelle de Likert (1 à 5), moyennes : « Manger équilibré améliore ma condition physique pour les interventions » : 4,3 ; « À la caserne, on mange gras et sucré, c'est la tradition » : 4,1 ; « Le chef de centre donne l'exemple en mangeant équilibré » : 2,0 ; « Pendant les gardes de nuit, je peux manger équilibré si je le veux » : 2,4.

Document 2 – Ce qu'ils disent

« La popote, c'est ce qui fait l'équipe. » « Celui qui mange de la salade, on le chambre. » « La nuit, entre deux départs, il n'y a que le distributeur et les gâteaux apportés par les collègues. » « Après une intervention difficile, on a besoin de décompresser, et ça passe par le sucre. » « Si on me dit de faire un régime, je n'écoute plus. »

Document 3 – Données et repères réels

L'ANSES (avis de 2016 sur les risques sanitaires des horaires de travail atypiques, notamment de nuit) a conclu à des effets probables du travail de nuit sur la prise de poids, le diabète de type 2 et les maladies coronariennes, et à des effets avérés sur la somnolence et la qualité du sommeil. Budget accordé par le service départemental : 1 200 €.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de réponse, les indicateurs du questionnaire et la répartition par stade (en %). (5 pts)
2. Analysez la situation avec quatre notions de psychologie sociale : identité professionnelle et appartenance au groupe, normes, conformisme, alimentation émotionnelle. (6 pts)
3. Interprétez les moyennes de l'échelle de Likert avec la théorie du comportement planifié et déduisez-en les leviers principaux. (4 pts)
4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et trois objectifs opérationnels. (4 pts)

5. Présentez un plan d'action de quatre actions, chacune justifiée par un concept (norme, modèle, engagement, environnement, efficacité personnelle) et adaptée aux stades. (7 pts)

6. Établissez un budget qui respecte les 1 200 €. (3 pts)

7. Proposez la démarche d'évaluation (processus et résultats). (5 pts)

8. Indiquez les règles éthiques (données de santé, lien avec l'employeur, résultats des tests physiques) et les principes de communication auprès de l'équipe. (6 pts)

Ma réponse

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 3.43

1. a) double négation, difficile à comprendre ; b) deux idées dans un item (rapide et économique) : on ne sait pas à laquelle la personne répond ; c) jugement moral implicite (« responsables ») qui pousse à la désirabilité sociale et culpabilise ; d) vocabulaire compliqué (« légumineuses », « hebdomadaires ») pour un public large ; e) item trop vague (à quelle fréquence ? quoi ?) et qui décrit un comportement, pas une attitude.
2. a) « Je sais cuisiner. » ; b) « Cuisiner est rapide. » et « Cuisiner permet de faire des économies. » (deux items) ; c) « Cuisiner pour mes enfants est important pour moi. » ; d) « Je cuisine des lentilles, des pois chiches ou des haricots secs au moins une fois par semaine. » ; e) « J'aime préparer des repas pour ma famille. » (ou une question de fréquence séparée).

Corrigé – Exercice 3.44

1. Parent 1 : 5 + (6 − 1) + 4 + (6 − 2) + 4 = 5 + 5 + 4 + 4 + 4 = 22 sur 25 ; moyenne 22 / 5 = 4,4. Parent 2 : 3 + (6 − 3) + 2 + (6 − 4) + 3 = 3 + 3 + 2 + 2 + 3 = 13 sur 25 ; moyenne 2,6. Parent 3 : 4 + (6 − 2) + 5 + (6 − 1) + 5 = 4 + 4 + 5 + 5 + 5 = 23 sur 25 ; moyenne 4,6.
2. (22 + 13 + 23) / 3 = 58 / 3 = 19,3 sur 25.
3. Le parent 2 a une attitude plutôt défavorable (2,6 par item, sous le point neutre de 3) ; son score le plus bas porte sur la capacité perçue (item 3 : 2) et sur la comparaison avec les plats tout prêts (item 4 inversé : 2). Levier : renforcer le sentiment d'efficacité personnelle par un atelier pratique avec une recette très simple et réussie (expérience de maîtrise), et faire goûter un plat maison comparé à un plat tout prêt.
4. La compréhension des items par le public (pré-test auprès de quelques parents) ; la cohérence interne de l'échelle (les items mesurent-ils la même chose ?) ; la stabilité des réponses ; l'absence d'item ambigu.

Corrigé – Exercice 3.45

1. Légumineuses : (0,4 − 1,8 + 2,1 − 1,2 − 0,9 + 1,6) / 6 = 0,2 / 6 = + 0,03. Pâtes : (1,9 + 2,3 + 2,0 + 0,8 + 0,6 + 1,4) / 6 = 9,0 / 6 = + 1,50.
2. Écarts (pâtes − légumineuses) : savoureux 1,9 − 0,4 = 1,5 ; rapide 2,3 − (− 1,8) = 4,1 ; bon marché 2,0 − 2,1 = − 0,1 ; digeste 0,8 − (− 1,2) = 2,0 ; moderne 0,6 − (− 0,9) = 1,5 ; rassasiant 1,4 − 1,6 = − 0,2. Les deux plus grands écarts : rapidité (4,1) et digestibilité (2,0).
3. Les légumineuses sont jugées bon marché (+ 2,1, autant que les pâtes) et rassasiantes (+ 1,6, plus que les pâtes) : ce sont deux arguments à mettre en avant.
4. Rapidité : montrer les solutions rapides (lentilles corail cuites en 15 minutes sans trempage, légumineuses en conserve rincées, cuisson en grande quantité et congélation). Digestibilité : expliquer le trempage, la cuisson complète, le rinçage des conserves, l'introduction progressive et les épices (cumin), et faire goûter des préparations douces (houmous, soupe).
5. L'outil décrit l'image de l'aliment sur plusieurs dimensions : il montre précisément quels freins lever (temps, digestion) et quels atouts utiliser, alors qu'une question globale donne seulement un « oui » ou un « non » sans orienter l'action.

Corrigé – Exercice 3.46

1. Transcrire les entretiens ; lire plusieurs fois ; découper le texte en unités de sens ; construire une grille de catégories (définies à l'avance ou issues du texte) ; classer chaque unité, de préférence à deux pour vérifier l'accord ; compter les fréquences ; interpréter en illustrant par des citations.
2. Prix : 34 / 120 × 100 = 28,3 % ; temps : 26 / 120 = 21,7 % ; goût des enfants : 22 / 120 = 18,3 % ; transport : 15 / 120 = 12,5 % ; savoir-faire : 14 / 120 = 11,7 % ; équipement : 9 / 120 = 7,5 % ; total 34 + 26 + 22 + 15

+ 14 + 9 = 120 unités, soit 100 %.

3. Capacité : savoir-faire (capacité psychologique), fatigue (capacité physique, liée au temps). Opportunité physique : prix, temps, transport, équipement. Opportunité sociale : goût des enfants (contexte familial). Motivation automatique : la peur de jeter et le découragement (« je jette ») relèvent aussi de la motivation.

4. Six entretiens seulement, avec des parents volontaires ; le nombre d'unités de sens dépend de la façon de parler de chacun (une personne bavarde pèse plus) ; une catégorie souvent citée n'est pas forcément la plus importante pour la personne ; l'entretien qualitatif sert à comprendre et à construire des hypothèses, pas à mesurer une fréquence dans une population. Il faudrait un questionnaire auprès d'un échantillon plus large pour quantifier.

Corrigé – Exercice 3.47

1. Avant : 42 / 120 = 35,0 % ; après : 63 / 115 = 54,8 % ; écart : 54,8 − 35,0 = 19,8 points.

2. Avant : erreur type = racine de (0,350 × 0,650 / 120) = 0,0435 ; marge = 1,96 × 0,0435 = 0,085, soit 8,5 points ; IC 95 % = [26,5 % ; 43,5 %]. Après : erreur type = racine de (0,548 × 0,452 / 115) = 0,0464 ; marge = 1,96 × 0,0464 = 0,091, soit 9,1 points ; IC 95 % = [45,7 % ; 63,9 %].

3. Les deux intervalles ne se chevauchent pas (43,5 % < 45,7 %) : la hausse est très probablement réelle et pas seulement due au hasard de l'échantillonnage. (Un chevauchement n'aurait pas suffi à conclure à l'absence de différence ; un test de comparaison de deux proportions est plus rigoureux.)

4. Non. Les personnes interrogées ne sont pas les mêmes (les participants assidus ont pu être davantage interrogés la seconde fois) ; d'autres facteurs ont pu jouer (hausse du prix de la viande, campagne nationale, saison) ; il n'y a pas de groupe de comparaison ; les réponses sont déclaratives et la désirabilité sociale peut augmenter après des ateliers.

5. Interroger les mêmes personnes avant et après (données appariées, avec un code anonyme) ; comparer avec un quartier sans ateliers (groupe témoin) ; mesurer aussi la participation de chaque personne aux ateliers (relation dose-effet) ; ajouter une mesure à distance (6 mois après la fin).

Corrigé – Exercice 3.48

1. Taux de réponse : 48 / 64 × 100 = 75,0 %. Grignotage la nuit : 31 / 48 × 100 = 64,6 %. Boissons sucrées ou énergisantes en intervention : 22 / 48 × 100 = 45,8 %. Repas en commun : 40 / 48 × 100 = 83,3 %. Stades : précontemplation 14 / 48 = 29,2 % ; contemplation 16 / 48 = 33,3 % ; préparation 10 / 48 = 20,8 % ; action 5 / 48 = 10,4 % ; maintien 3 / 48 = 6,3 % ; total 100,0 %. Plus de six sur dix (62,5 %) ne sont pas encore prêts à agir.

2. Identité professionnelle et appartenance : la « popote » est un rite qui construit l'équipe ; toucher aux repas, c'est toucher à l'identité du groupe (« la popote, c'est sacré », « c'est ce qui fait l'équipe »). Normes : la norme descriptive et injonctive est « on mange gras et sucré, c'est la tradition » (4,1 sur 5) ; manger léger est sanctionné par la moquerie (« on le chambre »). Conformisme : dans un groupe très soudé, s'écarter de la norme est coûteux ; chacun suit le groupe. Alimentation émotionnelle : après une intervention difficile, le sucre sert à « décompresser » ; c'est une régulation du stress. À cela s'ajoutent l'environnement (distributeur, gâteaux apportés la nuit) et le travail de nuit, qui perturbe la faim et la satiété.

3. Attitude très favorable (4,3) : les pompiers savent que l'alimentation compte pour leur condition physique ; un message d'information est inutile. Norme subjective défavorable (tradition à 4,1 ; exemple du chef à 2,0). Contrôle perçu faible (2,4) : la nuit, l'offre disponible ne permet pas de manger équilibré. Leviers : la norme (s'appuyer sur des leaders d'opinion, le chef de centre, et sur l'identité « pompier en forme ») et le contrôle perçu (changer l'offre de nuit), sans jamais parler de régime.

4. Objectif général : d'ici fin 2027, améliorer l'alimentation pendant les gardes de nuit des sapeurs-pompiers du centre de Saint-Avit pour soutenir leur condition physique et leur vigilance. Objectifs spécifiques : réduire de 64,6 % à 45 % la part des pompiers qui grignotent au moins trois fois par garde de nuit ; faire

passer de 2,4 à 3,5 le score moyen de l'item « je peux manger équilibré pendant les gardes de nuit ». Objectifs opérationnels : mettre en place, avant mars 2027, une collation de nuit préparée à la popote pour chaque garde (indicateur : nombre de gardes avec collation, cahier de la popote) ; organiser deux ateliers « popote de garde » avec les cuisiniers volontaires avant juin 2027 (feuilles de présence) ; obtenir que le chef de centre et deux chefs d'agrès présentent le projet lors du rapport de garde avant février 2027 (compte rendu).

5. Action 1 : « collation de garde » préparée la veille à la popote (pain complet, fromage, fruits, soupe, œufs durs) et rangée dans un réfrigérateur dédié : restructuration de l'environnement, contrôle perçu ; utile à tous les stades. Action 2 : ateliers « popote de garde » animés avec les pompiers cuisiniers, qui revisitent les plats traditionnels (même plaisir, moins gras) : identité respectée, expérience de maîtrise, efficacité personnelle ; pour les stades de contemplation et de préparation. Action 3 : le chef de centre et des pompiers reconnus (sportifs, anciens) montrent l'exemple et en parlent au rapport : modélisation, norme injonctive et descriptive, influence des leaders. Action 4 : défi d'équipe volontaire « garde sans distributeur » pendant un mois, avec un tableau des équipes participantes : engagement libre et public, cohésion du groupe mise au service du changement ; pour les stades de préparation et d'action. Pour la précontemplation : aucune pression, informations courtes et concrètes sur le sommeil, la vigilance et la condition physique, et accès à la collation comme tout le monde.

6. Budget : collations de nuit pour un test de 3 mois : 13 semaines × 7 nuits × 6 pompiers de garde × 0,80 € = 436,80 € ; deux ateliers « popote de garde » (denrées et intervention) : 2 × 150,00 € = 300,00 € ; boîtes et gourdes : 64 × 4,50 € = 288,00 € ; affiches et supports : 80,00 € ; sous-total 436,80 + 300,00 + 288,00 + 80,00 = 1 104,80 € ; imprévus : 1 200 − 1 104,80 = 95,20 € (7,9 %) ; total 1 200,00 €.

7. Processus : nombre de gardes avec collation, nombre de participants aux ateliers, nombre d'équipes engagées dans le défi, consommation du distributeur la nuit (relevé des ventes), respect du budget. Résultats : même questionnaire anonyme à un an (part des grignoteurs, stades, scores de Likert) ; satisfaction ; entretiens de groupe sur la popote. Impact à plus long terme : résultats collectifs et anonymes aux tests de condition physique, suivis par le médecin-chef, en restant prudent (beaucoup d'autres facteurs agissent).

8. Les données de santé (poids, résultats médicaux) restent sous la responsabilité du service de santé et sont couvertes par le secret médical ; elles ne sont jamais transmises à la hiérarchie opérationnelle ; le questionnaire reste anonyme et les résultats ne sont présentés que de façon collective ; aucune participation n'est obligatoire et aucune sanction ou notation n'est liée au projet ; les résultats aux tests physiques ne servent pas à classer les pompiers. Communication : parler de « popote de garde », de vigilance et de condition physique, jamais de régime ou de poids ; associer les cuisiniers et les leaders d'opinion ; valoriser les réussites de l'équipe ; photos uniquement avec accord, sans données de santé.

Bilan : grille d'auto-évaluation

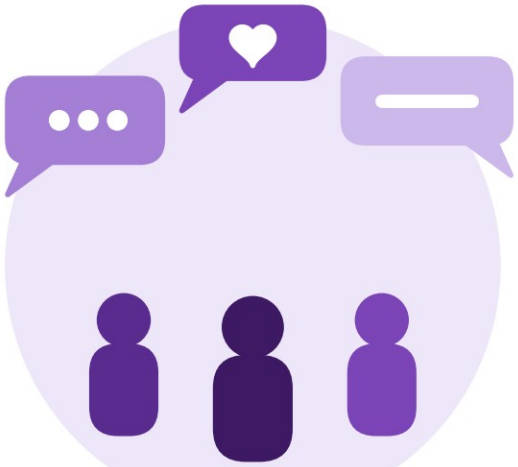
Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Distinguer les regards disciplinaires ; expliquer le paradoxe de l'omnivore, l'incorporation, l'espace social alimentaire, la socialisation et l'identité	3.1 à 3.6			
2	Définir une représentation sociale ; réaliser une analyse prototypique et une mise en cause ; distinguer normes descriptives et injonctives ; analyser une situation interculturelle	3.7 à 3.12			
3	Présenter les expériences d'influence sociale ; utiliser la dissonance et l'engagement de façon éthique ; prévenir la stigmatisation ; coter une échelle d'attitude	3.13 à 3.18			
4	Classer les 9 CPS ; concevoir une séance SAFE ; coter une échelle d'estime de soi ; analyser des silhouettes ; distinguer faim physiologique et émotionnelle	3.19 à 3.24			
5	Utiliser les stades du changement, la théorie du comportement planifié, les croyances relatives à la santé, l'efficacité personnelle et COM-B	3.25 à 3.30			
6	Repérer les bruits de la communication ; reconnaître les attitudes de Porter ; reformuler ; appliquer l'entretien motivationnel ; construire une balance décisionnelle	3.31 à 3.36			
7	Reconnaître les étapes, les rôles et les styles d'animation ; choisir une technique ; situer une motivation ; utiliser un nudge de façon éthique	3.37 à 3.42			
8	Construire et coter une échelle ; utiliser un différenciateur sémantique ; faire une analyse de contenu ; comparer deux proportions ; traiter un cas complet	3.43 à 3.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5



CHAPITRE

03

Éléments de psychologie sociale

Psychologie | Sociologie | Anthropologie de l'alimentation

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 3 223
Mode d'emploi du cahier d'annales 223
Ce que le jury attend sur ce chapitre 223
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 224
S1 – « Un vrai casse-croûte de chantier » : représentations et habitudes alimentaires des apprentis d'un CFA du bâtiment 224
S2 – « Les hommes aux fourneaux » : un atelier pour des hommes âgés qui vivent seuls 228
S3 – Vers l'autonomie : des jeunes de la protection de l'enfance qui apprennent à se nourrir seuls 231
Partie II – Les corrigés détaillés 234
Corrigé S1 – « Un vrai casse-croûte de chantier » : les apprentis d'un CFA du bâtiment 234
Corrigé S2 – « Les hommes aux fourneaux » : un atelier pour des hommes âgés qui vivent seuls 241
Corrigé S3 – Vers l'autonomie : des jeunes de la protection de l'enfance 246
Grille d'auto-évaluation 252

Cahier d'annales E5 – chapitre 3

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes et les données des enquêtes sont fictives : elles sont construites pour l'entraînement et ne doivent pas être citées comme des données réelles. Les données nationales et les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Un vrai casse-croûte de chantier » : représentations et habitudes alimentaires des apprentis d'un CFA du bâtiment	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Les hommes aux fourneaux » : un atelier pour des hommes âgés qui vivent seuls	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	Vers l'autonomie : des jeunes de la protection de l'enfance qui apprennent à se nourrir seuls	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 3 donne les outils pour comprendre le mangeur et le groupe : représentations sociales, normes, identité et socialisation, influence sociale, attitudes et dissonance, stéréotypes et stigmatisation, compétences psychosociales, modèles du changement de comportement (Prochaska et DiClemente, Ajzen, Bandura, COM-B, autodétermination), écoute et animation de groupe. Le jury vérifie que le candidat sait **recueillir** les représentations et les attitudes d'un public (évocation hiérarchisée, échelle de Likert), **analyser** les résultats avec rigueur, puis **choisir des leviers** cohérents avec ce diagnostic : agir sur les normes et l'environnement plutôt que culpabiliser, renforcer le sentiment d'efficacité personnelle, respecter l'autonomie des personnes et ne jamais stigmatiser.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner le public, ses représentations (citations), les chiffres, les contraintes et le verbe de chaque consigne. Pendant : pour chaque résultat d'enquête, écrire le calcul, le résultat et une phrase d'interprétation qui nomme un concept de psychologie sociale (norme, représentation, efficacité personnelle, stade de changement) et le levier qui en découle. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Un vrai casse-croûte de chantier » : représentations et habitudes alimentaires des apprentis d'un CFA du bâtiment

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année au centre de formation d'apprentis (CFA) du bâtiment et des travaux publics de Vauclair (structure fictive). Le CFA accueille 640 apprentis de 16 à 25 ans (maçonnerie, couverture, plomberie, électricité, menuiserie, peinture) ; 94 % sont des garçons. Les apprentis alternent deux semaines en entreprise et une semaine au CFA. L'infirmière du CFA vous confie une demande : « Plusieurs jeunes ont fait des malaises sur les chantiers en début de matinée. Beaucoup partent à 6 heures sans rien avaler et tiennent avec une boisson énergisante. Au self, ils prennent des frites et laissent les légumes. Quand l'un d'eux prend une salade, les autres se moquent. Les messages du type "mangez cinq fruits et légumes" ne marchent pas du tout avec eux. » Vous devez comprendre ce public, concevoir un projet, en réaliser une partie pendant votre stage et en rendre compte dans votre dossier E5.

Document 1 – La structure, le public et les moyens

- Équipe : une infirmière à temps plein, une conseillère principale d'éducation, une référente handicap, 42 formateurs ; un self de 220 places géré par une société de restauration collective (menu à 4,10 € pour l'apprenti) ; un foyer de jeunes travailleurs voisin qui loge 56 apprentis.
- Public : apprentis de 16 à 25 ans, rémunérés en pourcentage du SMIC selon l'âge et l'année de formation ; journées de chantier de 7 h 30 à 16 h 30, avec un départ souvent avant 6 h 30 en camionnette ; repas de midi pris sur le chantier, dans le véhicule ou dans une boulangerie.
- Partenaires possibles : maîtres d'apprentissage (entreprises), service de prévention de l'organisme professionnel du BTP, mission locale, maison des adolescents, société de restauration du self, association sportive du CFA.
- Budget : 1 700 € accordés par le fonds régional de prévention pour l'année scolaire, matériel compris.

Document 2 – Recueil des représentations par évocation hiérarchisée (données fictives)

Consigne donnée à 160 apprentis : « Écrivez les cinq premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand on vous dit "bien manger", puis numérotez-les du plus important (1) au moins important (5). » Les réponses ont été regroupées en catégories. Le tableau donne, pour les dix catégories les plus citées, le nombre de citations et le rang moyen d'importance.

Catégorie	Nombre de citations	Rang moyen d'importance (1 à 5)
Viande	92	2,1
Manger beaucoup, être calé	78	2,4
Légumes	70	3,6
Force	64	2,8

Catégorie	Nombre de citations	Rang moyen d'importance (1 à 5)
Plaisir	58	2,7
Sport, muscles	44	3,2
Régime, faire attention	41	3,9
Maman, repas de famille	38	2,2
Cher	30	3,8
Fast-food	26	2,6

Pour l'analyse prototypique (méthode de Vergès, 1992), on retient comme seuil de fréquence la moyenne des citations des dix catégories et comme seuil d'importance la moyenne des rangs moyens.

Document 3 – Questionnaire et échelles d'attitude (données fictives, 160 répondants sur 640 apprentis)

Question	Nombre de « oui » (n = 160)
Ne prend rien à manger avant de partir, les jours de chantier	98
Boit au moins une boisson énergisante par jour	54
Déjeune au self du CFA pendant les semaines de formation	46
Mange un sandwich ou un repas de restauration rapide le midi, au moins 3 jours de chantier sur 5	88
Mange des fruits ou des légumes chaque jour	37
A déjà entendu une moquerie sur ce qu'il mange, au CFA ou sur le chantier	61

Stade de changement pour « prendre quelque chose à manger avant de partir sur le chantier » : précontemplation 72 ; contemplation 40 ; préparation 22 ; action 16 ; maintien 10.

Échelle de Likert construite selon la théorie du comportement planifié (1 = pas du tout d'accord ; 5 = tout à fait d'accord) : moyenne des 160 réponses.

Item	Dimension	Sens	Moyenne
A1 – Manger avant de partir m'aide à tenir sur le chantier	Attitude	positif	3,8
A2 – Le petit-déjeuner, c'est une perte de temps	Attitude	négatif	3,1
N1 – Mon maître d'apprentissage pense que je devrais manger avant de partir	Norme subjective	positif	2,4
N2 – Mes collègues de chantier mangent avant de partir	Norme descriptive	positif	2,1
C1 – Je peux facilement manger quelque chose avant de partir à 6 heures	Contrôle perçu	positif	2,0
C2 – Le matin, je n'ai rien à manger chez moi	Contrôle perçu	négatif	3,4
I1 – J'ai l'intention de manger avant de partir la semaine prochaine	Intention	positif	2,6

Croisement selon le logement : parmi les 104 apprentis qui vivent chez leurs parents, 56 ne prennent rien avant de partir ; parmi les 56 qui vivent seuls ou au foyer de jeunes travailleurs, 42 ne prennent rien.

Document 4 – Ce qu'ils disent (entretiens collectifs, deux groupes de 8 apprentis)

« Sur le chantier, celui qui mange une salade, on l'appelle "la chèvre". » (Enzo, 17 ans, maçon)

« Un vrai repas, c'est de la viande et des frites. Le reste, c'est pour les filles. » (Bilal, 18 ans, couvreur)

« Le matin à 5 h 45, j'ai pas faim. Je prends un energy dans la camionnette, ça réveille. » (Théo, 16 ans, électricien)

« Mon patron, lui, il mange rien jusqu'à midi. Il dit que ça coupe les jambes. » (Kylian, 19 ans, plombier)

« Chez ma mère, on mange bien, avec des légumes. Depuis que je suis au foyer, c'est kebab. » (Mathis, 20 ans, menuisier)

« Si c'est pour nous dire qu'on mange mal, on connaît, on a eu ça au collège. » (Yanis, 17 ans, peintre)

« Moi je veux prendre du muscle. Je regarde des vidéos sur l'alimentation des sportifs. » (Lucas, 18 ans, maçon)

Document 5 – Deux propositions reçues par l'équipe du CFA

Un formateur propose de « motiver les jeunes » en les pesant tous en début de séance, puis en publiant chaque mois sur le groupe de messagerie de la classe un classement « des kilos perdus et gagnés ». Une semaine plus tard, une courte vidéo circule sur un réseau social : un apprenti en situation d'obésité y est filmé au self, à son insu, avec des commentaires moqueurs. Enfin, la direction vous demande de réaliser pour la page publique du CFA une vidéo du projet « avec les visages des jeunes, pour que ça fasse vrai ».

Document 6 – Données nationales et cadre des politiques publiques (données réelles)

- L'ANSES (avis du 1er octobre 2013 sur les boissons dites « énergisantes ») recommande d'éviter leur consommation en association avec l'alcool et lors d'un exercice physique, et de la limiter chez les enfants et les adolescents.
- Santé publique France a publié en 2022 un référentiel des compétences psychosociales (CPS) : 9 CPS générales réparties en trois catégories (cognitives, émotionnelles, sociales).
- L'instruction interministérielle du 19 août 2022 fixe une stratégie nationale de développement des CPS chez les enfants et les jeunes pour la période 2022-2037.
- Le programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5) a été lancé le 8 avril 2026 ; la réduction des inégalités sociales de santé en nutrition en est une priorité.
- La stigmatisation liée au poids est fréquente à l'école, au travail et dans les soins ; elle nuit à la santé psychologique et favorise des comportements défavorables, comme l'évitement de l'activité physique et des soins (Puhl et Heuer, « The stigma of obesity: a review and update », Obesity, 2009).

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Réalisez l'analyse prototypique du document 2 : calculez les deux seuils, classez les dix catégories dans un tableau à quatre cases, puis interprétez la représentation du « bien manger » des apprentis (noyau central, éléments périphériques, zone contrastée). Indiquez ce que cette analyse change pour vos messages. (2 pts)
2. Calculez les indicateurs du document 3 (pourcentages, taux de participation, répartition par stade de changement) et posez le diagnostic ; formulez le problème central. (1,5 pt)
3. Calculez le score de chaque dimension de l'échelle de Likert (en inversant les items négatifs) et interprétez-les avec la théorie du comportement planifié d'Ajzen (1991). Quels leviers en déduisez-vous ? (1,5 pt)
4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et des objectifs opérationnels, chacun avec un indicateur, une valeur cible et une échéance. (1,5 pt)
5. Présentez le plan d'action sur l'année scolaire en justifiant chaque action par un concept de psychologie sociale (normes sociales, influence des pairs, engagement, sentiment d'efficacité personnelle, compétences psychosociales) et un budget qui respecte les 1 700 €. (1,5 pt)
6. Construisez la démarche d'évaluation (processus, résultats) et proposez la valorisation du projet. (1 pt)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

7. Calculez le risque relatif de ne rien manger avant de partir selon le logement (document 3) et interprétez-le. Peut-on conclure que vivre seul est la cause de ce comportement ? (1,5 pt)

8. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion d'apprentis qui ne mangent rien avant de partir, puis la taille d'échantillon nécessaire pour une précision de ± 5 points (avec correction pour une population de 640). Présentez trois limites de l'évocation hiérarchisée et de l'échelle de Likert. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

9. Organisez une veille sur les interventions psychosociales en nutrition auprès des jeunes et sur l'alimentation des travailleurs du bâtiment : sources fiables, outils, fréquence, diffusion. (2 pts)

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique – C3.5 et C3.6 (3 points)

10. Analysez les trois situations du document 5 (stigmatisation, cyberharcèlement, droit à l'image et données de santé) et rédigez la réponse que vous proposez à la direction du CFA. (1,5 pt)

11. Proposez des supports de communication adaptés à ces jeunes (sans moralisation) ; rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 15 questions probables du jury. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Les hommes aux fourneaux » : un atelier pour des hommes âgés qui vivent seuls

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène) et du BTS blanc CNED E5B (adaptation d'une recette et calcul nutritionnel).

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Belcourt-sur-Loire (structure fictive) a repéré, grâce au service de portage de repas et aux médecins généralistes, des hommes de plus de 65 ans qui vivent seuls depuis peu, le plus souvent après le décès de leur épouse. Beaucoup n'ont « jamais fait la cuisine » ; ils mangent des plats tout prêts, du pain et du fromage, ou sautent le repas du soir. Deux d'entre eux ont perdu plus de 5 % de leur poids en six mois. Les hommes refusent les ateliers « nutrition » existants (« c'est plein de dames, je n'ose pas »). Le CCAS vous demande de concevoir et d'animer le premier atelier d'un cycle de six séances baptisé « Les hommes aux fourneaux », réservé aux hommes, dans la cuisine du foyer-restaurant municipal.

Document 1 – Le public et les contraintes

- 8 hommes de 66 à 84 ans, veufs ou séparés, vivant seuls à domicile ; anciens ouvriers, artisans, agriculteurs ou employés.
- Monsieur R. (79 ans) a un diabète de type 2 traité par comprimés ; Monsieur P. (84 ans) porte un appareil dentaire et a du mal à mâcher les aliments durs ; Monsieur L. (72 ans) suit un régime pauvre en sel pour une insuffisance cardiaque ; Monsieur D. (68 ans) dit en riant : « Moi, je ne sais même pas faire cuire un œuf. »
- Plusieurs participants ont des difficultés de vue ou d'audition ; deux se déplacent avec une canne.
- Cuisine du foyer-restaurant : 4 plaques, 2 fours, 1 four à micro-ondes, 1 réfrigérateur, 4 postes de travail pour 2 personnes, tables à hauteur réglable.
- Budget denrées : au plus 3,00 € par portion ; 10 portions (8 participants et 2 professionnels).
- Durée de l'atelier avec le public : 2 h 30, de 9 h 30 à 12 h 00, repas compris. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Menu imposé

Plat : papillote de lieu noir aux poireaux, à la crème et au citron ; pommes de terre vapeur.

Dessert : crumble pommes-poires aux flocons d'avoine.

Le candidat réalise le plat et le dessert. Il présente aussi les adaptations pour Monsieur R. (diabète), Monsieur P. (mastication) et Monsieur L. (sel), et une version « pour un » que chaque participant pourra refaire chez lui.

Document 3 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Perte au parage ou à l'épluchage	Prix
Filet de lieu noir, frais, sans peau ni arêtes	120 g	sans perte	12,90 € le kg
Poireaux	100 g	30 %	2,20 € le kg

Denrée	Grammage net par portion	Perte au parage ou à l'épluchage	Prix
Pommes de terre	200 g	20 %	1,20 € le kg
Crème légère 15 % MG, fluide	15 g	sans perte	3,40 € le kg
Citron	10 g	40 %	3,00 € le kg
Pommes	60 g	20 %	2,40 € le kg
Poires	60 g	20 %	2,80 € le kg
Flocons d'avoine	15 g	sans perte	2,00 € le kg
Farine de blé T55	10 g	sans perte	1,10 € le kg
Beurre doux	8 g	sans perte	9,50 € le kg
Sucre blanc	6 g	sans perte	1,30 € le kg
Papier sulfurisé, aneth, poivre, cannelle	–	–	forfait 0,80 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Vitamine D (µg)
Lieu noir, cru	82,5	18,8	0	0,8	0	0,2	1,77
Poireau, cru	30,4	1,5	4,55	0,3	1,8	0,05	0
Pomme de terre, sans peau, crue	80	2,02	16,2	0,09	2,2	< 0,0011	0
Crème 12 à 20 % MG, légère, fluide, rayon frais	173	2,96	4,3	16	0	0,15	–
Citron, chair sans peau, sans pépins, cru	24,3	0,25	1,56	< 0,5	< 0,5	< 0,013	0
Pomme, chair sans peau, crue (aliment moyen)	51,3	0,26	11,9	0,24	2,39	0,0064	–
Poire, chair, crue (aliment moyen)	49,7	0,25	11,4	< 0,5	3,1	< 0,013	–
Flocons d'avoine	369	10,6	57,7	7,82	11,2	0,011	0
Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains)	350	9,03	73,7	1	3,2	< 0,13	< 0,25
Beurre à 80 % MG minimum, doux	753	0,64	0,71	83	0	0,035	< 1
Sucre blanc	399	0	99,7	0	0	0,0054	0

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » ou « – » (non disponible) est comptée 0. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (fichier du 3 novembre 2025, mis en ligne le 19 novembre 2025).

Document 5 – Repères utiles (données réelles)

- Besoin en protéines estimé à environ 1,0 g par kg de poids et par jour chez la personne âgée (AFSSA, rapport « Apport en protéines : consommation, qualité, besoins et recommandations », 2007).
- Apport satisfaisant en vitamine D : 15 µg par jour chez l'adulte (ANSES, références nutritionnelles, 2021) ; 30 g de fibres par jour chez l'adulte.
- Apport en sel : moins de 5 g par jour pour un adulte (OMS, 2012).
- Une perte de poids d'au moins 5 % en un mois ou d'au moins 10 % en six mois est un critère phénotypique de dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (HAS, recommandation de novembre 2021).
- Sentiment d'efficacité personnelle : croyance d'une personne en sa capacité à réaliser une action ; il se renforce surtout par les expériences de réussite (Bandura, 1977).

Travail à faire

Partie 1 – Conception (11 points)

1. Identifiez les besoins de ce public (nutritionnels, psychologiques et sociaux) et formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier. (2 pts)

2. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes, quantités brutes, unités de commande, coût) ; calculez le coût par portion et vérifiez le respect du budget. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique de la papillote (ingrédients, matériel, étapes, points critiques) et la fiche « pour un » simplifiée ; présentez les adaptations pour Monsieur R., Monsieur P. et Monsieur L. (3 pts)

4. Calculez l'apport d'une portion du plat et du repas complet (énergie, protéines, glucides, lipides, fibres, sel, vitamine D) et la répartition de l'énergie ; calculez la part du besoin en protéines couverte pour un homme de 75 kg ; commentez au regard du risque de dénutrition. (2 pts)

5. Expliquez, avec les notions de psychologie sociale du chapitre (identité et rôles de genre, sentiment d'efficacité personnelle, isolement, motivation), pourquoi ces hommes ne cuisinent pas et comment l'atelier peut les aider ; montrez les limites d'un atelier isolé. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants), en tenant compte de la vue, de l'audition et de la mobilité des participants. (2 pts)

7. Présentez les méthodes d'animation qui renforcent le sentiment d'efficacité personnelle, les outils (fiche recette en gros caractères, photos des étapes) et une grille de dégustation adaptée. (1,5 pt)

8. Présentez les règles d'hygiène (5 M, poisson, cuisson, conservation des restes à domicile), les allergènes et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

9. Réalisez la papillote, les pommes de terre vapeur et le crumble ; dressez deux assiettes, dont une adaptée à Monsieur P. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier (satisfaction, acquis, sentiment de compétence, intention de refaire). (1 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Vers l'autonomie : des jeunes de la protection de l'enfance qui apprennent à se nourrir seuls

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet mixte – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) sur une même situation

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral préparé (temps 1) et 3 h (temps 2) · Barème : 20 points par temps.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique au service d'accompagnement vers l'autonomie « Les Passerelles » de la ville de Maurepont (structure fictive), rattaché à une maison d'enfants à caractère social. Le service accompagne 24 jeunes de 16 à 20 ans confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) : les mineurs et les jeunes majeurs sous contrat d'accompagnement vivent seuls ou à deux dans des studios répartis dans la ville. Chaque jeune reçoit du service une allocation pour son alimentation et gère ses courses. Les éducateurs constatent que beaucoup de jeunes « vivent de livraisons et de pâtes au ketchup », sautent des repas et n'ont plus d'argent à la fin du mois. Lors de la réunion des jeunes, plusieurs ont dit : « On ne nous a jamais appris, au foyer tout était fait. » La cheffe de service vous confie un projet « Se nourrir seul, c'est possible ».

Document 1 – Données réelles sur les jeunes de la protection de l'enfance

- La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants renforce l'accompagnement des jeunes majeurs de moins de 21 ans sortant de l'ASE qui n'ont pas de ressources ou de soutien familial suffisants.
- Dans l'enquête Sans-domicile 2012 (Insee et Ined), 23 % des personnes sans domicile nées en France avaient été placées dans leur enfance (Frechon et Marpsat, Économie et statistique n° 488-489, 2016).
- Santé publique France (2022) range parmi les compétences psychosociales sociales la capacité à « développer des relations constructives » et parmi les compétences cognitives la capacité à « prendre des décisions constructives » ; leur développement fait partie de la stratégie nationale 2022-2037.
- Selon la théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 1985, révisée en 2000), la motivation durable repose sur la satisfaction de trois besoins : autonomie, compétence et appartenance sociale.

Document 2 – Enquête menée au service (données fictives)

22 jeunes sur 24 ont répondu à un questionnaire anonyme rempli sur tablette pendant un temps collectif, avec l'aide d'une éducatrice pour la lecture si besoin.

Question	Nombre de « oui » (n = 22)
Saute au moins un repas par jour, au moins 4 jours sur 7	13
Mange un plat préparé, une livraison ou un repas de restauration rapide au moins 4 fois par semaine	15
Sait cuisiner au moins 3 plats sans aide	6
Fait ses courses avec une liste	4
N'a plus eu d'argent pour manger avant la fin du mois, au moins une fois dans les 3 derniers mois	12
Souhaite apprendre à cuisiner	17

Échelle de sentiment d'efficacité personnelle (« Je me sens capable de… », 1 = pas du tout capable ; 5 = tout à fait capable), moyenne des 22 réponses : préparer un repas complet : 2,1 ; faire mes courses de la semaine avec 30 € : 2,4 ; cuisiner pour des amis : 1,9 ; lire une étiquette et comparer deux produits : 3,0 ; conserver et

réutiliser des restes : 2,2 ; préparer un repas quand je suis fatigué au lieu de commander : 2,6.

Document 3 – Moyens et contraintes

Budget accordé par le département au titre des actions collectives : 900 € pour l'année. Cuisine collective du service : 4 plaques, 1 four, 1 four à micro-ondes, 2 réfrigérateurs, 1 congélateur, 4 postes de travail. Contraintes signalées par les éducateurs : horaires décalés (lycée professionnel, apprentissage, emploi de nuit pour deux jeunes) ; méfiance envers « les adultes qui décident pour nous » ; histoires familiales difficiles, pour lesquelles le repas peut réveiller des souvenirs douloureux ; usage intensif des réseaux sociaux ; petits studios avec deux plaques, un four à micro-ondes et un réfrigérateur avec un petit compartiment congélateur.

Travail à faire – Temps 1

1. Calculez les indicateurs de l'enquête, le taux de réponse et le score moyen d'efficacité personnelle ; repérez les deux capacités les plus faibles et la plus forte ; présentez les limites de ces données. (4 pts)
2. Analysez la situation avec les notions de psychologie sociale : socialisation primaire et secondaire, identité, compétences psychosociales, théorie de l'autodétermination ; montrez en quoi ces jeunes sont exposés à une inégalité sociale de santé. (3 pts)
3. Formulez les objectifs (général, spécifiques, opérationnels) et le plan d'action sur 12 mois, en associant les jeunes aux décisions. (5 pts)
4. Présentez la démarche d'évaluation et un budget qui respecte les 900 €. (3 pts)
5. Indiquez les précautions éthiques et juridiques : données personnelles, secret professionnel, photos et réseaux sociaux, sujets sensibles (histoire familiale). (3 pts)
6. Expression et sources. (2 pts)

Travail à faire – Temps 2

Document 4 – Atelier imposé et données (prix construits pour le sujet ; composition : table Ciqual 2025, ANSES, 19 novembre 2025)

Atelier « Cuisiner une fois, manger quatre fois » de 2 h, de 17 h 30 à 19 h 30, pour 8 jeunes (dont une jeune fille végétarienne qui mange des œufs et des produits laitiers, et deux jeunes qui ne mangent que de la viande halal), suivi du repas pris ensemble. Coût des denrées : au plus 2,00 € par portion ; 10 portions (8 jeunes et 2 professionnels). Chaque jeune repart avec une portion congelée.

Menu : chili doux au bœuf et aux haricots rouges, riz blanc ; salade d'oranges à la cannelle.

Grammages nets par portion : bœuf haché 5 % MG 60 g ; haricots rouges en conserve, égouttés 80 g ; oignon 20 g (10 % de perte) ; poivron 40 g (20 % de perte) ; tomates pelées au jus en conserve 80 g ; huile de colza 5 g ; riz blanc 60 g (cru) ; orange 150 g (30 % de perte).

Prix : bœuf haché 5 % MG (halal) 11,50 € le kg ; haricots rouges égouttés 2,40 € le kg ; oignons 1,80 € le kg ; poivrons 3,50 € le kg ; tomates pelées 2,20 € le kg ; huile de colza 3,20 € le litre (1 L = 920 g) ; riz 1,80 € le kg ; oranges 2,20 € le kg ; ail, cumin, paprika doux, cannelle : forfait 0,80 € pour l'atelier.

Aliment (libellé Ciqual 2025), pour 100 g	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)
Boeuf, steak haché 5% MG cru	130	21,9	0,3	4,59	0	0,097	2,65
Haricot rouge, appertisé, égoutté	108	8,31	13	0,97	7	0,68	1,5
Oignon, cru	39	1,1	6,25	0,62	1,7	0,098	0,00019

Aliment (libellé Ciqual 2025), pour 100 g	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)
Poivron, vert, jaune ou rouge, cru	22,6	0,8	3,5	0,27	1,5	0,021	0,4
Tomate, pelée, appertisée, au jus, non égouttée	21,8	0,79	3,15	0,25	1,9	0,025	0,57
Huile de colza	900	0	0	100	0	< 0,0028	0,023
Riz blanc, cru	350	7,02	77,5	0,79	1,53	0,0079	1,94
Orange, chair sans peau, sans pépins, crue	42	0,75	8,03	< 0,5	2,7	< 0,013	0,57

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » est comptée 0. Repères (ANSES, 2021) : fer 11 mg par jour pour une femme adulte ayant des pertes menstruelles faibles à normales ; fibres 30 g par jour.

7. Identifiez les besoins et les objectifs de l'atelier ; justifiez le choix du menu au regard du public (budget, équipement des studios, horaires, autonomie, convictions). (3 pts)

8. Établissez le bon de commande pour 10 portions et la fiche technique du chili ; calculez l'apport du repas complet (énergie, protéines, glucides, lipides, fibres, sel, fer) et la répartition de l'énergie ; proposez la version végétarienne et calculez sa teneur en protéines. (5 pts)

9. Présentez le déroulé de l'atelier, les techniques d'animation qui respectent l'autonomie des jeunes et la grille de dégustation. (4 pts)

10. Présentez les règles d'hygiène (viande hachée, refroidissement rapide, congélation et décongélation, allergènes) et les éco-gestes. (4 pts)

11. Réalisez les préparations, conditionnez les portions à emporter et évaluez l'atelier. (4 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Un vrai casse-croûte de chantier » : les apprentis d'un CFA du bâtiment

que le jury attend

Le jury évalue la capacité à comprendre un public avant d'agir : recueillir et analyser ses représentations et ses attitudes, puis choisir des leviers cohérents avec ce diagnostic. Il valorise les calculs exacts et interprétés, l'usage juste des concepts (noyau central, norme descriptive, contrôle perçu, efficacité personnelle) et un projet qui s'appuie sur l'identité professionnelle des apprentis. Il pénalise la moralisation (« ils mangent mal »), les messages qui attaquent de front la représentation des jeunes et toute action qui expose un apprenti à la moquerie.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Analyse prototypique de l'évocation hiérarchisée (2 pts)

Calcul posé – Les deux seuils

- Total des citations des dix catégories : 92 + 78 + 70 + 64 + 58 + 44 + 41 + 38 + 30 + 26 = **541**.
- Seuil de fréquence = 541 / 10 = **54,1 citations**.
- Somme des rangs moyens : 2,1 + 2,4 + 3,6 + 2,8 + 2,7 + 3,2 + 3,9 + 2,2 + 3,8 + 2,6 = 29,3.
- Seuil d'importance = 29,3 / 10 = **2,93**. Un rang moyen inférieur à 2,93 signifie que le mot est cité parmi les plus importants.

	Rang moyen inférieur à 2,93 (jugé important)	Rang moyen supérieur ou égal à 2,93 (jugé moins important)
Fréquence supérieure ou égale à 54,1	**Zone du noyau central** : viande (92 ; 2,1), manger beaucoup, être calé (78 ; 2,4), force (64 ; 2,8), plaisir (58 ; 2,7)	**Première périphérie** : légumes (70 ; 3,6)
Fréquence inférieure à 54,1	**Zone contrastée** : maman, repas de famille (38 ; 2,2), fast-food (26 ; 2,6)	**Seconde périphérie** : sport, muscles (44 ; 3,2), régime, faire attention (41 ; 3,9), cher (30 ; 3,8)

Interprétation. Selon la théorie du noyau central (Abric, 1994), le **noyau** donne son sens à la représentation ; il est stable, partagé et résiste au changement. Pour ces apprentis, « bien manger », c'est d'abord **manger copieux, de la viande, pour avoir de la force, avec plaisir** : une représentation liée à l'**identité professionnelle** d'un métier physique et à des **normes de genre** (document 4 : « le reste, c'est pour les filles »). Les **légumes** sont souvent cités (43,8 % des répondants : 70 / 160 × 100) mais à un rang tardif : ils sont connus comme une norme apprise (« on a eu ça au collège »), sans être au cœur du sens. La **seconde périphérie** associe le « bien manger » à la contrainte (régime) et au coût. La **zone contrastée** révèle des sous-groupes : pour certains, le bien manger est un **repas de famille** (souvent perdu en quittant le domicile, comme pour Mathis) ; pour d'autres, c'est la restauration rapide.

Conséquences pour les messages : ne pas attaquer le noyau (« mangez moins de viande », « 5 fruits et légumes ») ; **s'appuyer sur le noyau** pour y rattacher les éléments périphériques : « tenir jusqu'à midi sur le chantier », « le carburant du matin », « un casse-croûte qui cale et qui donne de la force » ; présenter les légumes et le petit-déjeuner comme des alliés de la force et du plaisir, jamais comme une privation. La périphérie est la partie de la représentation qui change le plus facilement : c'est là que le projet peut agir.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Classer les mots seulement selon leur fréquence ; oublier que le rang le plus important est le rang 1 (un rang moyen faible signifie une grande importance) ; parler de « noyau central » sans vérifier la centralité par une seconde technique (questionnaire de mise en cause) ; juger les représentations (« elles sont fausses ») au lieu de les comprendre.

Question 2 – Indicateurs et diagnostic (1,5 pt)

Calcul posé – Indicateurs du questionnaire (n = 160)

- Ne prend rien avant de partir : 98 / 160 × 100 = **61,3 %**.
- Boisson énergisante chaque jour : 54 / 160 × 100 = **33,8 %**.
- Déjeune au self pendant les semaines au CFA : 46 / 160 × 100 = **28,8 %**.
- Sandwich ou restauration rapide au moins 3 midis sur 5 : 88 / 160 × 100 = **55,0 %**.
- Fruits ou légumes chaque jour : 37 / 160 × 100 = **23,1 %**.
- A entendu une moquerie sur ce qu'il mange : 61 / 160 × 100 = **38,1 %**.
- Taux de participation : 160 / 640 × 100 = **25,0 %**.

Stades de changement (Prochaska et DiClemente, 1983) : précontemplation 72 / 160 = **45,0 %** ; contemplation 40 / 160 = **25,0 %** ; préparation 22 / 160 = **13,8 %** ; action 16 / 160 = **10,0 %** ; maintien 10 / 160 = **6,3 %**. La somme des arrondis fait 100,1 % ; on le signale sans modifier les valeurs.

Diagnostic. Le comportement le plus fréquent est l'absence de prise alimentaire avant le chantier (61,3 %), souvent remplacée par une boisson énergisante (33,8 %), alors que l'ANSES (2013) déconseille ces boissons lors d'un effort physique. Le midi, l'alimentation est surtout faite de sandwichs ou de restauration rapide (55,0 %) et les fruits et légumes sont rares (23,1 %). Le contexte social pèse : plus d'un apprenti sur trois (38,1 %) a déjà été moqué pour ce qu'il mange, ce qui montre une **norme de groupe** défavorable. Enfin, **70,0 %** des apprentis (45,0 + 25,0) ne sont pas encore prêts à agir : une campagne d'information classique toucherait surtout les 30 % déjà prêts.

Type de besoin (Bradshaw, 1972)	Dans la situation
Normatif	Repères PNNS non atteints ; avis de l'ANSES (2013) sur les boissons énergisantes à l'effort ; malaises signalés par l'infirmière
Ressenti	Absence de faim à 5 h 45, fatigue, envie de « prendre du muscle »
Exprimé	Rejet des messages moralisateurs ; intérêt pour l'alimentation du sportif ; demande de l'infirmière
Comparatif	Les apprentis qui vivent seuls sautent plus souvent la prise du matin que ceux qui vivent chez leurs parents (question 7)

Problème central : une majorité d'apprentis du CFA de Vauclair (61,3 % des répondants) commence la journée de chantier sans rien manger, dans un contexte de normes de groupe et de représentations qui dévalorisent les légumes et le petit-déjeuner, ce qui les expose à des malaises et à des accidents. **Causes** : départ très matinal, absence de faim, rien à manger chez soi, modèle des adultes (« mon patron ne mange rien »), moqueries entre pairs, représentation du « vrai repas », budget limité, perte du repas familial pour ceux qui vivent seuls. **Conséquences** : malaises, baisse de vigilance (travail en hauteur, outils), consommation de boissons énergisantes, apports insuffisants en fibres et en vitamines.

Question 3 – Échelle de Likert et théorie du comportement planifié (1,5 pt)

Calcul posé – Scores par dimension (items négatifs inversés : score inversé = 6 – score)

- Attitude : A1 = 3,8 ; A2 inversé = 6 – 3,1 = 2,9 ; score = (3,8 + 2,9) / 2 = **3,35**.
- Norme sociale : N1 = 2,4 ; N2 = 2,1 ; score = (2,4 + 2,1) / 2 = **2,25**.

- Contrôle comportemental perçu : C1 = 2,0 ; C2 inversé = 6 − 3,4 = 2,6 ; score = (2,0 + 2,6) / 2 = **2,30**.
- Intention : I1 = **2,6**.

Le point neutre de l'échelle est 3.

Interprétation. Selon Ajzen (1991), l'intention dépend de l'attitude, de la norme subjective et du contrôle perçu. Ici, l'**attitude** est plutôt favorable (3,35, au-dessus du point neutre) : les apprentis savent que manger le matin aide à tenir. En revanche, la **norme sociale** (2,25) et le **contrôle perçu** (2,30) sont nettement défavorables : leurs modèles (maître d'apprentissage, collègues) ne mangent pas le matin, et ils se sentent incapables de le faire (heure, absence de faim, rien chez soi). L'**intention** reste faible (2,6). Conclusion : un message qui répète « le petit-déjeuner est important » serait inutile, car l'attitude est déjà acquise. Les leviers sont **la norme** (faire évoluer ce que font et pensent les adultes et les pairs de référence) et **le contrôle perçu** (solutions simples, préparées la veille, à manger dans la camionnette ou à la première pause de 9 h).

Limites – Ce que les moyennes ne disent pas

Une moyenne de groupe cache des profils différents (un apprenti de 16 ans qui vit chez ses parents et un apprenti de 22 ans qui vit seul). Deux items par dimension sont peu : on ne peut pas vérifier la cohérence interne de l'échelle. À l'oral, présentez ces scores comme des tendances, pas comme une mesure exacte.

Question 4 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : d'ici juin 2027, améliorer l'alimentation du matin et du midi des apprentis du CFA de Vauclair afin de réduire les malaises sur les chantiers.
- **Objectif spécifique 1** : d'ici juin 2027, réduire de 61,3 % à 45 % au plus la part des apprentis qui ne prennent rien à manger avant de partir sur le chantier.
- **Objectif spécifique 2** : d'ici juin 2027, augmenter de 23,1 % à 35 % au moins la part des apprentis qui mangent des fruits ou des légumes chaque jour.
- **Objectifs opérationnels** : former 12 apprentis relais volontaires avant le 15 décembre 2026 (indicateur : nombre de relais formés, feuille de présence) ; organiser 8 « casse-croûtes du lundi » au CFA entre janvier et mai 2027, avec au moins 60 apprentis présents à chacun (indicateur : comptage) ; animer 6 ateliers « casse-croûte de chantier préparé la veille » de janvier à avril 2027 (indicateur : nombre d'ateliers et de participants) ; présenter le projet aux maîtres d'apprentissage lors de la réunion annuelle de mars 2027 et obtenir l'accord d'au moins 20 entreprises pour une pause collation à 9 h (indicateur : nombre d'engagements signés) ; créer avec la société de restauration une « assiette du bâtisseur » proposée chaque jour au self dès février 2027 (indicateur : nombre d'assiettes servies).

Question 5 – Plan d'action et budget (1,5 pt)

Action	Contenu	Concept de psychologie sociale mobilisé
1. Apprentis relais	12 volontaires de différents métiers, formés en deux demi-journées (repères simples, écoute, animation) ; ils co-construisent les actions et les messages	**Influence des pairs** et pair-éducation : un message porté par un membre du groupe est plus crédible ; respect de l'**identité** du groupe
2. « Le casse-croûte du lundi »	Petit-déjeuner partagé à 7 h 45 les semaines de formation : pain, fromage, œufs durs, fruits, yaourts à boire, préparés par les apprentis relais	**Norme descriptive** rendue visible (« ici, on mange le matin ») ; **expérience vicariante** (Bandura) ; plaisir et convivialité, éléments du noyau
3. Atelier « casse-croûte de chantier »	Préparer la veille, en 10 minutes et pour moins de 2 €, une boîte qui cale (pain, œuf dur, fromage, fruit, restes du dîner) et une gourde ; chaque participant repart avec sa boîte	**Contrôle perçu** et **sentiment d'efficacité personnelle** (expérience de réussite) ; **engagement** (Joule et Beauvois, 1998) : un acte concret, choisi librement, rend le comportement plus probable

Action	Contenu	Concept de psychologie sociale mobilisé
4. Maîtres d'apprentissage	Intervention à la réunion annuelle, avec l'organisme de prévention du BTP : lien entre jeûne matinal, vigilance et accidents ; proposition d'une pause collation à 9 h	**Norme subjective** : le maître d'apprentissage est un modèle et une référence ; action sur l'**environnement** de travail
5. « Assiette du bâtisseur » au self	Assiette copieuse construite avec la restauration et les relais : viande ou œufs, féculents, légumes intégrés au plat (gratin, poêlée), pain ; nom choisi par les apprentis	S'appuyer sur le **noyau central** (calé, force) pour y attacher les légumes ; **nudge** (placement en tête de ligne)
6. Séances CPS « Les moqueries, on en parle »	Deux séances par classe avec la CPE : repérer la pression du groupe, savoir dire non, s'affirmer sans agressivité	**Compétences psychosociales** sociales (communiquer de façon constructive, résoudre des difficultés) ; lutte contre la **stigmatisation**

Calcul posé – Budget prévisionnel (prix construits pour le sujet)

- Casse-croûtes du lundi : 8 matinées × 80 apprentis × 0,90 € = **576,00 €**.
- Gourdes isothermes : 160 × 3,50 € = **560,00 €**.
- Matériel de formation des 12 apprentis relais : **120,00 €**.
- Supports (affiches, autocollants pour casques, montage de la vidéo réalisée par les apprentis) : **180,00 €**.
- Kit de démonstration « casse-croûte de chantier » (boîtes, sacs isothermes, denrées pour les ateliers) : **150,00 €**.
- Sous-total : 576 + 560 + 120 + 180 + 150 = 1 586,00 €.
- Imprévus : 1 700 − 1 586 = **114,00 €**, soit 114 / 1 700 × 100 = 6,7 % du budget.

Total : **1 700,00 €**, soit exactement le budget.

Question 6 – Évaluation et valorisation (1 pt)

Type	Indicateurs	Outils
Processus	Nombre de relais formés, de casse-croûtes et d'ateliers, d'apprentis présents, d'entreprises engagées ; respect du budget	Feuilles de présence, tableau de bord, comptes
Résultats	Part des apprentis qui ne mangent rien le matin ; part qui mange des fruits ou des légumes chaque jour ; scores de norme et de contrôle perçu ; place des « légumes » et du « petit-déjeuner » dans une nouvelle évocation hiérarchisée	Même questionnaire, même échelle et même consigne en mai 2027, sur un échantillon comparable
Impact (à moyen terme)	Nombre de malaises signalés à l'infirmerie et par les entreprises	Registre de l'infirmerie (données agrégées), comparaison avec l'année précédente

Valorisation : bilan au conseil de perfectionnement du CFA ; article dans la lettre aux entreprises ; présentation au réseau régional des CFA et à l'organisme de prévention du BTP ; fiche action déposée dans la base régionale des actions de promotion de la santé ; reconduction par les apprentis relais de l'année suivante.

Partie B – Recherche appliquée

Question 7 – Risque relatif (1,5 pt)

Calcul posé – Risque relatif de ne rien manger avant de partir selon le logement

- Exposés (vivent seuls ou au foyer) : 42 / 56 = 0,750, soit **75,0 %**.
- Non exposés (vivent chez leurs parents) : 56 / 104 = 0,538, soit **53,8 %**.
- Risque relatif RR = 0,750 / 0,538 = **1,39**.

Vérification des effectifs : 56 + 104 = 160 répondants ; 42 + 56 = 98 apprentis qui ne mangent rien, comme dans le tableau.

Interprétation : les apprentis qui vivent seuls ou au foyer ont **1,4 fois plus de risque** de ne rien manger avant de partir que ceux qui vivent chez leurs parents. On ne peut pas conclure à une **causalité** : l'enquête est transversale ; l'association peut s'expliquer par des **facteurs de confusion** (âge : les apprentis qui vivent seuls sont plus âgés ; métier ; distance au chantier ; revenus). Il faudrait aussi tester la significativité (intervalle de confiance du RR). L'hypothèse est cependant cohérente avec la **socialisation** : quitter le domicile familial fait perdre le cadre du repas familial (zone contrastée de la question 1, témoignage de Mathis).

Question 8 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon et limites des outils (1,5 pt)

Calcul posé – Intervalle de confiance à 95 % et taille d'échantillon

p = 98 / 160 = 0,6125 ; n = 160.

Erreur type = racine de (0,6125 × 0,3875 / 160) = racine de 0,001483 = 0,0385.

Marge = 1,96 × 0,0385 = 0,075, soit 7,5 points.

IC 95 % = [61,3 – 7,5 ; 61,3 + 7,5] = **[53,7 % ; 68,8 %]**.

Taille pour ± 5 points : n = 1,96 × 1,96 × 0,6125 × 0,3875 / (0,05 × 0,05) = 364,7, soit **365** apprentis.

Correction pour une population finie de N = 640 : n' = n / (1 + (n – 1) / N) = 364,7 / (1 + 363,7 / 640) = 364,7 / 1,568 = **233** apprentis.

L'enquête (160 répondants) n'atteint pas cette taille : la précision est de ± 7,5 points, ce qui reste suffisant pour affirmer qu'une majorité ne mange rien le matin (la borne basse, 53,7 %, dépasse 50 %).

Limites des outils :

- **Évocation hiérarchisée** : le regroupement des mots en catégories dépend du jugement de l'enquêteur (il faut le faire à deux et comparer) ; la zone du noyau ne prouve pas la centralité (il faut une seconde technique, comme un questionnaire de mise en cause) ; les mots écrits devant les camarades peuvent suivre la **désirabilité sociale** du groupe (« viande », « force »).
- **Échelle de Likert** : biais d'**acquiescement** (tendance à répondre « d'accord ») ; **tendance centrale** ; deux items seulement par dimension ; items formulés par des adultes, parfois éloignés du langage des apprentis.
- **Échantillon** : 25,0 % de participation ; questionnaire passé pendant la semaine au CFA, ce qui exclut les absents (souvent les plus en difficulté) ; **biais de sélection** possible selon les classes interrogées.

Partie C – Veille

Question 9 – Organiser une veille (2 pts)

- **Besoins** : interventions efficaces en nutrition auprès des jeunes de 16 à 25 ans ; développement des CPS ; influence des réseaux sociaux sur l'alimentation des jeunes ; santé et sécurité des travailleurs du BTP ; boissons énergisantes.
- **Sources fiables** : Santé publique France (référentiel CPS 2022, répertoire des interventions efficaces ou prometteuses, site Manger Bouger) ; ANSES (avis de 2013 sur les boissons dites énergisantes et avis plus récents) ; Fédération Promotion Santé et structures régionales de promotion de la santé ; base OSCARS des actions régionales de santé ; INRS et organisme professionnel de prévention du BTP (OPPBTP) ; bases bibliographiques (Cairn pour la psychologie sociale francophone, PubMed pour les études internationales).
- **Outils** : alertes par courriel et flux RSS des sites officiels ; lettres d'information des structures de promotion de la santé ; tableau de veille partagé (date, source, résumé, utilité pour le projet, action décidée).

- **Fréquence** : une heure par semaine, et une synthèse mensuelle.
- **Diffusion** : note d'une page à l'infirmière, à la CPE et aux apprentis relais ; affichage en salle des formateurs ; point de veille lors des réunions d'équipe.
- **Évaluation** : nombre d'informations utilisées dans le projet ; retour des destinataires sur l'utilité de la note.

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique

Question 10 – Les trois situations du document 5 (1,5 pt)

- **La pesée publique et le classement** : refus. Le poids associé à une personne identifiée est une **donnée de santé**, donnée sensible au sens du RGPD (article 9) : sa collecte doit avoir une finalité légitime, être limitée au nécessaire et rester confidentielle. Publier un classement sur une messagerie de classe expose les apprentis à la **stigmatisation** et à la moquerie, ce qui va contre l'objectif du projet : la stigmatisation liée au poids nuit à la santé (Puhl et Heuer, 2009). Le projet ne vise d'ailleurs pas la perte de poids mais des comportements (manger le matin, manger des légumes).
- **La vidéo de l'apprenti filmé au self** : il s'agit d'une atteinte au **droit à l'image** et à la vie privée (article 9 du code civil) et d'un fait de **cyberharcèlement** : le harcèlement moral est puni par le code pénal (article 222-33-2-2), plus sévèrement lorsqu'il passe par un service de communication en ligne. Conduite à tenir : protéger et écouter le jeune ; prévenir la CPE et la direction ; signaler le contenu à la plateforme et, si besoin, sur PHAROS ; informer le jeune et sa famille du numéro national 3018 (harcèlement et violences numériques) ; ne pas repartager la vidéo, même pour la dénoncer ; utiliser l'événement, sans nommer la victime, dans les séances CPS.
- **La vidéo publique du projet** : elle est possible avec des précautions. Il faut une **autorisation écrite** de chaque personne filmée, signée aussi par les représentants légaux pour les mineurs ; une finalité précise et une durée de diffusion limitée ; aucune information sur le poids ou la santé ; le droit de retirer son accord. Le plus simple est de filmer les **mains, les gestes et les plats**, et de laisser les apprentis relais raconter le projet en voix off, ce qui protège aussi l'**e-réputation** des jeunes et du CFA.
- **Réponse proposée à la direction (exemple)** : « Nous proposons de renoncer à la pesée et au classement : ce sont des données de santé et ils exposeraient les jeunes à la moquerie, que le projet cherche justement à réduire. La vidéo diffusée au self doit être signalée et retirée, et l'apprenti accompagné. Pour la page du CFA, nous réaliserons avec les apprentis relais une vidéo sans visages, centrée sur les gestes et les plats, avec l'accord écrit de chacun. »

Question 11 – Communication, exposé et questions du jury (1,5 pt)

Supports adaptés : messages **positifs et concrets**, dans le langage des apprentis et validés par les relais (« Le carburant du chantier », « Tenir jusqu'à midi ») ; autocollants pour casques et boîtes ; affiches photo des casse-croûtes réalisés ; courtes vidéos sans visages tournées par les apprentis et diffusées sur les écrans du CFA et sur les réseaux du CFA ; défi en ligne « Montre ta boîte » (photo du casse-croûte, sans visage) ; aucun message culpabilisant ni de chiffres de poids. Pour les maîtres d'apprentissage : une fiche d'une page sur le lien entre repas du matin, vigilance et accidents.

Préparer l'oral – Trame de l'exposé de 10 minutes

0 – 1 min : contexte et demande de l'infirmière. 1 – 3 min : représentations (analyse prototypique) et comportements (enquête). 3 – 4 min : attitudes et leviers (théorie du comportement planifié), problème central. 4 – 5 min : objectifs. 5 – 7 min : plan d'action et concepts mobilisés, partenaires, budget. 7 – 8 min : évaluation et premiers résultats observés pendant le stage. 8 – 9 min : éthique (pesée, cyberharcèlement, droit à l'image). 9 – 10 min : bilan personnel et ce que je referais autrement.

Questions probables du jury – Questions probables et réponses attendues

1. Qu'est-ce qu'une représentation sociale ? Une forme de connaissance partagée par un groupe, qui oriente ses conduites (Moscovici, 1961 ; Jodelet, 1989).
2. Comment avez-vous fixé les seuils de l'analyse prototypique ? Moyenne des fréquences et moyenne des rangs moyens.

3. Le noyau central est-il prouvé ? Non : la zone du noyau donne des candidats ; il faut une seconde technique pour confirmer.

4. Pourquoi ne pas avoir dit aux jeunes de manger cinq fruits et légumes ? Le message est connu, il attaque leur représentation et provoque de la réactance.

5. Qu'est-ce qu'une norme descriptive ? Ce que font la plupart des membres du groupe, à distinguer de la norme injonctive (ce qu'il faudrait faire).

6. Pourquoi inverser certains items ? Pour que tous les scores aillent dans le même sens et pour limiter le biais d'acquiescement.

7. Pourquoi agir sur le contrôle perçu plutôt que sur l'attitude ? L'attitude est déjà favorable (3,35) ; le contrôle (2,30) et la norme (2,25) freinent l'intention.

8. Qu'est-ce que le sentiment d'efficacité personnelle ? La croyance en sa capacité à réussir une action ; il se renforce par les expériences de réussite (Bandura, 1977).

9. Comment avez-vous recruté les apprentis relais ? Volontariat, plusieurs métiers et âges, accord des formateurs.

10. Votre RR montre-t-il que vivre seul fait sauter le petit-déjeuner ? Non : association, enquête transversale, facteurs de confusion comme l'âge.

11. Que faites-vous face à un cas de cyberharcèlement ? Protéger, signaler, ne pas repartager, orienter (3018), en lien avec la CPE.

12. Pourquoi ne pas peser les jeunes ? Ce n'est pas l'objectif ; données de santé ; risque de stigmatisation.

13. Que proposez-vous à un apprenti qui n'a pas faim à 5 h 45 ? Une collation à la pause de 9 h, préparée la veille, et un verre d'eau ou de lait au réveil.

14. Comment avez-vous associé les maîtres d'apprentissage ? Réunion annuelle, organisme de prévention du BTP, lien avec la sécurité.

15. Quelles CPS travaillez-vous et comment ? Communiquer de façon constructive et résoudre des difficultés, par des jeux de rôle sur la pression du groupe.

16. Comment le projet peut-il durer ? Relais renouvelés chaque année, assiette du bâtisseur intégrée au marché du self, inscription au projet d'établissement.

Grille d'évaluation et barème

Partie	Indicateurs du référentiel évalués	Points
A – Projet	Analyse et diagnostic de situation posé (représentations, comportements, attitudes, besoins) ; objectifs formulés et adaptés ; plan d'action justifié par des concepts et moyens réalistes ; évaluation et valorisation (C3.1)	9
B – Recherche	Traitement et analyse des données (RR, IC, taille d'échantillon) ; limites des outils de recueil ; prudence sur la causalité (C3.3)	3
C – Veille	Besoins identifiés ; sources fiables ; outils et diffusion (C3.4)	2
D – Communication et numérique	Supports adaptés au public ; droit à l'image ; cyberharcèlement ; confidentialité des données de santé (C3.5, C3.6)	3
Expression	Expression écrite et orale maîtrisée ; vocabulaire ; sources datées	3
Total		20

Niveaux de maîtrise pour chaque partie : non maîtrisé (moins de 25 % des points), insuffisamment maîtrisé (25 à 49 %), maîtrisé (50 à 79 %), bien maîtrisé (80 % et plus).

Corrigé S2 – « Les hommes aux fourneaux » : un atelier pour des hommes âgés qui vivent seuls

> **que le jury attend**
>
> Le jury attend un atelier pensé pour des hommes âgés qui n'ont jamais cuisiné : des gestes simples, des réussites rapides, une ambiance entre pairs, sans infantiliser. Il évalue la justesse des calculs (quantités brutes, coût, apports Ciqual), l'adaptation aux pathologies et aux difficultés (diabète, mastication, sel, vue, mobilité), la sécurité sanitaire (poisson, cuisson, restes) et la compréhension des freins psychosociaux. Il pénalise les recettes trop techniques, les adaptations qui retirent tout plaisir et le discours « il faut maigrir » chez une personne âgée qui perd du poids.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Besoins et objectifs (2 pts)

Besoins **nutritionnels** : prévenir la dénutrition (deux hommes ont perdu plus de 5 % de leur poids en six mois ; ce n'est pas encore le critère de la HAS, qui est d'au moins 10 % en six mois, mais c'est un signal d'alerte qui justifie un dépistage par le médecin traitant) ; apporter assez de protéines (environ 1,0 g par kg et par jour, AFSSA 2007), de la vitamine D et des fibres ; repas du soir régulier. Besoins **psychologiques** : sentiment d'efficacité personnelle très faible (« je ne sais même pas faire cuire un œuf ») ; perte de repères après le deuil, le repas étant lié à l'épouse disparue. Besoins **sociaux** : isolement, perte des repas partagés, gêne à rejoindre un groupe majoritairement féminin.

- **Objectif général** : permettre à des hommes âgés vivant seuls de préparer eux-mêmes des repas simples, équilibrés et adaptés à leur santé, et de retrouver le plaisir de manger, si possible en compagnie.
- **Objectifs opérationnels** : à la fin de l'atelier, chaque participant aura réalisé lui-même au moins trois gestes (éplucher, émincer, fermer une papillote, mélanger un crumble) (observation) ; aura goûté le repas complet et donné son avis sur la grille (grilles remplies) ; repartira avec la fiche « pour un » en gros caractères et saura citer le temps de cuisson de la papillote et une règle de conservation des restes (question orale en fin de séance) ; aura choisi la recette de la séance suivante avec le groupe (décision notée).

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions

Quantité nette totale = grammage net × 10 ; quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte) ; coût = quantité brute en kg × prix au kg.

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Unité de commande	Prix unitaire	Coût
Filets de lieu noir	1 200 g	1 200 g	1,200 kg	12,90 € le kg	15,48 €
Poireaux	1 000 g	1 000 / 0,70 = 1 428,6 g	1,429 kg	2,20 € le kg	3,14 €
Pommes de terre	2 000 g	2 000 / 0,80 = 2 500 g	2,500 kg	1,20 € le kg	3,00 €
Crème légère 15 % MG	150 g	150 g	0,150 kg	3,40 € le kg	0,51 €
Citrons	100 g	100 / 0,60 = 166,7 g	0,167 kg	3,00 € le kg	0,50 €
Pommes	600 g	600 / 0,80 = 750 g	0,750 kg	2,40 € le kg	1,80 €
Poires	600 g	600 / 0,80 = 750 g	0,750 kg	2,80 € le kg	2,10 €
Flocons d'avoine	150 g	150 g	0,150 kg	2,00 € le kg	0,30 €
Farine T55	100 g	100 g	0,100 kg	1,10 € le kg	0,11 €
Beurre doux	80 g	80 g	0,080 kg	9,50 € le kg	0,76 €
Sucre blanc	60 g	60 g	0,060 kg	1,30 € le kg	0,08 €

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Unité de commande	Prix unitaire	Coût
Papier sulfurisé, aneth, poivre, cannelle	–	–	forfait	–	0,80 €
Total					28,58 €

Coût par portion = 28,58 / 10 = **2,86 €**, inférieur au plafond de 3,00 € : le budget est respecté, avec une marge de 0,14 € par portion. Le poisson représente 15,48 / 28,58 × 100 = 54,2 % du coût : pour les séances suivantes, on peut proposer du lieu noir surgelé, souvent moins cher, ou des œufs.

Question 3 – Fiche technique, fiche « pour un » et adaptations (3 pts)

Modèle – Fiche technique de la papillote de lieu noir (10 portions)

Ingrédients : filets de lieu noir 1,200 kg ; poireaux 1,000 kg nets ; crème légère 150 g ; 2 citrons ; aneth ; poivre ; pommes de terre 2,000 kg nettes.

Matériel : four à 200 °C, plaques, papier sulfurisé (10 feuilles de 35 cm), cuit-vapeur ou faitout avec panier, planches et couteaux (code couleur poisson et légumes), économes, thermomètre-sonde, balance, saladiers.

1. Se laver les mains ; sortir le poisson du réfrigérateur au dernier moment.
2. Laver soigneusement les poireaux (terre entre les feuilles), les émincer finement ; les faire fondre 10 minutes à couvert dans une sauteuse avec un peu d'eau.
3. Éplucher, laver, tailler les pommes de terre en morceaux réguliers ; les cuire à la vapeur 20 à 25 minutes.
4. Sur chaque feuille, déposer un lit de poireaux, un filet de poisson, 15 g de crème, une rondelle de citron, de l'aneth, du poivre (pas de sel ajouté).
5. Fermer la papillote en roulant les bords ; cuire 15 minutes au four à 200 °C.
6. Contrôler la cuisson : la chair se détache en lamelles nacrées ; température à cœur d'au moins 63 °C.
7. Servir dans la papillote ouverte, avec les pommes de terre.

Points critiques : chaîne du froid du poisson (0 à 2 °C), arêtes à vérifier du bout des doigts, cuisson à cœur, séparation des planches cru et cuit, vapeur brûlante à l'ouverture de la papillote.

Fiche « pour un » (gros caractères, une étape par photo) : un filet de poisson frais ou surgelé (sans décongeler, ajouter 5 minutes de cuisson), un demi-poireau émincé ou une poignée de poireaux surgelés, une cuillère à soupe de crème, une rondelle de citron ; papillote fermée ; 15 à 20 minutes à 200 °C au four, ou 4 à 5 minutes au four à micro-ondes dans un plat couvert (sans papier aluminium). Pommes de terre : 2 ou 3 pommes de terre coupées en morceaux, 8 à 10 minutes au micro-ondes dans un bol couvert avec 2 cuillères à soupe d'eau. Crumble « pour un » : un fruit coupé dans un ramequin, deux cuillères à soupe du mélange flocons-farine-beurre préparé à l'avance et gardé au réfrigérateur, 20 minutes au four ou 3 minutes au micro-ondes (moins croustillant).

Adaptations :

- **Monsieur R. (diabète de type 2)** : le repas est déjà adapté (féculents en quantité habituelle, fibres, dessert pris en fin de repas). On supprime le sucre du crumble et on parfume à la cannelle : les glucides du dessert passent de 36,0 g à 30,1 g, et les sucres de 18,8 g à 12,8 g. On ne supprime pas le dessert, qui fait partie du plaisir du repas.
- **Monsieur P. (mastication)** : le poisson et les poireaux fondus sont déjà tendres ; on écrase les pommes de terre à la fourchette avec un peu de jus de cuisson et de crème ; on remplace le crumble croustillant par une compote pommes-poires avec les flocons d'avoine trempés dans un peu de lait. On garde une présentation soignée (assiette séparée, pas de mixé), car il s'agit d'une texture tendre, pas d'un régime mixé.

- **Monsieur L. (sel)** : aucun sel ajouté dans la recette (0,31 g de sel naturellement présent dans le plat) ; on donne du goût par le citron, l'aneth, le poivre, l'ail ; on lui apprend à repérer le sel sur les étiquettes des plats tout prêts qu'il achète.

Question 4 – Apports nutritionnels (2 pts)

Calcul posé – Apport d'une portion (table Ciqual 2025, document 4)

Apport = grammage net × teneur pour 100 g / 100. Les teneurs « < » ou « – » sont comptées 0.

Ingrédient (plat)	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Vitamine D (µg)
Lieu noir	120 g	99,0	22,56	0	0,96	0	0,24	2,12
Poireau	100 g	30,4	1,50	4,55	0,30	1,80	0,05	0
Pomme de terre	200 g	160,0	4,04	32,40	0,18	4,40	0	0
Crème légère	15 g	26,0	0,44	0,65	2,40	0	0,02	0
Citron	10 g	2,4	0,03	0,16	0	0	0	0
Total plat		317,8	28,6	37,8	3,8	6,2	0,31	2,12
Crumble (pomme 60 g, poire 60 g, flocons 15 g, farine 10 g, beurre 8 g, sucre 6 g)		235,1	2,9	36,0	8,1	5,3	0,01	0
Repas complet		552,9	31,4	73,8	11,9	11,5	0,32	2,12

Répartition de l'énergie du repas : protéines 31,42 × 4 / 552,9 = **22,7 %** ; lipides 11,90 × 9 / 552,9 = **19,4 %** ; glucides 73,79 × 4 / 552,9 = **53,4 %** ; le reste (4,2 %) vient surtout des fibres, comptées 2 kcal par gramme dans le calcul réglementaire de l'énergie (11,49 × 2 / 552,9).

Part du besoin en protéines d'un homme de 75 kg (1,0 g par kg et par jour, soit 75 g) : 31,4 / 75 × 100 = **41,9 %**.

Fibres : 11,5 / 30 × 100 = **38,3 %** du repère journalier. Sel : 0,32 g, soit 6,4 % de la limite de 5 g. Vitamine D : 2,12 / 15 × 100 = **14,1 %** de l'apport satisfaisant.

Commentaire : le repas est **riche en protéines** (41,9 % du besoin journalier en un repas), **pauvre en sel** (adapté à Monsieur L.) et apporte plus du tiers des fibres de la journée. Sa part de lipides est faible (19,4 %) : pour des hommes qui perdent du poids, il ne faut pas chercher à « alléger ». On peut enrichir sans augmenter le volume (un peu plus de crème, un filet d'huile de colza sur les pommes de terre, un fromage ou un laitage en plus), comme le recommande la prévention de la dénutrition. La vitamine D reste faible : le poisson en apporte, mais l'exposition au soleil et l'avis du médecin (supplémentation) comptent davantage chez la personne âgée.

Question 5 – Pourquoi ces hommes ne cuisinent pas, et ce que l'atelier peut changer (2 pts)

- **Identité et rôles de genre** : dans la **socialisation** de ces générations, la cuisine quotidienne était un rôle féminin ; cuisiner peut être vécu comme une perte de statut, et l'atelier « plein de dames » renforce la gêne. Un atelier **entre hommes**, au nom valorisant, avec des gestes techniques (papillote, cuisson au four), réduit cette menace identitaire.
- **Sentiment d'efficacité personnelle** (Bandura, 1977) : il est très faible ; il se renforce par des **expériences de réussite** (chacun réalise une étape et mange le résultat), par l'**exemple de pairs** qui réussissent (expérience vicariante : un participant un peu plus expérimenté montre un geste), par les **encouragements** et par un climat détendu qui réduit l'anxiété.
- **Deuil et motivation** : le repas rappelle l'épouse disparue ; manger seul diminue l'envie de cuisiner. La motivation durable repose sur l'autonomie (choisir les recettes), la compétence (réussir) et l'appartenance (le groupe), selon la théorie de l'autodétermination.

- **Isolement** : le repas partagé à la fin de l'atelier recrée du lien ; l'atelier peut déboucher sur un repas mensuel entre participants ou au foyer-restaurant.

Limites d'un atelier isolé : une seule séance ne change pas des habitudes ; il faut le **cycle de six séances**, un lien avec le médecin traitant (dépistage de la dénutrition, pesée régulière), le portage de repas si besoin, l'accès aux courses (mobilité, canne) et un suivi après le cycle. L'atelier n'agit pas sur les revenus ni sur la solitude au quotidien.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire	Candidat	Participants
8 h 30 – 9 h 30	Mise en place : contrôle des denrées et des températures, postes de travail à hauteur réglable, chaises disponibles, fiches en gros caractères, couteaux et économes ergonomiques ; préchauffage du four	–
9 h 30 – 9 h 45	Accueil autour d'un café ; présentation de chacun ; règles de sécurité ; lavage des mains montré puis réalisé	Se présentent, se lavent les mains
9 h 45 – 10 h 15	Démonstration courte puis travail en binômes : épluchage des pommes de terre, lavage et émincé des poireaux ; parler fort, face au groupe, montrer de près	Épluchent, émincent ; s'assoient s'ils le souhaitent
10 h 15 – 10 h 40	Crumble : couper les fruits, sabler le mélange avec les doigts ; enfournement	Préparent le crumble, version sans sucre pour M. R.
10 h 40 – 11 h 10	Papillotes : chaque participant monte et ferme la sienne ; cuisson des pommes de terre à la vapeur	Montent leur papillote
11 h 10 – 11 h 30	Cuisson des papillotes ; pendant ce temps, échange sur les courses « pour un », lecture d'étiquette (sel)	Échangent, posent des questions
11 h 30 – 12 h 00	Dressage, repas partagé, grille de dégustation, choix de la recette suivante, remise des fiches	Mangent ensemble, évaluent, décident
12 h 00 – 12 h 30	Remise en état, plonge, nettoyage et désinfection, gestion des déchets, bilan écrit	Ceux qui le souhaitent aident à ranger

Question 7 – Animation, outils et grille de dégustation (1,5 pt)

Méthodes qui renforcent l'efficacité personnelle : **démonstration courte puis pratique immédiate** ; difficulté progressive (on commence par un geste facile et réussi) ; **valorisation concrète** (« votre papillote est parfaitement fermée ») ; entraide entre pairs ; droit à l'erreur et humour ; jamais faire à la place. Outils : fiche recette en police de 16 points au moins, très contrastée, une étape par photo ; quantités en repères visuels (une cuillère à soupe, une poignée) ; minuteur à gros chiffres ; plan de travail bien éclairé. Grille de dégustation : trois questions simples (aspect, goût, envie de refaire), réponse par une note de 1 à 4 ou par des visages, remplie oralement si la vue est gênée ; une question ouverte : « Que changeriez-vous ? ».

Question 8 – Hygiène, conservation des restes, allergènes, éco-gestes (1,5 pt)

Hygiène (5 M) : **main-d'œuvre** (lavage des mains, tablier, cheveux attachés, plaies protégées) ; **milieu** (plans de travail nettoyés et désinfectés, marche en avant) ; **matériel** (planches distinctes pour le poisson cru et les légumes) ; **matière** (poisson conservé entre 0 et 2 °C jusqu'au dernier moment, poireaux bien lavés) ; **méthode** (cuisson à cœur d'au moins 63 °C, service rapide). À domicile : mettre les restes au réfrigérateur dans une boîte fermée dans les deux heures, les consommer dans les 24 heures pour le poisson cuit, réchauffer une seule fois jusqu'à ce que ce soit très chaud ; vérifier la température du réfrigérateur (4 °C au plus) ; dates limites lisibles avec une loupe ou en gros caractères. Allergènes à déclarer : **poisson**, **lait** (crème, beurre), **gluten** (farine, flocons d'avoine). Éco-gestes : légumes de saison (poireaux, pommes, poires en hiver), épluchures au compost, cuisson

simultanée des papillotes et du crumble dans le four, eau de cuisson vapeur limitée, restes emportés dans des boîtes réutilisables, poisson issu d'une pêche durable (label).

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (3 pts)

Critères : poisson nacré, qui se détache en lamelles, cuit à cœur ; poireaux fondants ; papillote bien fermée puis ouverte au service ; pommes de terre cuites et entières (version écrasée pour M. P.) ; crumble doré et croustillant, fruits tendres ; assiette de M. P. aussi soignée que les autres ; respect des températures, du temps et de l'hygiène ; poste propre en fin de séance.

Question 10 – Évaluation (1 pt)

Satisfaction : grille de dégustation et tour de table. Acquis : chaque participant cite le temps de cuisson de la papillote et une règle de conservation. **Sentiment de compétence** : question « De 1 à 10, vous sentez-vous capable de refaire ce plat seul chez vous ? », posée au début et à la fin de l'atelier, puis à la dernière séance du cycle. Intention et comportement : « Allez-vous refaire ce plat cette semaine ? », puis à la séance suivante « L'avez-vous refait ? ». Suivi : nombre de participants présents aux six séances, évolution du poids suivie par le médecin traitant (donnée de santé, non recueillie par l'atelier).

Barème – Barème du sujet

Besoins et objectifs 2 ; bon de commande 2 ; fiche technique, fiche « pour un » et adaptations 3 ; apports nutritionnels 2 ; analyse psychosociale et limites 2 ; déroulé 2 ; animation et outils 1,5 ; hygiène, allergènes, éco-gestes 1,5 ; réalisation 3 ; évaluation 1 ; total 20.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier les pertes au parage des poireaux (30 %) ; proposer un menu « allégé » à des hommes qui perdent du poids ; supprimer le dessert du diabétique ; mixer le repas de M. P. alors qu'une texture tendre suffit ; ajouter du sel ; faire les gestes à la place des participants ; oublier les allergènes poisson, lait et gluten ; ignorer la vue et la mobilité dans l'organisation.

Corrigé S3 – Vers l'autonomie : des jeunes de la protection de l'enfance

que le jury attend

Le jury attend un projet construit **avec** les jeunes et non pour eux : des jeunes qui se méfient des adultes qui décident à leur place, qui ont souvent vécu des ruptures, et pour qui l'autonomie alimentaire fait partie de l'accès à une vie d'adulte. Il évalue la rigueur des indicateurs, la mobilisation juste de la socialisation, des CPS et de l'autodétermination, la faisabilité dans des studios peu équipés, et les précautions éthiques propres à la protection de l'enfance. Il pénalise les ateliers « scolaires », les jugements sur les familles et les photos de jeunes publiées sans précaution.

Temps 1

Question 1 – Indicateurs, efficacité personnelle et limites (4 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête (n = 22)

- Saute au moins un repas par jour, 4 jours sur 7 : 13 / 22 × 100 = **59,1 %**.
- Plat préparé, livraison ou restauration rapide au moins 4 fois par semaine : 15 / 22 × 100 = **68,2 %**.
- Sait cuisiner au moins 3 plats sans aide : 6 / 22 × 100 = **27,3 %**.
- Fait ses courses avec une liste : 4 / 22 × 100 = **18,2 %**.
- Plus d'argent pour manger avant la fin du mois : 12 / 22 × 100 = **54,5 %**.
- Souhaite apprendre à cuisiner : 17 / 22 × 100 = **77,3 %**.
- Taux de réponse : 22 / 24 × 100 = **91,7 %**.

Score moyen d'efficacité personnelle = (2,1 + 2,4 + 1,9 + 3,0 + 2,2 + 2,6) / 6 = 14,2 / 6 = **2,37** sur 5 (point neutre : 3).

Les deux capacités les plus faibles sont **cuisiner pour des amis** (1,9) et **préparer un repas complet** (2,1) ; la plus forte est **lire une étiquette et comparer deux produits** (3,0), qui est la seule à atteindre le point neutre. Lecture : les jeunes savent plutôt « lire » l'alimentation, mais ne se sentent pas capables de la « faire ». Le levier n'est donc pas l'information mais la **pratique** : des expériences de réussite répétées. La forte demande (77,3 %) est un atout : la motivation existe.

Limites : petit effectif (22 jeunes : un jeune représente 4,5 points de pourcentage) ; questionnaire rempli en temps collectif, avec un risque de **désirabilité sociale** et d'influence du groupe ; aide d'une éducatrice pour la lecture, qui peut orienter les réponses ; échelle d'efficacité personnelle construite pour le service, non validée ; données déclaratives ; pas de comparaison possible avec une population générale du même âge.

Question 2 – Analyse psychosociale et inégalité sociale de santé (3 pts)

- **Socialisation primaire** : elle se fait surtout dans la famille ; pour ces jeunes, elle a été marquée par des ruptures (placement), et l'apprentissage ordinaire de la cuisine, des courses et du repas familial a souvent manqué.
- **Socialisation secondaire** : en foyer, « tout était fait » ; l'institution a nourri les jeunes sans toujours leur apprendre à se nourrir. Le passage en studio les place brutalement devant des tâches jamais apprises.
- **Identité** : à 16-20 ans, l'identité se construit en partie contre les adultes et avec les pairs ; la nourriture rapide et la livraison peuvent être des marqueurs d'appartenance et de liberté. Le repas peut aussi réveiller des souvenirs familiaux douloureux.
- **Compétences psychosociales** (Santé publique France, 2022) : l'autonomie alimentaire mobilise des CPS cognitives (prendre des décisions constructives : choisir, planifier, gérer un budget), émotionnelles (gérer son stress et sa fatigue, ne pas « compenser » par la livraison) et sociales (cuisiner et manger avec d'autres, demander de l'aide).
- **Théorie de l'autodétermination** (Deci et Ryan) : la motivation durable suppose de satisfaire les besoins d'**autonomie** (choisir, ne pas subir « des adultes qui décident pour nous »), de **compétence** (réussir, ce que

montre le faible score d'efficacité personnelle) et d'**appartenance** (le groupe des pairs, un adulte de confiance).

C'est une **inégalité sociale de santé** : ces jeunes cumulent des ressources économiques faibles (54,5 % manquent d'argent pour manger en fin de mois), un soutien familial absent ou fragile et une entrée dans l'autonomie plus précoce que les jeunes du même âge, qui restent en moyenne plus longtemps chez leurs parents. Le document 1 montre que le passage par la protection de l'enfance est surreprésenté parmi les personnes sans domicile (23 % des personnes sans domicile nées en France). Ces écarts sont **évitables** et **injustes** : ils ne viennent pas de choix individuels mais d'un parcours de vie.

Question 3 – Objectifs et plan d'action sur 12 mois (5 pts)

- **Objectif général** : d'ici décembre 2027, permettre aux jeunes du service « Les Passerelles » de se nourrir seuls de façon suffisante, variée et économique, en préparant leur sortie du dispositif.
- **Objectif spécifique 1** : d'ici décembre 2027, porter de 27,3 % à 60 % au moins la part des jeunes qui savent cuisiner au moins 3 plats sans aide.
- **Objectif spécifique 2** : d'ici décembre 2027, réduire de 54,5 % à 35 % au plus la part des jeunes qui n'ont plus d'argent pour manger avant la fin du mois.
- **Objectif spécifique 3** : d'ici décembre 2027, faire passer le score moyen d'efficacité personnelle de 2,37 à 3,2 au moins.
- **Objectifs opérationnels** : constituer avant février 2027 un **comité de jeunes** (4 volontaires) qui choisit les recettes, les horaires et le nom des ateliers (compte rendu de réunion) ; organiser 6 ateliers culinaires de février à novembre 2027, à des horaires compatibles avec les emplois du temps (17 h 30 ou samedi midi), avec au moins 6 jeunes à chacun (feuilles de présence) ; réaliser 4 sorties « courses accompagnées » avec un budget de 30 € pour la semaine (fiches de courses) ; co-écrire avec les jeunes un livret de 20 recettes « studio » réalisables avec deux plaques et un four à micro-ondes, remis à chaque jeune avant juin 2027 (livrets distribués) ; remettre un kit d'ustensiles aux 12 jeunes qui quittent le service dans l'année (kits remis).

Période	Action	Respect de l'autodétermination
Janvier – février	Réunion des jeunes, création du comité, choix des thèmes (« manger pour 30 € par semaine », « cuisiner une fois, manger quatre fois », « recevoir des amis »)	Les jeunes décident ; participation libre
Février – novembre	6 ateliers culinaires de 2 h, repas pris ensemble	Recettes choisies par le comité ; chacun choisit son poste
Mars – octobre	4 sorties courses accompagnées (marché, supermarché discount, épicerie solidaire), comparaison des prix au kilo	Le jeune tient le budget et choisit les produits
Avril – juin	Écriture et illustration du livret « recettes studio » (photos de plats, sans visages)	Les jeunes sont auteurs du livret
Toute l'année	Accompagnement individuel par l'éducateur référent : liste de courses, budget, essais à domicile	Objectifs fixés par le jeune lui-même
Novembre – décembre	Repas de fin d'année préparé par les jeunes pour les éducateurs ; bilan collectif	Valorisation des compétences ; appartenance

Question 4 – Évaluation et budget (3 pts)

Type	Indicateurs	Outils
Processus	Nombre d'ateliers et de sorties réalisés, nombre de jeunes présents, nombre de réunions du comité, livrets et kits remis, respect du budget	Feuilles de présence, comptes rendus, tableau de bord

Type	Indicateurs	Outils
Résultats	Part des jeunes qui savent cuisiner 3 plats sans aide ; part qui manque d'argent en fin de mois ; score d'efficacité personnelle ; satisfaction	Même questionnaire et même échelle en décembre 2027 ; entretien de groupe
Effets à plus long terme	Situation alimentaire des jeunes 6 mois après leur sortie du service	Questionnaire court envoyé avec leur accord, par le canal qu'ils choisissent

Calcul posé – Budget prévisionnel (prix construits pour le sujet)

- Denrées des 6 ateliers : 6 × 10 portions × 2,00 € = **120,00 €**.
- Boîtes de conservation et de congélation : 24 lots × 9,00 € = **216,00 €**.
- Impression du livret de recettes : 24 × 4,50 € = **108,00 €**.
- Sorties courses accompagnées (transport, achats tests) : 4 × 40,00 € = **160,00 €**.
- Kits d'ustensiles pour les jeunes qui quittent le service : 12 × 18,00 € = **216,00 €**.
- Sous-total : 120 + 216 + 108 + 160 + 216 = 820,00 €.
- Imprévus : 900 – 820 = **80,00 €**, soit 80 / 900 × 100 = 8,9 %.

Total : **900,00 €**, soit exactement le budget.

Question 5 – Précautions éthiques et juridiques (3 pts)

- **Données personnelles** : questionnaire anonyme, sans nom ni date de naissance ; données conservées sur un support sécurisé du service, détruites à la fin du projet ; information des jeunes sur la finalité (RGPD : minimisation, information, sécurité). Les difficultés financières et les habitudes alimentaires d'un jeune identifié sont des informations personnelles sensibles.
- **Secret professionnel** : les personnes qui participent aux missions de l'aide sociale à l'enfance sont tenues au secret professionnel (code de l'action sociale et des familles, article L221-6). La stagiaire ne transmet aucune information individuelle hors de l'équipe ; le partage d'informations se limite à ce qui est nécessaire à l'accompagnement du jeune, avec l'éducateur référent.
- **Photos et réseaux sociaux** : pas de visages ni de lieux reconnaissables ; pour certains jeunes placés, le lieu de vie doit rester confidentiel (protection vis-à-vis de la famille). Toute photo d'un mineur demande l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale, après avis du service de l'ASE, et l'accord du jeune ; pour un majeur, son autorisation écrite. On privilégie les photos de plats et de mains.
- **Sujets sensibles** : ne pas demander aux jeunes de raconter les repas de leur enfance ; laisser chacun libre de ne pas participer à une activité ; prévoir avec l'éducateur une conduite à tenir si une émotion forte apparaît ; ne jamais juger les familles.
- **Respect des convictions** : viande halal, végétarisme, sans commentaire ni pression.

Question 6 – Expression et sources (2 pts)

Sources citées et datées : loi du 7 février 2022 ; enquête Sans-domicile 2012 (Insee-Ined, publication 2016) ; référentiel CPS de Santé publique France (2022) ; théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 1985 et 2000) ; Bandura (1977) pour l'efficacité personnelle ; table Ciqual 2025 ; références nutritionnelles de l'ANSES (2021). Vocabulaire attendu : socialisation primaire et secondaire, identité, CPS, autodétermination, efficacité personnelle, inégalité sociale de santé, secret professionnel.

Temps 2

Question 7 – Besoins, objectifs et choix du menu (3 pts)

Besoins : apprendre une recette complète, économique, réalisable dans un studio avec deux plaques et un four à micro-ondes ; savoir cuisiner en grande quantité et conserver des portions pour les soirs de fatigue (alternative à la livraison) ; gagner en confiance (score d'efficacité personnelle de 2,1 pour « préparer un repas complet »).

Objectif de l'atelier : à la fin de la séance, chaque jeune aura réalisé au moins une étape du chili, aura conditionné et étiqueté une portion à congeler, et saura dire comment la décongeler et la réchauffer.

Choix du menu : le chili est un **plat complet** (légumineuses, viande, légumes, féculent) ; il se prépare dans une seule casserole, se congèle bien et coûte peu ; il est apprécié des jeunes (plat épicé, convivial) et peut se décliner (wraps, gratin, version végétarienne). La viande achetée halal permet à tous de manger le même plat. La salade d'oranges est rapide, de saison en hiver, sans cuisson. Les horaires (17 h 30) tiennent compte du lycée, de l'apprentissage et des emplois.

Question 8 – Bon de commande, fiche technique, apports et version végétarienne (5 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Unité de commande	Prix unitaire	Coût
Bœuf haché 5 % MG (halal)	600 g	600 g	0,600 kg	11,50 € le kg	6,90 €
Haricots rouges égouttés	800 g	800 g	0,800 kg	2,40 € le kg	1,92 €
Oignons	200 g	200 / 0,90 = 222,2 g	0,222 kg	1,80 € le kg	0,40 €
Poivrons	400 g	400 / 0,80 = 500 g	0,500 kg	3,50 € le kg	1,75 €
Tomates pelées au jus	800 g	800 g	0,800 kg	2,20 € le kg	1,76 €
Huile de colza	50 g	50 / 920 = 0,054 L	0,054 L	3,20 € le litre	0,17 €
Riz blanc	600 g	600 g	0,600 kg	1,80 € le kg	1,08 €
Oranges	1 500 g	1 500 / 0,70 = 2 142,9 g	2,143 kg	2,20 € le kg	4,71 €
Ail, cumin, paprika doux, cannelle	–	–	forfait	–	0,80 €
Total					19,49 €

Coût par portion = 19,49 / 10 = **1,95 €**, inférieur au plafond de 2,00 €. Version « studio » de 4 portions du chili et du riz (sans le dessert) : 2,76 + 0,77 + 0,16 + 0,70 + 0,70 + 0,07 + 0,43 = 5,59 €, soit **1,40 €** la portion, contre 8 à 15 € pour un plat livré.

Modèle – Fiche technique du chili doux (10 portions)

Ingrédients : bœuf haché 600 g ; haricots rouges égouttés 800 g ; oignons 200 g nets ; poivrons 400 g nets ; tomates pelées 800 g ; huile de colza 50 g ; 2 gousses d'ail ; cumin et paprika doux ; riz 600 g.

Matériel : grande sauteuse ou faitout, planches et couteaux (code couleur viande et légumes), passoire, casserole pour le riz, cuillère en bois, thermomètre-sonde, 10 boîtes de congélation et étiquettes.

1. Se laver les mains ; laver les poivrons ; éplucher et ciseler les oignons et l'ail ; tailler les poivrons en dés.
2. Faire revenir oignons et poivrons 5 minutes dans l'huile.
3. Ajouter le bœuf haché, l'émietter et le cuire jusqu'à ce qu'il ne reste plus de partie rose.
4. Ajouter les épices, les tomates et leur jus, puis les haricots rincés et égouttés ; laisser mijoter 20 minutes à feu doux.
5. Cuire le riz dans un grand volume d'eau (environ 12 minutes), l'égoutter.
6. Vérifier la cuisson à cœur (au moins 70 °C pour un plat à base de viande hachée), goûter, rectifier les épices.
7. Servir ; conditionner aussitôt les portions à emporter en boîtes peu profondes, étiqueter (nom du plat, date), refroidir rapidement.

Points critiques : cuisson à cœur de la viande hachée ; planches séparées cru et cuit ; refroidissement rapide des portions ; riz cuit refroidi vite et gardé au froid (Bacillus cereus).

Calcul posé – Apport d'une portion (table Ciqual 2025, document 4)

Ingrédient	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)
Bœuf haché 5 % MG	60 g	78,0	13,14	0,18	2,75	0	0,06	1,59
Haricots rouges	80 g	86,4	6,65	10,40	0,78	5,60	0,54	1,20
Oignon	20 g	7,8	0,22	1,25	0,12	0,34	0,02	0
Poivron	40 g	9,0	0,32	1,40	0,11	0,60	0,01	0,16
Tomates pelées	80 g	17,4	0,63	2,52	0,20	1,52	0,02	0,46
Huile de colza	5 g	45,0	0	0	5,00	0	0	0
Riz blanc	60 g	210,0	4,21	46,50	0,47	0,92	0	1,16
Total chili et riz		453,7	25,17	62,25	9,44	8,98	0,65	4,57
Orange	150 g	63,0	1,12	12,04	0	4,05	0	0,85
Repas complet		516,7	26,30	74,29	9,44	13,03	0,65	5,43

Répartition de l'énergie : protéines 26,30 × 4 / 516,7 = **20,4 %** ; lipides 9,44 × 9 / 516,7 = **16,4 %** ; glucides 74,29 × 4 / 516,7 = **57,5 %** ; fibres 13,03 × 2 / 516,7 = 5,0 % ; la somme (99,3 %) diffère de 100 % à cause des arrondis de la table.

Fer : 5,43 / 11 × 100 = **49,3 %** du repère d'une jeune femme adulte. Fibres : 13,03 / 30 × 100 = **43,4 %** du repère journalier.

Commentaire : repas rassasiant, riche en fibres et en fer (près de la moitié du repère en un repas), peu salé (0,65 g, dont l'essentiel vient des haricots en conserve, qu'on rince) et peu gras. La part des lipides est basse : un jeune très actif peut ajouter du pain ou une portion de fromage.

Version végétarienne : remplacer les 60 g de bœuf par 60 g de haricots rouges en plus (140 g au total). Protéines du chili et du riz : 25,17 − 13,14 + 60 × 8,31 / 100 = 25,17 − 13,14 + 4,99 = **17,02 g** (au lieu de 25,17 g). Pour compenser, on ajoute un œuf dur (50 g, 12,8 g de protéines pour 100 g dans la table Ciqual : 6,4 g) ou un laitage au dessert : on revient à environ 23,4 g. L'association de céréales (riz) et de légumineuses (haricots) améliore la qualité des protéines.

Question 9 – Déroulé, animation et grille de dégustation (4 pts)

Horaire	Candidat	Jeunes
16 h 30 – 17 h 30	Mise en place, contrôle des températures, postes, étiquettes, boîtes ; affiche des étapes en photos	–
17 h 30 – 17 h 45	Accueil, boisson ; présentation du plat choisi par le comité ; règles d'hygiène ; répartition des postes au choix	Choisissent leur poste
17 h 45 – 18 h 30	Préparation en binômes : légumes, cuisson de la viande, mijotage ; riz ; pendant la cuisson, jeu « combien ça coûte ? » (chili maison contre plat livré)	Cuisinent, comparent les prix
18 h 30 – 18 h 45	Salade d'oranges ; conditionnement et étiquetage des portions à emporter	Préparent, étiquettent
18 h 45 – 19 h 30	Repas ensemble, grille de dégustation, idées de variantes, choix de la prochaine recette	Mangent, évaluent, décident
19 h 30 – 20 h 00	Remise en état, refroidissement contrôlé, bilan écrit	Volontaires pour ranger

Animation qui respecte l'autonomie : le jeune choisit son poste et sa variante (plus ou moins épicé) ; l'animatrice explique pourquoi (« on refroidit vite parce que… ») plutôt que d'ordonner ; elle valorise les réussites ; elle ne

fait pas à la place ; elle accepte qu'un jeune observe avant de participer. Grille de dégustation : note de 1 à 5 (aspect, goût, envie de refaire), une question ouverte « Ma variante » ; réponse possible sur tablette ou sur papier.

Question 10 – Hygiène, refroidissement, congélation, allergènes, éco-gestes (4 pts)

Viande hachée : conservée au froid jusqu'au dernier moment, cuite à cœur sans partie rose. Refroidissement : en collectivité, passer de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures (arrêté du 21 décembre 2009) ; à la maison, répartir en boîtes peu profondes, ne pas laisser plus de 2 heures à température ambiante, puis réfrigérer ou congeler. Congélation : à – 18 °C, avec une étiquette (plat, date), à consommer dans les 3 mois. Décongélation : au réfrigérateur la veille ou directement au four à micro-ondes, puis réchauffer jusqu'à ce que le plat soit très chaud, une seule fois ; ne jamais recongeler un plat décongelé. Riz cuit : refroidi rapidement et consommé dans les 24 heures au réfrigérateur. Allergènes : la recette ne contient aucun des 14 allergènes à déclarer, mais il faut vérifier la composition des mélanges d'épices (céleri, moutarde possibles) ; signaler l'œuf de la version végétarienne. Éco-gestes : cuisson en grande quantité (énergie économisée), légumes de saison, boîtes réutilisables, pas de gaspillage grâce à la congélation, épluchures au compost, achat en vrac des légumineuses et du riz.

Question 11 – Réalisation, conditionnement et évaluation (4 pts)

Réalisation : viande bien cuite, chili nappant et mijoté, riz cuit et égoutté, oranges pelées à vif et tranchées ; portions à emporter conditionnées et étiquetées ; respect de l'hygiène, du temps et des températures. Évaluation : grille de dégustation ; nombre de jeunes ayant réalisé une étape seuls ; question « De 1 à 5, vous sentez-vous capable de refaire ce plat seul ? », posée en début et en fin d'atelier ; à l'atelier suivant, « Avez-vous mangé votre portion congelée ? L'avez-vous refait ? » ; retour au comité de jeunes pour ajuster la séance suivante.

Barème – Barème du sujet mixte

Temps 1 : indicateurs, efficacité personnelle et limites 4 ; analyse psychosociale et inégalité 3 ; objectifs et plan d'action 5 ; évaluation et budget 3 ; éthique 3 ; expression et sources 2 ; total 20.

Temps 2 : besoins et menu 3 ; bon de commande, fiche technique, apports et version végétarienne 5 ; organisation et animation 4 ; hygiène et éco-gestes 4 ; réalisation et évaluation 4 ; total 20.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Décider des recettes à la place des jeunes ; organiser des ateliers à des horaires incompatibles avec le travail ; publier des photos de mineurs placés ; demander aux jeunes de parler de leur famille ; oublier les pertes des oranges (30 %) ; oublier le refroidissement rapide et l'étiquetage des portions congelées ; proposer une version végétarienne sans compenser les protéines.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Réaliser une analyse prototypique (seuils, quatre zones) et en tirer des messages	S1			
C3.1	Calculer les scores d'une échelle de Likert avec items inversés et les interpréter (Ajzen)	S1			
C3.1	Répartir un public selon les stades de changement et en tirer des conséquences	S1			
C3.1	Analyser une situation avec la socialisation, l'identité, les CPS et l'autodétermination	S2, S3			
C3.1	Justifier chaque action par un concept de psychologie sociale	S1, S3			
C3.1	Formuler des objectifs avec indicateur, cible et échéance ; construire un budget	S1, S3			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes	S2, S3			
C3.2	Adapter une recette (diabète, mastication, sel, végétarien, halal, studio)	S2, S3			
C3.2	Calculer un apport nutritionnel avec la table Ciqual 2025 et la part des besoins couverte	S2, S3			
C3.2	Animer un atelier qui renforce le sentiment d'efficacité personnelle et l'autonomie	S2, S3			
C3.2	Appliquer l'hygiène (poisson, viande hachée, refroidissement, congélation, allergènes)	S2, S3			
C3.3	Calculer un risque relatif, un intervalle de confiance, une taille d'échantillon ; discuter la causalité	S1			
C3.3	Présenter les limites de l'évocation hiérarchisée et de l'échelle de Likert	S1, S3			
C3.4	Organiser une veille sur les interventions psychosociales	S1			
C3.5	Communiquer sans moraliser avec des jeunes ; adapter les supports à la vue et à l'audition	S1, S2			
C3.6	Réagir à un cyberharcèlement ; protéger le droit à l'image et les données de santé	S1, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; BTS blanc CNED E5B pour l'adaptation d'une recette et le calcul nutritionnel ; texte de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024) pour la répartition des compétences entre les deux temps.